



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**LAPORAN BULAN APRIL
RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA MALANG
2024**

DAFTAR ISI

Daftar Isi i

Bab I Pendahuluan 1

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Tujuan 1

Bab II Gambaran Umum Rumah Sakit Prima Husada Malang 2

2.1 Visi 2

2.2 Misi..... 2

2.3 Motto 2

2.4 7 Nilai Budi Utama 2

2.5 Struktur Organisasi 3

Bab III Laporan Kinerja Pelayanan..... 4

3.1 Kinerja RS Prima Husada (TT, BOR, ALOS, BTO, TOI) 4

3.1.1 Tabel Capaian BOR,LOS,TOI,BTO 4

3.1.2 Grafik Capaian BOR,LOS,TOI,BTO 4

3.1.3 Analisa dan Tindak Lanjut 4

3.1.4 Terkait BPJS Kesehatan 4

3.2 Pengembangan Pelayanan RS Prima Husada 6

3.3 Kinerja Bidang Pelayanan 9

3.3.1 Rawat Jalan Poliklinik 9

3.3.2 Rawat Inap 11

3.3.3 Intensive Care Unit (ICU) 17

3.3.4 Instalasi Gawat Darurat (IGD) 18

3.3.5 Instalasi Kamar Operasi (IKO) 20

3.4 Kinerja Bidang Penunjang 21

3.4.1 Instalasi Farmasi 21

3.4.2 Laboratorium 24

3.4.3 Rekam Medis - Pendaftaran..... 26

3.4.4 Radiologi 28

3.4.5 Gizi..... 30

3.4.6 CSSD - Laundry 32

3.5 Kinerja Umum dan Keuangan 33

3.5.1 SDM 33

3.5.2 MFK dan K3RS 39

3.5.3 Security 43

3.5.4 Parkir..... 45

3.5.5 Humas Marketing 45

3.5.6 Penjaminan 48

3.5.7 PIPP – MOD - MPP..... 49

3.5.8 *Cleaning Service* 54

3.6 Komite dan Tim 56

3.6.1 Komite Mutu 56

3.6.2 Komite PPI 87

3.6.3 Tim PKRS..... 86

3.6.4 Tim Prognas..... 99

3.6.5 Tim PPRA..... 140

3.6.6 Tim Review RM (E-RM)-IT 150

3.7 Permasalahan Rumah Sakit 151

3.8 Profil SDM 155

Bab IV Kesimpulan dan Saran..... 158

Bab V Penutup..... 159

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka terselenggaranya *good governance* diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan rumah sakit dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Laporan Kinerja rumah sakit dalam hal ini Rumah Sakit Prima Husada Malang adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan kewajiban Rumah Sakit Prima Husada Malang untuk mempertanggungjawabkan kinerja, keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi misi Rumah Sakit Prima Husada Malang dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Selain dari tuntutan akuntabilitas kinerja, Laporan Kinerja juga sebagai alat ukur keberhasilan Rumah Sakit dalam mencapai tujuan dan/atau sasaran atau kegiatan utama yang dapat digunakan sebagai fokus perbaikan kinerja dimasa datang, kuncinya adalah penekanan pada tujuan dan sasaran atau program kegiatan yang perlu mendapat perhatian sebagai ukuran keberhasilan.

Rumah Sakit Prima Husada Malang adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan kegiatan dibidang kesehatan berkelanjutan secara paripurna dengan mengutamakan pengobatan dan pemulihan tanpa mengabaikan peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit yang dilaksanakan melalui penyediaan pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat, penunjang dan tindakan medik.

1.2 TUJUAN

Tujuan penyusunan Laporan Bulan April Tahun 2024 adalah untuk :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan pelayanan antar unit untuk meningkatkan kinerja rumah sakit

BAB II

GAMBARAN UMUM RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA MALANG

2.1 VISI

Menjadi Rumah Sakit berkualitas prima pilhan seluruh lapisan masyarakat

2.2 MISI

1. Memberikan Pelayanan Kesehatan dengan Aman, Tepat, Cepat dan Akurat
2. Mengutamakan Kepuasan dan Keselamatan Pasien
3. Meningkatkan Mutu Pelayanan yang Berkelanjutan

2.3 MOTTO

Sahabat Menuju Sehat

2.4 7 NILAI BUDI UTAMA

1. Jujur
2. Tanggung Jawab
3. Visioner
4. Disiplin
5. Kerjasama
6. Adil
7. Peduli

2.5 STRUKTUR ORGANISASI

Susunan struktur Organisasi Rumah Sakit Prima Husada Malang sebagai berikut :



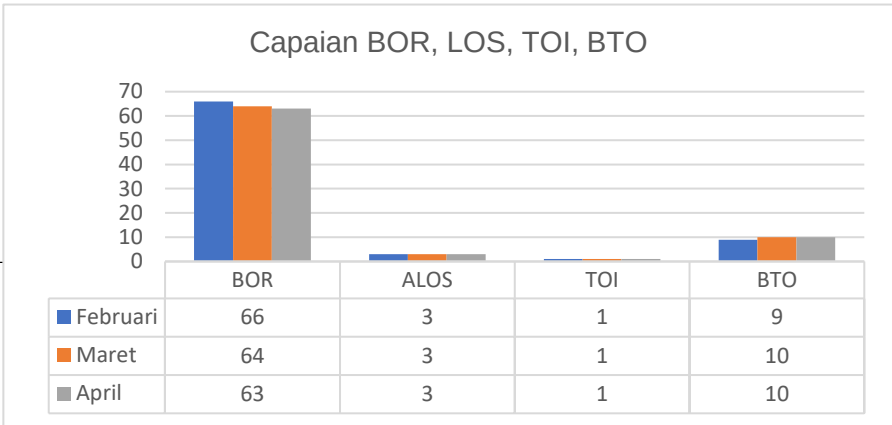
BAB III
LAPORAN KINERJA PELAYANAN

3.1 Kinerja RS Prima Husada (TT,BOR,ALOS,BTO,TOI)

3.1.1 Tabel Capaian BOR,LOS,TOI,BTO

NO	INDIKATOR	FEBRUARI	MARET	APRIL
1	BOR	66	64	63
2	ALOS	3	3	3
3	TOI	1	1	1
4	BTO	9	10	10

3.1.2 Grafik Capaian BOR,LOS,TOI,BTO

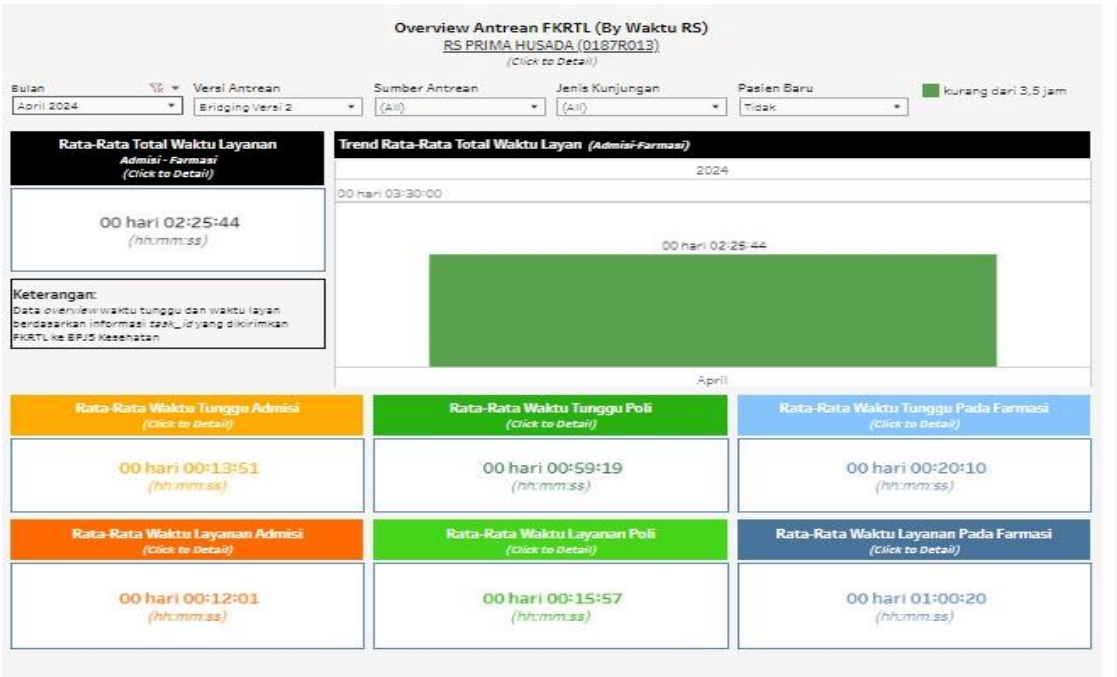


3.1.3 Analisa dan Tindak Lanjut

Nilai BOR di bulan April 2024 sudah mencapai nilai ideal (>60%), namun terdapat penurunan dibanding dua bulan sebelumnya. Dibanding bulan Maret, terdapat penurunan BOR sebesar 1,5%. Hal ini sejalan dengan penurunan jumlah pasien rawat inap yang masuk dari IGD. Penurunan jumlah pasien rawat inap dari IGD disebabkan karena adanya kondisi libur Idul Fitri yang menyebabkan pasien enggan untuk ke rumah sakit di momentum tersebut. Kejadian ini sudah menjadi tren dan juga terjadi di tahun 2023, dimana akan terjadi penurunan jumlah pasien saat Idul Fitri.

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan adalah meningkatkan kinerja semua unit agar semua pasien merasa puas dan meminimalisir complain sehingga pasien tersebut tetap memilih RS Prima Husada Malang.

3.1.4 Terkait BPJS Kesehatan



NO	KETERANGAN	BULAN			
	Waktu Rata-Rata	Jan 2024	Feb 2024	Maret 2024	April 2024
1	Total Waktu Layanan	02.04.53	02.16.59	02.25.23	02.25.44
2	Waktu Tunggu Admisi	00.18.13	00.14.35	00.23.18	00.13.51
3	Waktu Layanan Admisi	00.08.01	00.05.38	00.13.19	00.12.01
4	Waktu Tunggu Poli	00.57.33	01.03.08	00.54.20	00.59.19
5	Waktu Layanan Poli	00.19.11	00.14.49	00.15.46	00.15.57
6	Waktu Tunggu Farmasi	00.11.55	00.15.24	00.21.43	00.20.10
7	Waktu Layanan Farmasi	00.43.35	00.52.15	01.02.57	01.00.20

Analisis :

Pada bulan April 2024, total waktu layanan tidak jauh berbeda dengan bulan Maret 2024. Peningkatan ada di waktu tunggu poli namun terdapat perbaikan pada waktu tunggu admisi.

Untuk waktu layanan farmasi masih tidak jauh berbeda dengan bulan Maret 2024. Hal ini dikarenakan masih tidak tertib untuk klik obat selesai pada system oleh staf unit farmasi. Waktu tunggu poli yang sedikit bertambah disebabkan oleh penumpukan pasien pada hari-hari tertentu akibat Libur Hari Raya.

Plan	Menyampaikan hasil evaluasi ke unit
Do	Koordinasi dengan unit terkait dan factor yang mempengaruhi.
Study	Data rekap lima bulan yang menjadi acuan dalam perbandingan perbaikan.
Action	1. Menghubungi ka unit 2. Monitoring evaluasi 3. Supervisi kabit

NO	JENIS	TARGET	FEB '24	MAR 24	APR 24
1	Sumber antrian melalui mobile JKN	>30%	36.34%	34.86%	Data belum mendapat feedback dari BPJS
2	Capaian pemanfaatan antrian (onsite dan online Mobile JKN)	>90%	96.21%	94.57%	Data belum mendapat feedback dari BPJS

Analisis :

Pemanfaatan antrian online sudah mencapai target yang disyaratkan. Namun pada bulan April belum ada informasi dari pihak BPJS Kesehatan.

Plan	Followup pihak BPJS Kesehatan
Do	Melakukan tindaklanjut sesuai angka yang diberikan oleh BPJS
Study	Data bulan-bulan sebelumnya sebagai acuan dari data yang sudah diperbaiki mulai diperbaiki.
Action	1. Memanfaatkan aplikasi https://dataviz.bpjs-kesehatan.go.id/ untuk monitoring 2. Monitoring evaluasi <i>feedback</i> 3. Supervisi kabit

3.2 Pengembangan Pelayanan RS Prima Husada

NO	UNIT	PENGEMBANGAN PELAYANAN	PROGRESS PENGEMBANGAN	KENDALA
BIDANG PELAYANAN DAN KEPERAWATAN				
1	IRNA	Bimbingan Doa pada pasien IRNA	Sudah berjalan rutin 1 minggu 3x. Sudah ada SOP	Kendala pengembangan ini jika di ruangan crowded tidak ada yang menemani pendampingan doa
2	IRNA	Senam hamil dan hypnobirthing	Untuk senam hamil sudah berjalan tetapi untuk hynobithing belum berjalan	Hypnobirthing belum berjalan karena terkendala jumlah SDM yang kurang
3	IRNA	Foto bayi	Sudah berjalan dengan baik, respon keluarga pasien juga baik	-
4	IRJA	Poli Eksekutif	Progress 80%. DPJP sudah ready	Masih menunggu kesiapan dan kelengkapan sarana-prasarana poli
5	IGD	Pemutaran Edukasi Triase di IGD	Sudah diputar secara berkala	20% pasien masih ada yang belum paham mengenai system triase, hal ini dapat disebabkan karena pasien tidak focus mendengarkan edukasi tentang triase tersebut
BIDANG UMUM DAN KEUANGAN				
1	Humas & Marketing	1. MCU	Bertahap dalam setiap bulan mengunjungi perusahaan untuk deal	1. Belum memiliki kontak seluruh perusahaan 2. Kunjungan belum rutin 3. Tarif MCU masih tinggi dibanding kompetitor
		2. Digital Marketing	Upgrading jenis konten setiap bulan	Belum ada skill khusus tentang digital marketing
2	SDM	1. Konseling	Sudah dilakukan namun belum rutin sesuai target	Waktu pelaksanaan masih

				bertabrakan dengan pekerjaan lain
		2. Supervisi	Sudah dilakukan namun belum rutin sesuai target	Belum dijadwalkan rutin
		3. Penegakan Tata Tertib	Sudah dilakukan namun belum rutin sesuai target	Waktu pelaksanaan masih bertabrakan dengan pekerjaan lain (penyesuaian SDM baru)
3	CS	1. Penambahan trolley kerja Cleaning Service	Belum terealisasi	Di pengadaan
		2. Pengajuan ruang penyimpanan matras tiap area	Belum terealisasi	Untuk tempat belum di tentukan
		3. Pengajuan bursak matras yang tidak layak dan potong menjadi 1 ukuran	Belum terealisasi	Sudah di sampaikan tapi tidak segera di TL oleh pengadaan
		4. Pengajuan ruang penyimpanan inventaris hall (kursi,meja,taplak,sarung kursi)	Belum terealisasi	Masih di tentukan untuk tempat
		5. Pengajuan alat pembersih kaca magnet	Belum terealisasi	Masih di ajukan
		6. Penambahan tong sampah non medis	Belum terealisasi	Masih di ajukan untuk penambahan
4	Security	1. Penertiban Jam Berkunjung Pasien	Terealisasi dengan adanya tambahan personel memudahkan untuk patrol dan adanya pengumuman dengan rekaman suara	Anak-anak dibawah usia 12 tahun masih ada yang masuk ke ruang irna karena alasan tertentu
		2. Kartu Tanda Penunggu Pasien	Sudah diajukan	Dalam proses. Tidak ada kendala
5	IT SIMRS	1. Peremajaan Komputer di Unit	Sudah dilakukan bertahap	Tidak ada kendala. Menunggu instruksi pengadaan
		2. Instalasi ruang server baru dan server backup	Sudah dilakukan bertahap	Akan mengganggu internet dan SIMRS pelayanan
BIDANG PENUNJANG				
1	Depo	1. Website Primantara	Proses	Dalam proses

	Farmasi		penyelesaian oleh Programmer PT	
		2. Open Recruitmen Admin Primantara	Proses dibuatkan ABK oleh Kains Farmasi	Dalam proses
		3. TTD elektronik semua pasien rawat jalan, baik pasien IGD maupun rawat inap	Follow up programmer	Menunggu programmer
		4. Fitur Iterisasi pada SIMRS	Fitur sudah tersedia di SIMRS, SPO sudah dibuatkan.	Proses koreksi oleh Dir RS. Belum disosialisasikan
2	Gudang Farmasi	1. Repack sediaan farmasi sharing dose	1. Sudah pengajuan barang penunjang yang dibutuhkan 2. Proses pengajuan Lemari Asam 3. Proses pengajuan tarif repack sesuai list	Belum dijalankan Menunggu barang penunjang datang seluruhnya
3	Rekam Medis	Mengaplikasikan E-RM (IRJA dan IRNA)	Sudah terealisasi E-RM Rawat Jalan IGD dan IRJA. Rehab sudah berjalan mulai tanggal 01-05-2024. IRNA dalam proses memasukan form kedalam aplikasi SIMRS.	Kurang sinkron antara fitur perawat dan rekam medis, seperti : TTD tidak terisi, belum muncul pengkajian fisioterapis di fitur rekam medis.
4	Radiologi	Menambahkan fitur hasil radiologi di SIMRS supaya hasil radiograf dapat diakses	Sudah dirapatkan dengan Programmer untuk dibuatkan fitur tersendiri.	Dalam antrian programmer
5	Laboratorium	1. Pengadaan LIS	1. Hardware sudah terpasang di Laboratorium. 2. Software proses dikerjakan oleh Programmer dan Vendor.	Dalam proses
		Pengadaan BDRS	Masuk kedalam proker	Follow up Direksi PT
6	Gizi	1. Pengaktifan Poli Gizi di Rawat Jalan	Kolaborasi dengan Humas&Marketing	Monitoring dan evaluasi setiap bulan
		2. MCU Gizi	Rencana diajukan review tarif ke	Dalam Proses

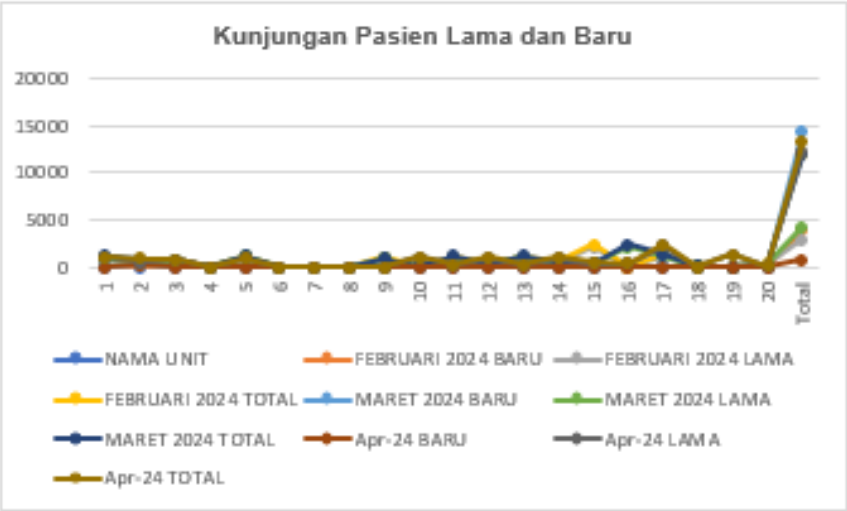
			Keuangan PT	
7	CSSD	Mengajukan mesin sterilikator	Belum terealisasi	Monitoring dan evaluasi permintaan sterilisasi alat semi critical
8	Laundry	Mengajukan mesin cuci industry dengan kapasitas 30kg	Belum terealisasi	Monitoring dan evaluasi penggunaan mesin cuci industry utama

3.3 Kinerja Bidang Pelayanan

3.3.1 Rawat Jalan Poliklinik

3.3.1.1 Kunjungan Pasien Lama dan Baru

NO	NAMA UNIT	FEBRUARI 2024			MARET 2024			APRIL 2024		
		BARU	LAMA	TOTAL	BARU	LAMA	TOTAL	BARU	LAMA	TOTAL
1	Klinik Anak	180	905	1085	204	999	1203	76	1095	1171
2	IGD	212	414	616	269	588	857	317	599	916
3	Klinik Bedah	155	658	813	132	652	784	48	786	834
4	Klinik Bedah Plastik	11	11	22	8	5	13	1	20	21
5	Klinik Fisioterapi	96	954	1050	88	1191	1279	4	1027	1031
6	Klinik Gigi Periodonti	12	5	17	19	20	39	3	16	19
7	Klinik Gigi Spesialis	10	8	18	2	1	3	8	13	21
8	Klinik Ibu dan Anak	38	0	38	13	1	14	0	0	0
9	Klinik Jantung	76	1030	1106	64	954	1018	1	13	14
10	Klinik Jiwa	18	192	210	16	204	220	15	1074	1089
11	Klinik Kandungan	194	963	1157	202	999	1201	7	261	268
12	Klinik Kulit dan Kelamin	111	315	426	120	316	436	104	965	1069
13	Klinik Mata	119	955	1074	146	1080	1226	37	306	343
14	Klinik Orthopedi	99	442	541	95	411	506	48	1010	1058
15	Klinik Paru	241	2239	2480	49	380	429	15	505	520
16	Klinik Penyakit Dalam	1	0	1	234	2191	2425	14	481	495
17	Klinik Syaraf	125	1193	1318	154	1284	1438	48	2369	2417
18	Klinik THT	112	110	222	92	126	218	0	0	0
19	Klinik Umum	33	4	37	16	2	18	32	1315	1347
20	Klinik Urologi	96	301	397	81	280	361	55	158	213
Total		3958	2990	12058	14287	4334	11954	900	12358	13258



Analisis :

- 1. Kunjungan di Bulan April menurun dari bulan sebelumnya, sebanyak 5,6% dari bulan Maret. Jumlah penurunan ini di mulai dari bulan februari karena bulan april ini di karenakan banyak kendala.
- 2. Jumlah pasien terbanyak ada di Poli penyakit dalam sebanyak 2417 pasien. Kunjungan tersebut menurun dari bulan sebelumnya sebanyak 2425 pasien, karena dokter penyakit dalam libur lebaran 1 minggu.
- 3. Kunjungan terendah adalah klinik gigi spesialis drg Bhakti, SpORT. Karena selama ramadhan dan lebaran, pasien meminta reservasi untuk kontrol setelah lebaran. Dan spesialis ortodonti hanya melayani pasien umum dan asuransi saja.

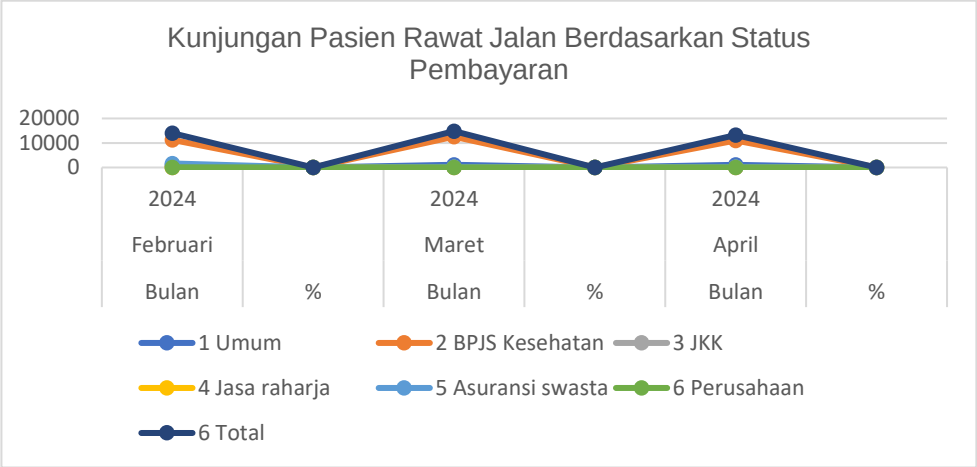
Rencana Tindak Lanjut :

- 1. Membuat video edukasi dengan tujuan menjelaskan terkait penyakit sekaligus manfaat perawatan gigi selama bulan puasa dan lebaran
- 2. Koordinasi dengan PKRS agar diupload di sosial media
- 3. Koordinasi dengan Humas dan Marketing untuk materi menarik pangsa pasar Poli utamanya poli eksekutif dan Klinik Ortodonti
- 4. Sosialisasi pada komunitas pasien geriatri maupun prolanis klinik MS, bahwa ada dokter gigi ortodonti, yang bisa melayani pasien umum dan asuransi

3.3.1.2 Kunjungan Pasien Rawat Jalan Berdasarkan Status Pembayaran

NO	STATUS PEMBAYARAN	BULAN FEBRUARI 2024	%	BULAN MARET 2024	%	BULAN APRIL 2024	%
1	Umum	988	7,04%	1109	7,4%	1098	8,1%
2	BPJS Kesehatan	11221	80,04%	12556	84,59 %	10970	82,47%
3	JKK	71	0,50%	95	0,64%	95	0,7%
4	Jasa raharja	7	0,04%	16	0,01%	17	0,01%
5	Asuransi swasta	1646	11,74%	178	1,19%	136	1,02%
6	Perusahaan	85	0,64%	28	0,18%	34	0,20%
	Total	14018	100%	14843	100%	13266	100%

3.3.1.2.1 Grafik Kunjungan Pasien Rawat Jalan Berdasarkan Status Pembayaran



Analisis :
Kunjungan pasien bulan April 2024 berdasarkan cara pembayaran menurun dari bulan Februari sebesar 5,6%. Kunjungan terbanyak adalah pasien dengan penjamin BPJS Kesehatan sebesar 89,02%. Kunjungan terendah adalah Pasien Jasa Raharja sebesar 0,05%

Rencana Tindak Lanjut :
Untuk meningkatkan kunjungan pasien jasa raharja, koordinasi dengan humas dan marketing untuk Kerjasama dengan pihak jasa marga dan polisi, sehingga jika ada KLL, RS rujukan pertama adalah RS Prima Husada

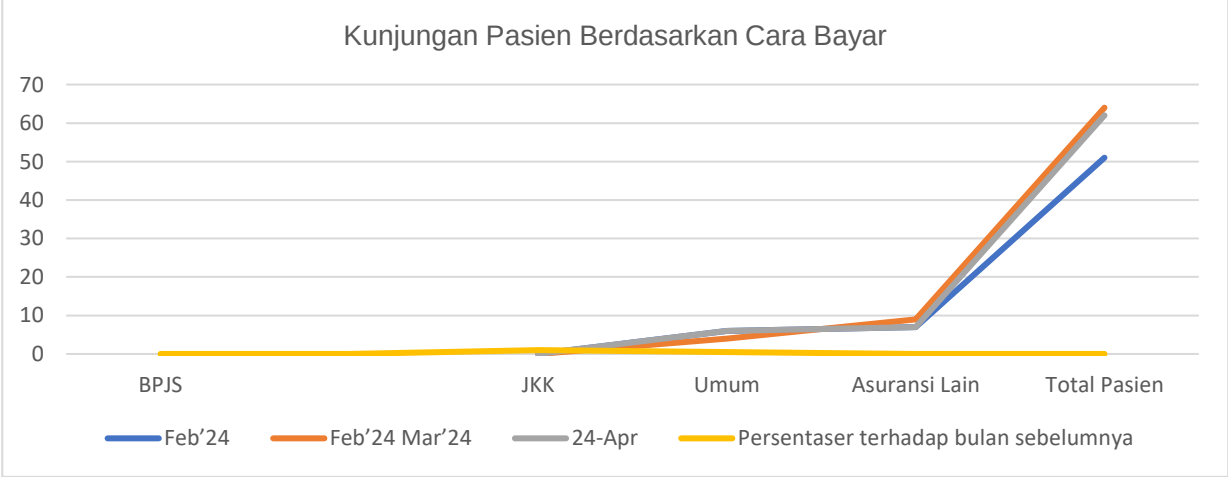
3.3.2 Rawat Inap

3.3.2.1 Kunjungan Rawat Inap 2C

3.3.2.1.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Februari –Maret 2024)

NO	HAL	FEBRUARI 2024	MARET 2024	APRIL 2024	PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA
1	BPJS	38	51	49	↓3,92%
2	JKK	0	0	0	100%
3	Umum	6	4	6	↑ 50%
4	Asuransi Lain	7	9	7	↓22,22%
Total Pasien		51	64	62	0,049%

3.3.2.1.2 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Februari-Maret 2024)



3.3.2.1.3 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

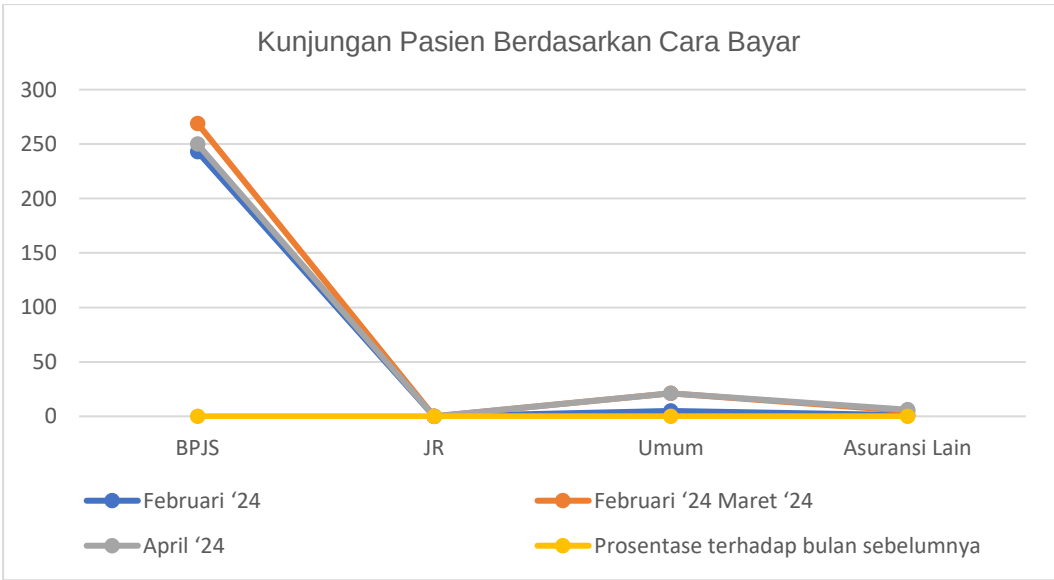
NO.	BULAN	RAWAT INAP				TOTAL PASIEN
		BPJS	UMUM	JKK	JR/ASURANSI	
1	APRIL 2024	49	6	0	7	62
	Analisa	Pasien BPJS dalam	Pasien umum mengalami peningkatan meskipun sedikit	Pasien JKK kosong dibulan April	Untuk pasien asuransi mengalami penurunan yang signifikan di bulan April	Total pasien bulan April mengalami penurunan dari bulan Maret
	RTL	Meningkatkan capaian dengan memperbaiki alur proses naik kelas ke VIP/VVIP yg dilakukan di awal pendaftaran, memperbaiki sarana prasarana VIP/VVIP dengan memberikan fasilitas tambahan seperti paket alat, mandi, baju pasien khusus VIP/VVIP dan meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada pasien dan keluarga mengenai kelanjutan perawatan pasca rawat inap				

3.3.2.2 Kunjungan Rawat Inap 3C Anak

3.3.2.2.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Februari-Maret 2024)

NO	HAL	FEBRUARI 2024	MARET 2024	APRIL 2024	PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA
1	BPJS	243	269	250	↓7,6%
2	JR	0	0	0	0%
3	Umum	5	21	21	0%
4	Asuransi Lain	1	5	6	↑17%
Total Pasien		3	295	278	6%

3.3.2.2.2 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Februari-Maret 2024)



3.3.2.2.3 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

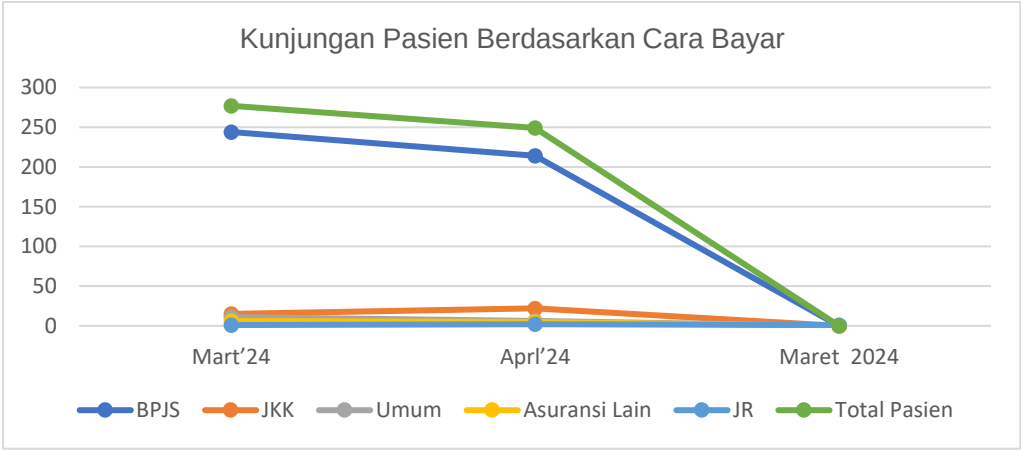
NO.	BULAN	RAWAT INAP				TOTAL PASIEN
		BPJS	UMUM	JKK	JR/ASURANSI	
1	Analisis	Pasien BPJS mengalami penurunan 7,6% di bulan April, dikarenakan DPJP sudah mulai mehami alur yng berlaku dan dikarenakan cuaca yang tidak menentu banyak anak2 sakit serta banyak penderita DBD	Untuk pasien Umum di bulan April sama denga di bulan sebelumnya dikarenakan kebanyakan pasien sudah memiliki BPJS	Untuk pasien JKK tidak ada	Untuk pasien Asuransi lain masih sama dengan bulan sebelumnya dikarenakan kebanyakan orang tidak punya asuransi dan mereka memilih untuk memakai BPJS dan terjadi banyak KLL	Total keseluruhan ada 278 pasien
	RTL	Pasien BPJS mengalami penurunan 7,6% di bulan April, dikarenakan DPJP sudah mulai mehami alur yng berlaku dan dikarenakan cuaca yang tidak menentu banyak anak2 sakit serta banyak penderita DBD				

3.3.2.3 Kunjungan Rawat Inap 2,3,4 A

3.3.2.3.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Februari-Maret 2024)

NO	HAL	FEBRUARI 2024	MARET 2024	APRIL 2024
1	BPJS	244	↓ 12,2 %	214
2	JKK	15	↑ 46,6 %	22
3	Umum	11	↓ 45,4 %	6
4	Asuransi Lain	6	↓ 16,6 %	5
5	JR	1	↑ 100 %	2
Total Pasien		277	↓ 10,1 %	249

3.3.2.3.2 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Februari-April 2024)



3.3.2.3.3 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

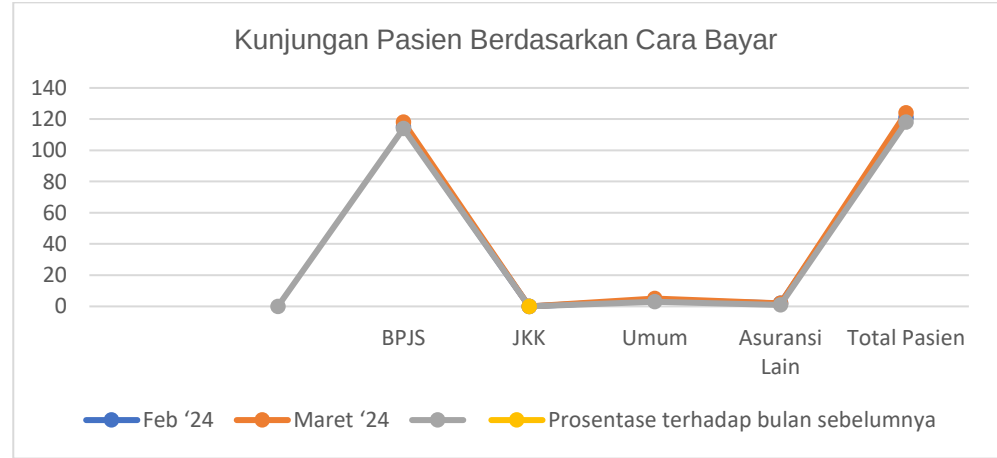
NO.	BULAN	RAWAT INAP				TOTAL PASIEN
		BPJS	UMUM	JKK	JR/ASURANSI	
1	Analisis capaian April 2024	Pasien BPJS mengalami penurunan pada bulan April 2024 yaitu sebanyak 214 pasien	Pasien Umum mengalami penurunan pada bulan April 2024 yaitu sebanyak 6 pasien	Pasien JKK mengalami peningkatan pada bulan April 2024 yaitu sebanyak 22 pasien	Pasien Asuransi mengalami Penurunan pada bulan April yaitu sebanyak 5 pasien , dan Pasien JR mengalami peningkatan pada bulan April 2024 yaitu sebanyak 2 pasien	Penurunan jumlah pasien terjadi di bulan April 2024 dengan jumlah pasien sebanyak 249 pasien.
	RTL	Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target setiap bulannya				

3.3.2.4 Kunjungan Rawat Inap 5C

3.3.2.4.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Februari-Maret 2024)

NO	HAL	FEBRUARI 2024	MARET 2024	APRIL 2024	PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA
1	BPJS	115	118	114	↓ 3,3%
2	JKK	0	0	0	0
3	Umum	4	5	3	↓ 40%
4	Asuransi Lain	2	2	1	↓ 50%
Total Pasien		121	124	118	↓ 4,8%

3.3.2.4.2 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Februari-Maret 2024)



3.3.2.4.3 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

NO.	BULAN	RAWAT INAP				KESIMPULAN
		BPJS	UMUM	JKK	JR/ASURANSI	
1	Analisis capaian	Pasien BPJS mengalami	Pasien Umum	Tidak ada pasien JKK	Pasien Asuransi / JR mengalami	Pada bulan April untuk kunjungan

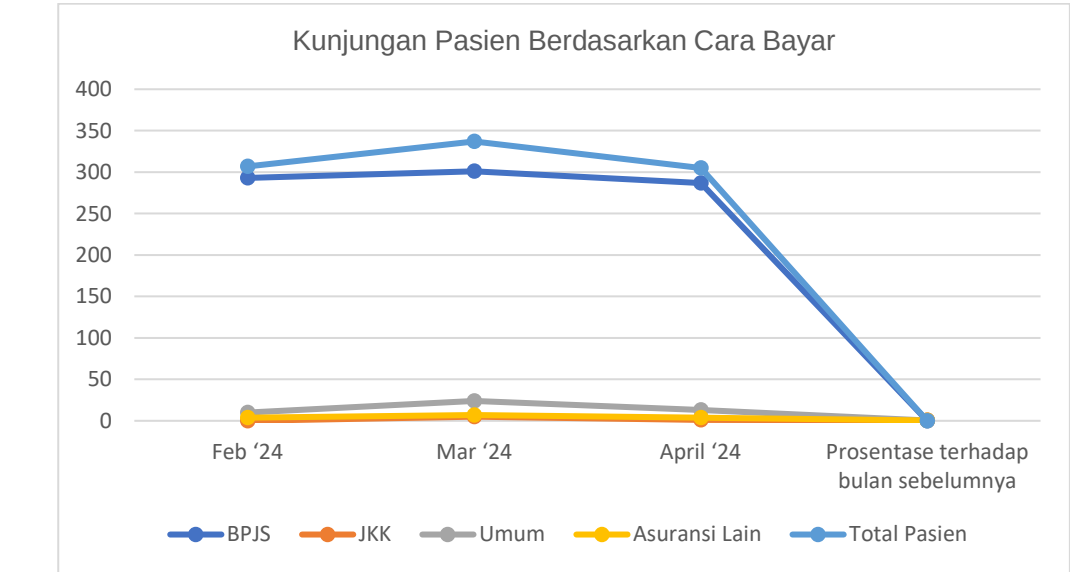
	April	penurunan sebanyak 3,3% dari bulan sebelumnya	mengalami penurunan sebanyak 40 % dari bulan sebelumnya	pada bulan April	penurunan sebanyak 50% dari bulan sebelumnya	pasien mengalami penurunan dari bulan sebelumnya yaitu sebesar 4,8%
	RTL	Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target setiap bulannya				

3.3.2.5 Kunjungan Rawat Inap 6, 7, 8 A

3.3.2.5.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Februari-Maret 2024)

NO	HAL	FEBRUARI 2024	MARET 2024	APRIL 2024	PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA
1	BPJS	293	301	287	↓4.6%
2	JKK	0	5	1	↓80%
3	Umum	10	24	13	↓45%
4	Asuransi Lain	4	7	4	↓42%
Total Pasien		307	337	305	↓9,4%

3.3.2.5.2 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Februari-Maret 2024)



3.3.2.5.3 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

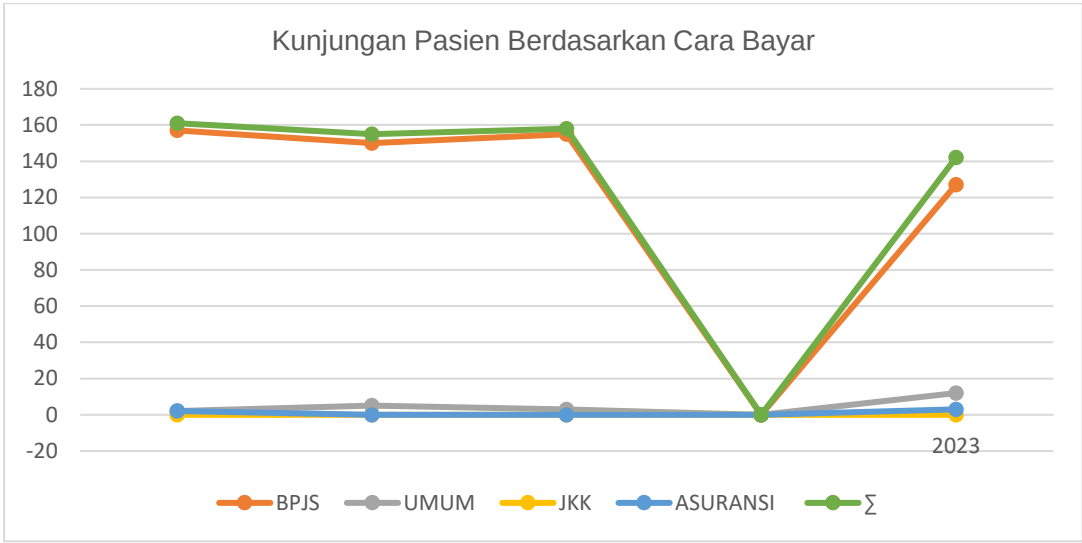
NO.	BULAN	RAWAT INAP				KESIMPULAN
		BPJS	UMUM	JKK	JR/ASURANSI	
1	Analisis capaian 3 bulan terakhir	Pasien BPJS mengalami peningkatan terbanyak selama 3 bulan terakhir pada bulan Maret 2024 yaitu sebanyak 301 pasien	Pasien Umum mengalami peningkatan terbanyak selama 3 bulan terakhir pada bulan Maret 2024 yaitu sebanyak 24 pasien	Pasien JKK mengalami peningkatan terbanyak selama 3 bulan terakhir pada bulan Maret 2024 yaitu sebanyak 5 pasien	Pasien Asuransi / JR mengalami peningkatan terbanyak selama 3 bulan terakhir pada bulan Maret 2024 yaitu sebanyak 7 pasien	Peningkatan jumlah pasien selama 3 bulan terakhir banyak terjadi di bulan Maret 2024 dengan jumlah pasien sebanyak 337 pasien.
	RTL	Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target setiap bulannya				

3.3.2.6 Kunjungan Rawat Inap Maternitas

3.3.2.6.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Februari-Maret 2024)

NO	HAL	FEBRUARI 2024	MARET 2024	APRIL 2024	PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA
1	BPJS	157	150	155	3,18%
2	Umum	2	5	3	-1%
3	JKK	0	0	0	0%
4	Asuransi	2	0	0	0%
Total Pasien		161	155	158	1,86%

3.3.2.6.2 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Februari – Maret 2024)



3.3.2.6.3 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

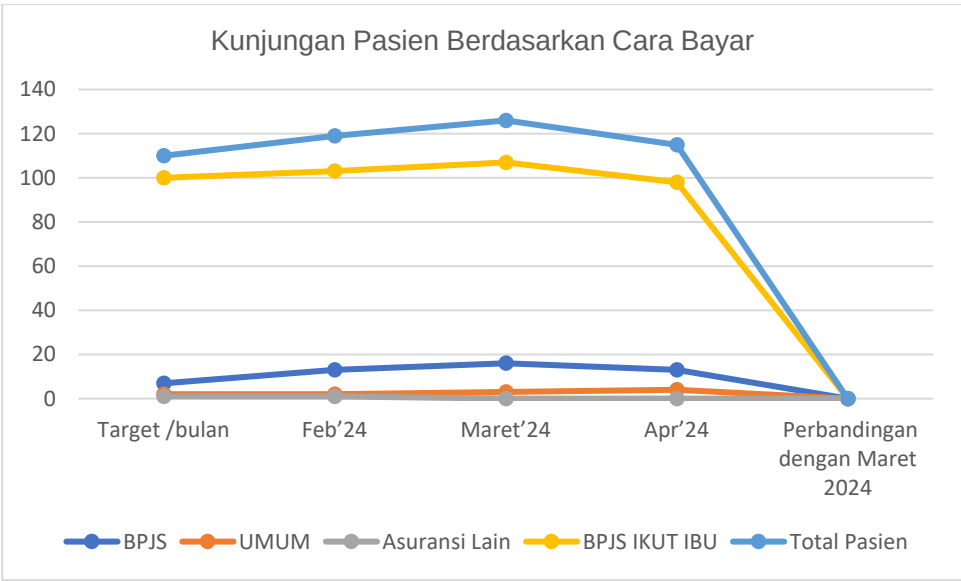
NO.	BULAN	RAWAT INAP				KESIMPULAN
		BPJS	UMUM	JKK	JR/ASURANSI	
1	Analisis capaian Feb-April	Pasien BPJS pada bulan april mengalami peningkatan 3,18%.	Pasien umum pada bulan april mengalami penurunan - 1%	Tidak ada pasien JKK april	Tidak ada pasien asuransi di bulan april	Kunjungan mengalami penurunan dengan bulan sebelumnya. Perlu Upaya peningkatan dan evaluasi program telusur sederhana
2	RTL	Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target disetiap bulan	Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target disetiap bulan	Bekerjasama dengan IGD untuk promosi kesehatan	Meningkatkan pelayanan serta koordinasi dengan tim IGD	

3.3.2.7 Kunjungan Rawat Inap Neonatologi

3.3.2.7.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Februari-Maret 2024)

NO	HAL	TARGET/BULAN	FEBRUARI 2024	MARET 2024	APRIL 2024	PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA
1	BPJS	7	13	16	13	↓2,4%
2	Umum	2	2	3	4	↑1%
3	Asuransi Lain	1	1	0	0	0
4	BPJS IKUT IBU	100	103	107	98	↓7,8%
Total Pasien		110	119	126	115	↓9,6%

3.3.2.7.2 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Februari-Maret 2024)



3.3.2.7.3 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

NO.	BULAN	RAWAT INAP					KESIMPULAN
		BPJS	UMUM	JKK	ASURANSI	BPJS IKUT IBU	
1	April 2024	13	4	0	98	April 2024	115
2	Analisa	Pasien BPJS mengalami penurunan dari bulan sebelumnya sebanyak 2,4%	Untuk pasien Umum kenaikan bulan sebelumnya sebanyak 1%	Tidak ada pasien asuransi	Pasien BPJS Ikut Ibu mengalami penurunan 7,8%	Analisa	

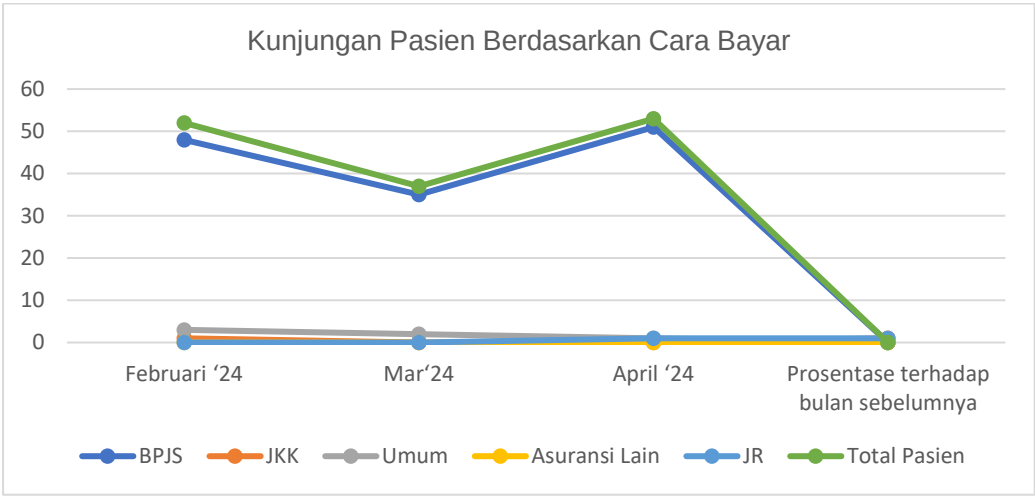
3.3.3 Intensive Care Unit (ICU)

3.3.3.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Februari-Maret 2024)

NO	HAL	FEBRUARI 2024	MARET 2024	APRIL 2024	PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA
1	BPJS	48	35	51	↑37%
2	JKK	1	0	0	100%
3	Umum	3	2	1	↓50%

4	Asuransi Lain	0	0	0	0
5	JR	0	0	1	100%
Total Pasien		52	37	53	↑40%

3.3.3.2 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Februari-Maret 2024)



3.3.3.3 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

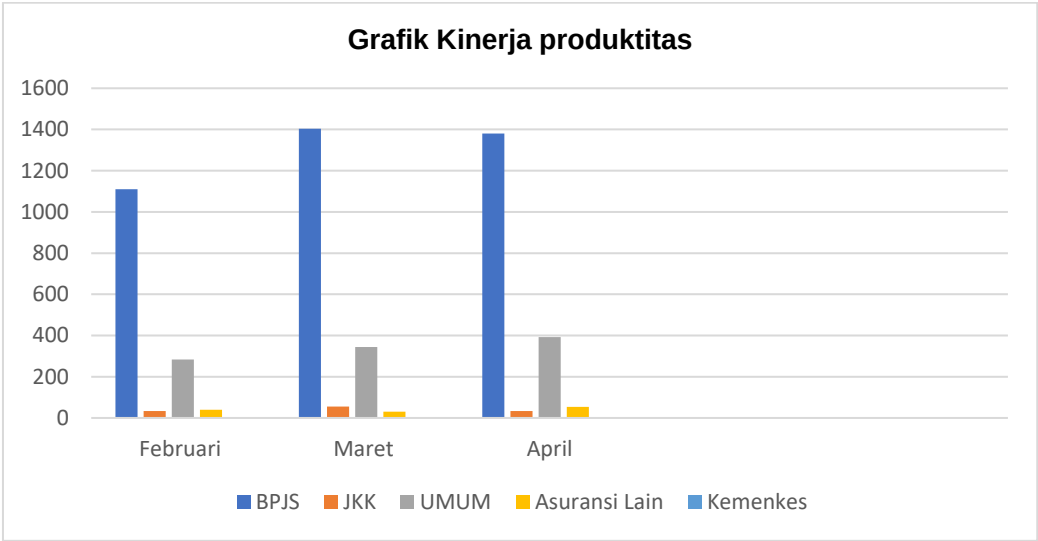
NO.	BULAN	RAWAT INAP				KESIMPULAN
		BPJS	UMUM	JKK	JR/ASURANSI	
1	Analisis capaian Desember	Pasien BPJS pada bulan April 2024 mengalami peningkatan sebanyak 37%	Untuk bulan April 2024 pasien umum mengalami Penurunan sebanyak 50%	Tidak ada pasien JKK di bulan April 2024	ada pasien pada 1 pasien di bulan April 2024	Pada bulan April utk pasien BPJS, Umum dan asuransi lain mengalami Peningkatan sebesar 40%
2	RTL					

3.3.4 Instalasi Gawat Darurat (IGD)

3.3.4.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Februari-Maret 2024)

NO	HAL	FEBRUARI 2024	MARET 2024	APRIL 2024	PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA
1	BPJS	1.110	1.404	1.383	↓1,5%
2	JKK	33	56	34	↓64,7%
3	Umum	283	343	393	↑12,72%
4	Asuransi Lain	36	27	46	↑41,30%
5	JR	3	4	7	↑42,85%
Total Pasien		1.465	1.834	1.861	↑1,45%

3.3.4.2 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Februari-Maret 2024)



Analisis :
Berdasarkan grafik diatas, terdapat peningkatan kunjungan pasien dari bulan Maret ke April pada pasien dengan jaminan BPJS meningkat 21 (↑1,5%), jaminan JKK mengalami penurunan seebanyak 22 (↓64,7%), jaminan UMUM meningkat 50 (↑12,72%), Asuransi lain mengalami peningkatan 22 (↑41,50%) , secara total terdapat peningkatan 27 (↑1,45%).

Rencana Tindak Lanjut :
Meningkatkan capaian kunjungan IGD dengan memperbaiki pelayanan yang prima dan maksimal, serta bekerjasama dengan pihak marketing untuk memperluas kerjasama dengan faskes 1 dan beberapa perusahaan serta asuransi swasta terutama yang di area Kabupaten Malang

3.3.4.3 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

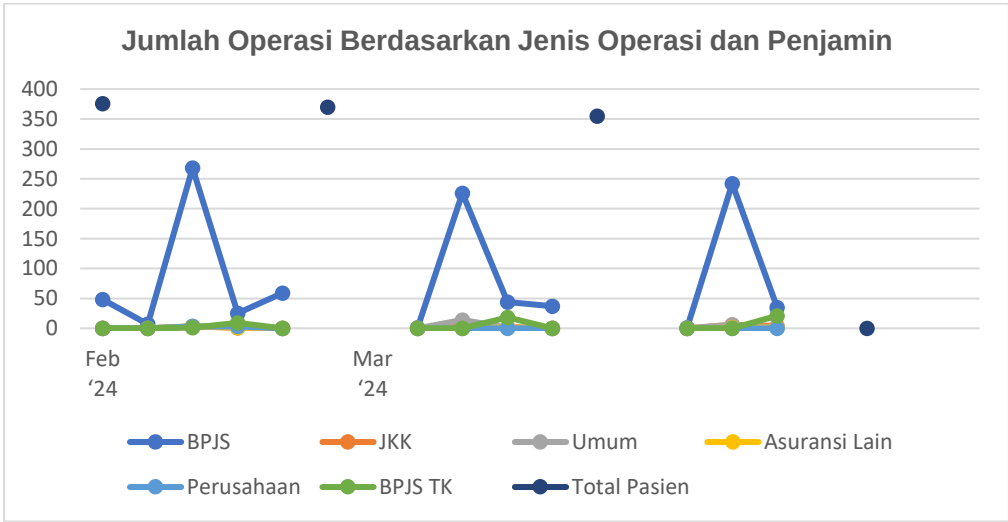
NO.	BULAN APRIL	RAWAT INAP				TOTAL PASIEN
		BPJS	UMUM	JKK	JR/ASURANSI	
1	Analisis	Kunjungan pasien BPJS dari bulan Maret ke April mengalami penurunan 21 (↓1,5%)	njungan pasien UMUM dari bulan Maret ke April Mengalami peningkatan 50 (↑12,72%)	Kunjungan pasien dengan jaminan JKK dari bulan Maret ke April mengalami penurunan 22 (↓64,7%)	Kunjungan pasien dengan jaminan Asuransi lain dari bulan Maret ke April mengalami peningkatan 22 (↑41,50%)	tal kunjungan pasien IGD semua jaminan dari bulan Maret ke April meningkat 27 (↑1,45%)
2	RTL	Meningkatkan capaian kunjungan jaminan pasien BPJS IGD bekerjasama dengan marketing untuk menambah kerja sama dengan beberapa faskes l area kabupaten Malang	Meningkatka n capaian kunjungan IGD dengan jaminan UMUM dengan memberikan pelayanan kesehatan yang prima dan maksimal	Meningkatka n capaian kunjungan IGD jaminan JKK dengan berkoordinasi dan bekerjasama dengan marketing untuk memperluas kerjasama dengan beberapa Perusahaan Kabupaten Malang	Meningkatkan capaian kunjungan jaminan Asuransi swasta IGD bekerjasama dengan marketing untuk memperluas kerjasama dengan perusahaan asuransi	Meningkatkan capaian kunjungan IGD dengan memperbaiki pelayanan dan bekerjasama dengan pihak terkait (marketing, asuransi centre)

3.3.5 Instalasi Kamar Operasi (IKO)

3.3.5.1 Jumlah Operasi Berdasarkan Jenis Operasi dan Penjamin
(Februari -Maret 2024

NO	HAL	FEBRUARI 2024				MARET 2024				APRIL 2024				PROSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA
		k	s	b	kh	k	s	b	kh	k	s	b	kh	
1	BPJS	48	7	26	25	5	1	22	44	3	1	242	35	
2	JKK	0	0	3	1	0	0	4	2	0	0	6	4	
3	Umum	0	0	3	1	0	0	14	1	0	0	6	1	
4	Asuransi Lain	0	0	3	1	0	0	0	1	0	0	1	1	
5	Perusahaan	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	BPJS TK	0	0	1	9	0	0	0	18	0	0	0	21	
	Total Pasien	376				370				355				4,6%

3.3.5.2 Grafik Jumlah Operasi Berdasarkan Jenis Operasi dan Penjamin (Februari-Maret 2024)



3.3.5.3 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

NO.	BULAN	IKO					KESIMPULAN
		BPJS	BPJS TK	UMUM	JKK	JR/ASURANSI	
1	Analisis capaian 3 bulan terakhir	Pasien BPJS mengalami penurunan 3 bulan terakhir	Pasien BPJS TK mengalami kenaikan dari bulan februari ke april 2024	Pasien Umum naik turun 3 bulan terakhir belum ada kenaikan yang secara stabil	Pasien JKK masih belum stabil dan tetap tidak ada kenaikan	Pasien Asuransi / JR mengalami belum stabil selama 3 bulan dan belum ada kenaikan	Selama 3 bulan jumlah operasi yang ada di IKO belum stabil dan tidak ada kenaikan yang signifikan
2	RTL	Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target setiap bulannya dan berkolaborasi dengan IKO					

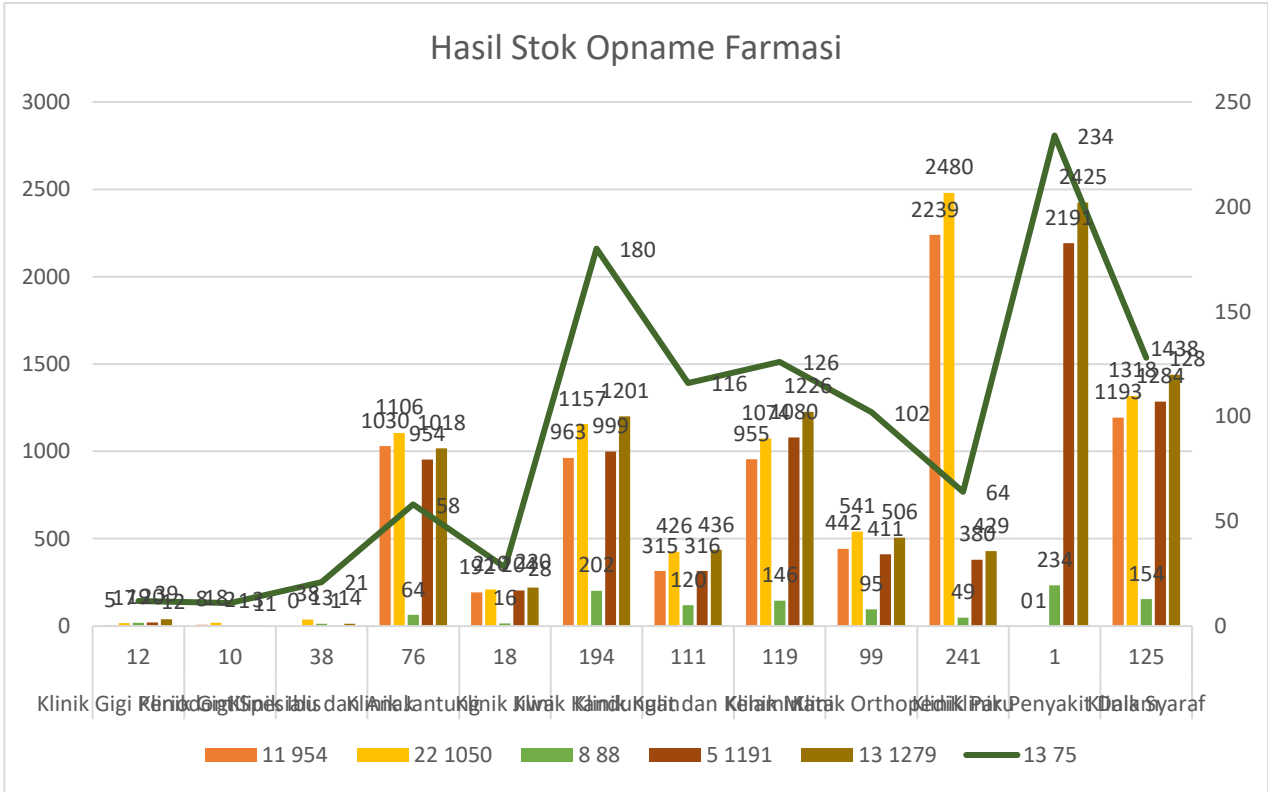
3.4 Kinerja Bidang Penunjang

3.4.1 Instalasi Farmasi

3.4.1.1 Tabel Hasil Stok Opname Instalasi Farmasi Bulan Februari-April 2024

UNIT	STOCK	JUMLAH STOK					
		FEBRUARI 2024		MARET 2024		APRIL 2024	
GUDANG	Sesuai	1118	98,68%	1056	98,88%	1061	98%
	Tidak Sesuai	15	1,32%	12	1,12%	21	2%
	Total	1133	100%	1068	100%	1082	100%
DEPO FARMASI	Sesuai	442	47,37%	385	43,65%	385	43%
	Tidak Sesuai	491	52,63%	497	56,35%	516	57%
	Total	933	100%	882	100%	901	100%
IKO	Sesuai	105	46,26%	84	39,07%	76	36%
	Tidak Sesuai	122	53,74%	131	60,93%	138	64%
	Total	227	100%	215	100%	214	100%
GUDANG RETUR	Sesuai	399	100%	305	97,75%	306	99%
	Tidak Sesuai	0	0	7	2,24%	4	1%
	Total	399	100%	312	100%	310	100%

3.4.1.2 Grafik Hasil Stok Opname Instalasi Farmasi Bulan Februari-April 2024



3.4.1.3 Analisis dan Tindak Lanjut

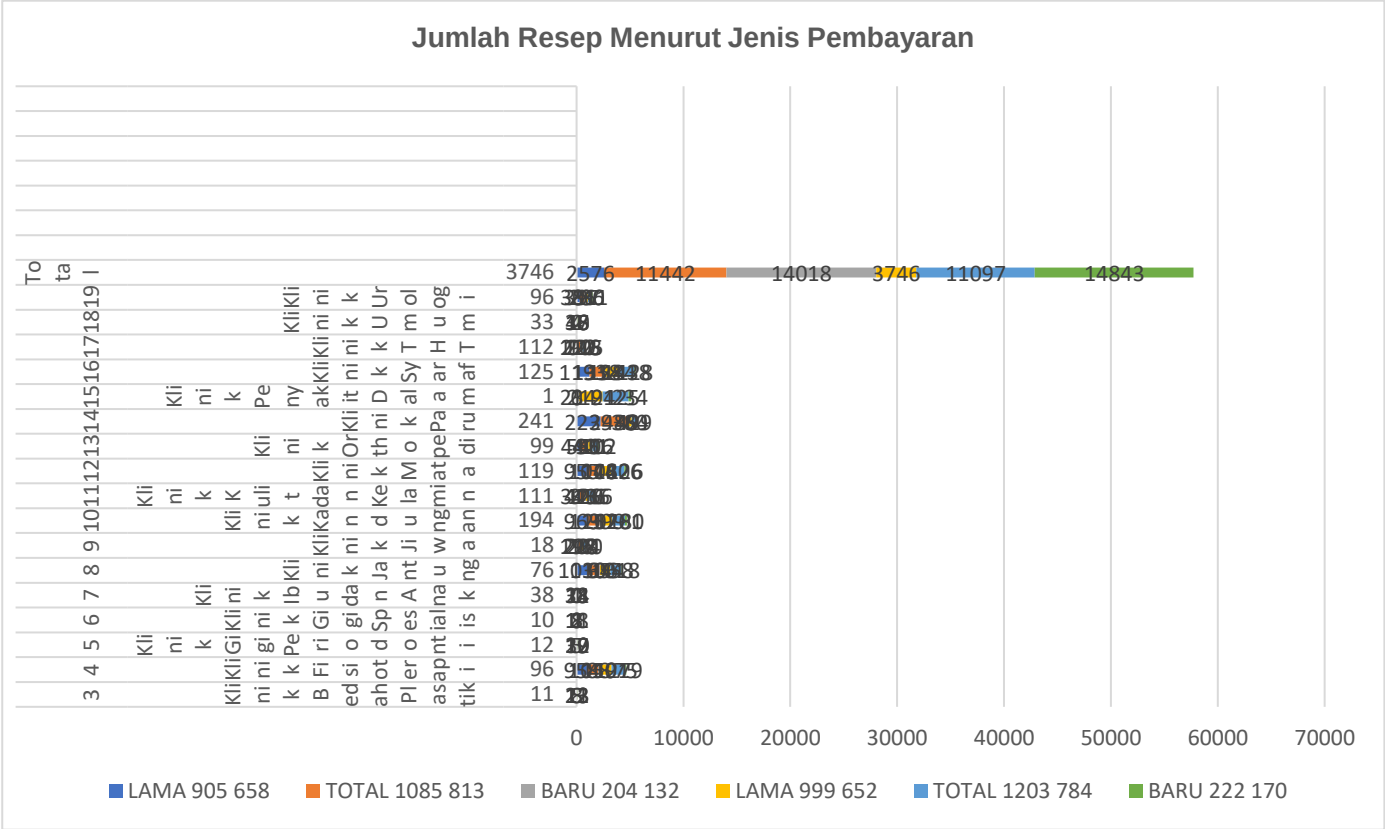
NO.	ANALISA	RENCANA TINDAK LANJUT
1	Dorgibot Tab ED Juni 2024, dengan jumlah stok Depo sebesar 174 Tab.	Barang-barang yang mendekati ED sudah pernah disosialisasikan melalui surat ke DPJP, akan tetapi distribusi barangnya masih slow moving. (Dorbigot tab pengajuan dr. Hari, SP.THT yang sudah resign, maka sounding DPJP THT baru untuk bisa membantu meresepkan).
2	Cairan Ring-As Sanbe 500ml ada double master barang. Pada awalnya master barang F00237 dinonaktifkan kemudian di aktifkan kembali dan muncul stok di Depo dengan jumlah stok sebanyak 265. Padahal jumlah fisiknya 0. Telusur disimrs master F00237 ada mutasi transfer antar unit sebanyak 266 tanggal 5/12/2022 kemudian master dinonaktifkan karena jumlah barang sudah habis dan diaktifkan kembali bulan April oleh pengadaan dengan alasan untuk order barang namun stok disimrs masih ada sedangkan barang belum pernah di order kembali	Penonaktifkan Kembali untuk item barang dengan kode F00237 - Cairan Ring-As Sanbe 500ml, sudah dilakukan penyesuaian jumlah di sistem.
3	Accu Chek Safe-T Pro Uno pada SO sebelumnya tidak di stok di Depo, pada bulan ini dilakukan penjualan ke klinik MS, namun pada saat dibuatkan rak SO muncul stok sistem dengan jumlah 410 padahal fisik 0. Telusur di mutasi simrs release Accu Chek Safe-T Pro dari Gudang sebanyak 1410 tanggal 6/4/2024 namun dilakukan penjualan ke MS sebanyak 1000	Dilakukan penyesuaian stok pada sistem dan membuat berita acara bukti mutasi barang. Pengadaan melakukan penjualan 400 pcs ke MS Lawang
4	Terdapat item barang Elastomull Haft 10cm x 4m dengan jumlah sistem 35, namun jumlah fisiknya 0, Elastomull Haft 12cm x 4m dengan jumlah sistem 0 sementara jumlah fisiknya 46. Petugas salah atau tertukar dalam menghitung dan input SO bulan maret. Setelah dilakukan perhitungan pada pagi hari elastomul haft 10cmx4m sebanyak 7, dan elastomul haft 12cmx4m sebanyak 39)	Dilakukan telusur untuk mengetahui selisih. (meningkatkan ketelitian petugas dalam menghitung alkes dan perbaikan SO selanjutnya, penataan rak, serta membuat BA).
5	Terdapat selisih lebih stok buffer di Depo sebanyak 300 box untuk item barang Asam Traneksamat Tab Generik, sementara di Gudang terdapat selisih kurang sebanyak 400 box.	Meningkatkan ketelitian petugas dalam melakukan serah terima Gudang ke depo sesuai SOP
6	Masih banyak perhitungan yang tidak teliti, misalnya pada rak High Alert dan juga ketidaksesuaian penempatan barang pada rak tertentu.	Ketelitian petugas pada saat perhitungan dan penempatan barang sesuai rak. Perbaikan penataan rak
7	Masih banyak ditemukan ketidaksesuaian jumlah stok dengan jenis barang yang sama dan merk yang berbeda. Contoh asam tranexamat merk HJ / dexta, omeprazole OGB / dexta dan Amoxicillin.	Menghabiskan stok lama untuk dilakukan penyesuaian. Perbaikan penataan rak dan kartu stok
8	Barang Washlap belum memiliki stok di SIMRS, barang menjadi stok depo dan masuk dalam peresepan.	Farmasi sudah melakukan perhitungan washlap dan tertera dilembar kerja sebanyak 233 tetapi oleh PT tidak diinputkan karena dianggap BMHP maka dibuatkan BA
9	Terdapat selisih Jacksoon Rees sebanyak 30 barang padahal fisik ada 3, hal ini disebabkan karena master jacksoon rees yang lama di aktifkan oleh programer/pengadaan F03216 tanpa ada mutasi barang masuk sejak 29/9/2021 di Gudang dan tidak ada mutasi sejak 2021 dan ada mutase transfer antar unit tanggal 5/12/2022 sebanyak 30 pcs ke depo farmasi, sedangkan barang tidak ada karena master yang ada stok sekarang adalah F04133 (1 biji) dan F03413 (2 biji).	Penonaktifkan Kembali untuk item barang dengan kode F03216, sudah dilakukan penyesuaian jumlah di sistem.

10	Korset lumbal Uk XL selisih lebih stok, dilakukan penjualan resep ke pasien BPJS tetapi barang tidak diberikan oleh karena pasien tidak mengambil barang ke farmasi.	SOP dan alur pemberian alkes Lupis pasien BPJS. Penyesuaian data alkes lupis di simrs dan serah terima alkes ke pasien jika tidak diberikan ke pasien wajib di retur ke simrs.
11	Selisih alkes manset tensi anak 2 selang, barang sudah diserahkan tetapi belum direlease Gudang.	SOP serah terima barang dan meningkatkan kepatuhan petugas dalam release barang
12	Selisih benang BENANG MONOCRYL 5-0 MCP493H 70 CM di IKO sejumlah 18 pcs di SIMRS.	Meningkatkan kepatuhan perawat IKO dalam input paket tindakan benang yang digunakan. Penambahan TTK di IKO
13	Penggunaan Sput masih selisih banyak, apakah ada indikasi pemakaian spuit berulang di IKO.	Dilakukan telusur koordinasi dengan kains IKO dan penambahan TTK di IKO.
14	Analisis selisih Sevodex, Vasodrin inj Mahakam dan Isonest karena penggunaan sharing.	Dilakukan evaluasi terkait penggunaan sharing dose. Masuk ke dalam tarif tindakan/ pemakaian menggunakan takaran spuit dan penginputan decimal.

3.4.1.4 Tabel Jumlah Resep Menurut Jenis Pembayaran Februari – April 2024

NO	UNIT	PENJAMIN	BULAN/JENIS RESEP					
			FEBRUARI 2024		MARET 2024		APRIL 2024	
			RACIK	NON RACIK	RACIK	NON RACIK	RACIK	NON RACIK
1.	IRNA	Umum	28	316	32	730	36	689
		BPJS Kesehatan	259	7145	214	7463	212	6316
		BPJS Ketenagakerjaan	0	10	0	0	0	2
		Asuransi Swasta	0	41	2	52	0	75
		Jasaraharja	0	41	2	52	0	75
Total			287	7553	250	8297	248	7157
2.	IRJA	Umum	172	619	209	421	221	418
		BPJS Kesehatan	1735	8011	1784	7865	1778	8581
		BPJS Ketenagakerjaan	0	0	0	0	0	0
		Asuransi Swasta	0	4	0	16	0	15
		Jasaraharja	0	4	0	16	0	15
Total			1907	8638	1993	8318	1999	9029
3.	IGD	Umum	46	290	59	341	88	353
		BPJS Kesehatan	81	1288	161	1461	169	1520
		BPJS Ketenagakerjaan	0	1	0	0	0	1
		Asuransi Swasta	0	11	0	23	0	18
		Jasaraharja	0	11	0	23	0	18
Total			127	1601	220	1848	257	1910
4.	IKO	Umum	0	6	0	19	0	6
		BPJS Kesehatan	0	384	0	384	0	343
		BPJS Ketenagakerjaan	0	0	0	0	0	0
		Asuransi Swasta	0	10	0	14	0	14
		Jasaraharja	0	10	0	14	0	14
Total			0	410	0	431	0	377
Total Resep			2321	18202	2463	18894	2504	18473

3.1.1.1 Grafik Jumlah Resep Menurut Jenis Pembayaran Februari – April 2024



Analisis :

- 1. Total Resep tidak ada perubahan yang signifikan, pelayanan resep di IGD meningkat berbanding lurus dengan peningkatan jumlah kunjungan pasien di IGD.
- 2. Tarikan data pasien BPJS Ketenagakerjaan masih menjadi satu dengan Asuransi Swasta dan Jasaraharja (jika menjadi penjamin pertama), dibuktikan dengan jumlah pasien operasi di IKO sebanyak 21 sedangkan pelayanan resep di IKO tidak ada atau 0.

Rencana Tindak Lanjut :

- 1. Koordinasi dengan Programmer untuk memisahkan data pasien BPJS Ketenagakerjaan dari data pasien Asuransi Swasta supaya mendapatkan data yang valid.

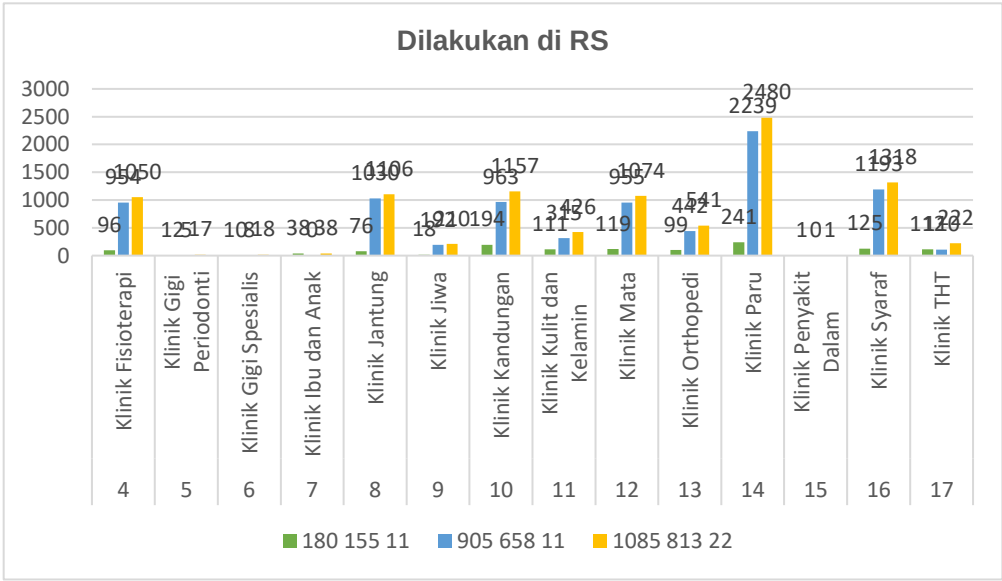
3.1.2 Laboratorium

3.1.2.1 Tabel Daftar Pemeriksaan Laboratorium yang Dilakukan Didalam dan Diluar Februari-April 2024

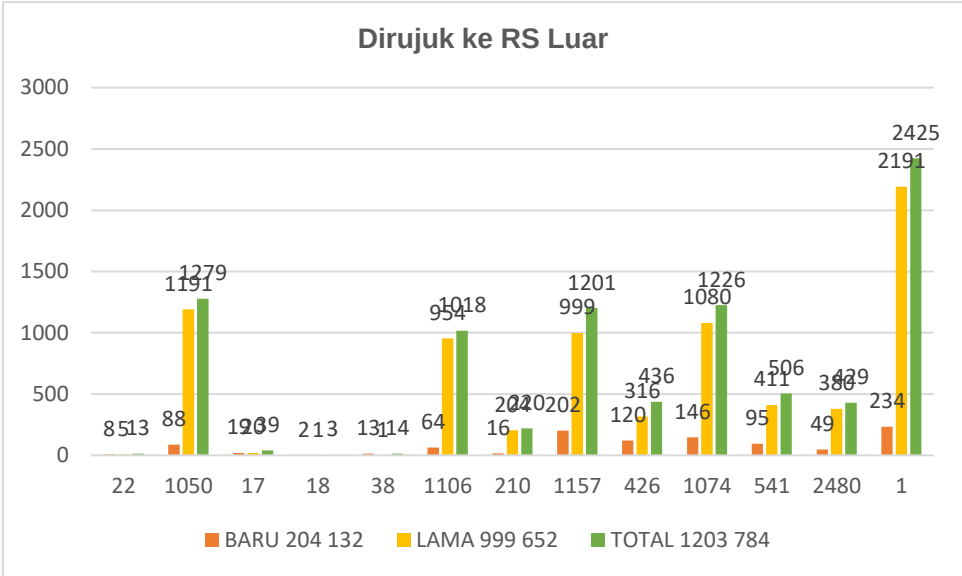
NO	JENIS PEMERIKSAAN	FEBRUARI 2024	MARET 2024	APRIL 2024
Dilakukan di RS				
1	Patologi Klinik			
	Kimia darah	4931	5059	4965
	Hematologi	2377	2799	2858
	Serologi dan Molekuler	507	638	640
	Urine	372	371	374
	Liquor	-	-	-
	Transudat/Eksudat	-	-	-
	Feses	43	57	35

2	Patologi Anatomi			
	Pemeriksaan Sitologi	2	0	0
	Pemeriksaan Histopatologi	34	17	0
3	Bakteriologi/Mikrobiologi	14	17	20
4	Narkoba	22	20	34
5	Covid-19	73	55	37
Dirujuk				
1	Patologi Klinik			
	Kimia darah	0	3	0
	Hematologi	3	0	4
	Serologi dan Molekuler	3	7	14
	Urine	1	0	0
	Transudat/Eksudat	-	-	-
	Liquor	-	-	-
	Feses	0	0	0
2	Patologi Anatomi			
	Pemeriksaan Sitologi	6	14	11
	Pemeriksaan Histopatologi	40	47	68
	Bakteriologi/Mikrobiologi	14	5	3
	PCR	2	2	0
	Tumor Marker	2	1	0

3.1.2.2 Grafik Pemeriksaan Didalam Rumah Sakit



3.1.2.3 Grafik Pemeriksaan Diluar Rumah Sakit



Analisis :

- 1. Angka rujukan pemeriksaan patologi anatomi di Laboratorium luar masih mendominasi diantara pemeriksaan lainnya dalam 3 bulan terakhir, yaitu :
 - a) Patologi Anatomi : 79 sampel
 - b) Patalogi Klinik : 28 sampel
 - c) Bakteri/Mikrobiologi : 3 sampel

Rencana Tindak Lanjut

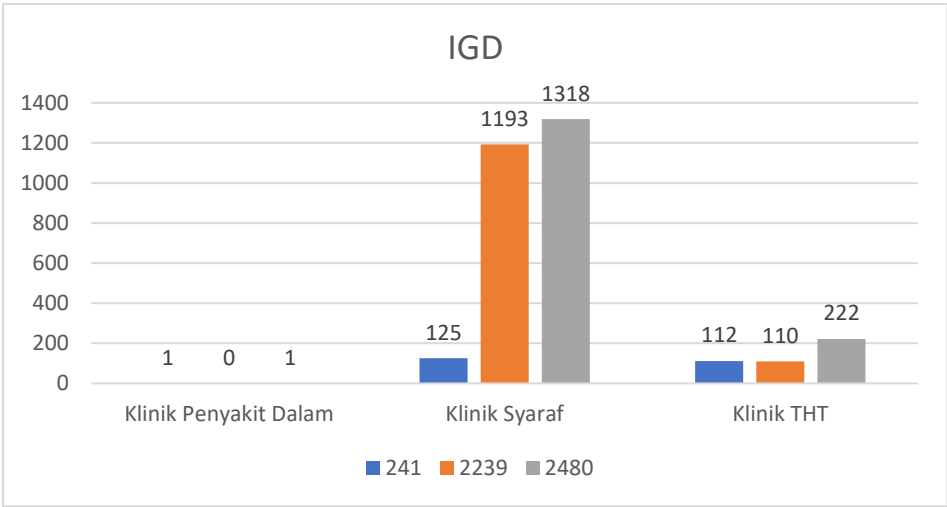
- 1. Perencanaan Tahun 2024 laboratorium mengadakan pengembangan pelayanan dengan mendirikan Laboratorium PA di RS Prima Husada Malang, untuk mengurangi jumlah rujukan dan meningkatkan pendapatan.
- 2. Proses pengembangan pelayanan dengan menggunakan LIS.

3.1.3 Rekam Medis – Pendaftaran

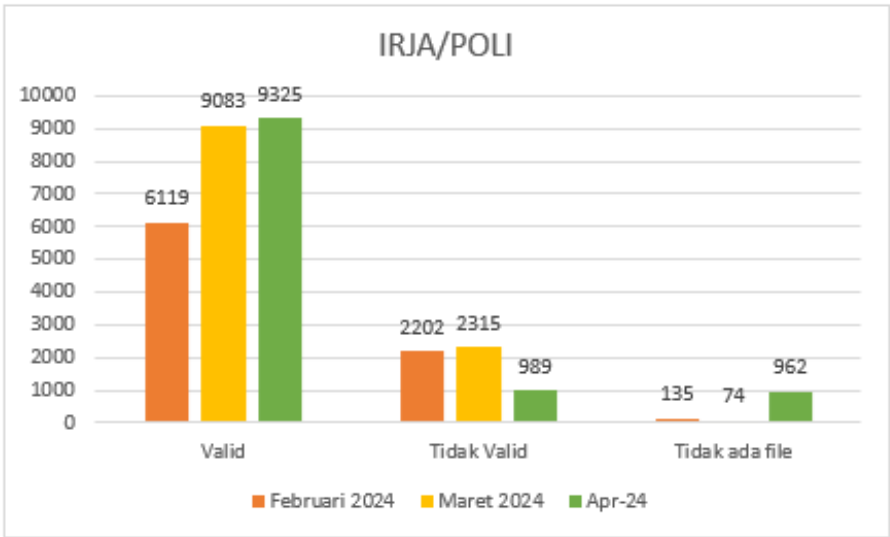
3.1.3.1 Tabel Validasi Data E-RM Bulan Februari-April 2024

NO	UNIT	KUALIFIKASI	BULAN					
			FEBRUARI 2024		MARET 2024		APRIL 2024	
			JUMLAH	(%)	JUMLAH	(%)	JUMLAH	(%)
1	IGD	Valid	0	0	0	0	0	0
		Tidak Valid	468	99,6	772	99,5	833	97
		Tidak ada file	2	0,4	3	0,5	20	3
Total			470		775		853	
2	IRJA/POLI	Valid	6119	72	9083	79	9325	82,5
		Tidak Valid	2202	26	2315	20	989	9
		Tidak ada file	135	2	74	1	962	8,5
Total			8456		11472		11276	

3.1.3.2 Validasi data E-RM di IGD Bulan Februari-April 2024



3.1.3.3 Validasi data E-RM di IRJA/Poli Bulan Februari-April 2024



Analisis :

- 1. Angka valid di IGD dalam 3 bulan terakhir tidak ada perubahan.
- 2. Angka valid di IRJA/Poli mengalami peningkatan dan angka tidak valid mengalami penurunan, dimana tarikan data erm sudah sinkron.
- 3. Masih ditemukan angka tidak ada file dikarenakan pasien yang sudah terdaftar rawat inap meninggal dunia di IGD sebelum 6 jam atau dilakukan rujuk ke RS lain, pada akhirnya terhitung rawat jalan tetapi belum dilakukan ERM.

Rencana Tindak Lanjut :

- 1. Mendata temuan masalah penggunaan ERM dan disampaikan ke Programmer untuk dilakukan tindaklanjut.

3.1.4 Radiologi

3.1.4.1 Tabel Jumlah Pemeriksaan Radiologi Februari – April 2024

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JENIS PEMBAYARAN	FEBRUARI 2024	MARET 2024	APRIL 2024
1.	Radiodiagnostik	Umum	20	29	20
		BPJS Kesehatan	666	814	907
		BPJS TK	35	47	30
		Asuransi Swasta	65	55	15
		Jasaraharja	90	75	10
	Total		876	1020	982
2.	Foto Tanpa Bahan Kontras	Umum	20	29	20
		BPJS Kesehatan	666	814	907
		BPJS TK	35	47	30
		Asuransi Swasta	65	55	15
		Jasaraharja	90	75	10
	Total		876	1020	982
3.	Foto Dengan Rol Film	Umum	20	29	20
		BPJS Kesehatan	666	814	907
		BPJS TK	35	47	30
		Asuransi Swasta	65	55	15
		Jasaraharja	90	75	10
	Total		876	1020	982
4.	CT Scan Tanpa Kontras	Umum	29	15	11
		BPJS Kesehatan	201	164	137
		BPJS TK	-	-	-
		Asuransi Swasta	-	-	8
		Jasaraharja	-	-	3
	Total		230	179	159
5.	CT Scan Dengan Kontras	Umum	-	1	-
		BPJS Kesehatan	7	6	11
		BPJS TK	-	-	-
		Asuransi Swasta	-	-	-
		Jasaraharja	-	-	-
	Total		7	7	11
6.	USG Tanpa Kontras	Umum	35	18	9
		BPJS Kesehatan	198	187	184
		BPJS TK	-	-	-
		Asuransi Swasta	-	-	-
		Jasaraharja	-	-	-
	Total		233	205	193

Jumlah Pemeriksaan Radiologi

Kategori	Klinik	Jumlah Pemeriksaan	
22	Klinik Fisioterapi	1050	
	Klinik Gigi Periodonti	1788	
	Klinik Gigi Spesialis	1106	
	Klinik Ibu dan Anak	1570	
	Klinik Jantung	7074	
	Klinik Jiwa	2654	
	Klinik Kandungan	1	
	Klinik Kulit dan Kelamin	2480	
	Klinik Mata	1318	
	Klinik Paru	2239	
	Klinik Penyakit Dalam	397	
8	Klinik Syaraf	88	
	Klinik THT	1921	
	Klinik Umum	54	
	Klinik Urologi 3746 2576	14018	
	5	Klinik Urologi 3746 2576	1191
		Klinik Urologi 3746 2576	201
		Klinik Urologi 3746 2576	954
		Klinik Urologi 3746 2576	991
		Klinik Urologi 3746 2576	1080
		Klinik Urologi 3746 2576	180
		Klinik Urologi 3746 2576	2191
Klinik Urologi 3746 2576		1284	
Klinik Urologi 3746 2576		126	
Klinik Urologi 3746 2576		280	
Klinik Urologi 3746 2576		3746	

Analisis :

- 1. Pelayan pemeriksaan dalam 3 bulan terakhir meliputi USG, CT-Scan, dan Rontgen terbagi menjadi pasien Umum, BPJS, dan Asuransi.
Pada 3 bulan terakhir pemeriksaan terbanyak yaitu :
 - a) Rontgen : 982
 - b) USG : 193
 - c) CT Scan : 170
- 2. Pada Bulan April produktivitas radiologi pada pemeriksaan radiodiagnostik sejumlah 982 pasien. Terbagi menjadi pasien Umum, BPJS, dan Asuransi.
Mengalami penurunan dibandingkan Bulan Maret, hal ini disebabkan karena jumlah libur lebih banyak.
Penurunan produktivitas radiologi berbanding lurus dengan penurunan jumlah pasien rawat jalan dan rawat inap.

Rencana Tindak Lanjut :

- 1. Koordinasi dengan Humas & Marketing untuk mengadakan promo/MOU dengan RS yang belum mempunyai Alat CT Scan jika sudah diperbaiki untuk menaikkan pendapatan.
- 2. Kolaborasi dengan Humas & Marketing untuk mengadakan MCU pemeriksaan USG.

3.1.5 Gizi

3.1.5.1 Tabel Pemesanan Diit Februari-April 2024

NO	NAMA DIIT	JUMLAH PESANAN DIIT			PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA (%)
		FEBRUARI 2024	MARET 2024	APRIL 2024	
1	Diabetes Melitus	288	285	117	117
2	Rendah Garam	408	528	88	88
3	Jantung	223	190	110	110
4	Rendah serat	352	373	78	78
5	TKTP	1079	1424	89	89
6	Makanan biasa	24	16	63	63
7	Makanan Lunak	20	10	100	100
8	Rendah Lemak	160	239	87	87
9	Rendah Protein	87	79	118	118
10	Bubur Halus	92	171	69	69
11	Cair	72	71	86	86
12	Rendah Purin	102	97	77	77
13	Tinggi Protein	24	23	174	174
14	Blender	17	21	52	52
15	Tinggi serat	3	0	0	0
16	Tinggi Kalsium	123	131	127	127
17	Rendah Kalsium	42	30	160	160
18	Rendah Sisa	9	10	40	40
Total		3125	3698	3419	92

3.1.5.2 Grafik Jumlah Pesanan Diet 2024



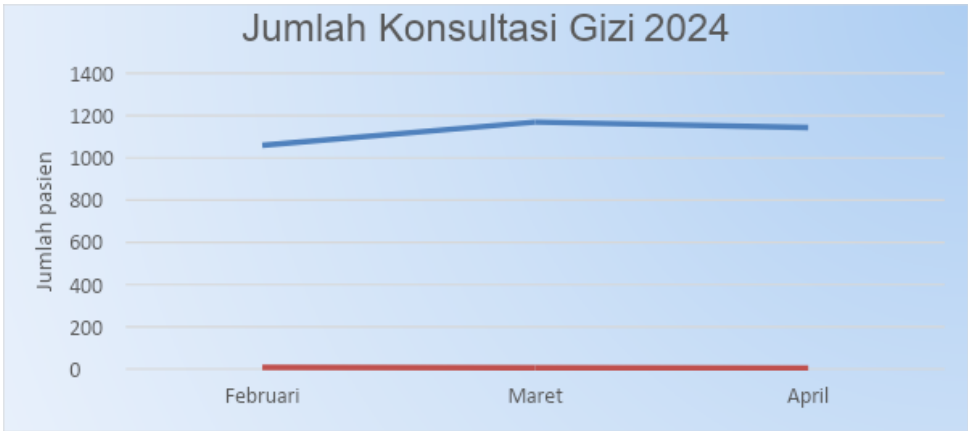
Analisis :
Jumlah pasien yang rawat inap menurun sehingga mempengaruhi jumlah pemberian diet pasien di rawat inap.
Dari hasil survey kepuasan pasien terhadap menu makanan tidak ditemukan penurunan kepuasan terhadap variasi makanan.

Rencana Tindak Lanjut :
Koordinasi dengan Humas dan Marketing untuk meningkatkan jumlah kunjungan pasien rawat inap.
Evaluasi kembali terkait kepuasan pasien terhadap variasi menu makanan

3.1.5.3 Jumlah Konsultasi Gizi Februari-April 2024

NO.	INDIKASI	JUMLAH PASIEN FEBRUARI	JUMLAH PASIEN MARET	JUMLAH PASIEN APRIL
1.	Konsultasi Rawat Inap	1059	1169	1143
2.	Konsultasi Rawat Jalan	8	6	5

3.1.5.4 Grafik Jumlah Konsultasi Gizi Februari-April 2024



Analisis :
Jumlah konsultasi gizi ranap pada bulan April menurun mengikuti jumlah pasien yang rawat inap. Jumlah konsultasi gizi rajal bulan April menurun dikarenakan sebagian besar pasien minta diedukasi ulang sebelum KRS dari rawat inap.

Rencana Tindak Lanjut :

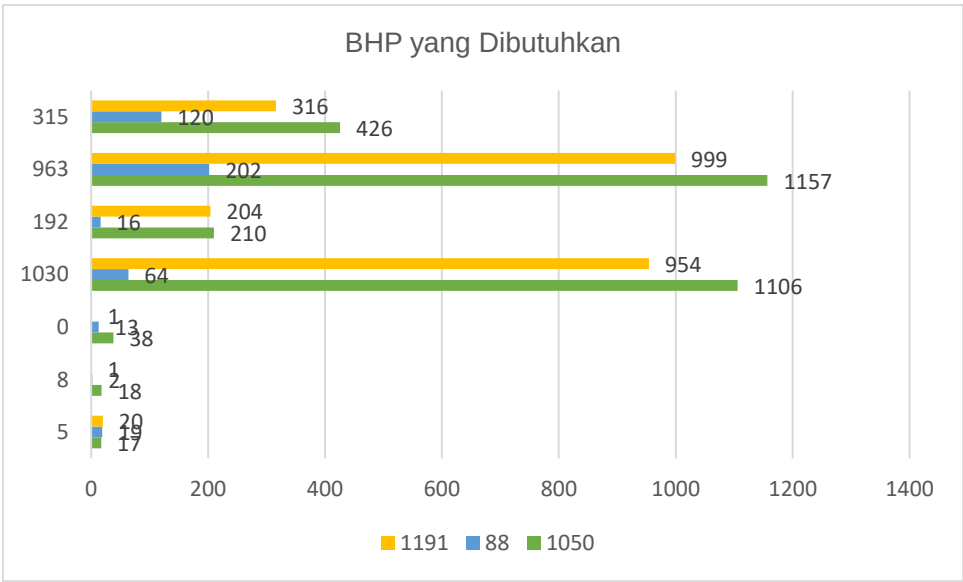
- 1. Koordinasi dengan dokter DPJP agar sering merujuk pasien nya untuk ke poli gizi dan lebih baik lagi jika ada dokter spesialis gizi.
- 2. Mengajukan MCU Gizi.

3.1.6 CSSD – Laundry

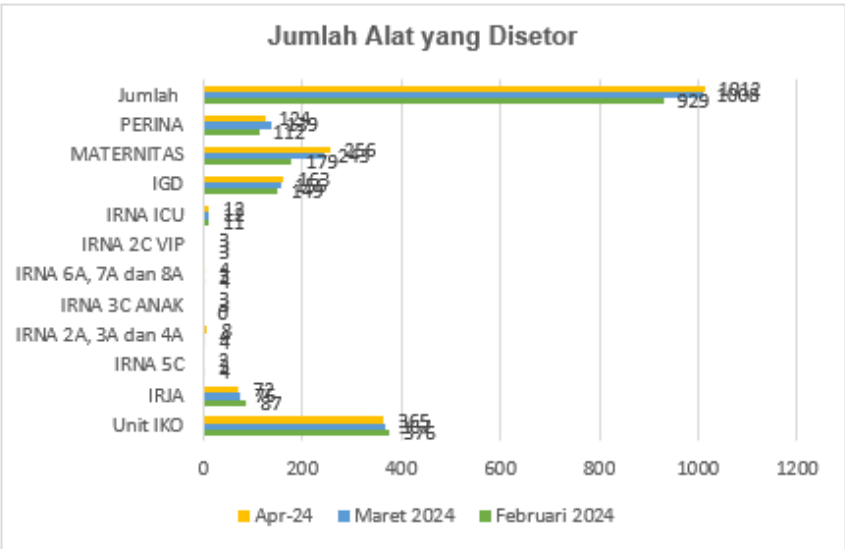
3.1.6.1 Tabel Jumlah Pengeluaran Bahan Habis Pakai dan Alat yang Disetor ke CSSD di Bulan Februari-April 2024

NO	HAL	FEBRUARI 2024	MARET 2024	APRIL 2024
1	Chemical Alcalide	1500ml	1400ml	1200ml
2	Chemical Alkazyme	37pcs	34pcs	31pcs
3	Kassa Masuk	54roll	38roll	45roll
4	Kassa Keluar	2130pouches	1983pouches	2003pouches
5	BHP Pouces	5roll	5roll	5roll
6	Indikator Adhesive	1roll	1roll	1roll
7	Indikator Strip Steam	2roll	2roll	2roll
Alat yang disetor				
		Jumlah (set)	Jumlah (set)	Jumlah (set)
8	Unit IKO	376	367	365
9	IRJA	87	75	72
10	IRNA 5C	4	3	2
11	IRNA 2A, 3A dan 4A	4	4	8
12	IRNA 3C ANAK	0	3	3
13	IRNA 6A, 7A dan 8A	4	3	4
14	IRNA 2C VIP	3	3	3
15	IRNA ICU	11	12	12
16	IGD	149	156	163
17	MATERNITAS	179	243	256
18	PERINA	112	139	124
Jumlah		929	1008	1012

3.1.6.2 Grafik Jumlah Pengeluaran Bahan Habis Pakai CSSD di Bulan Februari-April 2024



3.1.6.3 Grafik Jumlah Alat Yang disetor ke CSSD di Bulan Februari-April 2024



Analisis :
Jumlah alat yang disterilisasi paling banyak dari Unit IKO dengan jumlah setor alat dalam 3 bulan terakhir yaitu sebanyak 1.108 set, diikuti dari Unit Maternitas 678 set dan IGD 468 set. Dimana dari ketiga unit tersebut paling sering melakukan tindakan.

- Rencana Tindak Lanjut :**
- 1. Memperbaiki pencatatan keluar masuk alat bersih dan kotor.
 - 2. Pendistribusian kasa steril dalam bentuk pouches terpusat di Gudang Farmasi, dengan jadwal permintaan BMHP seminggu 2x.

3.2 Kinerja Umum dan Keuangan

3.2.1 SDM

3.2.1.1 Ketenagaan (Distribusi Tenaga, Kualifikasi, Jabatan dan Kebutuhan)

NO	UNIT	PENDIDIKAN	TOTAL	JUMLAH	TETAP	TIDAK TETAP	RESIGN
1	Direktur	Dokter Umum	1	1	0	1	0
2	Kabid Pelayanan medik	Dokter Umum	1	1	0	1	0
3	Kabid Penunjang Medik	D3 Kebidanan	1	1	1	0	0
4	Kabid Umum & Keuangan	Dokter Gigi	1	1	0	1	0
5	Kabid Keperawatan	Profesi Ners	1	1	0	1	0
6	Dokter IGD	Dokter Umum	7	7	0	7	0
7	Dokter Ruangan	Dokter Umum	0	0	0	0	0
8	Farmasi	SMK	42	5	0	5	0
		D3 Farmasi		20	4	16	0
		S1 Apoteker		12	0	12	0
		S1 Farmasi		3	0	3	0
		S1 Analisis Farmasi dan Makanan		1	0	1	0
		S1 Ekonomi		1	0	1	0
9	Asuransi Center	SMA	11	1	1	0	0
		SMK		1	1	0	0

		D3 Kesehatan		3	0	3	0
		D3 Asuransi Kesehatan		1	0	1	0
		D3 RMIK		5	0	5	0
10	CSSD	SMK	4	2	1	1	0
		D3 Keperawatan		1	0	1	0
		D3 Farmasi		1	0	1	0
11	Fisioterapi	D3 Fisioterapi	4	2	2	0	0
		D3 Kesehatan		1	0	1	0
		S1 Terapi Wicara		1	0	1	0
12	Gizi	SMP	16	2	2	0	0
		SMK		6	0	6	0
		SMA		2	0	2	0
		D3 Gizi		2	2	0	0
		D4 Gizi		2	0	2	0
		S1 Gizi		2	1	1	0
13	Humas & Marketing	S1 Kesehatan Masyarakat	2	1	0	1	0
		Profesi Ners		1	0	0	0
14	ICU dan HCU	D3 Keperawatan	12	5	1	4	0
		Profesi Ners		6	4	2	0
		D3 Kebidanan		1	0	1	0
15	IGD	D3 Kebidanan	28	1	0	1	0
		D4 Kebidanan		5	0	5	0
		D3 Keperawatan		10	0	10	0
		D4 Keperawatan		5	0	5	0
		Profesi Ners		7	1	6	0
16	IKO	D3 Kebidanan	12	1	1	0	0
		D3 Keperawatan		3	1	2	0
		Profesi Ners		8	3	5	0
17	IPCN	Profesi Ners	1	1	1	0	0
18	IPSRs	D3 TEM	7	1	0	1	0
		SKM		1	0	1	0
		D3 Teknik		1	0	1	0
		S1 Teknik		1	0	1	0
		SMA		3	1	2	0
19	IRJA	D3 Kebidanan	27	5	3	2	0
		D3 Keperawatan		13	6	7	0
		D4 Keperawatan Gigi		1	0	1	0
		Profesi Ners		8	4	4	0
20	IRNA 2C	D3 Keperawatan	7	2	0	2	0
		Profesi Ners		5	1	4	0
21	IRNA 6A & 7A & 8A	D3 Keperawatan	24	12	0	12	0
		D4 Keperawatan		4	0	4	0
		Profesi Ners		8	0	8	0
22	IRNA 3C Anak	D3 Keperawatan	14	8	0	8	0
		D4 Keperawatan		1	0	1	0
		Profesi Ners		5	0	5	0
23	IRNA 3A & 4A	D3 Keperawatan	19	14	0	14	0
		Profesi Ners		5	0	5	0
24	IRNA 5C	D3 Keperawatan	10	5	0	5	0
		Profesi Ners		5	0	5	0
25	Maternitas	D3 Kebidanan	12	8	7	1	0

		D4 Kebidanan		2	1	1	0
		Profesi Bidan		2	0	2	0
26	Neonatologi	D3 Keperawatan	9	5	0	5	0
		Profesi Ners		4	3	1	0
27	Keuangan dan Akuntansi	SMA	10	4	1	3	0
		S1		5	3	2	0
		D3 Keuangan		1	0	1	
28	Laboratorium	D3 Kesehatan	10	4	0	4	0
		D3 Analisis Kesehatan		4	1	3	0
		D4 Analisis Kesehatan		2	0	2	0
29	Laundry	SMA	5	5	3	2	0
30	Rekam Medis	D3 RMIK	10	9	3	6	0
		D4 RMIK		1	0	1	0
32	Pendaftaran	SMA	15	6	1	5	0
		D3 RMIK		4	2	2	0
		D3 Kesehatan		2	0	2	0
		S1 Sosial		1	0	1	0
		D4 Manajemen		2	0	2	0
33	PIPP	Ners	5	1	1	0	0
		D3 Keperawatan		1	0	1	0
		D3 Kebidanan		1	1	0	0
		D4 Kebidanan		2	1	1	0
34	PMKP	Profesi Ners	1	1	0	1	0
35	Radiologi	D3 Radiodiagnostik & Radioterapi	7	7	0	7	0
36	SDM	S1 Psikologi	2	2	0	2	0
37	Sekretaris	S1 Administrasi Publik	1	1	0	1	0
38	SIMRS & IT	S1 Komunikasi	3	3	0	3	0
39	Umum Rumah Tangga	S1 Ekonomi	1	1	1	0	0
40	Cleaning Service	SMP	44	3	1	2	0
		SMA		41	5	36	0
41	Security	SMA	12	12	6	6	0
42	Driver	SMA	5	5	1	4	0
43	Gudang Umum	SMA	1	1	1	0	0
44	Dokter Spesialis Syaraf		4	4	0	4	0
45	Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah		3	3	0	3	0
46	Dokter Spesialis Paru		4	4	0	4	0
47	Dokter Spesialis Penyakit Dalam		3	3	0	3	1
48	Dokter Spesialis Anestesi		2	2	0	2	0
49	Dokter Spesialis Bedah		4	4	0	4	0
50	Dokter Spesialis Bedah Plastik		1	1	0	1	0
51	Dokter Spesialis Orthopedi		3	3		3	0
52	Dokter Spesialis Patologi Anatomi		1	1	0	1	0

53	Dokter Spesialis Patologi Klinis		1	1	0	1	0
54	Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi		1	1	0	1	0
55	Dokter Spesialis Mata		3	3	0	3	0
56	Dokter Spesialis Urologi		2	2	0	2	0
57	Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa		2	2	0	2	0
58	Dokter Spesialis Obstetri Ginekology		4	4	0	4	0
59	Dokter Gigi Spesialis Orthodontist		1	1	0	1	0
60	Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin		2	2	0	2	0
61	Dokter Spesialis THT		1	1	0	1	0
62	Dokter Spesialis Gigi Periodonti		1	1	0	1	0
63	Dokter Spesialis Radiologi		3	3	0	3	0
TOTAL			451				

Keterangan :
 Pada bulan Maret 2024 terdapat perubahan staf dari 428 ke 436 karena penambahan staf di unit CS sebanyak 3, di unit Laundry sebanyak 1, di unit Farmasi sebanyak 3, di unit ipsrs sebanyak 1

3.2.1.2 Rekrutmen

NO	PROFESI	JUMLAH YANG DIBUTUHKAN	TERPENUHI	KEKURANGAN	PENYEBAB	RENCANA TINDAK LANJUT
1	Apoteker	2	0	2	Sulit mencari kandidat yang cocok	Dilakukan rekrutmen tertutup dengan menggunakan relasi karyawan apoteker rs
2	Terapi Okupasi	1	0	1	Sulit mencari kandidat terapis okupasi	Menghubungi sosial media komunitas terapis okupasi, menghubungi kampus dengan jurusan terapis okupasi

3	Dokter Spesialis Bedah Mulut	1	0	1	Sulit mencari dokter spesialis bedah mulut	Bekerja sama dengan dokter maupun staf RSPHM untuk membagikan lowongan pekerjaan dan menghubungi kampus dengan jurusan dokter spesialis tersebut.
4	Dokter Gigi Spesialis Konservasi Gigi	1	0	1	Sulit mencari dokter spesialis konservasi gigi	Bekerja sama dengan dokter maupun staf RSPHM untuk membagikan lowongan pekerjaan dan menghubungi kampus dengan jurusan dokter spesialis tersebut.

3.2.1.3 Orientasi Staf Baru

NO	TANGGAL	JENIS ORIENTASI	NAMA STAF	PENDIDIKAN	PROFESI	SPMJ (TANGGAL MASUK)	KET.
1	30 April 2024	Orientasi Umum	Maharani Juwita Zhalsabilla S.Tr.Par	D4 Pariwisata	Pendaftaran	1 Mei 2024	Pengganti Resign
			Mayputri Nabilla, A.Md.Kes	D3 Kesehatan	Rekam Medis		
			Yeni Khikmatus Sholikhah. A.Md.Aktr	D3 Asuransi Kesehatan	Pendaftaran		
			Dea Rira Panduwinat a, A.Md. Aktr	D3 Asuransi Kesehatan	Pendaftaran		
			Niken Eka Lidiani, A.Md. Farm	D3 Farmasi	TTK		Penambahan
			Lola Novira Risdiyanti, A.Md.Kep	D3 Keperawatan	CSSD		Pengganti Pensiun
			M. Riza Kurniawan	SMA	CS		Penambahan
			Auliya	D3	Perawat		Pengganti

			Rahmatul Amani, A.Md.Kep	Keperawatan			Resign
			Rifqi Eka Prasetya	SMA	CS		Penambahan
			Hamzah Zulfikar Jonas	SMA	Laundry		Pengganti Pensiun

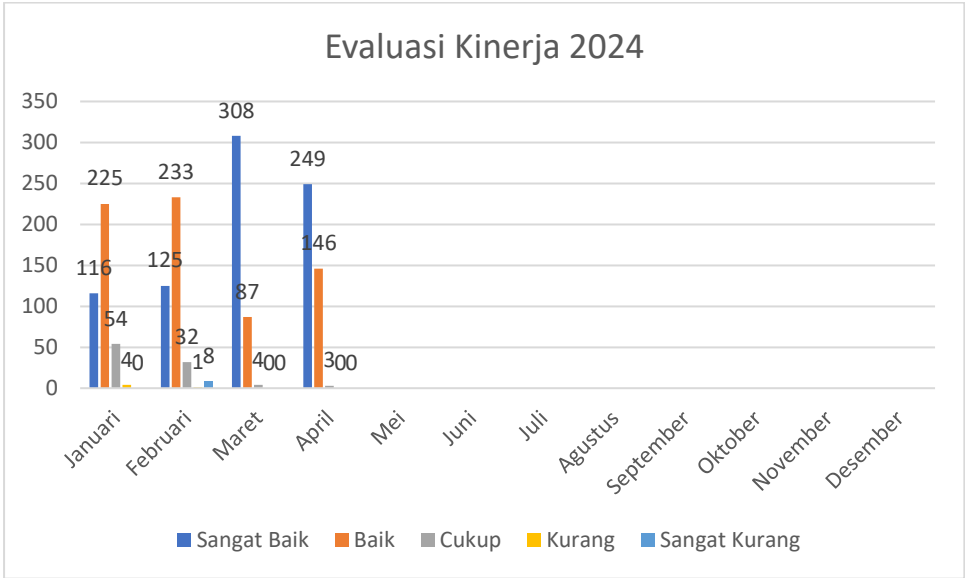
3.2.1.4 Diklat

NO	NAMA DIKLAT	TANGGAL PELAKSANAAN	SASARAN	JUMLAH PESERTA YANG DIUNDANG	JUMLAH PESERTA YANG HADIR	RENCANA TINDAK LANJUT
1	Early Warning System (EWS)	25 April 2024	Perawat dan Bidan	86	61	Upload seluruh materi, pre-test dan post-test ke google drive dan dibuka akses untuk karyawan yang tidak mengikuti diklat.

3.2.1.5 Evaluasi Kinerja Staf

NO	KATEGORI	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL
1	Sangat Baik	116	125	308	249
2	Baik	225	233	87	146
3	Cukup	54	32	4	3
4	Kurang	4	1	0	0
5	Sangat Kurang	0	8	0	0

3.5.1.5.1 Grafik Evaluasi Kinerja Karyawan



Analisis :

Penurunan predikat sangat baik dan baik pada bulan April adalah karena tingkat keterlambatan karyawan meningkat pada bulan April 2024

Rencana Tindak Lanjut :

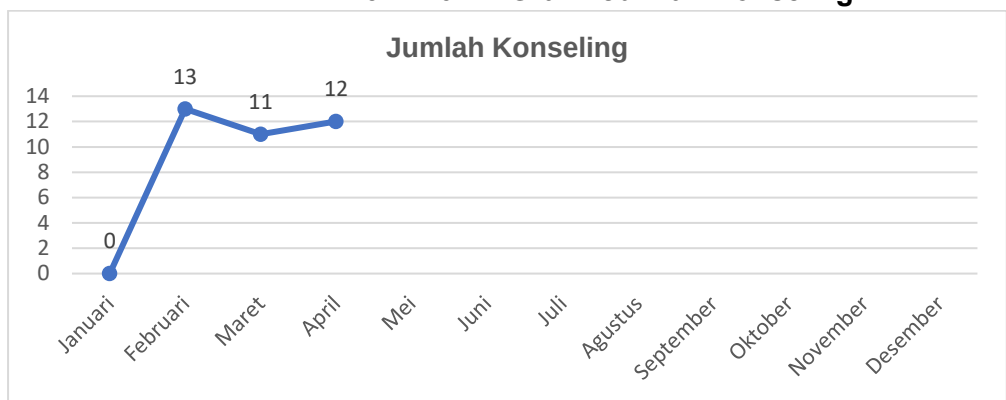
- 1. Sosialisasi kepada Karu dan Kabid untuk mengingatkan kembali kepada stafnya.
- 2. Melakukan tahapan teguran sesuai taat tertib yang berlaku.

3.2.1.6 Konseling

3.2.1.6.1 Tabel Capaian Konseling Perbulan Tahun 2024

NO	JENIS	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL
1	Konseling	0	13	11	12

3.2.1.6.1.1 Grafik Jumlah Konseling



Analisis :

Program konseling karyawan rutin belum berjalan dikarenakan staf SDM masih menyesuaikan dengan jobdesk-jobdesk administratif lainnya. Jumlah konseling diatas adalah konseling karyawan dengan kasus tertentu.

Rencana Tindak Lanjut :

Mengkonsep Kembali program konseling dan menjadikannya program rutin dan b erkelanjutan.

3.2.2 MFK dan K3RS

3.2.2.1 Pemeliharaan Alat Medis

Penghitungan capaian berdasarkan jumlah kunjungan per unit oleh elektromedis ke unit-unit di rumah sakit (33 unit) dalam satu bulan

3.2.2.1.1 Tabel Capaian Maintanance Alat Medis

NO	KET	TARGET	MARET	APRIL
1	Capaian Maintenance	90%	93,94	90,91

Analisis :

Beberapa factor yang menyebabkan penurunan antara lain : alat medis masih dipakai oleh pasien, ruangan atau unit masih ada tindakan pasien. Contoh IKO.

Rencana Tindak Lanjut :

Followup ke Karu/Ka unit untuk memberikan info ketika alat medis yang belum di maintenance tidak dalam kondisi dipaka

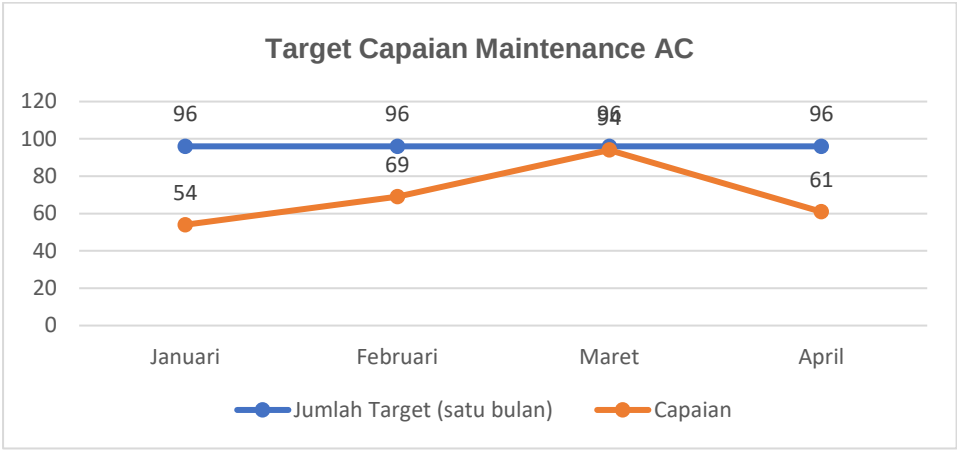
3.2.2.2 Pemeliharaan Alat Non Medis

3.2.2.2.1 Air Conditioner

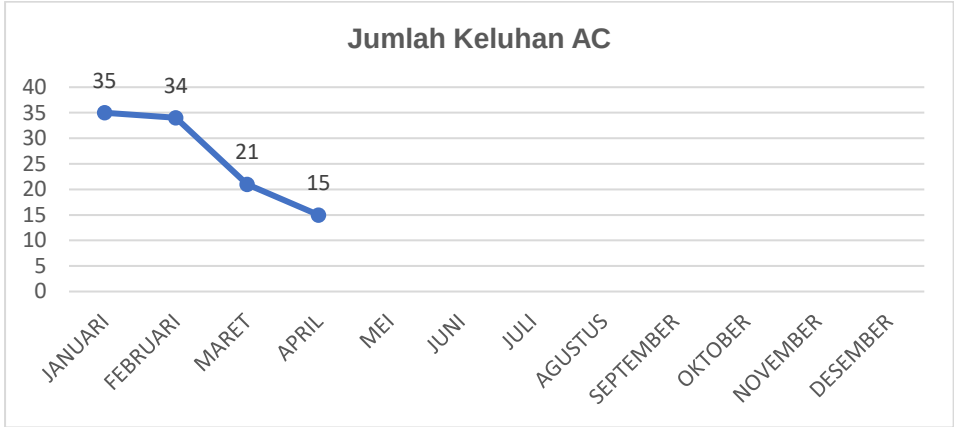
3.2.2.2.1.1 Tabel Capaian Pemeliharaan AC Split

NO	BULAN	JUMLAH TARGET (SATU BULAN)	CAPAIAN	KETERANGAN
1	Januari	96	54	Belum mencapai target
2	Februari	96	69	Belum mencapai target
3	Maret	96	94	Belum mencapai target
4	April	96	61	Belum mencapai target

3.2.2.2.1.2 Grafik Target Capaian Maintenance AC



3.1.1.1.1 Grafik Keluhan AC Split dari Unit



Analisis :

Sudah terdapat progress perbaikan yang baik terhadap pemeliharaan AC baik secara fisik maupun pelaporan ini berdampak pada keluhan staf di unit terhadap AC mulai berkurang setiap bulannya.

Beberapa penyebab yang mengakibatkan target masih tidak tercapai :

- 1. Masih ada pemeliharaan yang tidak tercatat sehingga tidak masuk laporan
- 2. Adanya tugas insidental diluar jadwal IPSRS
- 3. AC ruangan masih terdapat pasien / dala pemakaian

Rencana Tindak Lanjut :

- 1. Monitoring dan evaluasi terutama terkait system pencatatan dan target perbulan.
- 2. Pembuatan aplikasi lokal IPSRS

3.5.2.2.3 Genset
3.5.2.2.3.1 Tabel Capaian Pemeliharaan Genset

NO	BULAN	JUMLAH TARGET (SATU BULAN)	CAPAIAN	PROSENTASE	KETERANGAN
1	Januari	4x/bulan	4x/bulan	100%	sudah mencapai target
2	Februari	4x/bulan	4x/bulan	100%	sudah mencapai target
3	Maret	4x/bulan	4x/bulan	100%	sudah mencapai target
4	April	4x/bulan	4x/bulan	100%	sudah mencapai target

Analisis :
Genset dilakukan perbaikan 4x dalam satu bulan. Selama 3 bulan terakhir genset sudah dilakukan maintenance sesuai SOP namun belum ada pelaporan yang rapi. Pada bulan maret ini sudah terdata rapi dalam pelaporan

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan evaluasi berkala

3.5.2.2.4 Panel Listrik
3.5.2.2.4.1 Tabel Capaian Pemeliharaan Panel

NO	BULAN	JUMLAH TARGET (SATU BULAN)	CAPAIAN	PROSENTASE	KETERANGAN
1	Januari	4x/bulan	4x/bulan	100%	sudah mencapai target
2	Februari	4x/bulan	4x/bulan	100%	sudah mencapai target
3	Maret	4x/bulan	4x/bulan	100%	sudah mencapai target
4	April	4x/bulan	4x/bulan	100%	sudah mencapai target

Analisis :
Pemeliharaan panel listrik di Gedung A,B,C,D dilakukan 4x dalam satu bulan dan dilakukan rekapan. Kegiatan ini sudah berjalan sesuai target. Berdasarkan hasil supervisi, petugas sudah berkeliling dan melakukan pencatatan.

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan Evaluasi

3.5.2.2.8 Lift

3.5.2.2.8.1 Tabel Capaian Pemeliharaan Lift

NO	KETERANGAN	TARGET	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL
1	Pemeliharaan lift	2x/bulan	100%	100%	100%	100%

Analisis :
Pelaksanaan sudah sesuai target dan di dokumentasikan

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan evaluasi

3.5.2.2.9 UPS

3.5.2.2.9.1 Tabel Capaian Pemeliharaan UPS

NO	KETERANGAN	TARGET	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL
1	Pemeliharaan UPS	2x/bulan	100%	100%	100%	100%

Analisis :
Pelaksanaan sudah sesuai target dan di dokumentasikan

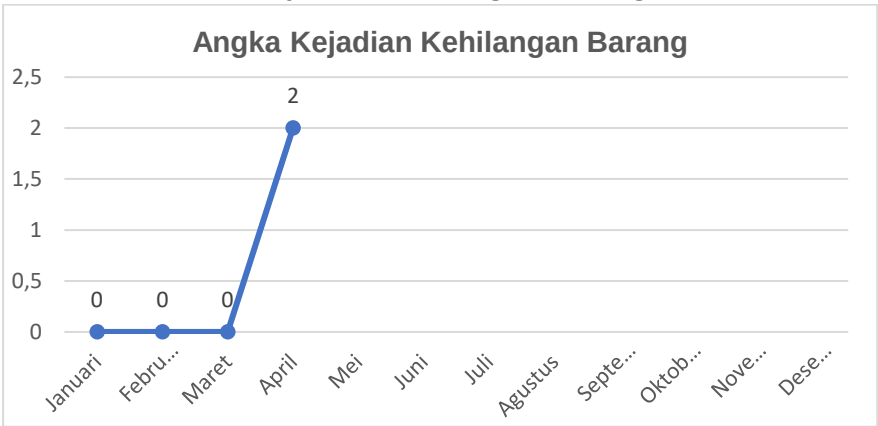
Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan evaluasi

3.1.2 Security

3.1.2.1 Tabel Angka Kejadian Kehilangan Barang

NO	JENIS AKTIVITAS	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL
1.	Angka kejadian kehilangan barang	0	0	0	2

3.1.2.2 Grafik Kejadian Kehilangan Barang



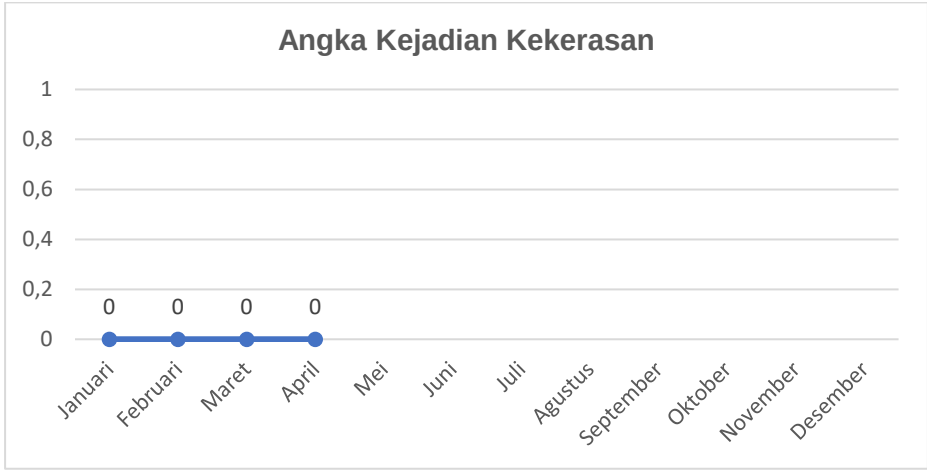
Analisis :
2 kejadian di bulan April adalah kejadian kehilangan akibat kelalaian pasien dan keluarga. Barang dapat ditemukan dan dikembalikan kepada pemilik

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan evaluasi

3.1.2.3 Tabel Angka Kekerasan di Lingkungan Rumah Sakit

NO	JENIS AKTIVITAS	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL
1.	Angka kejadian kekerasan	0	0	0	0

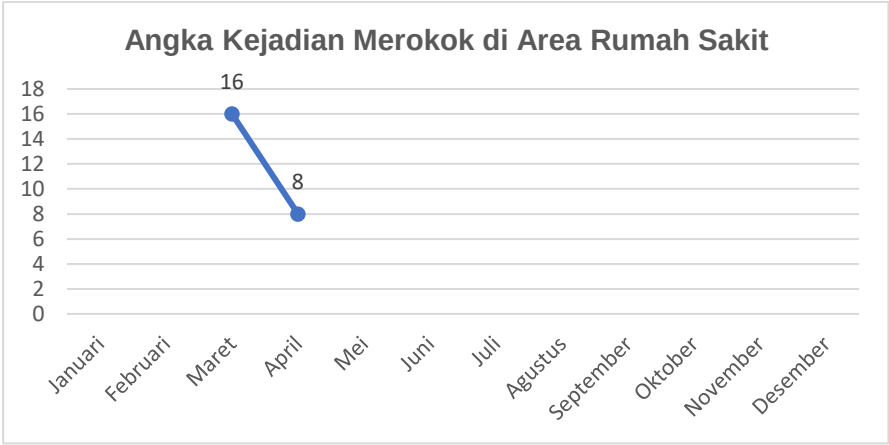
3.1.2.4 Grafik Angka Kejadian Kekerasan



Analisis :
Tidak terdapat kejadian kekerasan karena pelayanan dilakukan dengan baik oleh seluruh karyawan

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan evaluasi

3.1.2.5 Tabel Angka Kejadian Merokok di Area Rumah Sakit

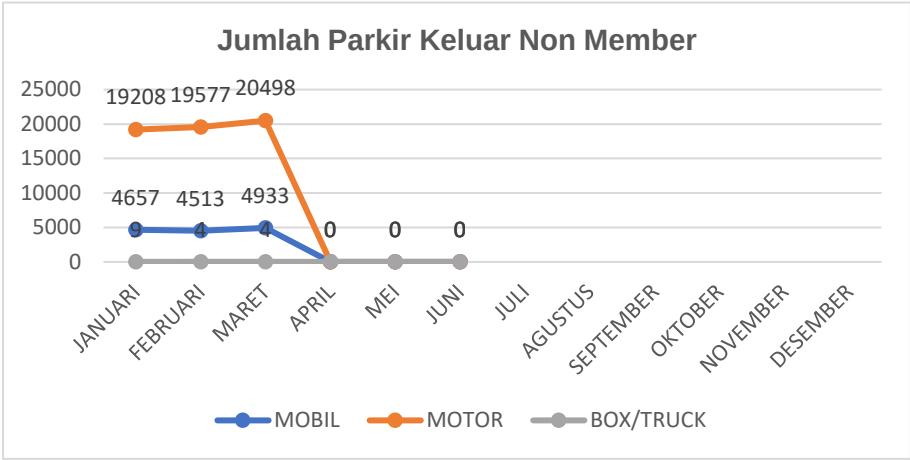


Analisis :
Angka kejadian merokok mulai tercatat rapi pada bulan Maret. Mengalami penurunan karena patroli dari satpam yang lebih intens dan dilaporkan dengan rapi.

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan evaluasi

3.1.1 Parkir

3.1.1.1 Grafik Jumlah Parkir Keluar Non Member (Maret 2024)



Analisis :
Peningkatan kapasitas jumlah kendaraan parkir meningkat setiap bulan akibat kenaikan pasien, kendaraan yang masuk > 10 menit dan perluasan lahan parkir di belakang

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan evaluasi

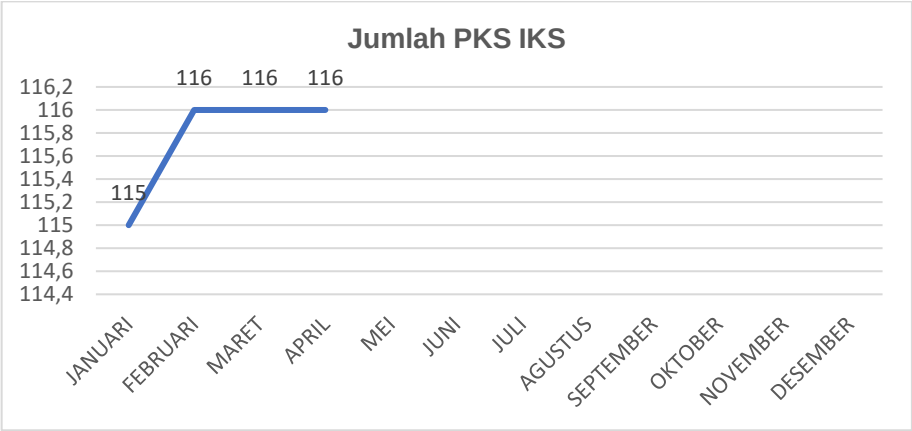
3.1.2 Humas Marketing

3.1.2.1 Perjanjian Kerjasama (PKS)

3.1.2.1.1 Tabel Jumlah PKS-IKS Aktif

NO	KETERANGAN	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL
1	Jumlah PKS IKS AKTIF	115	116	116	116

3.1.2.2.2 Grafik Jumlah PKS – IKS



3.1.2.3.4 Tabel Progres IKS Baru Bulan April 2024

NO	NAMA PKS	PROGRES PENGURUSAN	KENDALA
1	PT Pesta Pora Abadi	Review oleh pihak kedua	Sudah di follow up masih dilakukan telaah oleh bagian legal yang bersangkutan
2	Batas Media 99	Review oleh pihak kedua	Sudah di follow up masih dilakukan telaah oleh bagian legal yang bersangkutan

3	PT Tentrem	Review oleh pihak kedua	Sudah di follow up masih dilakukan telaah oleh bagian legal yang bersangkutan
4	PT YEMI	Review oleh pihak kedua	Sudah di follow up masih dilakukan telaah oleh bagian legal yang bersangkutan
5	PT Randi Cones Indonesia	Review oleh pihak kedua	Sudah di follow up masih dilakukan telaah oleh bagian legal yang bersangkutan
6	BKKBN	Masih proses TTD di BKKBN	Sudah di follow up, belum selesai, akan diberitahun ke grup bila sudah jadi
7	Dinkes TB DM	Masih di Dinkes	Sudah di follow up, belum selesai, akan diberitahukan ke grup bila sudah selesai

Analisis :

1. Pada bulan April, PKS baru dengan instansi lain masih dalam progress
2. Progres MOU baru direalisasi setelah draft MOU baru di paparkan oleh Legal PT DPM
3. MOU masih dalam tahap review oleh pihak kedua

Rencana Tindak Lanjut :

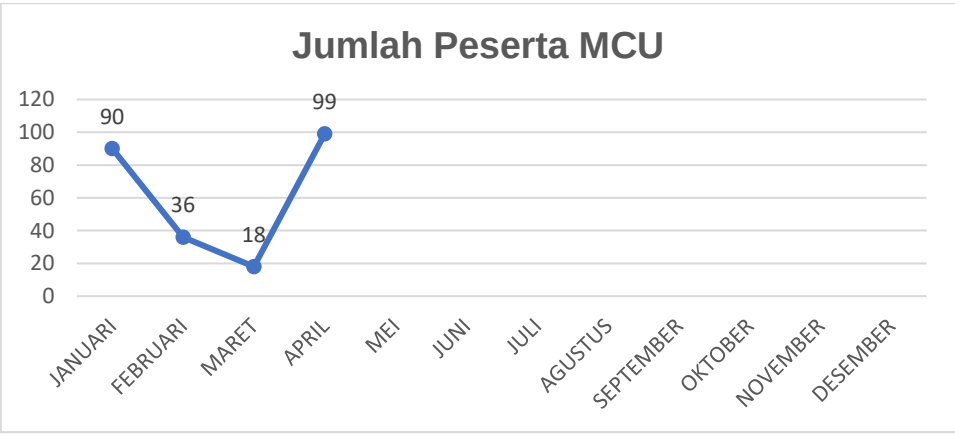
1. Memfollow up PKS yang sudah dikirim ke pihak kedua
2. Mengajukan surat permohonan PKS kepada Instansi Perusahaan, BPM, DPM, Klinik kesehatan, yang belum bekerjasama dengan RS Prima Husada Malang

3.1.2.2 Medical Check Up (MCU)

3.1.2.2.1 Tabel Jumlah Peserta MCU

NO	KETERANGAN	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL
1	JUMLAH PESERTA MCU	90	36	18	99

3.1.2.2.2 Grafik Jumlah Peserta MCU



Analisis :

Berdasarkan data tersebut, jumlah pasien Medical Check Up meningkat dibandingkan bulan sebelumnya.

Review hasil kunjungan dengan PDSA :

Plan :

1. Meningkatkan kunjungan ke Perusahaan
2. Mempromosikan program MCU
3. Mereview tarif/biaya pemeriksaan

Do :

- 1. Mempromosikan program MCU setiap kali melakukan kunjungan ke instansi Perusahaan
- 2. Koordinasi dengan bagian keuangan terkait review tarif MCU agar bisa bersaing dengan vendor lain

Study :

- 1. Harga MCU mempengaruhi jumlah kunjungan MCU.
- 2. Perusahaan memilih harga MCU paling murah diantara vendor.
- 3. Banyak perusahaan memilih MCU yang ditawarkan secara gratis dari klinik rekanan BPJS kesehatan karena hanya sebagai syarat pemenuhan dari Disnaker terkait kesehatan karyawan.

Action :

- 1. Pengajuan MCU ke berbagai Perusahaan untuk calon karyawan baru dan ke Institusi Pendidikan untuk calon Mahasiswa baru
- 2. Review harga pemeriksaan khusus untuk MCU

3.1.2.2.3 Kegiatan Kunjungan Eksternal

3.1.2.2.3.1 Tabel Jumlah Kunjungan Eksternal

NO	KETERANGAN	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL
1	Jumlah Kunjungan	6	10	19	4

3.1.2.2.3.2 Grafik Jumlah Kunjungan Marketing Eksternal



Analisis :

Pada bulan April banyak HRD perusahaan yang libur sehingga capaian menjadi turun.

Rencana Tindak Lanjut :

Menghubungi HRD dalam list perusahaan untuk menjadwalkan kunjungan kembali bagi perusahaan yang belum.

3.1.3 Penjaminan

3.1.3.1 Piutang

3.1.3.1.1 Tabel Piutang BPJS Kesehatan (FPK dan Pengajuan Reguler April 2024

REKAPITULASI FPK BPJS KESEHATAN							
NO	PERIODE LAYANAN	TARIF FPK/ PENGAJUAN	TGL FPK	TGL BAYAR	REALISASI PEMBAYARAN	SELISIH AUDIT DAN ADM BANK	SALDO PIUTANG FPK
PELAYANAN 2023							
1	OBAT KRONIS SEPT 23	435.837.336	18.01.2024	29.01.2024	435.837.336		-
2	FPK REG UTAMA DES 23	6.189.055.000	18.01.2024	29.01.2024	6.189.055.000		-
5	FPK OBAT KRONIS OKT 23	493.809.876	18.02.2024	26.02.2024	493.809.876		-
6	FPK LUPIS NOV 23 AMBULANCE	6.650.000	22.02.2024	28.02.2024	6.650.000		-
7	FPK LUPIS NOV 23 ALKES	6.215.000	22.02.2024	28.02.2024	6.215.000		-
8	FPK LUPIS DES 23 AMBULANCE	7.210.000	22.02.2024	28.02.2024	7.210.000		-
9	FPK LUPIS DES 23 ALKES	6.710.000	22.02.2024	28.02.2024	6.710.000		-
10	FPK OBAT KRONIS NOV 2023	465.212.636	21.03.2024	01.04.2024	465.212.636		-
11	FPK PEND DES 23	607.514.500	06.03.2024	18.03.2024	607.514.500		-
12	FPK OBAT KRONIS DES 2023	469.804.704	25.03.2024	03.04.2024	469.804.704		-
PELAYANAN 2024							
1	FPK Januari 2024	7.006.082.092	18.02.2024	28.02.2024	6.967.698.792	38.383.300	-
	FPK LUPIS JAN 24 AMBULANCE	6.015.000	20.03.2024	16.04.2024	6.015.000		-
	FPK LUPIS JAN 24 ALKES	12.485.000	20.03.2024	16.04.2024	12.485.000		-
2	FPK Februari 2024	7.215.241.743	20.03.2024	28.03.2024	7.215.241.743		-
	FPK LUPIS JAN 24 AMBULANCE	7.740.000	20.03.2024	16.04.2024	7.740.000		-
	FPK LUPIS JAN 24 ALKES	3.795.000	20.03.2024	16.04.2024	3.795.000		-
3	FPK Maret 2024	7.372.267.949	26.04.2024	08.05.2024	7.350.598.749	21.669.200	-
4	Pengajuan April 2024 belum FPK	7.392.467.800					7.392.467.800
		37.704.113.636			30.251.593.336	60.052.500	7.392.467.800

3.1.3.1.2 Tabel Saldo Pending BPJS Kesehatan

REKAP KLAIM DAN PENDING BPJS KESEHATAN							
NO	PERIODE LAYANAN	JENIS	JML KLAIM	FPK	Tidak Layak	JML PEND	% PEND
1	FEB 24	RJ	11.519	11.510	2	9	0,1%
		RI	1.004	915	-	89	9%
2	MARET 24	RJ	11.887	11.882		5	0,0%
		RI	1.104	983		121	11%

3.1.3.1.3 Analisa Progres Penyelesaian Piutang

PIUTANG RS PRIMA HUSADA MALANG													
PERIODE 2024													
									Y	Z	AA	AB	
NO	DESKRIPSI	SALDO AWAL PIUTANG	PEMBAYARAN (BULAN SEBELUMNYA)	SISA PIUTANG (BULAN SEBELUMNYA)	PENAMBAHAN PIUTANG (BULAN BERJALAN)	PEMBAYARAN (BULAN BERJALAN)	SISA PIUTANG (BULAN BERJALAN)	SALDO AKHIR PIUTANG	UMUR PIUTANG				JUMLAH PIUTANG
		a	b	(a-b-c= d)	e	f	(e-f-g=h)	d+h	0-30 HARI	31-60 HARI	61-90 HARI	91-120 HARI	Total
PERIODE APRIL 2024 :													
1	Asuransi	133.034.009	54.035.171	77.440.842	113.232.947	20.742.378	91.538.631	168.979.473	162.029.298	2.812.949	2.431.924	-	168.979.473
2	Perusahaan	80.156.807	22.898.312	57.258.495	75.291.241	-	75.291.241	132.549.736	120.591.920	3.405.108	-	-	132.549.736
3	Mandiri inhealth	103.454.510	18.545.614	84.693.154	24.876.970	-	24.876.970	109.570.125	109.570.125	-	-	-	109.570.125
4	Jasa Raharja	116.169.793	115.791.871	377.924	190.079.761	29.450.742	160.629.020	161.006.944	161.006.944	-	-	-	161.006.944
5	BPJS Ketenagakerjaan	1.266.491.754	22.379.306	1.242.960.221	643.955.887		643.955.887	1.886.916.108	1.565.396.670	311.354.060	2.449.014	4.836.712	1.886.916.108
Total Saldo								2.459.022.385	2.118.594.955	317.572.117	4.880.938	4.836.712	2.459.022.384

Keterangan :

1. Cut off piutang per tanggal 30 April 2024 dengan saldo Rp 2.459.022.384,-
2. Piutang Reliance Rp 2.431.924 menunggu mutasi bank Mei 2024 apabila dalam bulan mei tidak ada pembayaran mei maka akan bersurat penutupan layanan otomatis karena umur piutang lebih dari 90 hari.

- BPJS Ketenagakerjaan sudah mengirimkan surat rekonsiliasi piutang dan sudah mengirimkan adendum UP Ibu Lora proses verifikasi tagihan oleh BPJS TK

3.1.3.2 Klaim Pending

NO	MASALAH	DAMPAK	TINDAK LANJUT
1.	Indikasi pasien kunjungan rawat jalan dan rawatinap di hari yang sama	Klaim Pending	Menjawab konfirmasi pending
2.	Penggunaan diagnosa FEVER pada pasien Demam	Klaim Pending	Menjawab konfirmasi pending
3.	Penggunaan kode 83.39 pada tindakan debridemen menggunakan 86.22	Klaim Pending	Menjawab konfirmasi pending

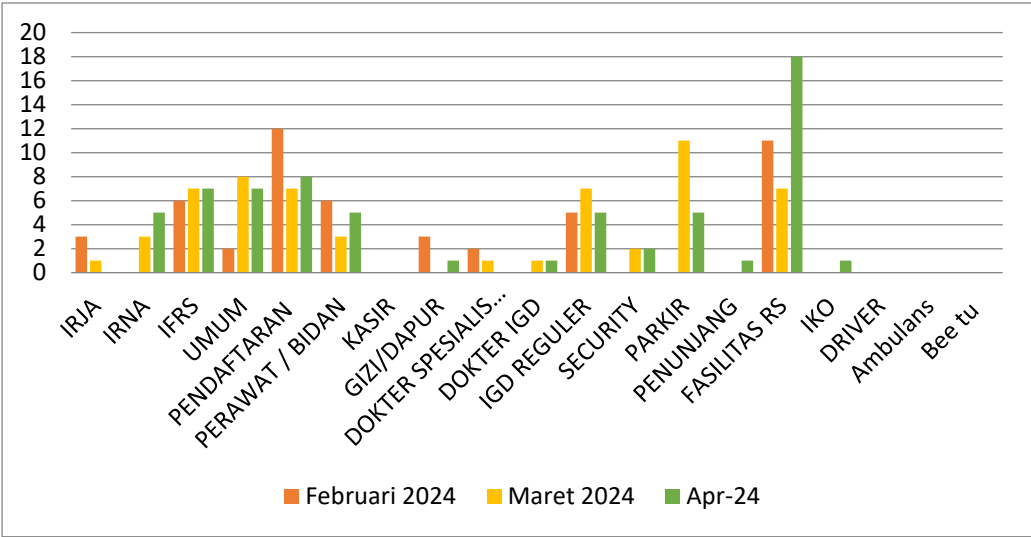
3.1.4 PIPP – MOD – MPP

3.1.4.1 Laporan Komplain Pasien

3.1.4.1 Tabel Distribusi Laporan Komplain Pasien Per Unit
Bulan April 2024

NO	JUMLAH KOMPLAIN PASIEN TERHADAP UNIT	FEBRUARI 2024	MARET 2024	APRIL 2024
1.	IRJA	3	1	0
2.	IRNA	0	3	5
3.	IFRS	6	7	7
4.	UMUM	2	8	7
5.	PENDAFTARAN	12	7	8
6.	PERAWAT / BIDAN	6	3	5
7.	KASIR	0	0	0
8.	GIZI/DAPUR	3	0	1
9.	DOKTER SPESIALIS (KOMITE MEDIS)	2	1	0
10.	DOKTER IGD	0	1	1
11.	IGD REGULER	5	7	5
12.	SECURITY	0	2	2
13.	PARKIR	0	11	5
14.	PENUNJANG	0	0	1
15	FASILITAS RS	11	7	18
16	IKO	0	0	1
17	DRIVER	0	0	0
18	Ambulans	0	0	0
19	Bee tu	0	0	0
Total		50	60	66

3.1.4.2 Grafik Laporan Komplain Pasien Per Unit April 2024



Analisis :

- 1. Jumlah pasien komplain selama Bulan April 2024 mengacu pada komplain pasien secara tatap muka langsung, pesan melalui chatt seperti whatsapp, SMS, Telegram, IG, telepon, kuesioner rawat inap, google ulasan dan Kessan BPJS.
- 2. Komplain terbanyak pada bulan April 2024 yaitu dari Fasilitas RS sebanyak 18 kasus yang disampaikan secara kuesioner, WA maupun tatap muka langsung.
- 3. Pada bulan April 2024 jumlah komplain Terjadi peningkatan dibanding bulan Maret 2024 yaitu sebanyak 66 kasus komplain.
- 4. Jumlah komplain yang tidak bisa langsung diselesaikan sebanyak 9 jenis komplain dengan rincian :
 - a) Fasilitas RS sebanyak 7 kasus (perbaruan bed VIP, perluasan ruangan kelas 1)
 - b) Parkir sebanyak 2 kasus terkait tariff dan luas lahan parkir

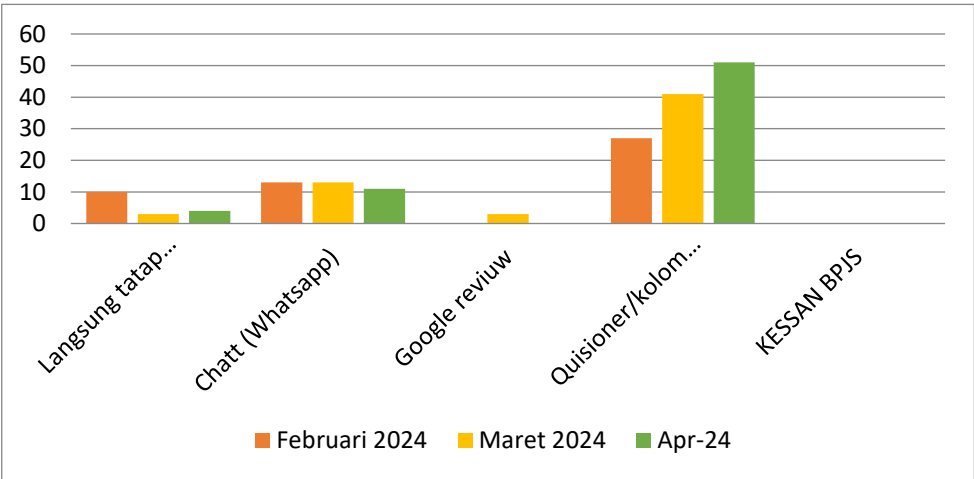
Rencana Tindak Lanjut :

Melakukan evaluasi pada bidang atau bagian yang dikeluhkan pasien agar pelayanan bisa berjalan dengan baik dengan kolaborasi dengan unit terkait

3.1.4.3 Tabel Media yang Digunakan Pasien Komplain Bulan April 2024

NO	JENIS PASIEN KOMPLAIN	FEBRUARI 2024	MARET 2024	APRIL 2024
1.	Langsung tatap muka	10	3	4
2.	Tidak Langsung :			
	a. Chatt (Whatsapp)	13	13	11
	b. Google reviuw	0	3	0
3.	Quisioner/kolom kritik saran	27	41	51
4.	KESSAN BPJS	0	0	0
Total		50	60	66

3.1.4.4 Grafik Media yang Digunakan Pasien Komplain Bulan April 2024



Analisis :

Pada bulan April 2024 jumlah jenis pasien complain terbanyak didapatkan dari Quisioner yaitu sebanyak 51 kasus complain. Sedangkan terbanyak kedua yaitu dari chatt whatsapp sebanyak 11 kasus kemudian complain secara tatap muka / langsung dan google reviuw sebanyak 4 kasus.

Rencana Tindak Lanjut :

Melakukan evaluasi pada bidang atau bagian yang dikeluhkan pasien agar pelayanan bisa berjalan dengan baik dengan kolaborasi dengan unit terkait

3.1.4.5 Tabel Waktu Tanggap dan Penyelesaian Komplai Bulan April 2024

NO	JENIS PASIEN KOMPLAIN	WAKTU TANGGAP		WAKTU PENYELESAIAN	
		STANDARD < 5 ‘	PENCAPAIAN (DARI WAKTU TOTAL DIBAGI JML KOMPLAI ATAU RATA2 WAKTU TANGGAP)	STANDARD < 60 ‘	PENCAPAIAN
1.	Langsung tatap muka	100%	100%	100%	100%
2.	Chatt (WA/Tele/SMS/IG)	100%	100%	100%	100%
3.	Google reviuw	100%	100%	100%	100%
4.	Quisioner/kolom kritik saran	100%	100%	100%	81,6%
5.	KESSAN	100%	0	100%	0

Analisis :

Waktu tanggap dan penyelesaian complain pasien pada bulan April 2024 masih ada yang belum sesuai target 100% yaitu complain melalui kuisioner capaian 81.6%. hal ini dikarenakan ada beberapa kasus complain yang tidak bisa langsung diselesaikan seperti fasilitas RS yang memerlukan diskusi dengan manajemen. Adapun Jumlah complain yang tidak bisa langsung diselesaikan sebanyak 11 jenis complain dengan rincian :

- 1. Fasilitas RS sebanyak 7 kasus (perbaruan bed VIP, perluasan ruangan kelas 1)
- 2. Parkir sebanyak 2 kasus terkait tarif dan luas lahan parkir

Rencana Tindak Lanjut :

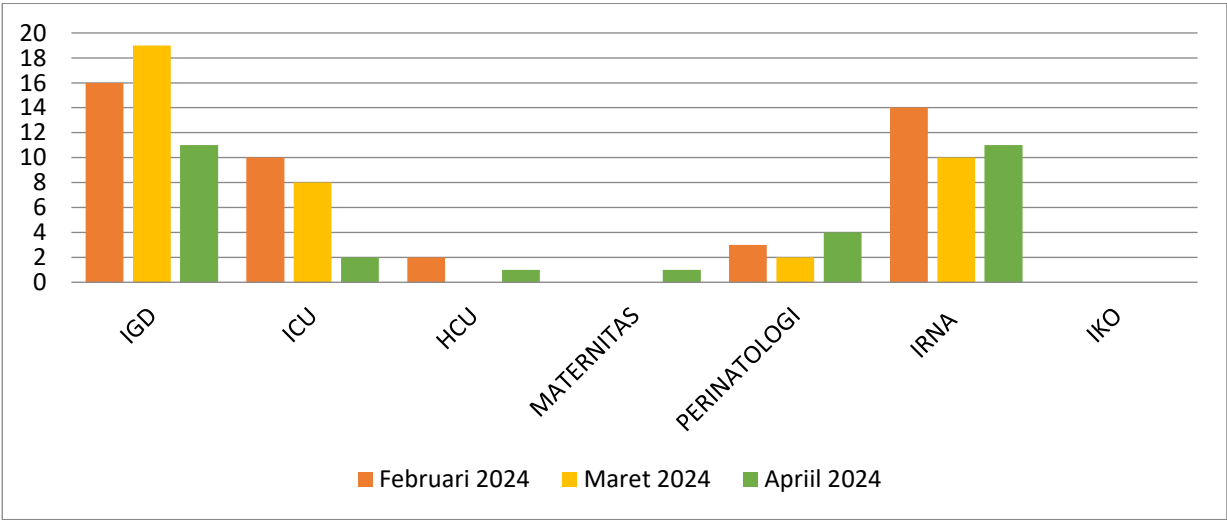
Penyelesaian complain dilakukan dengan melakukan telusur lapangan sederhana dengan kolaborasi dengan unit terkait diantaranya :

- 1. Parkir
 - a) Terkait parkir yang dikeluhkan adalah tarif parkir yang terlalu mahal dan tidak ada akses khusus untuk pasien rawat inap, sehingga keluarga pasien terlalu banyak membayar parkir setiap keluar masuk RS saat mengambil barang dirumah atau diluar RS.
 - b) Sudah dilakukan pelaporan oleh Kabid umum dan keuangan ke PT terkait hal tersebut (menunggu jawaban PT)

3.1.4.6 Laporan Pasien Rujuk
3.1.4.6.1 Tabel Distribusi Pasien Rujuk Per Unit Bulan April 2024

NO	UNIT PERUJUK	FEBRUARI 2024	MARET 2024	APRIL 2024
1.	IGD	16	19	11
2.	ICU	10	8	2
3.	HCU	2	0	1
4.	MATERNITAS	0	0	1
5.	PERINATOLOGI	3	2	4
6	IRNA	14	10	11
7	IKO	0	0	0
Total		45	39	30

3.1.4.6.2 Grafik Jumlah Pasien Rujuk Eksternal Bulan April 2024



Analisis :

- 1. Terjadi penurunan jumlah pasien yang dirujuk ke RS lain dalam 3 bulan terakhir, jumlah terbanyak pada bulan April 2024 yaitu dari Unit IGD yaitu 11 pasien, IRNA 11 pasien, ICU 2 pasien, HCU 1 pasien, Neonatologi 4 pasien, Maternitas 1 pasien, dengan total pasien rujukan keluar April 2024 sebanyak 30 pasien.
- 2. Alasan rujuk karena sarana dan prasarana tidak dimiliki oleh RSPH Malang, seperti :
 - a) Spesialis Bedah Syaraf, Bedah Anak, Bedah Digestif.
 - b) Percutaneous Coronary Intervention (PCI).
 - c) Hemodialisis (HD)

- d) Pro scleroterapi endoscopy.
 - e) Pro kolonoskopi.
 - f) Stroke unit.
 - g) Membutuhkan alat khusus (locking plate, C-Arm)
 - h) Membutuhkan ventilator bayi
3. Alasan rujuk karena plavon habis pada bulan april 2024 tidak ada.

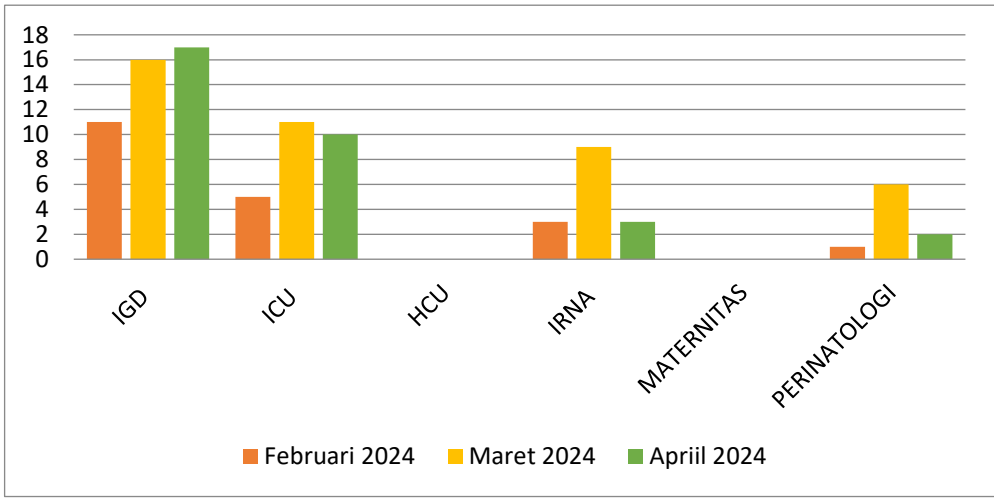
Rencana Tindak Lanjut :

- 1. Dilakukan evaluasi alasan terhadap rujukan pasien keluar yang semakin meningkat
- 2. Dilakukan komunikasi dengan DPJP melalui rapat komdik terkait plavon minus.

3.1.4.7 Laporan Pasien Meninggal
3.1.4.7.1 Tabel Hasil Rekapitulasi Jumlah Pasien Meninggal Bulan April 2024

NO	UNIT ASAL PASIEN MENINGGAL	FEBRUARI 2024	MARET 2024	APRIL 2024
1.	IGD	11	16	17
2.	ICU	5	11	10
3	HCU	0	0	0
4.	IRNA	3	9	3
5.	MATERNITAS	0	0	0
6	PERINATOLOGI	1	6	2
Total		20	42	32

3.1.4.7.2 Grafik Jumlah Pasien Meninggal Bulan April 2024



Analisis :

- 1. Jumlah pasien meninggal dunia pada bulan April 2024 sebanyak 32 pasien
- 2. Jumlah terbanyak yaitu dari IGD sejumlah 17 pasien, ICU sebanyak 10 pasien, Neonatologi sebanyak 2 pasien yang terdiri dari IUFD 1 dan premature 1 dan dari IRNA sebanyak 3 pasien.
- 3. Pada bulan maret 2024 Jumlah kasus DOA di IGD sebanyak 8 kasus.
- 4. Pengisian EWS sudah dilakukan di IGD dan IRNA.

Rencana Tindak Lanjut :

Dilakukan evaluasi terhadap pasien datang ke IGD dengan kasus DOA

3.1.4.8 Pengisian Form A, B dan Discart Planning

3.1.4.8.1 Tabel Kelengkapan Pengisian Form A, B dan Discart Planning

NO	NAMA PETUGAS	FEBRUARI		MARET		APRIL	
		FORM MPP	DISCARD PLANING	FORM MPP	DISCARD PLANING	FORM MPP	DISCARD PLANING
		JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH
1	Daning Pravitia YSM,S.Tr.Keb	48	32	52	32	64	32
2	Novita Pratama M,Amd.Keb	43	33	43	33	66	33
3	Fadilla Ayu,S.Kep	29	34	49	34	58	34
4	Cindytya,S.Kep	32	33	42	33	62	33
5	Wiwit Indah Yanti,S.Kep			32	32	48	32

3.1.5 Cleaning Service

3.1.5.1 Tabel Evaluasi

NO	JENIS	TARGET	APRIL	
			CAPAIAN	PROSENTASE
1	SEIRI / RINGKAS	6	5.86	98%
2	SEITON / RAPI	8	7.20	90%
3	SEISO / RESIK	18	9.35	52%
4	SEIKETSU / RAWAT	8	6.92	86%
5	SHITSUKE / RAJIN	12	9.32	78%

Analisis :

Metode evaluasi unit CS masih dilakukan bertahap dilakukan uji coba pada bulan Maret 2024. Monitoring dan evaluasi metode kemudian dilakukan perbaikan pada bulan April. Hasil mulai terlihat pada bulan April 2024. Capaian masih belum dapat memenuhi target. Hal ini disebabkan oleh : penyesuaian pengisian borang supervise baru oleh ka unit CS, hasil supervise dilapangan yang masih banyak perlu pembenahan termasuk kebersihan area (52%).

Rencana Tindak Lanjut :

- 1. Penyempurnaan pengisian borang di bulan Mei 2024
- 2. Supervisi rutin dengan evaluasi terfokus pada Seiso/resik

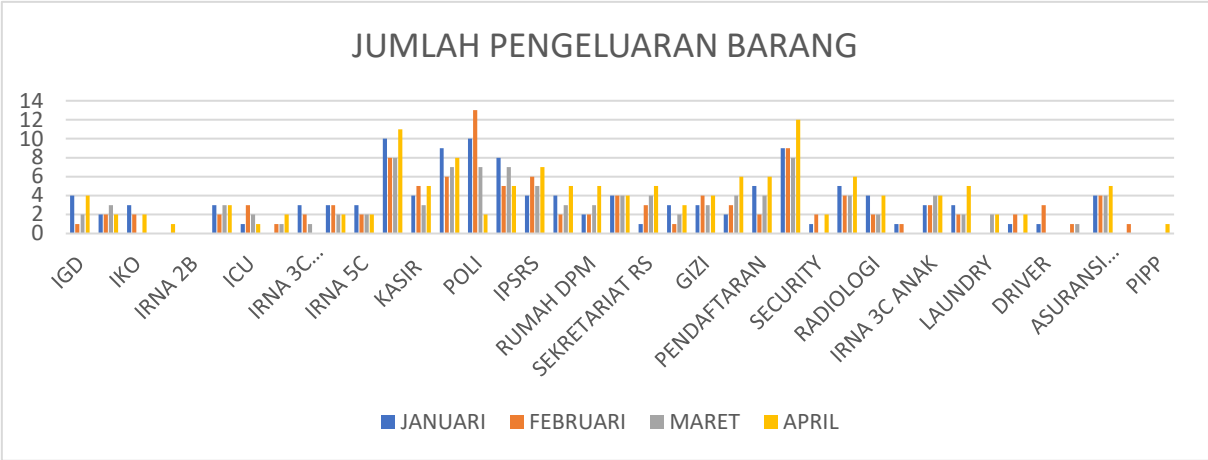
3.1.6 Pengadaan dan Gudang Umum

3.1.6.1 Tabel Laporan Pencatatan Pengeluaran Barang

NO	UNIT	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL
1	IGD	4	1	2	4
2	MATERNITAS	2	2	3	2
3	IKO	3	2	0	2
4	IRNA 2A	0	0	0	1
5	IRNA 2B	0	0	0	0
6	IRNA 2C	3	2	3	3
7	ICU	1	3	2	1
8	IRNA 3A	0	1	1	2

9	IRNA 3C DEWASA	3	2	1	0
10	IRNA 4C+4A	3	3	2	2
11	IRNA 5C	3	2	2	2
12	MS PTP LAWANG,MS KARLOS MS	10	8	8	11
13	KASIR	4	5	3	5
14	DAPUR	9	6	7	8
15	POLI	10	13	7	2
16	CLEANING SERVICE	8	5	7	5
17	IPSRs	4	6	5	7
18	GUDANG FARMASI	4	2	3	5
19	RUMAH DPM	2	2	3	5
20	SEKRETARIAT PT	4	4	4	4
21	SEKRETARIAT RS	1	3	4	5
22	CSSD	3	1	2	3
23	GIZI	3	4	3	4
24	REKAM MEDIS	2	3	4	6
25	PENDAFTARAN	5	2	4	6
26	DEPO FARMASI	9	9	8	12
27	SECURITY	1	2	0	2
28	LABORATORIUM	5	4	4	6
29	RADIOLOGI	4	2	2	4
30	FISIOTERAPI	1	1	0	0
31	IRNA 3C ANAK	3	3	4	4
32	NS NICU	3	2	2	5
33	LAUNDRY	0	0	2	2
34	LANTAI 6A,7A,8A	1	2	0	2
35	DRIVER	1	3	0	0
36	SIMRS	0	1	1	0
37	ASURANSI CENTER	4	4	4	5
38	DPW	0	1	0	0
39	PIPP			0	1

3.1.6.2 Grafik Jumlah Pengeluaran Barang



Analisis :
Pada grafik diatas dapat kita lihat bahwa data barang paling banyak ada pada unit Depo farmasi namun rata-rata dari 4 bulan, klinik Mutiara Sehat lebih tinggi

- Rencana Tindak Lanjut :**
- 1. Mendisiplinkan kepatuhan jadwal pengambilan barang
 - 2. Memberi edukasi ke unit agar tidak salah input barang atau salah unit
 - 3. Menyarankan ke all unit agar punya data inventaris ATK secara terperinci

3.2 Komite dan Tim

3.2.1 Komite Mutu

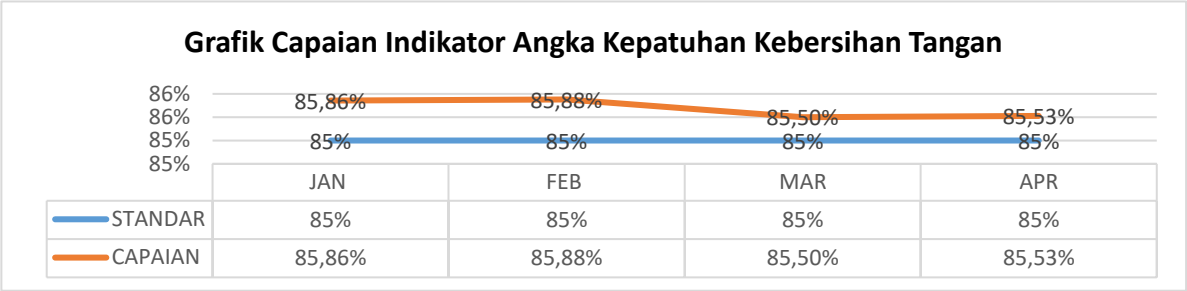
3.2.1.1 Indikator Mutu Nasional

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24
INDIKATOR MUTU NASIONAL						
1	Angka Kepatuhan Kebersihan Tangan	≥ 85%	85,86%	85,88%	85,5%	85,53%
2	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)	100%	93,04%	93,15%	93,3%	93,52%
3	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	99,9%	81,2%	98,78%	100%
4	Waktu Tanggap Operasi Seksio Sesarea Emergensi	≥ 80%	100%	100%	100%	100%
5	Waktu Tunggu Rawat Jalan	≥ 80%	95,2%	91,7%	95,74%	52,7%
6	Penundaan Operasi Elektif	≤ 5%	0%	0%	0%	0%
7	Kepatuhan Waktu Visite Dokter	≥ 80%	76,19%	79,08%	79,28%	78,06%
8	Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium	100%	98,69%	98,8%	98,46%	97,5%
9	Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional	≥ 80%	100%	100%	100%	100%
10	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (Clinical Pathway)	≥ 80%	63,8%	71,62%	67,56%	66,7%

11	Kepatuhan Upaya Pencegahan Risiko Pasien Jatuh	100%	98,47%	97,47%	99,54%	99,67%
12	Kecepatan Waktu Tanggap Komplain	≥ 80%	100%	93,15%	100%	100%
13	Kepuasan Pasien	≥ 76,61	100%	91,89%	99,63%	99,82%

3.2.1.1.1 Angka Kepatuhan Kebersihan Tangan

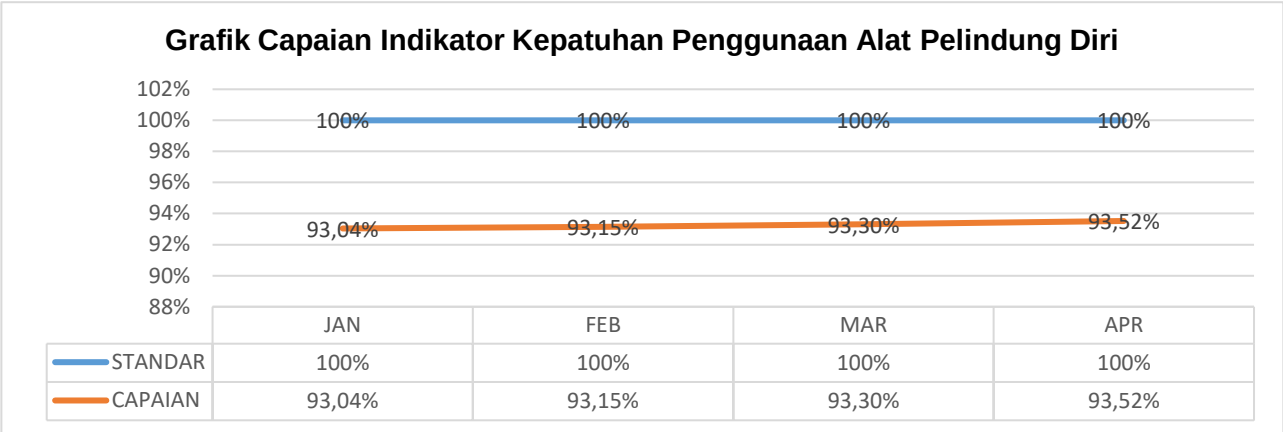
3.2.1.1.1.1 Grafik Capaian Indikator Angka Kepatuhan Kebersihan Tangan



PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan angka kepatuhan kebersihan tangan semaksimal mungkin (100%) dengan target peningkatan $\pm$ 5% setiap bulannya.				
DO	- Mendata ulang jumlah kebutuhan tatakan dan botol handrub unit. - Mengajak Karu untuk ikut mengecek kebutuhan fasilitas kebersihan tangan unitnya. - Monitoring pelaksanaan audit kepatuhan kebersihan tangan. - Melakukan supervisi terkait fasilitas kebersihan tangan. - Melakukan sosialisasi kebersihan tangan antar staf dibantu oleh IPCLN dan anggota Komite PPI lainnya.				
STUDY	Prosentase kepatuhan kebersihan tangan keseluruhan sudah mencapai standart minimal pada bulan ini yaitu sebesar 85,53%. Banyak ditemukan temuan petugas tidak melakukan kebersihan tangan sebelum melakukan tindakan karena terbiasa beranggapan tangannya sudah bersih dan perlu diingatkan dulu (pada saat di audit baru patuh). Selain itu, dari hasil supervise fasilitas kebersihan tangan masih ditemukan bed pasien atau troli tindakan yang tidak dilengkapi dengan handrub. Dari segi petugas, ada yang lebih memilih untuk Memakai sarung tangan (handscoon) dibandingkan dengan cuci tangan seperti pada profesi DPJP.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
- Meningkatkan kebersihan tangan.	- Meningkatkan kepatuhan kebersihan tangan.	- Tercapainya kepatuhan unit masing-masing diatas 85%.	- Resosialisasi 5 moment dan 6 langkah cuci tangan. - Melakukan audit kepatuhan kebersihan tangan secara rutin. - Memberikan reward-pembelajaran. - Melakukan control monitoring fasilitas kebersihan tangan di unit pelayanan. - Mengingatkan perawat atau nakes lain untuk lebih mengutamakan upaya kebersihan tangan agar aman bagi petugas dan pasien.	-Seluruh petugas yang melakukan pelayanan di RS.	- Satu bulan

3.2.1.1.2 Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)

3.2.1.1.2.1 Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri

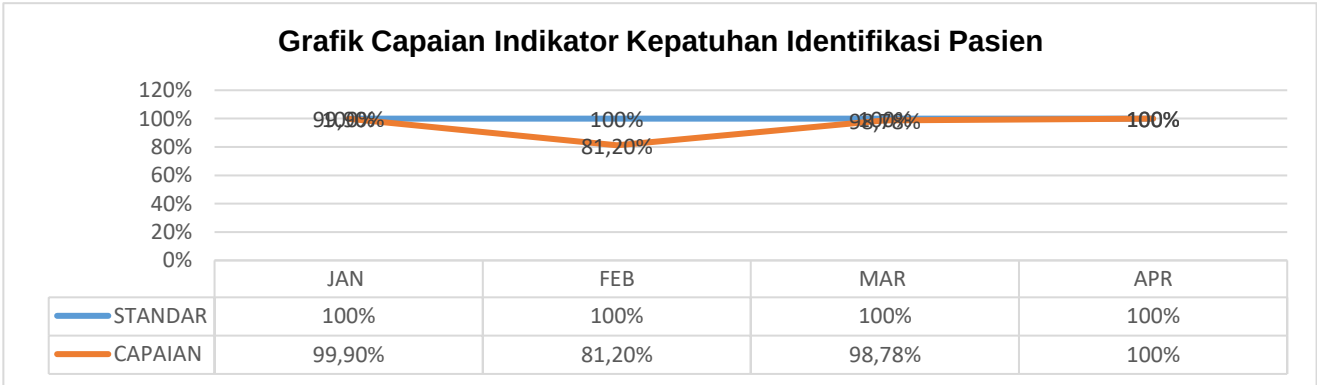


PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan angka kepatuhan penggunaan APD semaksimal mungkin (100%) dengan target peningkatan ± 5% setiap bulannya.				
DO	- Monitoring pelaksanaan audit kepatuhan penggunaan APD yang sesuai. - Melakukan supervise terkait ketersediaan dan kesesuaian penggunaan APD. - Menegur dan melakukan sosialisasi pemakaian APD yang tepat antar staf dibantu oleh IPCLN dan anggota Komite PPI lainnya. - Menegur kepala unit dan IPCLN yang anggotanya ketahuan tidak patuh dalam pemakaian APD. - Sudah dikeluarkan edaran terkait penggunaan jas dokter.				
STUDY	Prosentase kepatuhan penggunaan APD keseluruhan belum mencapai standart, pada bulan ini yaitu sebesar 93,52% meningkat sedikit dari bulan sebelumnya. Dari hasil monitoring dan supervise, penggunaan APD oleh petugas nakes non dokter sudah cukup baik, namun masih ditemukan 1 petugas yang masih berlebihan memakai APD, seperti halnya pada salah satu dokter yang lebih memilih memakai handscoon saat visite karena beranggapan safety untuk dirinya. Peningkatan APD juga ada pada unit CS Dimana petugas sudah tertib memakai sarung tangan kerja, tidak memakai handscoon saat membersihkan ruangan.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
- Meningkatkan kepatuhan pemakaian APD.	- Meningkatkan kepatuhan pemakaian APD di unit.	- Tercapainya kepatuhan APD unit minimal meningkat 2% pada bulan berikutnya.	- Melakukan sosialisasi antar staf tentang penggunaan APD. - Menegur staf yang salah dalam penggunaan APD dan memberikan metode pembelajaran dengan mendata ketidak patuhan teman-teman di unitnya. - Menanamkan kesadaran pada pribadi masing-masing petugas bahwa pemakaian APD yang	- Seluruh petugas yang melakukan pelayanan di RS.	- Satu bulan

			benar ini penting. - Berkolaborasi dengan perawat untuk tidak memberikan handscoon jika CS meminta handscoon. Selain itu kolaborasi dengan Karu CS untuk menyediakan stok sarung tangan sesuai nama petugas dan 1 stok tiap ruangan untuk menanggulangi sarung tangan yang cepat rusak. - Menjadikan kebiasaan pemakaian APD sesuai dengan jenis transmisi penyakit dan tindakan yang akan dilakukan.		
--	--	--	---	--	--

3.2.1.1.3 Kepatuhan Identifikasi Pasien

3.2.1.1.3.1 Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Identifikasi Pasien

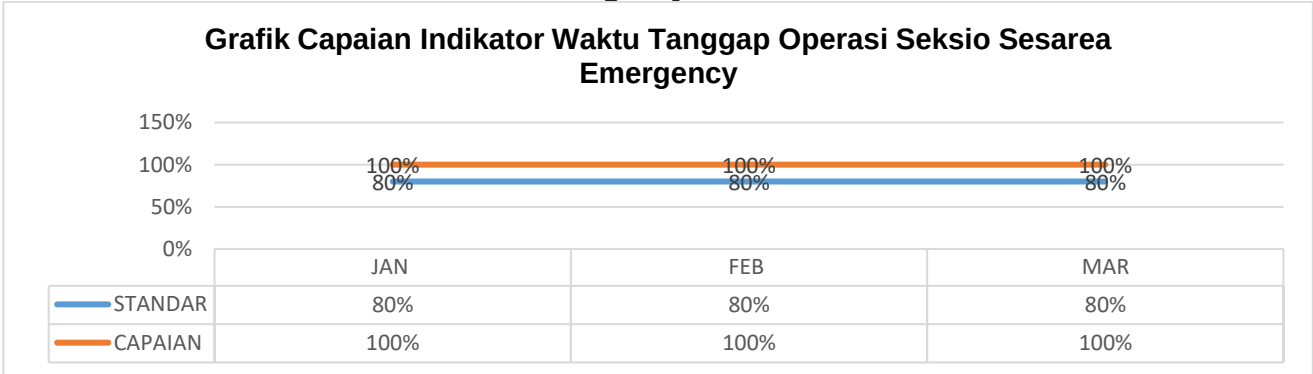


PLAN	Kami berencana untuk mempertahankan angka keatuhan identifikasi pasien semaksimal mungkin (100%).
DO	- Melakukan supervisi pada petugas di unit secara berkelanjutan - Kepala Instalasi untuk terus melaksanakan supervisi dan sosialisasi terkait identifikasi pasien - Memberikan teguran kepada petugas yang tidak melakukan identifikasi pasien atau melakukan identifikasi tetapi masih salah
STUDY	Berdasarkan hasil capaian di atas, dapat diketahui bahwa capaian kepatuhan identifikasi pasien di RS Prima Husada Malang masih belum mencapai standart pada bulan Januari hingga Maret tahun 2024. Pada bulan April tahun 2024 capaian telah mencapai standart

	100%. Supervisi secara berkelanjutan serta memberikan teguran secara langsung cukup efektif untuk meningkatkan kepatuhan identifikasi pasien.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
- Mempertahankan kepatuhan identifikasi pasien	- Mempertahankan kepatuhan identifikasi pasien	- Tercapainya indikator kepatuhan identifikasi pasien pada bulan berikutnya.	- Terus melakukan supervisi pada petugas unit - Memberikan teguran secara langsung jika menemukan petugas yang tidak melakukan identifikasi pasien dengan tepat	- Seluruh petugas yang melakukan pelayanan di RS.	- Satu bulan

3.2.1.1.4 Waktu Tanggap Operasi Seksio Sesarea Emergency

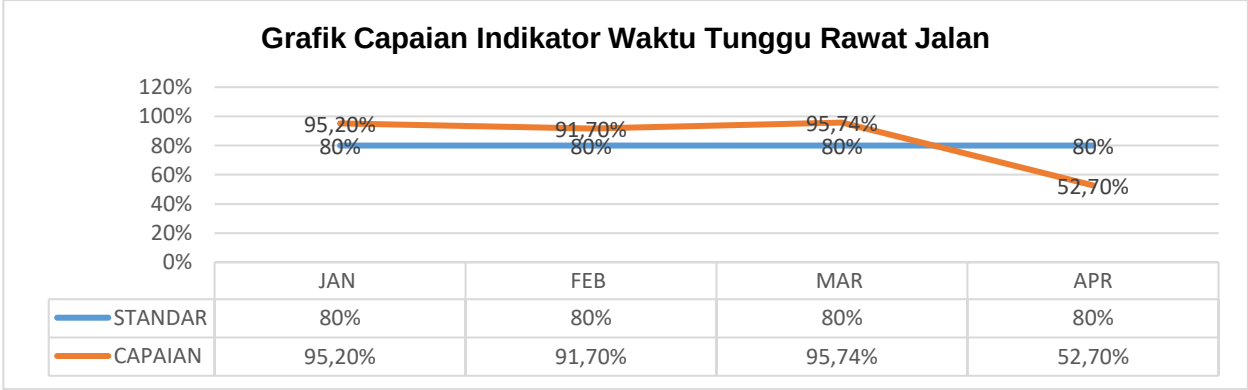
3.2.1.1.4.1 Grafik Capaian Indikator Waktu Tanggap Operasi Seksio Sesarea Emergency



Analisis Capaian :
 Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa persentase waktu tanggap operasi seksio sesarea emergency pada bulan Januari hingga April tahun 2024 juga capaian indikator waktu tanggap operasi seksio sesarea Emergency telah mencapai standart. Tim IGD dan IKO melakukan koordinasi dan tindakan secara tepat dan cepat sehingga operasi bisa dilaksanakan.

3.2.1.1.5 Waktu Tunggu Rawat Jalan

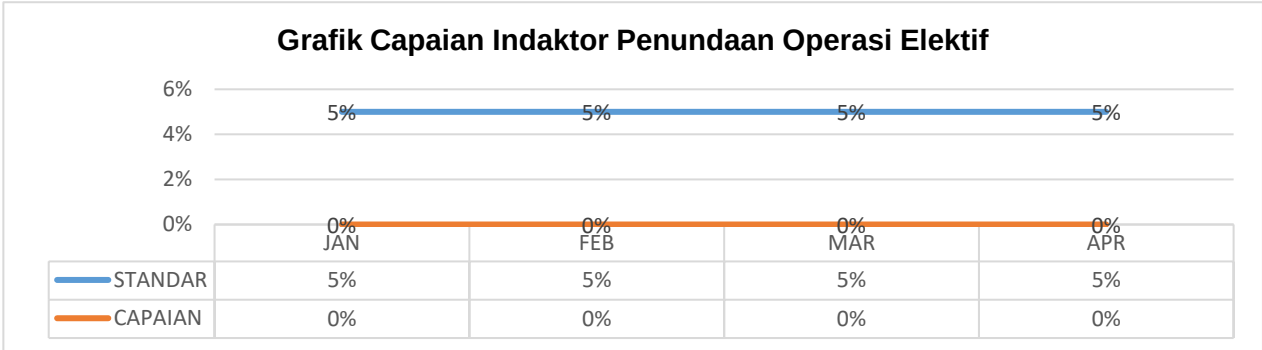
3.2.1.1.5.1 Grafik Capaian Indikator Waktu Tunggu Rawat Jalan



PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan capaian indikator waktu rawat jalan hingga mencapai standart 80%.				
DO	Memberikan teguran kepada DPJP yang sering datang terlambat.				
STUDY	Berdasarkan hasil capaian di atas, diketahui persentase kepatuhan waktu visite dokter pada bulan Januari hingga Maret tahun 2024 telah mencapai standart jika dilihat dari input mutu pada SIMRS, tetapi nilai tersebut tidak sesuai dengan hasil supervisi dan juga keluhan terkait keterlambatan dokter untuk praktek poli. Berdasarkan hal tersebut, mutu melakukan penilaian dengan observasi langsung dan juga mengevaluasi keterlambatan DPJP. - Dpjp tepat waktu : dr.Farid, Sp.N, dr. Aida, Sp.OG, dr. Akhmad Syahrir, Sp.N, dr. Ardhi Bustami, Sp. PD, dr, Dewi Maharani, Sp.S, dr. Dicky, Sp.A, dr.Vita, Sp.KK, dr.Humaira, Sp.OG, dr.Ira, Sp.JP, dr.Miryanti, Sp.JP, dr.Nimim, Sp.THT.KL, dr.Pradana,Sp.U, dr.Yoga, Sp.JP, dr.Zora, Sp.PD , dr Viona Sp.A - Dpjp Tidak tepat waktu : dr.Andi,Sp.B, dr.Andy,Sp.P, dr.Elvi,Sp.P, dr.Iwan,Sp.B, dr.Nurhadi,Sp.M, - Dpjp dengan tindakan lama : dr. Anton, Sp.B, dr.Huda, Sp.KJ, dr.Didid, Sp.KJ, dr.Eko, Sp.KFR.				
	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
- Meningkatkan capaian indikator waktu tunggu rawat jalan.	- Meningkatkan capaian indikator waktu tunggu rawat jalan.	- Waktu tunggu rawat jalan <80%	Mengevaluasi dpjp yang sering terlambat dan juga memberikan teguran melalui komdik dan SDM.	Manajemen RS	- Satu bulan

3.2.1.1.6 Penundaan Operasi Elektif

3.2.1.1.6.1 Grafik capaian Indikator Penundaan Operasi Elektif

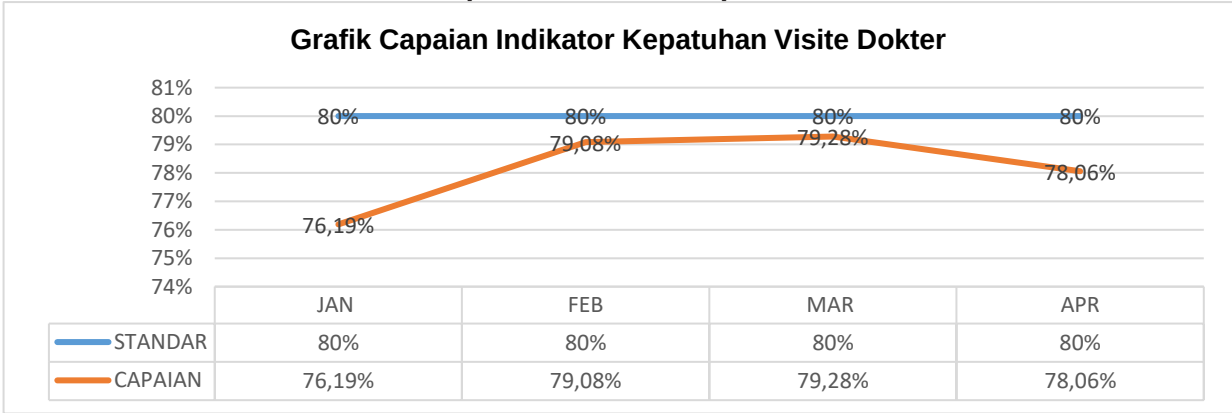


Analisa Capaian :

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa selama bulan Januari hingga April tahun 2024 tidak ada penundaan operasi elektif.

3.2.1.1.7 Kepatuhan Waktu Visite Dokter

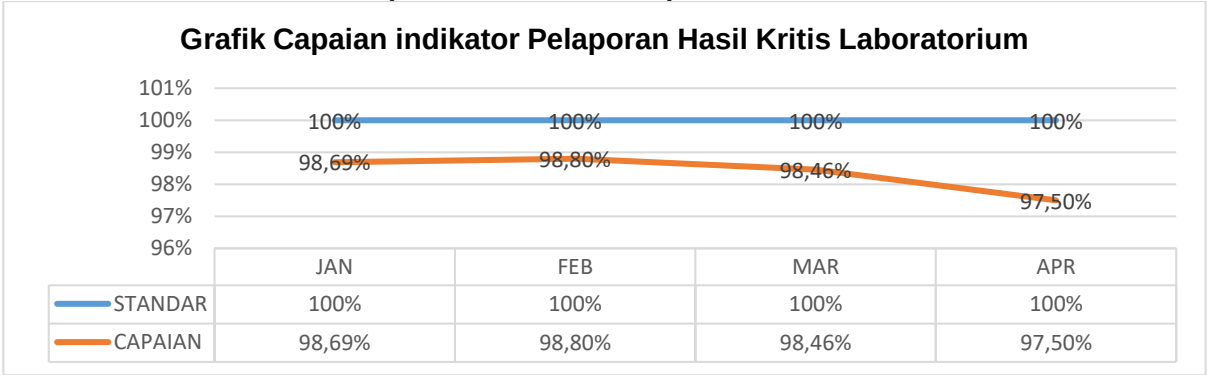
3.2.1.1.7.1 Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Visite Dokter



PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan angka kepatuhan waktu visite dokter hingga dapat mencapai standart 80%.				
DO	Memberikan teguran kepada DPJP yang melakukan visite lebih dari jam 14.00				
STUDY	Berdasarkan hasil capaian di atas, diketahui persentase kepatuhan waktu visite dokter pada bulan Januari hingga April tahun 2024 belum mencapai standart. Dari hasil supervisi didapatkannya Angka kepatuhan waktu visite Dokter belum mencapai standart karena masih banyak dokter yang visite diatas jam 14.00 karena masih bertugas di RS lain karena RS Prima Husada tidak memiliki Dokter tetap. Dokter visite jam 07.00-14.00 : dr. Ira, Sp.JP, dr. Mira, Sp.JP, dr. Anton, Sp.B, dr. dr. Dicky,Sp.A , dr. Elvi, Sp.P, dr. Dewi, Sp.S, dr. Ardhi, Sp.PD, dr. Humairoh, Sp.Og, dr. Aida, Sp.Og, dr. Nimim, Sp.THT.KL, dr. Dokter visite jam 14.00-21.00 : dr. Heriyatmo, Sp.PD, dr. Andi, Sp.P, dr. Farid, Sp.S, dr. Yoga, Sp.JP (Tidak menentu)				
	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
- Meningkatkan kepatuhan waktu visite dokter	- Meningkatkan kepatuhan waktu visite dokter	- Capaian Kepatuhan Visite dokter bisa meningkat pada bulan selanjutnya	Mengevaluasi hasil setelah memberikan teguran kepada DPJP dan memberikan surat peringatan kepada DPJP yang masih visite di atas jam 14.00	Manajemen RS	- Satu bulan

3.2.1.1.8 Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium

3.2.1.1.8.1 Grafik Capaian Indikator Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium

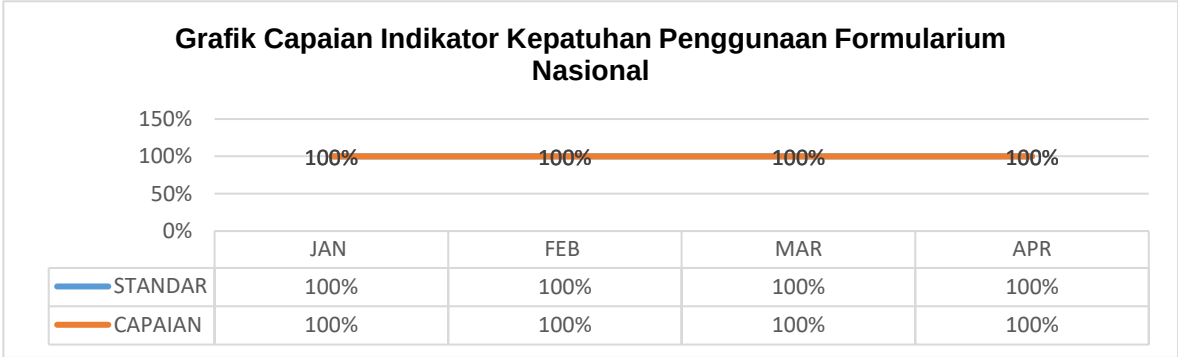


PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan pelaporan hasil kritis laboratorium hingga mencapai standart 100%				
DO	Meningkatkan supervisi baik dari komite mutu maupun kepala instalasi laboratorium supaya seluruh petugas laboratorium segera melaporkan hasil kritis dan melakukan dokumentasi dengan baik dan lengkap.				
STUDY	Berdasarkan hasil capaian di atas, diketahui indikator pelaporan hasil kritis laboratorium pada bulan Januari hingga April tahun 2024 masih belum mencapai standart. Berdasarkan hasil supervisi masih ada petugas yang melaporkan hasil kritis laboratorium tetapi tidak dilakukan pendokumentasian dengan lengkap.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU

Meningkatkan capaian indikator pelaporan hasil kritis laboratorium	Meningkatkan capaian indikator pelaporan hasil kritis laboratorium	Capaian pelaporan hasil kritis laboratorium dapat mencapai standart 100% pada bulan berikutnya	- Menganalisa jumlah hasil kritis laboratorium yang terlapor dan tidak terlapor - Memberikan teguran secara langsung kepada petugas laboratorium yang tidak melaporkan hasil kritis laboratorium ataupun yang melapor tapi tidak dilakukan pendokumentasian dengan baik dan lengkap.	- Komite mutu - Kepala instalasi laboratorium	Satu bulan
--	--	--	---	--	------------

3.2.1.1.9 Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional

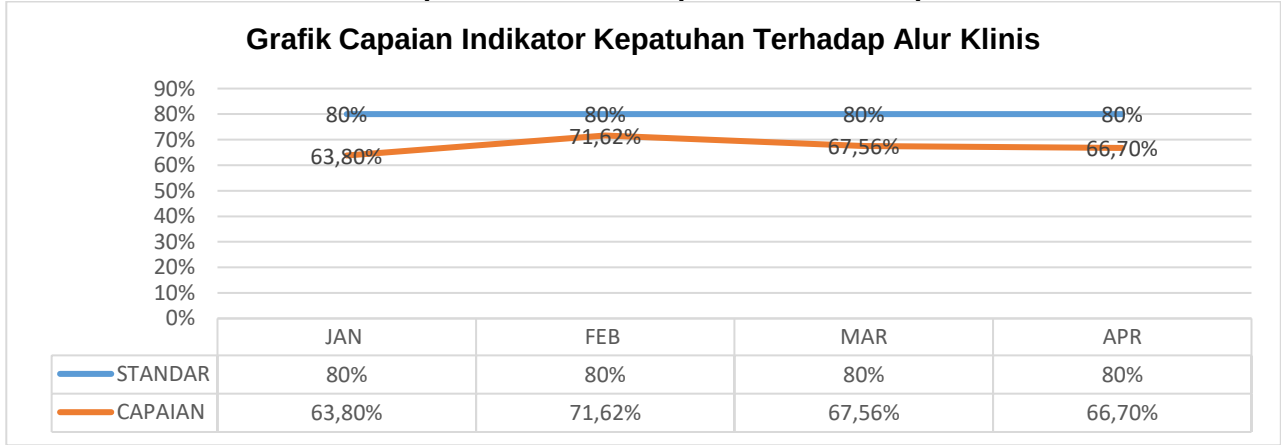
3.2.1.1.9.1 Grafik Capaian Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional



Analisis Capaian :
 Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa capaian indikator kepatuhan penggunaan Formularium Nasional pada Bulan Januari hingga April Tahun 2024 telah mencapai standart.

3.2.1.1.10 Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (Clinical Pathway)

3.2.1.1.10.1 Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Terhadap Alur Klinis

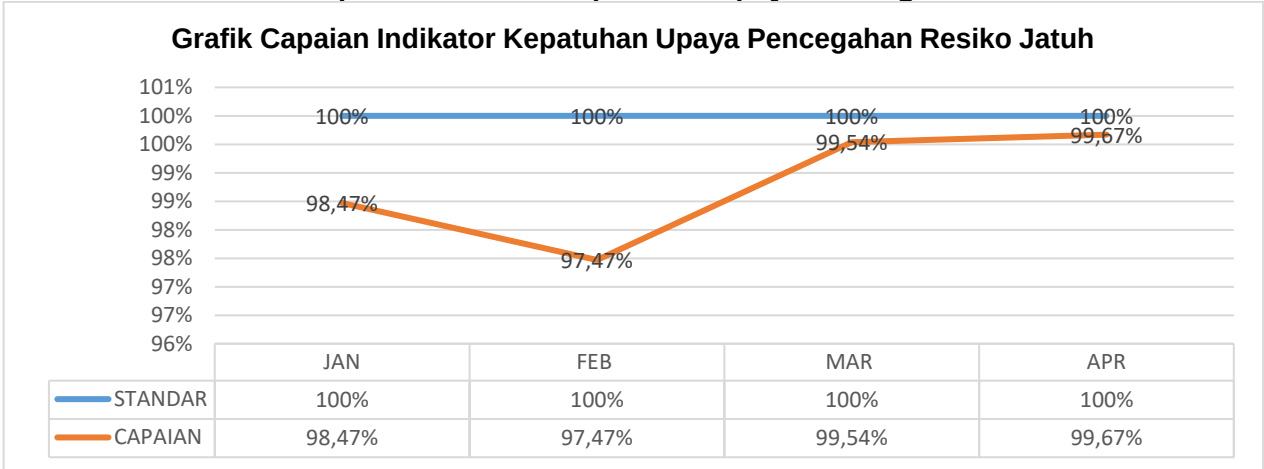


PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan capaian indikator kepatuhan terhadap alur klinis hingga mencapai standart 80%.
DO	Melakukan koordinasi dengan seluruh bidang profesi (dokter, perawat, apoteker dan ahli gizi) supaya mengisi form CP sesuai dengan yang diberikan kepada pasien sehingga kepatuhan terhadapa alur klinis dapat dianalisa.

STUDY	Berdasarkan hasil capaian di atas, diketahui indikator kepatuhan terhadap alur klinis masih belum stabil. Masih ditemukan profesi yang tidak memberikan asuhan sesuai dengan CP yang telah disepakati.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
- Meningkatkan capaian indikator kepatuhan terhadap alur klinis	- Meningkatkan capaian indikator kepatuhan terhadap alur klinis	- Capaian indikator kepatuhan terhadap alur klinis bisa mencapai standart 80%.	Melibatkan seluruh bidang profesi (dokter, perawat, apoteker dan ahli gizi) supaya mengisi form CP sesuai yang diberikan kepada pasien sehingga kepatuhan terhadap alur klinis dapat dianalisa.	- Komite mutu	- Satu bulan

3.2.1.1.11 Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Jatuh

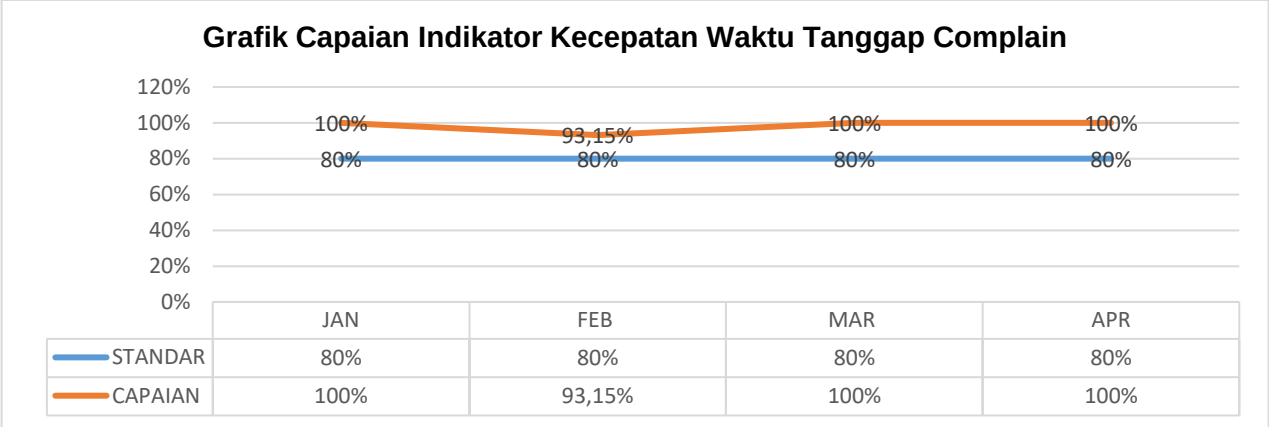
3.2.1.1.11.1 Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Jatuh



PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan capaian indikator kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh hingga mencapai standart 100%				
DO	Meningkatkan KIE kepada pasien dan keluarga tentang kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh				
STUDY	Berdasarkan capaian diatas, dapat diketahui bahwa prosentase kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh pada bulan Januari hingga April tahun 2024 belum mencapai standart. Kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh belum mencapai standart karena masih ditemukan tempat tidur pasien yang tidak terpasang handrell pada pasien rawat inap. Perawat telah memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga pasien agar selalumemasang handrell tetapi seringkali keluarga pasien tidak memasang kembali handrell ketika pasien telah dari kamar mandi.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
- Meningkatkan capaian indikator kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh	- Meningkatkan capaian indikator kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh	- Capaian indikator kepatuhan terhadap upaya pencegahan resiko jatuh bisa mencapai 100%.	KIE kepada pasien dan keluarga tentang upaya pencegahan resiko jatuh harus lebih ditekankan dan disertai tanda tangan sebagai bukti bahwa edukasi telah dilakukan.	Perawat instalasi rawat inap	- Satu bulan

3.2.1.1.12 Kecepatan Waktu Tanggap Komplain

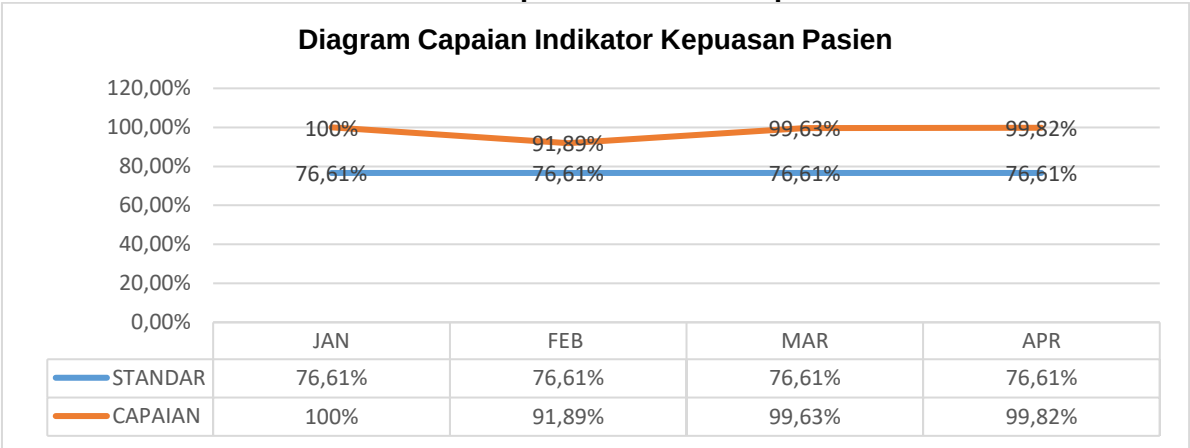
3.2.1.1.12.1 Grafik Capaian Indikator Kecepatan Waktu Tanggap Komplain



Analisis:
Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa persentase kecepatan waktu tanggap kompalin pada bulan Januari tahun 2024 capaian telah mencapai standart 100%, PIPP dan bidang terkait telah menanggapi dan menyelesaikan complain kurang dari 24 jam. Pada bulan Februari capaian menurun menjadi 93,15% tetapi masih diatas standart, pada bulan Maret dan April capaian kembali meningkat menjadi 100%.

3.2.1.1.13 Kepuasan Pasien

3.2.1.1.13.1 Grafik Capaian Indikator Kepuasan Pasien



Analisis :
Berdasarkan data diatas, diketahui bahwa persentase kepuasan pasien pada bulan Januari hingga April tahun 2024 sudah mencapai standart

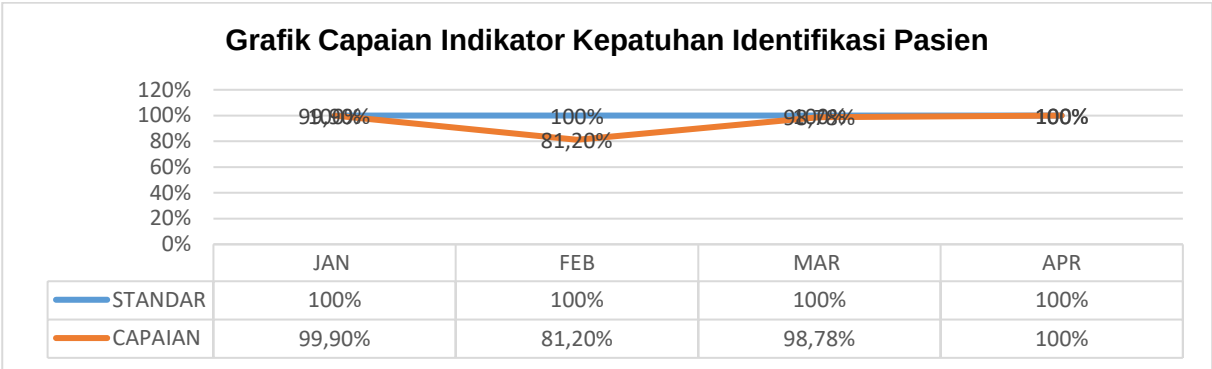
3.2.1.2 Indikator Mutu Prioritas

3.2.1.2.1 Indikator Sasaran Keselamatan Pasien

NO.	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	99,9%	81,2%	98,78%	100%
2	Kejadian ketidakpatuhan penempelan label obat high alert	0	0	0	0	0
3	Kejadian tidak dilaksanakannya penandaan lokasi operasi	0	0	0	0	0
4	Kepatuhan kebersihan tangan	100%	85,86%	85,88%	85,5%	85,53%
5	Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh	100%	98,47%	97,47%	99,54%	99,67%

3.2.1.2.1.1 Kepatuhan Identifikasi Pasien

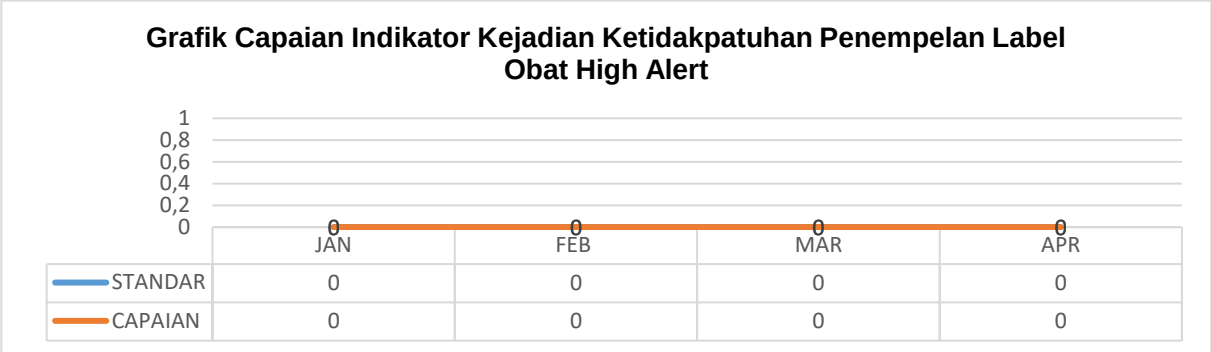
3.2.1.2.1.1.1 Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Identifikasi Pasien



PLAN	Kami berencana untuk mempertahankan angka keatuhan identifikasi pasien semaksimal mungkin (100%).				
DO	- Melakukan supervisi pada petugas di unit secara berkelanjutan - Kepala Instalasi untuk terus melaksanakan supervisi dan sosialisasi terkait identifikasi pasien - Memberikan teguran kepada petugas yang tidak melakukan identifikasi pasien atau melakukan identifikasi tetapi masih salah				
STUDY	Berdasarkan hasil capaian di atas, dapat diketahui bahwa capaian kepatuhan identifikasi pasien di RS Prima Husada Malang masih belum mencapai standart pada bulan Januari hingga Maret tahun 2024. Pada bulan April tahun 2024 capaian telah mencapai standart 100%. Supervisi secara berkelanjutan serta memberikan teguran secara langsung cukup efektif untuk meningkatkan kepatuhan identifikasi pasien.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
- Mempertahankan kepatuhan identifikasi pasien	- Mempertahankan kepatuhan identifikasi pasien	- Tercapainya indikator kepatuhan identifikasi pasien pada bulan berikutnya.	- Terus melakukan supervisi pada petugas unit - Memberikan teguran secara langsung jika menemukan petugas yang tidak melakukan identifikasi pasien denga tepat	- Seluruh petugas yang melakukan pelayanan di RS.	- Satu bulan

3.2.1.2.1.2 Kejadian Ketidakpatuhan Penempelan Label Obat High Alert

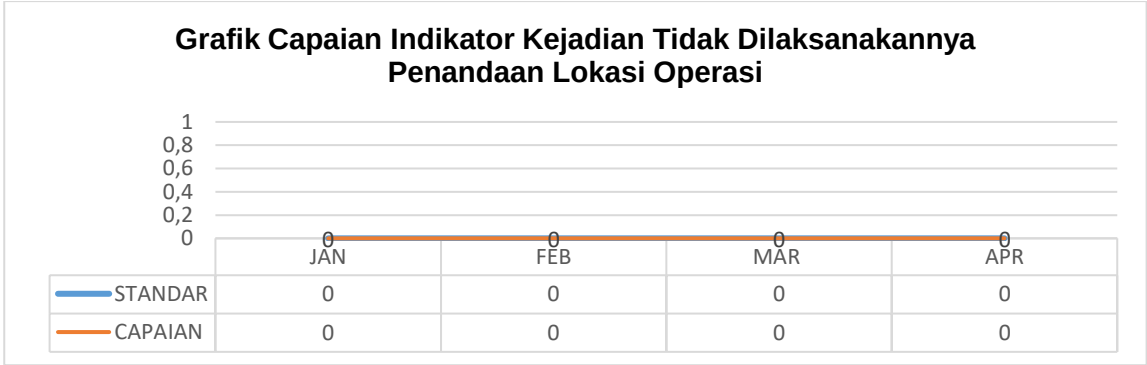
3.2.1.2.1.2.1 Grafik Capaian Indikator Kejadian Ketidakpatuhan Penempelan Label Obat High Alert



Analisis:
Berdasarkan data diatas, dapat diketahui persentase ketidakpatuhan penempelan label obat high alert pada bulan Januari hingga April tahun 2024 telah mencapai standart.

3.2.1.2.1.3 Kejadian Tidak Dilaksanakannya Penandaan Lokasi Operasi

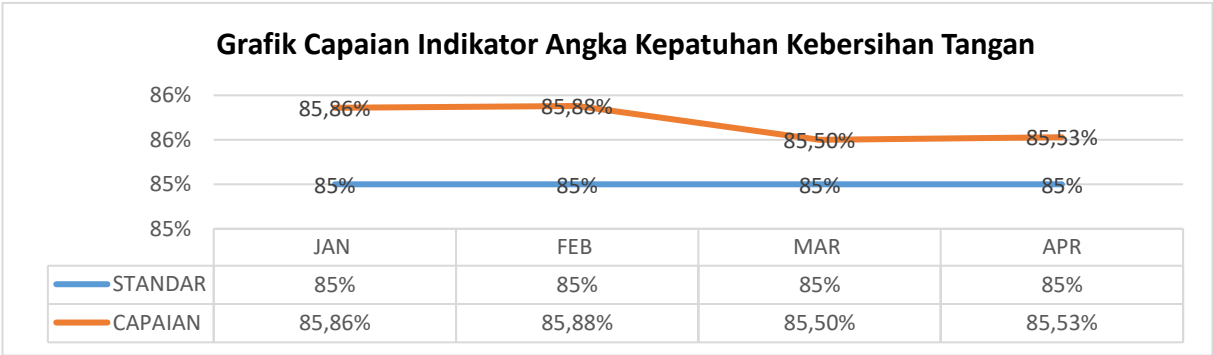
3.2.1.2.1.3.1 Grafik Capaian Indikator Kejadian Tidak Dilaksanakannya Penandaan Lokasi Operasi



Analisis :
Berdasarkan data diatas dapat diketahui persentase tidak dilaksanakannya penandaan lokasi operasi pada bulan Januari hingga April tahun 2024 telah mencapai standart.

3.2.1.2.1.4 Kepatuhan Kebersihan Tangan

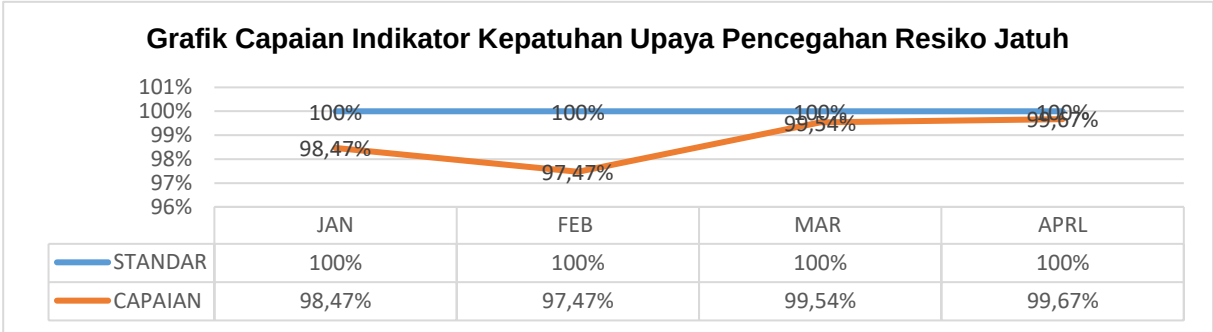
3.2.1.2.1.4.1 Grafik Capaian Indikator Angka Kepatuhan Kebersihan Tangan



PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan angka kepatuhan kebersihan tangan semaksimal mungkin (100%) dengan target peningkatan $\pm$ 5% setiap bulannya.				
DO	- Mendata ulang jumlah kebutuhan tatakan dan botol handrub unit. - Mengajak Karu untuk ikut mengecek kebutuhan fasilitas kebersihan tangan unitnya. - Monitoring pelaksanaan audit kepatuhan kebersihan tangan. - Melakukan supervisi terkait fasilitas kebersihan tangan. - Melakukan sosialisasi kebersihan tangan antar staf dibantu oleh IPCLN dan anggota Komite PPI lainnya.				
STUDY	Prosentase kepatuhan kebersihan tangan keseluruhan sudah mencapai standart minimal pada bulan ini yaitu sebesar 85,53%. Banyak ditemukan temuan petugas tidak melakukan kebersihan tangan sebelum melakukan tindakan karena terbiasa beranggapan tangannya sudah bersih dan perlu diingatkan dulu (pada saat di audit baru patuh). Selain itu, dari hasil supervise fasilitas kebersihan tangan masih ditemukan bed pasien atau trolis tindakan yang tidak dilengkapi dengan handrub. Dari segi petugas, ada yang lebih memilih untuk Memakai sarung tangan (handscoon) dibandingkan dengan cuci tangan seperti pada profesi DPJP.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Meningkatkan kebersihan tangan.	Meningkatkan kepatuhan kebersihan tangan.	Tercapainya kepatuhan kebersihan unit masing-masing diatas 85%.	- Resosialisasi 5 moment dan 6 langkah cuci tangan. - Melakukan audit kepatuhan kebersihan tangan secara rutin. - Memberikan reward-pembelajaran. - Melakukan control monitoring fasilitas kebersihan tangan di unit pelayanan. - Mengingatkan perawat atau nakes lain untuk lebih mengutamakan upaya kebersihan tangan agar aman bagi petugas dan pasien.	- Seluruh petugas yang melakukan pelayanan di RS.	- Satu bulan

3.2.1.2.1.5 Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Jatuh

3.2.1.2.1.5.1 Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Jatuh



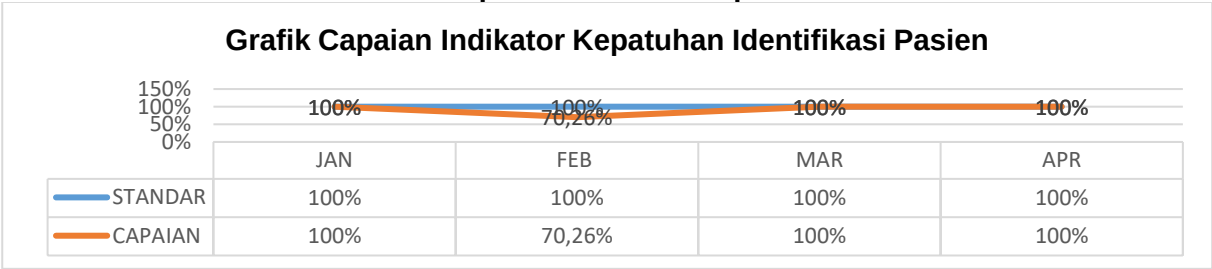
PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan capaian indikator kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh hingga mencapai standart 100%				
DO	Meningkatkan KIE kepada pasien dan keluarga tentang kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh				
STUDY	Berdasarkan capaian diatas, dapat diketahui bahwa prosentase kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh pada bulan Januari hingga April tahun 2024 belum mencapai standart. Kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh belum mencapai standart karena masih ditemukan tempat tidur pasien yang tidak terpasang handrell pada pasien rawat inap. Perawat telah memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga pasien agar selalumemasang handrell tetapi seringkali keluarga pasien tidak memasang kembali handrell ketika pasien telah dari kamar mandi.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Meningkatkan capaian indikator kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh	Meningkatkan capaian indikator kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh	Capaian indikator kepatuhan terhadap upaya pencegahan resiko jatuh bisa mencapai 100%.	KIE kepada pasien dan keluarga tentang upaya pencegahan resiko jatuh harus lebih ditekankan dan disertai tanda tangan sebagai bukti bahwa edukasi telah dilakukan.	Perawat instalasi rawat inap	- Satu bulan

3.2.1.2.2 Indikator Mutu Pelayanan Klinis Prioritas

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	70,26%	100%	100%
2	Kepatuhan penggunaan formularium Nasional	≥80%	100%	100%	100%	100%
3	Kejadian kesalahan penyiapan obat	0	1	0	0	0
4	Kejadian kesalahan penempelan label pada obat LASA	0	0	0	0	0
5	Angka keterlambatan penyediaan obat jadi rawat jalan >30 menit.	0%	68,81%	69,59%	73,43%	79,11%
6	Angka keterlambatan penyiapan obat racikan >60 menit.	0%	41,48%	50,77%	56,18%	61,29%
7	Kejadian kesalahan pemberian obat	0	0	0	0	0
8	Kejadian kesalahan penulisan etiket obat.	0	0	0	0	0
9	Kejadian ketidakpatuhan penempelan label obat high alert	0	0	0	0	0
10	Kejadian kesalahan input e-resep	0	0	0	0	0
11	Kejadian petugas tertusuk jarum	0	0	0	0	0
12	Kejadian terkena pemanas mesin press puyer	0	0	0	0	0
13	Kejadian ketidakpatuhan retur obat rawat inap	0	0	0	0	0
14	Kekosongan stok farmasi	0%	0,27%	0,36%	0,53%	0,7%

3.2.1.2.2.1 Kepatuhan Identifikasi Pasien

3.2.1.2.2.1.1 Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Identifikasi Pasien



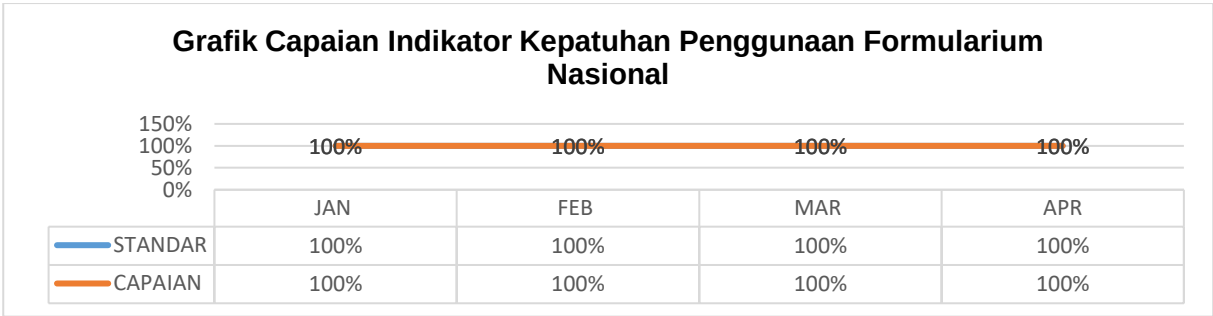
PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan angka keatuhan identifikasi pasien semaksimal mungkin (100%).
DO	- Melakukan supervisi pada petugas di unit secara berkelanjutan - Kepala Instalasi untuk terus melaksanakan supervisi dan sosialisasi terkait identifikasi pasien - Memberikan teguran kepada petugas yang tidak melakukan identifikasi pasien atau melakukan identifikasi tetapi masih salah
STUDY	Berdasarkan hasil capaian di atas, dapat diketahui bahwa capaian kepatuhan identifikasi pasien masih belum mencapai standart di bulan Februari, pada bulan Januari hingga April capaian telah mencapai standart 100%. Dari hasil supervisi didapatkan masih ditemukan petugas yang tidak melakukan identifikasi pasien dengan tepat ketika akan melakukan tindakan. Misalnya Ketika keluarga pasien mengambil obat dan tidak tahu tanggal lahir pasien beberapa petugas tetap memberikan obat tersebut

ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
- Meningkatkan kepatuhan identifikasi pasien	- Meningkatkan kepatuhan identifikasi pasien	- Tercapainya indikator kepatuhan identifikasi pasien pada bulan berikutnya.	- Meningkatkan supervisi pada petugas unit - Memberikan teguran secara langsung jika menemukan petugas yang tidak melakukan identifikasi pasien dengan tepat	- Seluruh petugas farmasi	- Satu bulan

3.2.1.2.2.2 Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional

3.2.1.2.2.2.1

Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional



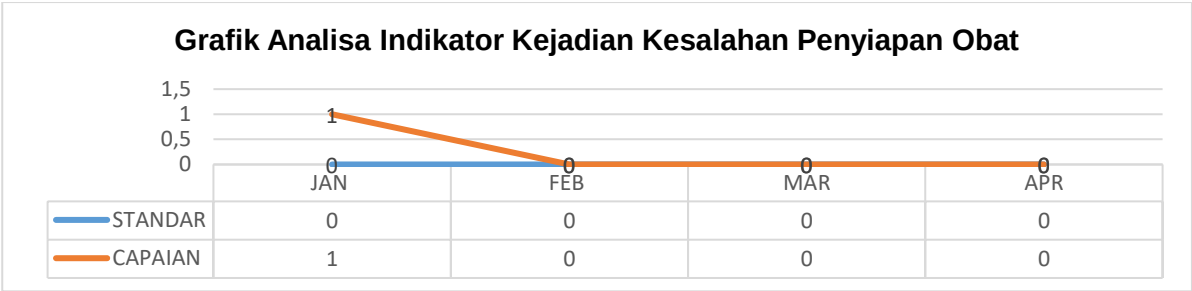
Analisis Capaian :

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa persentase kepatuhan penggunaan formularium nasional pada bulan Januari hingga April tahun 2024 telah mencapai standart

3.2.1.2.2.3 Kejadian Kesalahan Penyiapan Obat

3.2.1.2.2.3.1

Grafik Analisa Indikator Kejadian Kesalahan Penyiapan Obat

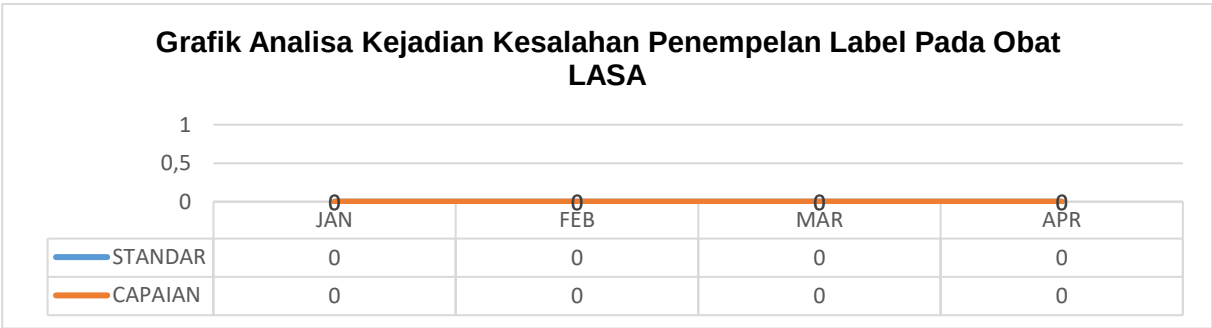


PLAN	Kami berencana untuk mempertahankan capaian kejadian kesalahan pemberian obat yang pada bulan ini telah mencapai standart.					
DO	- Melakukan supervisi pada petugas di unit farmasi secara berkelanjutan - Kepala unit farmasi harus menindaklanjuti anggota yang melakukan kesalahan penyiapan obat - Memberikan proses pembelajaran untuk petugas yang melakukan kesalahan pemberian obat					
STUDY	Berdasarkan data diatas, dapat diketahu bahwa kesalahan pemberian obat masih terjadi pada bulan Januari tahun 2024. Kesalahan pemberian obat terjadi karena petugas tidak teliti dalam melakukan penyiapan obat. Pada bulan Februari hingga April tahun 2024 diketahui tidak ada kejadian kesalahan penyiapan obat.					
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU	

Mempertahankan capaian kejadian kesalahan pemberian obat	Mempertahankan capaian kejadian kesalahan pemberian obat	Tidak ada kejadian kesalahan pemberian obat	- Meningkatkan supervisi pada petugas di unit farmasi secara berkelanjutan - Kepala unit farmasi harus menindaklanjuti anggota yang melakukan kesalahan penyiapan obat - Memberikan proses pembelajaran untuk petugas yang melakukan kesalahan pemberian obat	Seluruh petugas farmasi	Satu bulan
--	--	---	---	-------------------------	------------

3.2.1.2.2.4 Kejadian Kesalahan Penempelan Label Pada Obat LASA

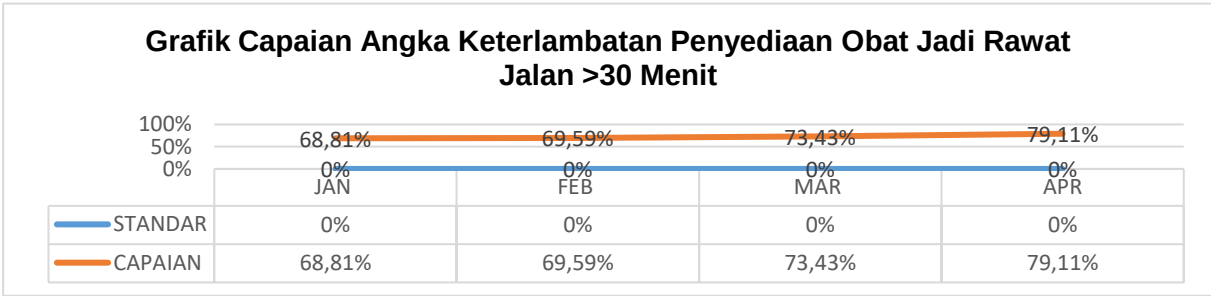
3.2.1.2.2.4.1 Grafik Analisa Kejadian Kesalahan Penempelan Label Pada Obat LASA



Analisis Capaian :
 Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan tidak ditemukan kejadian kesalahan penempelan pada obat LASA pada bulan Januari hingga April tahun 2024

3.2.1.2.2.5 Angka Keterlambatan Penyediaan Obat Jadi Rawat Jalan >30 Menit

3.2.1.2.2.5.1 Grafik Capaian Indikator Angka Keterlambatan Penyediaan Obat Jadi Rawat Jalan >30 Menit



PLAN	Kami berencana Menurunkan angka keterlambatan obat jadi rawat jalan >30 menit hingga mencapai standart 0% dengan target angka menurun 5% setiap bulan.				
DO	- Menganalisa jumlah ketenagaan dengan jumlah pasien rawat jalan - Melakukan rapat Bersama kepala instalasi farmasi supaya petugas tidak merapel klik setelah pelayanan farmasi selesai - Dari hasil supervisi kepala instalasi farmasi maka akan diberlakukan pembelajaran pada betugas yang tidak langsung klik selsai pelayanan ketika layanan farmasi telah selesai				
STUDY	Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa angka keterlambatan penyediaan obat jadi rawat jalan >30 menit masih belum mencapai standart. Hal ini disebabkan karena : - Pasien cendereung naik beberapa hari. - Tanda tangan elektronik diperlakukan untuk semua resep, termasuk rawat jalan IGD dan rawat jalan non kronis sehingga petugas farmasi memerlukan waktu untuk menyesuaikan				
ACTION/R TL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU

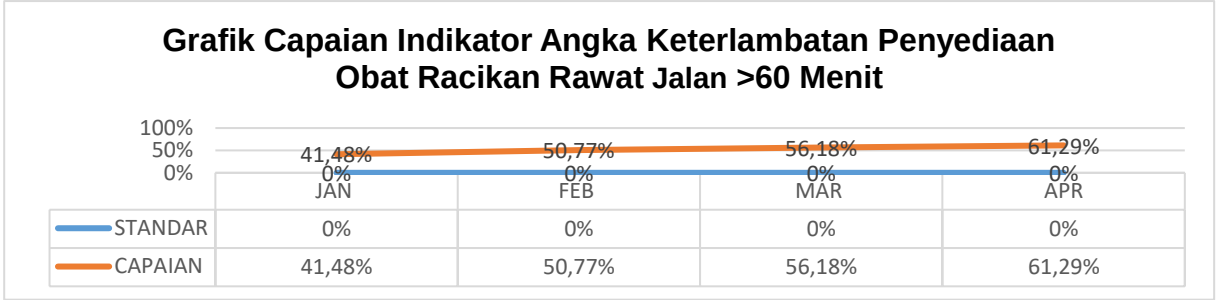
- Mengurangi angka keterlambatan penyediaan obat jadi rawat jalan >30 menit.	- Mengurangi angka keterlambatan penyediaan obat jadi rawat jalan >30 menit.	- Obat jadi rawat jalan bisa diselesaikan kurang dari 30 menit .	- Menganalisa jumlah ketenagaan dengan jumlah pasien rawat jalan - Melakukan rapat Bersama kepala instalasi farmasi supaya petugas tidak merapel klik setelah pelayanan farmasi selesai - Dari hasil supervisi kepala instalasi farmasi maka akan diberlakukan pembelajaran pada petugas yang tidak langsung klik selsai pelayanan ketika layanan farmasi telah selesai	-Seluruh petugas farmasi	- Satu bulan
--	--	--	---	--------------------------	--------------

3.2.1.2.2.6

Angka Keterlambatan Penyediaan Obat Racikan Rawat Jalan >60 Menit

3.2.1.2.2.6.1

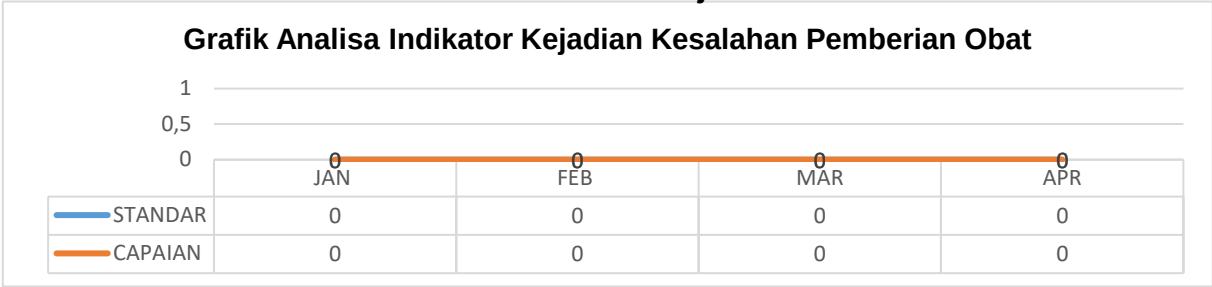
Grafik Capaian Indikator Angka Keterlambatan Penyediaan Obat Racikan Rawat Jalan >60 Menit



PLAN	Kami berencana Menurunkan angka keterlambatan obat racikan rawat jalan >60 menit hingga mencapai standart 0% dengan target angka menurun 5% setiap bulan.				
DO	- Menganalisa jumlah ketenagaan dengan jumlah pasien rawat jalan - Melakukan rapat Bersama kepala instalasi farmasi supaya petugas tidak merapel klik setelah pelayanan farmasi selesai - Dari hasil supervisi kepala instalasi farmasi maka akan diberlakukan pembelajaran pada petugas yang tidak langsung klik selsai pelayanan ketika layanan farmasi telah selesai				
STUDY	Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa angka keterlambatan penyediaan obat racikan rawat jalan >60 menit masih belum mencapai standart. Hal ini disebabkan karena : - Pasien cendereung naik beberapa hari - Tanda tangan elektronik diperlakukan untuk semua resep, termasuk rawat jalan IGD dan rawat jalan non kronis sehingga petugas farmasi memerlukan waktu untuk menyesuaikan				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
- Mengurangi angka keterlambatan penyediaan obat racikan rawat jalan >60 menit.	- Mengurangi angka keterlambatan penyediaan obat racikan rawat jalan >60 menit.	- Obat jadi rawat jalan bisa diselesaikan kurang dari 60 menit .	- Menganalisa jumlah ketenagaan dengan jumlah pasien rawat jalan - Melakukan rapat Bersama kepala instalasi farmasi supaya petugas tidak merapel klik setelah pelayanan farmasi selesai - Dari hasil supervisi kepala instalasi farmasi maka akan diberlakukan pembelajaran pada petugas yang tidak langsung klik selsai pelayanan ketika layanan farmasi telah selesai	-Seluruh petugas farmasi	- Satu bulan

3.2.1.2.2.7 Kejadian Kesalahan Pemberian Obat

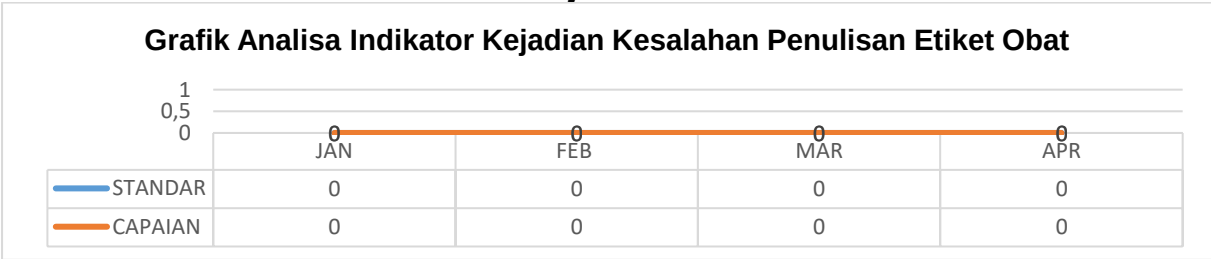
3.2.1.2.2.7.1 Grafik Analisa Indikator Kejadian Kesalahan Pemberian Obat



Analisis Capaian :
Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa tidak ditemukan kejadian kesalahan pemberian obat sejak bulan Januari hingga April tahun 2024.

3.2.1.2.2.8 Kejadian Kesalahan Penulisan Etiket Obat

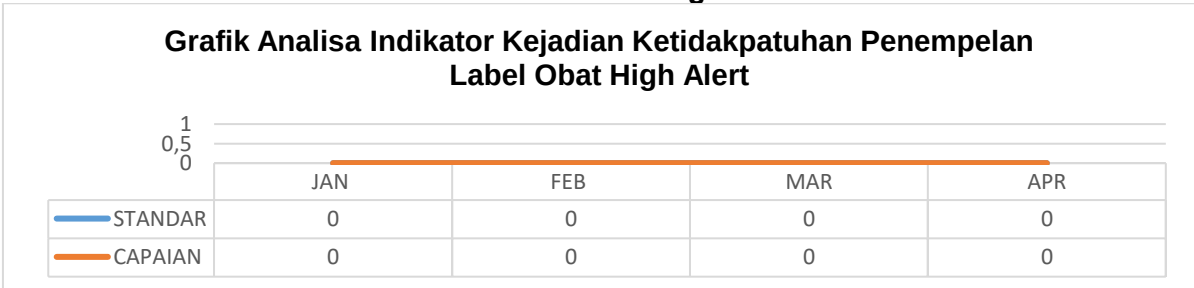
3.2.1.2.2.8.1 Grafik Analisa Indikator Kejadian Kesalahan Penulisan Etiket Obat



Analisis :
Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa tidak ada kejadian kesalahan penulisan etiket obat sejak bulan Januari hingga April tahun 2024.

3.2.1.2.2.9 Kejadian Ketidakpatuhan Penempelan Label Obat High Alert

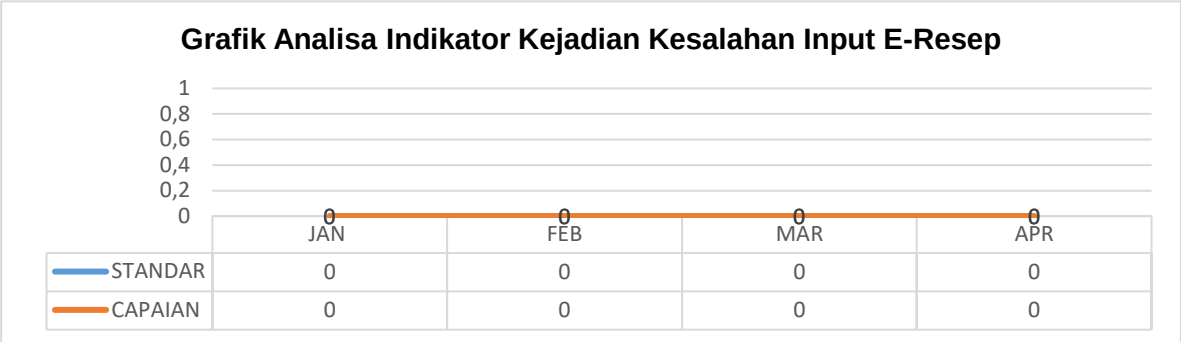
3.2.1.2.2.9.1 Grafik Analisa Indikator Kejadian Ketidakpatuhan Penempelan Label Obat High Alert



Analisis:
Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa tidak ditemukan kejadian ketidakpatuhan penempelan obat high alert sejak bulan Januari hingga April tahun 2024.

3.2.1.2.2.10 Kejadian Kesalahan Input E-Resep

3.2.1.2.2.10.1 Grafik Analisa Indikator Kejadian Kesalahan Input E- Resep

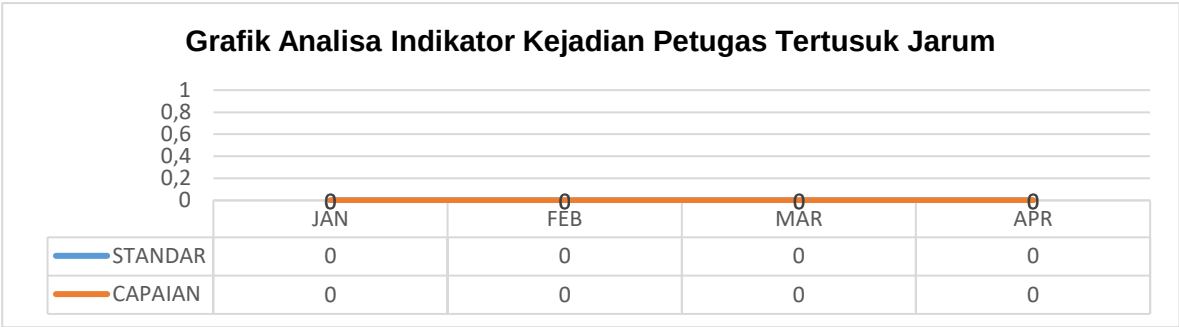


Analisis :

Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa tidak ditemukan kejadian kesalahan input e-resep pada bulan Januari hingga April tahun 2024.

3.2.1.2.2.11 Kejadian Petugas Tertusuk Jarum

3.2.1.2.2.11.1 Grafik Analisa Indikator Kejadian Petugas Tertusuk Jarum

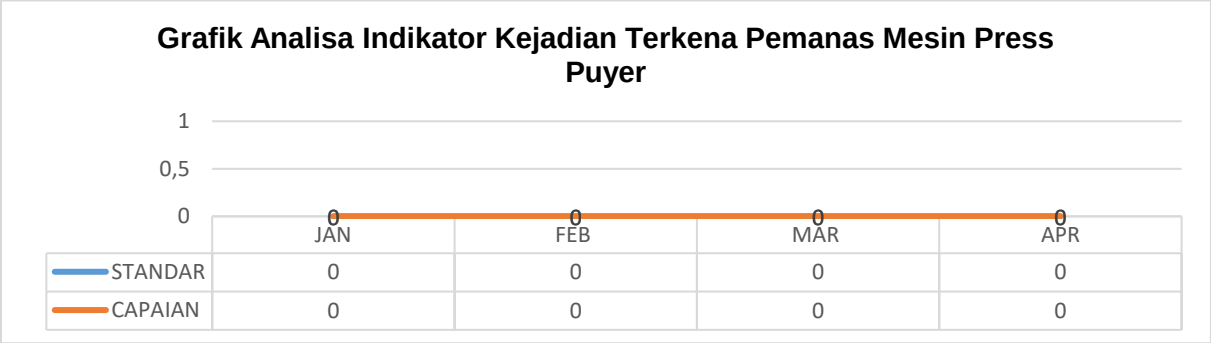


Analisis:

Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa tidak ada kejadian petugas tertusuk jarum sejak bulan Januari hingga April tahun 2024.

3.2.1.2.2.12 Kejadian Terkena Pemanas Mesin Press Puyer

3.2.1.2.2.12.1 Grafik Analisa Indikator Kejadian Terkena Pemanas Mesin Press Puyer

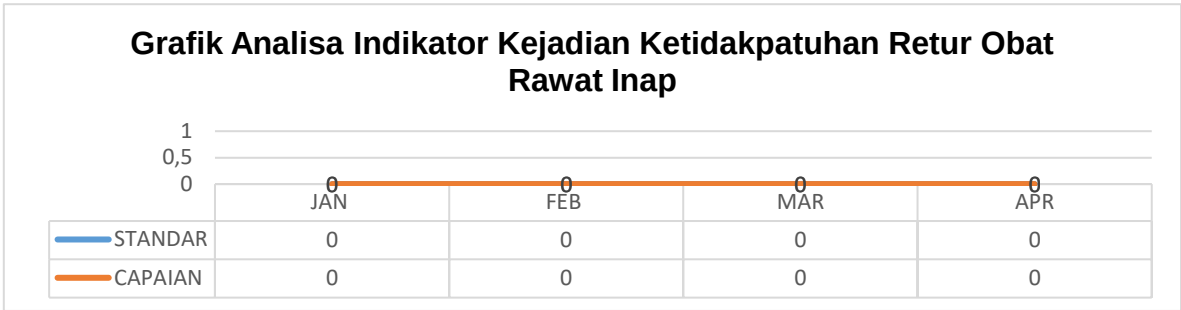


Analisis :

Dari data diatas dapat diketahui bahwa tidak ada kejadian terkena pemanas mesin press puyer sejak bulan Januari hingga April tahun 2024.

3.2.1.2.2.13 Kejadian Ketidapatuhan Retur Obat Rawat Inap

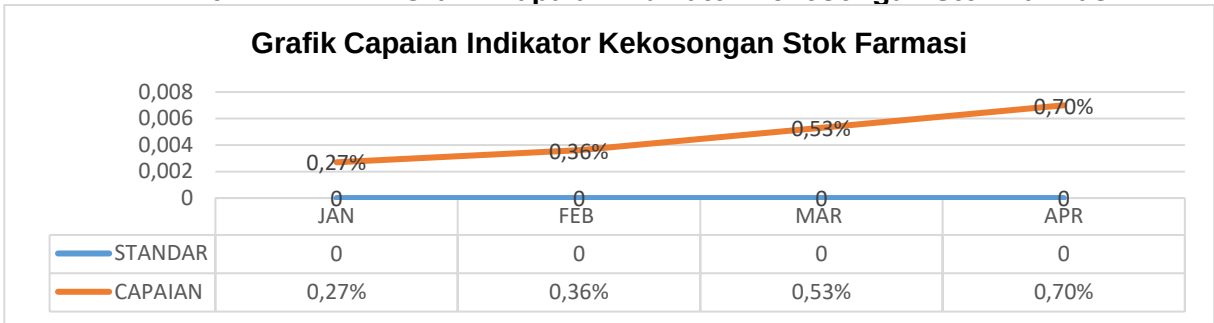
3.2.1.2.2.13.1 Grafik Analisa Indikator Kejadian Ketidapatuhan Retur Obat Rawat Inap



Analisis Capaian :
Berdasarkan hasil capaian di atas, dapat diketahui bahwa tidak ditemukan kejadian ketidapatuhan retur obat rawat inap sejak bulan Januari hingga bulan April tahun 2024.

3.2.1.2.2.14 Kekosongan Stok Sediaan Farmasi

3.2.1.2.2.14.1 Grafik Capaian Indikator Kekosongan Stok Farmasi



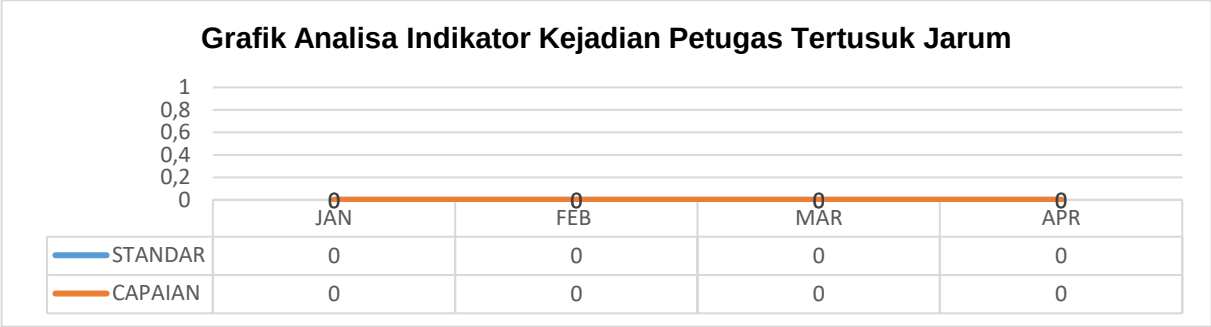
PLAN	Kami berencana Menurunkan angka kekosongan stok farmasi				
DO	Melakukan Analisa perhitungan waktu pengajuan hingga barang datang dengan kebutuhan, sehingga petugas dapat memperkirakan sediaan yang harus segera diinput pada pengadaan.				
STUDY	Berdasarkan hasil capaian di atas, dapat diketahui masih terjadi kekosongan stok farmasi yang disebabkan karena : 1. Barang yg sudah dipesan di pbf belum dikirim karena : - Barang sedang kosong distributor - Sp yg dikirim ke salesman belum terinput di data pemesanan pbf 2. Barang memang sedang kosong nasional karna bahan baku tidak ada 3. Human eror, bisa jadi terselip di defecta jd belum minta ke pengadaan 4. Barang yg awalnya slow moving, tiba2 jd fast moving. Banyak dipakai oleh dpjp ybs, padahal sebelumnya jarang sekali 5. Ada barang tertentu yg sedang dilakukan penyesuaian harga bpjs jadi belum bisa di jual oleh pbf 6. Ijin edar obat tertentu belum di setuju bpom, seperti kasus per sirup an kemarin				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Mengurangi angka kekosongan stok farmasi	Mengurangi angka kekosongan stok farmasi	Tidak ada kekosongan stok obat di farmasi	Memperbaruhi surat perjanjian kerjasama yang berisi tentang ketepatan waktu pengiriman obat setelah gudang farmasi order.	-Kepala Instalasi farmasi -Pengadaan Farmasi PT	- Satu bulan

3.2.1.2.3 Manajemen Resiko

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24
1	Kejadian petugas tertusuk jarum bekas pasien (pajanan)	0	0	0	0	0
2	Kejadian terkena pemanas mesin press puyer	0	0	0	0	0

3.2.1.2.3.1 Kejadian Petugas Tertusuk Jarum

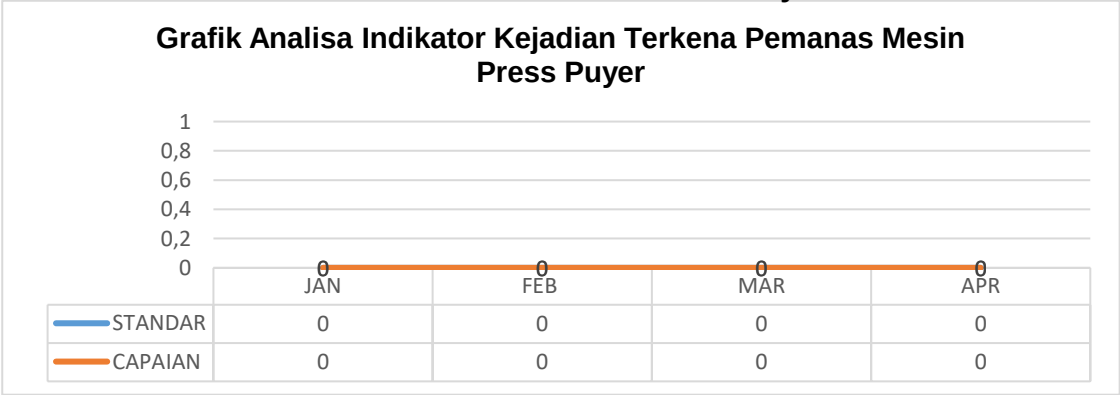
3.2.1.2.3.1.1 Grafik Analisa Indikator Kejadian Petugas Tertusuk Jarum



PLAN	Kami berencana untuk menurunkan kejadian petugas tertusuk benda tajam bekas pasien (pajanan) seminimal mungkin (0).				
DO	- Menginputkan laporan pada surveilans SIMRS dan kolaborasi dengan K3RS dan SDM. - Mengevaluasi keadaan luka pasien dan kondisi penyakit sumber pajanan. - Melakukan supervise terkait pengolahan benda tajam dan penyuntikan yang aman. - Melakukan supervise terkait penggunaan APD yang benar sesuai transmisi dan tindakan yang akan dilakukan.				
STUDY	Pada bulan ini tidak ditemukan kejadian petugas tertusuk benda tajam bekas pasien (pajanan).				
ACTION/RT L	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Melakukan penyuntikan aman.	Mempertahankan capaian kejadian pajanan 0 kejadian.	Tercapainya standar pajanan 0 kejadian setiap bulannya.	Mempertahankan kegiatan penyuntikan yang aman karena sudah meminimalisir kejadian petugas tertusuk benda tajam bekas pasien.	Seluruh petugas pelayanan di RS.	Satu bulan

3.2.1.2.3.2 Kejadian Terkena Pemanas Mesin Press Puyer

3.2.1.2.3.2.1 Grafik Analisa Indikator Kejadian Terkena Pemanas Mesin Press Puyer



Analisis:
Dari data diatas dapat diketahui bahwa tidak ada kejadian terkena pemanas mesin press puyer sejak bulan Januari hingga bulan April tahun 2024.

3.2.1.3 Mutu Unit

3.2.1.3.1 Instalasi Gawat Darurat

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24
1.	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	100%	96,25%	100%	100%
2.	Angka Tidak Terpasangnya Gelang Identitas Pasien IGD	0%	0%	0,17%	0%	0,28%
3.	Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Prosentase Pulang Atas Permintaan Sendiri	0%	0,7%	0,85%	0,61%	0,73%
5.	Waktu Tanggap Operasi Seksio Sesarea Emergenci	≥80%	100%	100%	100%	100%

3.2.1.3.2 IRNA 2C

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24
1	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	93,41%	100%	97,22%	100%
2	Kepatuhan Waktu Visite Dokter	≥80%	80%	73,53%	74,84%	73,57%
3	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (<i>Clinical Pathway</i>)	≥80%	0%	-	-	0%
4	Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh	100%	96,8%	100%	95,93%	100%
5	Prosentase Pulang Atas Permintaan Sendiri	0%	0%	0%	0%	0%
6	Angka Kelengkapan Penulisan Dalam Pengkajian Awal Medis (Indikator Baru 2024)	100%	94,7%	100%	100%	97,14%
7	Kelengkapan Pengisian EWS (Indikator Baru 2024)	100%	86,49%	86,36%	100%	100%

3.2.1.3.3 IRNA 3A

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24
1	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	100%	100%	100%	100%
2	Kepatuhan Waktu Visite Dokter	≥80%	93,18%	89,4%	91,28%	80,29%
3	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (<i>Clinical Pathway</i>)	≥80%	-	-	-	-
4	Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh	100%	100%	100%	100%	100%
5	Prosentase Pulang Atas Permintaan Sendiri	0%	0,75%	0%	0%	0%
6	Angka Kelengkapan Penulisan Dalam Pengkajian Awal Medis (Indikator Baru 2024)	100%	84,96%	87,65%	82,43%	83,94%

3.2.1.3.4 IRNA 4A

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24
1	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	100%	100%	100%	100%
2	Kepatuhan Waktu Visite Dokter	≥80%	94,84%	78,23%	86,54%	86,84%
3	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (<i>Clinical Pathway</i>)	≥80%	-	-	-	-
4	Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh	100%	71,83%	97%	100%	100%
5	Prosentase Pulang Atas Permintaan Sendiri	0%	0%	0%	0%	0%
6	Angka Kelengkapan Penulisan Dalam Pengkajian Awal Medis (Indikator Baru 2024)	100%	100%	90,75%	100%	100%
7	Kelengkapan Pengisian EWS (Indikator Baru 2024)	100%	100%	100%	100%	100%

3.2.1.3.5 IRNA 3C ANAK

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24
1	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	100%	100%	100%	100%
2	Kepatuhan Waktu Visite Dokter	≥80%	100%	100%	100%	100%
3	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (<i>Clinical Pathway</i>)	≥80%	0%	0%	0%	0%
4	Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh	100%	100%	100%	100%	100%
5	Prosentase Pulang Atas Permintaan Sendiri	0%	0%	0%	0%	0,37%
6	Angka Kelengkapan Penulisan Dalam Pengkajian Awal Medis (Indikator Baru 2024)	100%	100%	100%	100%	100%
7.	Kelengkapan Pengisian EWS (Indikator Baru 2024)	100%	100%	100%	100%	100%

3.2.1.3.6 IRNA 5C

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24
1	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	100%	100%	100%	100%
2	Kepatuhan Waktu Visite Dokter	≥80%	62,07%	66,86%	64,86%	55,35%
3	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (<i>Clinical Pathway</i>)	≥80%	-	-	-	-
4	Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh	100%	100%	100%	100%	100%
5	Prosentase Pulang Atas Permintaan Sendiri	0%	0,54%	0,55%	0,74%	0%
6	Angka Kelengkapan Penulisan Dalam Pengkajian Awal Medis (Indikator Baru 2024)	100%	99,13%	97,75%	93,02%	96,38%
7	Kelengkapan Pengisian EWS (Indikator Baru 2024)	100%	86,49%	100%	100%	100%

3.2.1.3.7 IRNA 6A						
NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24
1	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	100%	100%	100%	100%
2	Kepatuhan Waktu Visite Dokter	≥80%	61,11%	79,63%	84,92%	83,21%
3	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (<i>Clinical Pathway</i>)	≥80%	-	-	-	-
4	Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh	100%	100%	100%	100%	100%
5	Prosentase Pulang Atas Permintaan Sendiri	0%	0%	0%	0%	0%
6	Angka Kelengkapan Penulisan Dalam Pengkajian Awal Medis (Indikator baru 2024)	100%	100%	100%	100%	100%
7	Kelengkapan Pengisian EWS (Indikator baru 2024)	100%	100%	100%	100%	100%

3.2.1.3.8 IRNA 7A						
NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	MAR '24
1	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	100%	100%	100%	100%
2	Kepatuhan Waktu Visite Dokter	≥80%	58,22%	76,67%	75%	84,56%
3	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (<i>Clinical Pathway</i>)	≥80%	-	-	-	-
4	Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh	100%	96,67%	100%	100%	100%
5	Prosentase Pulang Atas Permintaan Sendiri	0%	0%	0%	0%	0%
6	Angka Kelengkapan Penulisan Dalam Pengkajian Awal Medis (Indikator baru 2024)	100%	100%	86,52%	100%	100%
7	Kelengkapan Pengisian EWS (Indikator baru 2024)	100%	100%	100%	100%	100%

3.2.1.3.2.9 IRNA 8A						
NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24
1	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	100%	100%	92,21%	100%
2	Kepatuhan Waktu Visite Dokter	≥80%	54,39%	78,49%	81,45%	84,56%
3	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (<i>Clinical Pathway</i>)	≥80%	-	-	-	-
4	Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh	100%	100%	99,15%	100%	100%
5	Prosentase Pulang Atas Permintaan Sendiri	0%	0%	0%	0%	0%
6	Angka Kelengkapan Penulisan Dalam Pengkajian Awal Medis (Indikator baru 2024)	100%	100%	100%	98,91%	100%
7	Kelengkapan Pengisian EWS (Indikator baru 2024)	100%	100%	100%	100%	100%

3.2.1.3.2.10 ICU

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '23	MAR '24	APR '24
1	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	100%	100%	98,2%	100%
2	Kepatuhan Waktu Visite Dokter	≥80%	100%	100%	100%	98,7%
3	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (<i>Clinical Pathway</i>)	≥80%				
4	Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh	100%	81,8%	92,53%	86%	90,4%
5	Angka kelengkapan asesmen pasien tahap akhir kehidupan	100%	100%	100%	100%	100%
6	Angka kelengkapan form kriteria keluar masuk ICU.	100%	100%	100%	100%	100%
7	Prosentase Pulang Atas Permintaan Sendiri	0%	-	0%	0%	0%

3.2.1.3.2.11 HCU

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	MAR '24
1	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	100%	100%	100%	100%
2	Kepatuhan Waktu Visite Dokter	≥80%	100%	100%	100%	100%
3	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (<i>Clinical Pathway</i>)	≥80%	-	-	-	-
4	Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh	100%	100%	100%	100%	96,3%
5	Angka kelengkapan asesmen pasien tahap akhir kehidupan	100%	-	-	-	-
6	Angka kelengkapan form kriteria keluar masuk HCU	100%	100%	100%	100%	100%
7	Prosentase Pulang Atas Permintaan Sendiri	0%	0%	0%	0%	0%

3.2.1.3.2.12 IRJA

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	99,75%	100%	95,71%	100%
2	Waktu tunggu rawat jalan	≥80%	95,2%	91%	95,74%	52,7%
3	Ketepatan Waktu Jam Praktek Dokter	100%	84,42%	82,35%	84,04%	84,04%
4	Angka rujukan horizontal FKRTL	0%	0%	0%	0%	0%

3.2.1.3.2.13 Maternitas						
NO.	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24
1	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	100%	100%	100%	100%
2	Waktu tanggap operasi Seksio Sesarea Emergensi.	≥80%	100%	100%	100%	100%
A3	Kepatuhan waktu visite dokter.	≥80%	99,44%	100%	100%	100%
4	Kepatuhan terhadap alur klinis (Clinical Pathway)	≥80%	100%	100%	100%	100%
5	Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh.	100%	100%	100%	100%	100%
6	Angka keterlambatan operasi sectio caesaria (SC) > 30 menit	<5%	0%	0%	0%	0%
7	Angka keterlambatan penyediaan darah > 60 menit	<10%	0%	0%	0%	0%
8	Angka kematian ibu	0%	0%	0%	0%	0%
9	Kejadian perdarahan post partum	0	0	0	0	0
10	Kejadian partus lama	0	1	2	0	0
11	Kejadian eklamsi	0	0	0	0	0
12	Kejadian pre eklamsi	0	3	1	0	0
13	Kejadian infeksi nifas	0	0	0	0	0
14	Angka ketidaklengkapan 10T pada ANC	0%	0%	0%	0%	0%
15	Angka capaian pelayanan KB per metode kontrasepsi, baik Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dan Non MKJP	100%	3,82%	0,83%	3,6%	8,49%
16	Angka capaian pelayanan KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	100%	3,82%	0,83%	3,6%	8,49%
17	Kejadian tidak dilakukannya KB Pasca Persalinan pada ibu baru bersalin dan KB Pasca Keguguran pada Ibu pasca keguguran	0	0	0	0	0
18	Prosentase Pulang Atas Permintaan Sendiri	0%	0%	0%	0,73%	0%

3.2.1.3.2.14 NICU						
NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24
1	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	100%	100%	100%	100%
2	Kepatuhan terhadap alur klinis (clinical pathway)	≥80%	-	-	-	-
3	Kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh	100%	100%	100%	100%	100%
4	Kepatuhan waktu visite dokter	≥80%	85,92%	90,63%	84,72%	90,8%
5	Prosentase pulang atas permintaan sendiri	0%	0%	4,17%	3,26%	0%
6	Angka Kematian Bayi	0	0%	0%	0%	0%
7	Kejadian tidak dilakukannya IMD (inisiasi menyusui dini) pada bayi baru lahir	0	0	0	0	0

3.2.1.3.2.15 IKO						
NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24
1	Kepatuhan identifikasi pasien.	100%	100%	100%	100%	100%
2	Penundaan operasi elektif.	≤ 5%	0%	0%	0%	0%
3	Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh.	100%	100%	100%	100%	100%
4	Kejadian keterlambatan operasi> 30 menit	0	0	10	10	10
5	Kejadian konversi tindakan anestesi dari local/regional ke general	0	0	0	0	0
6	Kejadian tidak dilaksanakannya proses monitoring pemulihan anestesi dan sedasi dalam	0	0	0	0	0
7	Kejadian tidak dilaksanakannya proses monitoring fisiologis selama anestesi	0	0	0	0	0
8	Kejadian tidak dilaksanakannya asesmen pra sedasi dan pra anestesi	0	0	0	0	0
9	Kejadian tidak dilaksanakannya pemantauan diskrepansi diagnose pre dan post op	0	0	0	0	0
10	Kejadian tidak dilaksanakan SSC	0	0	0	0	0
11	Kejadian tidak lengkapnya asesmen pra bedah	0	0	0	0	0
12	Kejadian tidak dilaksanakannya penandaan lokasi operasi	0	0	0	0	0
13	Kejadian ketidaklengkapan formular penandaan pasien operasi	0	0	0	0	0
14	Angka ketidakhadiran dokter anak saat operasi SC (indikator baru 2024)	0%	0%	0%	23,08%	0%

3.2.1.3.2.16 Laboratorium						
NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%
2	Pelaporan hasil kritis laboratorium	100%	98,69%	98,8%	98,48%	97,5%
3	Kejadian Pengulangan Phlebotomi Saat Sampling	0	3	2	4	2
4	Kejadian salah input hasil laboratorium	0	0	0	0	0
5	Waktu Tunggu Hasil Laboratorium >140 menit (Indikator baru 2024)	0%	0%	0%	0%	0%

3.2.1.3.2.17 Radiologi						
NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%
2	Angka ketidaklengkapan permintaan form radiologi	0%	3,72%	3,61%	2,65%	3,81%
3	Kejadian Ketidaktepatan persiapan pasien USG (Indikator baru 2024)	0	1	0	0	0

3.2.1.3.2.18 Gizi						
NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	MAR '24
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	99,76%	100%	100%	100%
2	Kejadian kesalahan pemberian diit	0	1	0	0	0
3	Kejadian adanya benda asing dalam makanan	0	0	0	0	0
4	Kejadian Pasien Tidak Mendapat Makan	0	0	1	0	0

3.2.1.3.2.19 Farmasi						
NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	70,26%	100%	100%
2	Kepatuhan penggunaan formularium Nasional	≥80%	100%	100%	100%	100%
3	Kejadian kesalahan penyiapan obat	0	1	0	0	0
4	Kejadian kesalahan penempelan label pada obat LASA	0	0	0	0	0
5	Angka keterlambatan penyediaan obat jadi rawat jalan >30 menit.	0%	68,81%	69,59%	73,43%	79,11%
6	Angka keterlambatan penyiapan obat racikan >60 menit.	0%	41,48%	50,77%	56,18%	61,29%
7	Kejadian kesalahan pemberian obat	0	0	0	0	0
8	Kejadian kesalahan penulisan etiket obat.	0	0	0	0	0
9	Kejadian ketidakpatuhan penempelan label obat high alert	0	0	0	0	0
10	Kejadian kesalahan input e-resep	0	0	0	0	0
11	Kejadian petugas tertusuk jarum	0	0	0	0	0
12	Kejadian terkena pemanas mesin press puyer	0	0	0	0	0
13	Kejadian ketidakpatuhan retur obat rawat inap	0	0	0	0	0

3.2.1.3.2.20 Pengadaan Farmasi						
NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24
1	Kekosongan stok farmasi	0%	0,27%	0,36%	0,53%	0,7%

3.2.1.3.2.21 PPI						
NO.	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APRIL '24
1.	IDO (Infeksi Daerah Operasi)	≤ 2 %	0,24%	0,8%	0,27%	0 %
2.	IADP (Infeksi Aliran Darah Primer)	≤3,5‰	0‰	0‰	0‰	0‰
3.	VAP (Ventilation Associated Pneumonia)	≤ 5,8 ‰	0‰	0‰	0‰	0‰
4.	ISK (Infeksi Saluran Kencing)	≤ 4,7 ‰	0‰	0‰	0‰	0‰
5.	Infeksi Aliran Darah Perifer /ILI (Phlebitis)	≤ 5 %	0,28%	0,22%	0,4%	0,25%

6.	Angka Decubitus	0%	0%	0%	0%	0%
7.	Angka kepatuhan kebersihan tangan	>85%	85,86%	85,88%	85,5%	85,53%
8.	Angka kepatuhan penggunaan APD oleh petugas	100%	93,04%	93,05%	93,3%	93,52%
9.	Kepatuhan Pemilahan Sampah Infeksius dan Non Infeksius di Unit Pelayanan	100%	91,91%	92,09%	92,22%	92,29%
10.	Kejadian petugas tertusuk benda tajam bekas pasien (pajanan)	0	0	0	0	0

3.2.1.3.2.22 PIPP

NO.	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24
1	Angka Terhubungnya Display TT Dengan Mobile JKN	100%	100%	100%	100%	100%
2	Angk Terhubungnya Operasi Dengan Mobile JKN	100%	100%	100%	100%	100%
3	Kecepatan Waktu Tanggap Komplain	100%	100%	93,15%	100%	100%
4	Kepuasan Pasien	76,61%	100%	91,89%	99,63%	99,82%
5	Kepatuhan Petugas Dalam Mengumpulkan Kuesioner Kompalin dan Kepuasan Pelanggan (Indikator baru 2024)	100%	86,94%	75,31%	57,76%	52,92%

3.2.1.3.2.23 SDM

NO.	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24
1	Kejadian keterlambatan pengurusan SIP/SIK.	0	0	0	1	0
2	Angka kedisiplinan staf terhadap finger print.	100%	98,99%	98,97%	99,14%	98,76%
3	Angka keterlambatan kehadiran staf	0%	3,32%	3,34%	2,97%	14,3%

3.2.1.3.2.24 Rekam Medis

NO.	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24
1.	Angka kejadian nomor rekam medis ganda.	0%	0%	0%	0%	0%
2.	Angka Kelengkapan Rekam Medis Pasien Rawat Inap	0%	-	-	96,65%	93,04%
3.	Kejadian kendala pada SIMRS dalam upaya menunjang pelayanan rekam medis rekam medis elektronik (Indikator baru 2024)	0	0	0	0	0
4.	Kelengkapan Keakuratan Pada Penginputan Data Pasien di SIMRS (Indikator baru 2024)	100%	100%	100%	100%	100%
5.	Keterlambatan Pengumpulan DRM Pasien Rawat Inap Lebih Dari 24 Jam	0%	0%	0%	7,06%	9,44%

3.2.1.3.2.25 Keuangan						
NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24
1	Angka keterlambatan pembayaran klaim lebih dari 90 hari	0%	7,7%	6%	3,86%	10,98%
2	Kejadian piutang umum atas permintaan sendiri	0	0	0	0	0
3	Angka keterlambatan pembayaran klaim BPJS	0%	0%	0%	0%	0%

3.2.1.3.2.26 K3RS						
NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24
1	Angka kepatuhan petugas melakukan pengecekan APAR.	100%	100%	100%	100%	100%
2	Kejadian kebakaran di ruangan.	0	0	1	0	0

3.2.1.3.2.27 Asuransi Center						
NO.	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24
1	Angka pending klaim BPJS	0%	1,07%	1,04%	0,78%	0,97%
2	Prosentase readmisi pasien rawat inap	0%	1,69%	1,04%	2,17%	1,66%
3	Angka kelengkapan berkas klaim di SIMRS (Indikator baru 2024)	100%	9,73%	0,57%	0,44%	0,42%
4	Kejadian Pasien Tidak Di SEP	0	0	0	1	1

3.2.1.2.28 IPSRS						
NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24
1	Angka Keterlambatan penanganan pelaporan kerusakan oleh unit dalam 1x 24 jam	0%	100%	91%	89%	89,47%

3.2.1.3.2.29 UMUM						
NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24
1	Keterlambatan barang datang di Gudang	0	3	7	4	3
2	Ketidakpatuhan pengambilan barang oleh unit	0	11	4	5	2

3.2.1.3.2.30 Cleaning Service						
NO	JUDUL	STAND	DES '23	JAN '24	MAR '24	APR '24
1	Angka ketidakpatuhan penggunaan spillkit	0%	1,39%	1,67%	29,17%	28,95%

3.2.1.3.2.31 Kesekretariatan						
NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24
1	Angka keterlambatan pengumpulan laporan bulanan unit tanggal 5 setiap bulannya	0%	34,21%	0%	20,69%	78,38%

2	Angka ketidaklengkapan pengumpulan dokumen meeting RS 1x 24 jam hari kerja	0%	25%	100%	62,5%	71,83%
3	Angka tindaklanjut balasan surat masuk eksternal lebih dari 2x24 jam	0%	65%	-	60,71%	86,21%

3.2.1.3.2.31 Laundry

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24
1	Angka keterlambatan penyediaan linen	0%	0%	5,2%	1,95%	4,19%
2	Kejadian linen ruang perawatan hilang	0	0	0	0%	0%

3.2.1.3.2.33 CSSD

NO	JUDUL	STAN	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24
1	Kejadian ditemukannya instrument hilang	0	1	0	0	0
2	Kejadian instrument kurang	0	1	0	1	1

3.2.1.3.2.34 Humas dan Pemasaran

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '34	APR '34
1	Angka kunjungan rawat inap >80 pasien perhari	0%	99,17%	90,88%	100%	100%
2	Angka kunjungan rawat jalan >300 pasien perhari	0%	93,71	100%	92,82%	92,82%

3.2.1.3.2.35 IT

NO	JUDUL	STAN	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24
1	Kejadian downtime	0	0	0	0	0
2	Respon time penanganan internet dan billing error < 30 mnt	100%	100%	100%	100%	100%
3	Respon Time untuk penanganan computer < 15 menit	100%	96,97%	100%	100%	100%

3.2.1.3.2.36 Kamar Jenazah

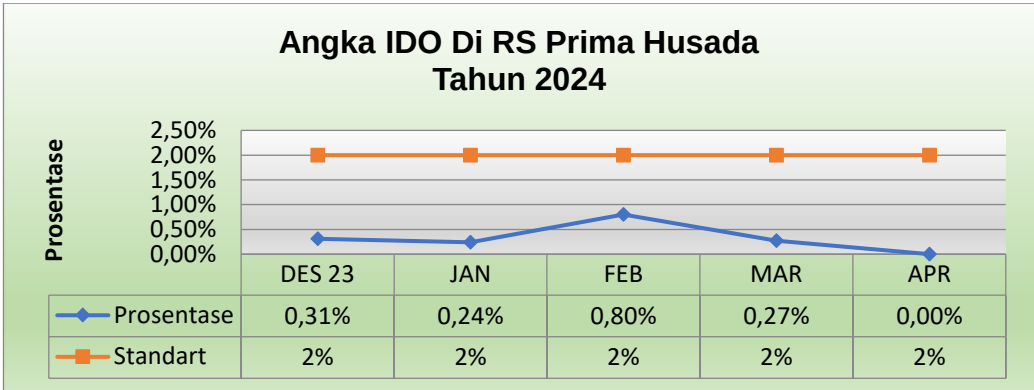
NO	JUDUL	STAN	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24
1.	Pencatatan kematian pasien di kamar mayat (registrasi) < 2jam	100%	100%	100%	100%	100%

3.1.1 Komite PPI

3.1.1.1 Hasil Surveilans dan Mutu PPI

3.1.1.1.1 IDO (Infeksi Daerah Operasi)

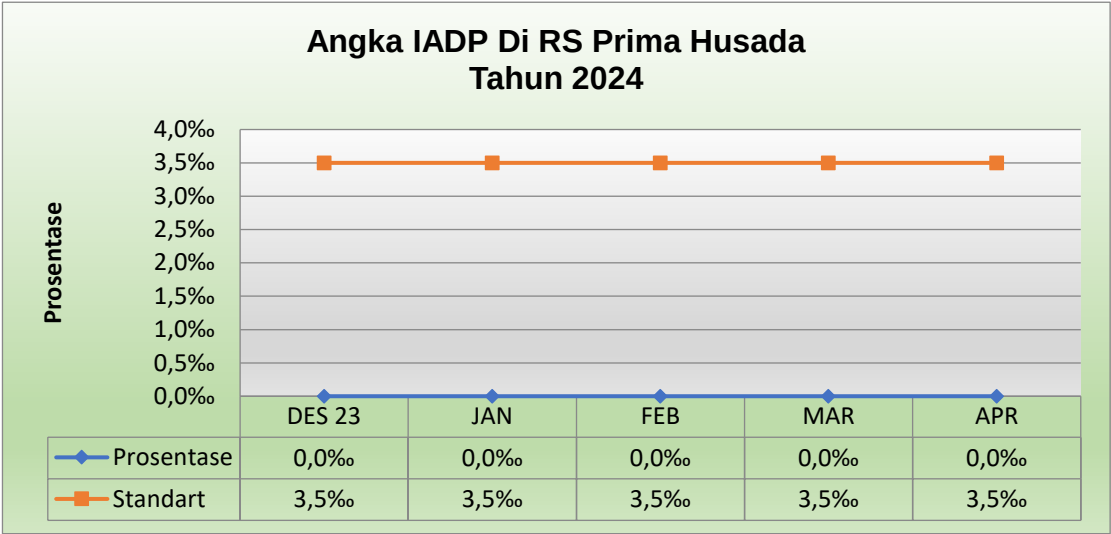
3.1.1.1.1.1 Grafik Angka Infeksi Daerah Operasi (IDO):



PLAN	Kami berencana untuk menurunkan angka IDO seminimal mungkin. (0%)					
DO	- Melakukan koordinasi dengan DPJP obgyn terkait Teknik aseptik pada saat melakukan perawatan luka maupun prosedur operasi. - Melakukan koordinasi dengan tim Kamar operasi terkait penggunaan kamar operasi dan pembersihannya saat ada operasi estafet (memakai kamar operasi yang berbeda, jika kamar operasi lainnya kosong). - Melakukan koordinasi dengan petugas unit perawatan untuk tetap menjaga Teknik aseptic saat melakukan proses perawatan luka pasien. - Berkoordinasi dengan ahli gizi dan perawat unit untuk pemantapan proses edukasi pasien terutama diit pasien pada saat pasien dirawat atau akan KRS. - Monitoring pembersihan alat dan kebersihan ruang kamar operasi tetap dilakukan secara rutin. - Monitoring pelaksanaan audit bundle IDO sesuai SPO.					
STUDY	Tidak ditemukan kasus IDO pada bulan ini.					
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI		PELAKSANA	WAKTU
Pertahankan bundle IDO.	Pertahankan kepatuhan petugas dalam menjalankan bundle IDO.	Kepatuhan audit bundle IDO meningkat 3% pada bulan berikutnya.	- Resosialisasi 5 moment cuci tangan. - Monitoring kepatuhan pemakaian handscon steril saat rawat luka. - Monitoring kepatuhan mandi dengan air sabun sebelum operasi. - Monitoring kepatuhan penggunaan alat cukur satu kali pakai dan pembersihan wadah alat cukur yang dipakai berulang. - Monitoring kepatuhan petugas dalam menjaga aseptic saat melakukan rawat luka/tindakan bedah.		- Perawat /Bidan - Dokter - Karu - IPCLN/IPCN	Satu bulan

3.1.1.1.2 IADP

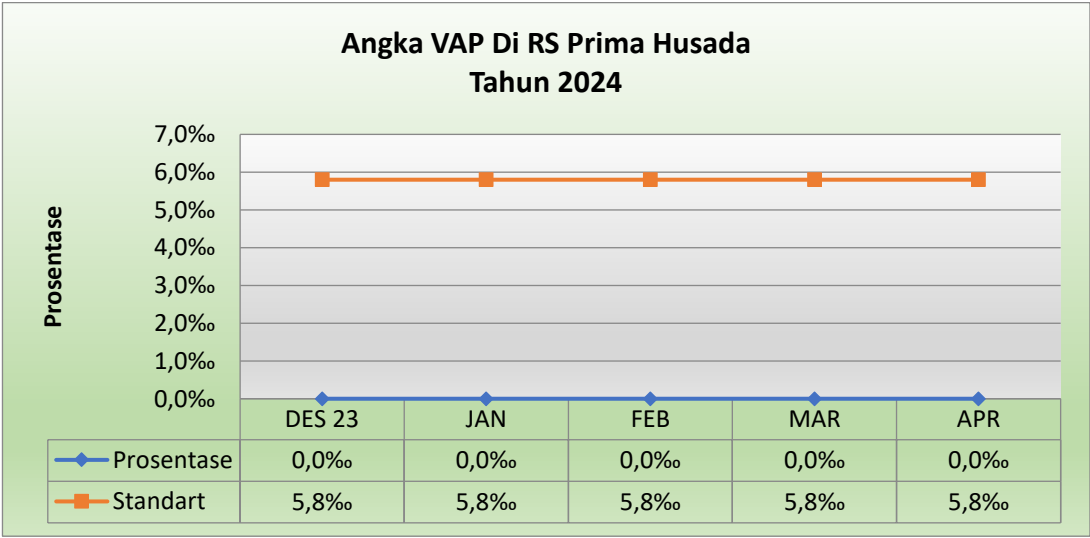
3.1.1.1.2.1 Grafik Angka Infeksi Aliran Darah Primer (IADP)



PLAN	Kami berencana untuk mempertahankan angka IADP sesuai standart seminimal mungkin. (0‰)				
DO	• Monitoring pelaksanaan audit bundle IADP sesuai standart.				
STUDY	Pada bulan ini tidak ditemukan kasus IADP pada 3 hari lama pemasangan CVC.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
• Pertahankan kepatuhan bundle IADP.	• Mempertahankan kepatuhan petugas dalam menjalankan bundle IADP.	• Kepatuhan bundle IADP tetap baik atau meningkat pada bulan berikutnya.	• Resosialisasi 5 moment cuci tangan. • Monitoring kepatuhan pemakaian APD saat penanganan pemasangan CVC. • Monitoring kepatuhan desinfeksi area penusukan dan lokasi yang tepat. • Monitoring perawatan pemasangan CVC rutin, penggunaan spuit disposable, dan desinfeksi area penyuntikan.	• Perawat /Bidan • Dokter • Karu • IPCLN/IPCN	• Satu bulan

3.1.1.1.3 VAP

3.1.1.1.3.1 Angka Pneumonia Akibat Penggunaan Ventilator (VAP)

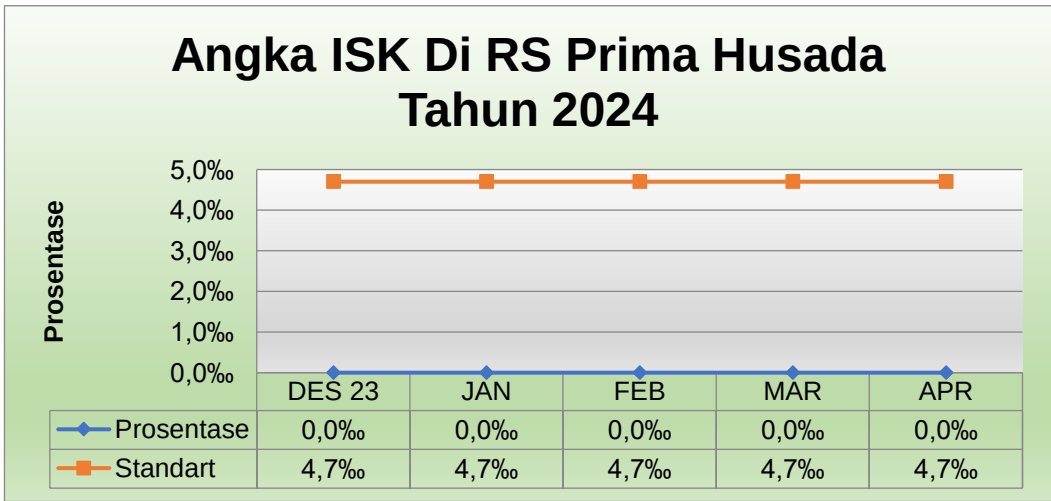


PLAN	Kami berencana untuk mempertahankan angka VAP sesuai standart seminimal mungkin. (0‰)
DO	• Monitoring pelaksanaan audit bundle VAP sesuai SPO.
STUDY	Pada bulan ini tidak ditemukan kasus VAP pada 10 hari lama pemasangan ventilator.

ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Pertahankan kepatuhan bundle VAP.	Mempertahankan kepatuhan petugas dalam menjalankan bundle VAP.	Kepatuhan bundle VAP tetap baik atau meningkat pada bulan berikutnya.	- Resosialisasi 5 moment cuci tangan. - Monitoring kepatuhan pemakaian APD saat penanganan pemasangan ventilator. - Monitoring posisi tepat pasien <i>head of bed</i> >30°-45°. - Monitoring perawatan pemasangan ventilator, pemberian profilaksis dan perawatan oral <i>hygiene</i>.	- Perawat /Bidan - Dokter - Karu - IPCLN/IPCN	Satu bulan

3.1.1.1.4 ISK

3.1.1.1.4.1 Grafik Angka Infeksi Saluran kencing (ISK)

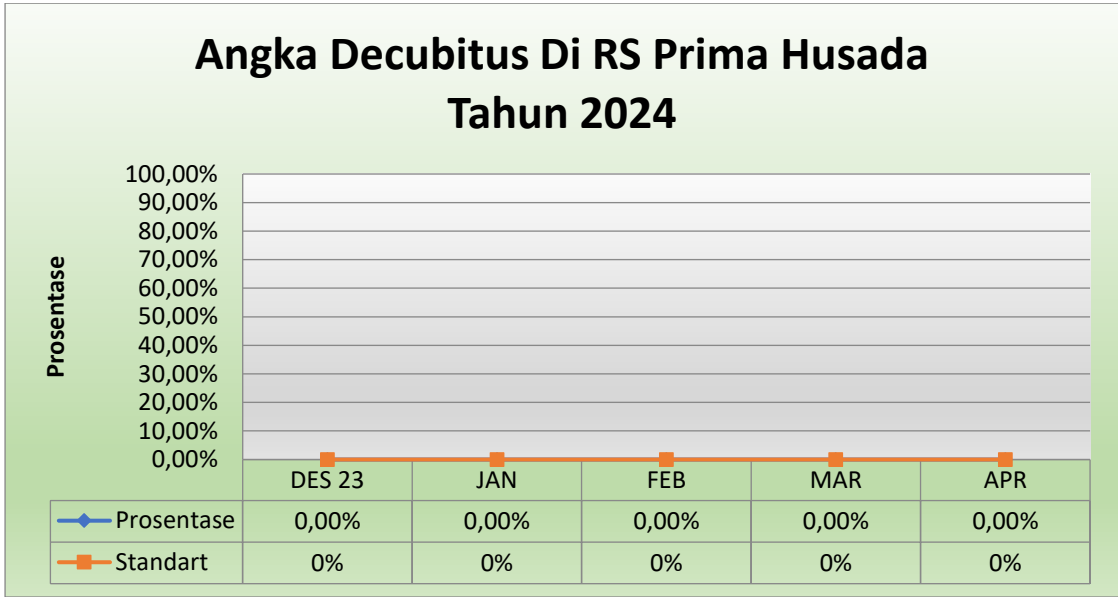


PLAN	Kami berencana untuk mempertahankan angka ISK sesuai standart seminimal mungkin. (0%)				
DO	Monitoring pelaksanaan audit bundle ISK sesuai SPO.				
STUDY	Pada bulan ini tidak ditemukan kasus ISK pada total 975 hari lama pemakaian kateter pasien.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Pertahankan kepatuhan bundle ISK.	Mempertahankan kepatuhan petugas dalam menjalankan bundle ISK.	Kepatuhan bundle ISK tetap baik atau meningkat pada bulan berikutnya.	- Resosialisasi 5 moment cuci tangan. - Monitoring kepatuhan pemakaian APD saat penanganan pemasangan kateter. - Monitoring teknik aseptik dan penggunaan alat steril pada saat pemasangan kateter. - Monitoring perawatan pemasangan kateter, pemasangan	- Perawat /Bidan - Dokter - Karu - IPCLN/IPCN	Satu bulan

			sesuai indikasi, pemakaian fiksasi kateter, pengisian balon kateter yang sesuai dan penggantungan kantong urine.		
--	--	--	--	--	--

3.1.1.1.5 Decubitus

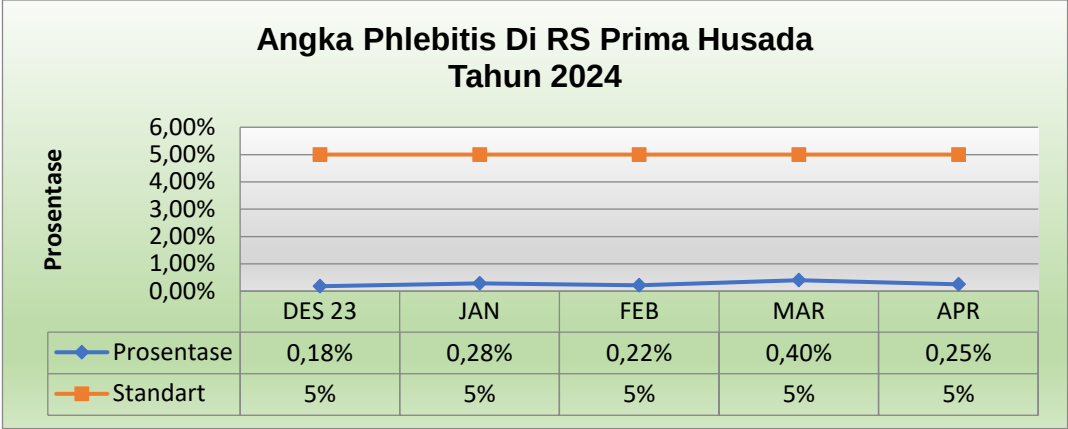
3.1.1.1.5.1 Grafik Angka Decubitus



PLAN	Kami berencana untuk mempertahankan angka decubitus sesuai standart seminimal mungkin. (0%)				
DO	Monitoring pelaksanaan pencegahan decubitus pada perawatan pasien dengan tirah baring lama.				
STUDY	Pada bulan ini tidak ditemukan kasus decubitus pada 32 pasien tirah baring lama (>3x24 jam).				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Pertahankan kepatuhan pencegahan dekubitus.	Mempertahankan kepatuhan petugas dalam menjalankan pencegahan dekubitus.	Kepatuhan pencegahan dekubitus tetap baik atau meningkat pada bulan berikutnya.	- Resosialisasi 5 moment cuci tangan. - Monitoring rutinitas petugas untuk melakukan imobilisasi pasien tiap 4 jam (mika-miki). - Anjurkan penggunaan kasur anti decubitus. - Monitoring timbulnya lecet pada area tubuh yang menempel pada alas tidur dan penggunaan serta penggantian pampers secara rutin. - Lakukan perawatan luka rutin jika sudah terdapat luka supaya tidak melebar.	- Perawat /Bidan - Karu - IPCLN/IPC�	Satu bulan

3.1.1.1.6 Phlebitis

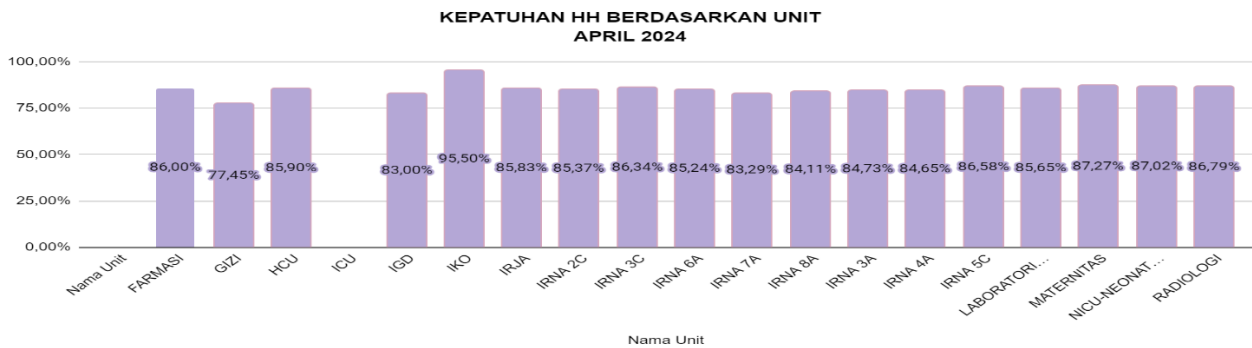
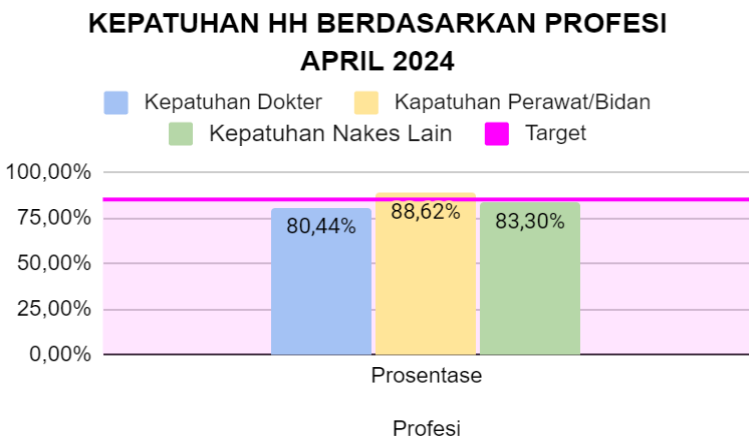
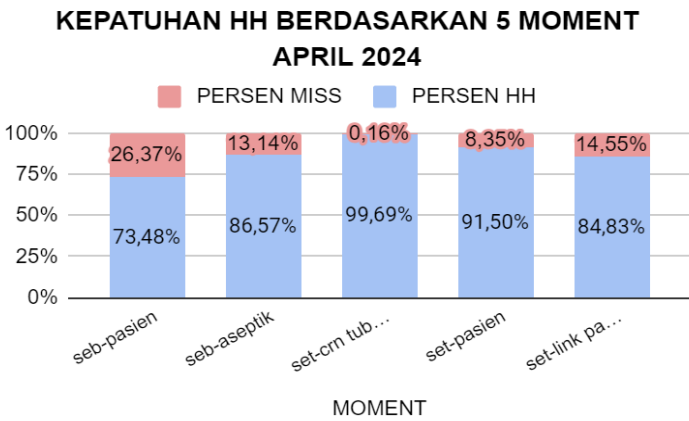
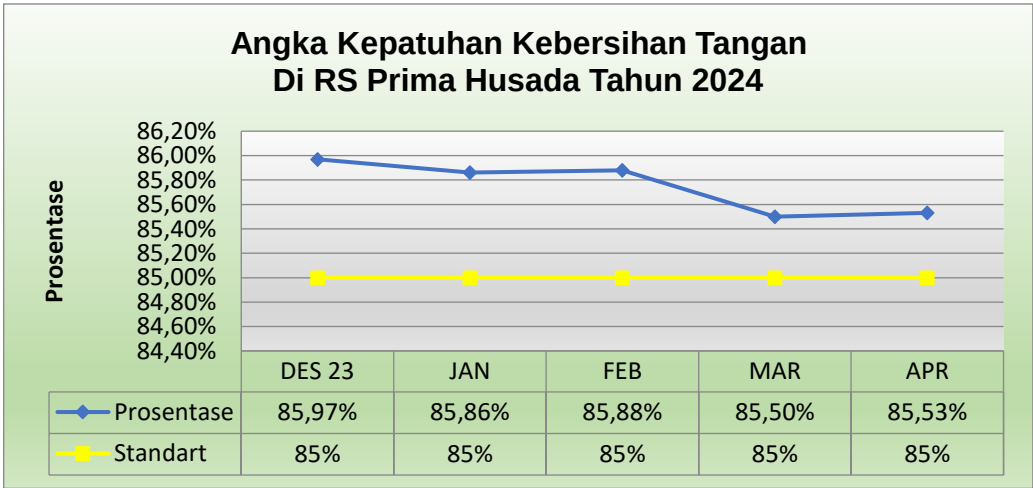
3.1.1.1.6.1 Grafik Angka Infeksi Jarum Infus (Phlebitis)



PLAN	Kami berencana untuk menurunkan angka phlebitis seminimal mungkin. (0%)				
DO	- Melakukan monitoring pelaksanaan audit bundle phlebitis sesuai SPO. - Melakukan sosialisasi kepada perawat tentang handhygiene dan pemakaian APD yang benar. - Berkolaborasi dengan komite keperawatan untuk melakukan supervisi berkala terkait prosedur pemasangan infus dan perawatan luka infus. - Monitoring pelaksanaan penyuntikan yang aman dan Teknik aseptik saat penyuntikan.				
STUDY	Masih ditemukan kasus Phlebitis pada bulan ini dari total 2824 pasien yang terpasang infus setiap harinya dengan prosentase 0,25%, masih memenuhi standar nasional. Dari data yang diperoleh, 4 dari 7 pasien yang mengalami phlebitis merupakan pasien yang mendapat cairan/obat yang konsentrasinya lebih pekat (NS 3%, osedasi, D40%). 1 pasien lainnya yang mengalami phlebitis merupakan pasien anak-anak dan 2 sisanya adalah pasien lansia dimana pembuluh darah pasien cenderung lebih rentan phlebitis dan mendapatkan injeksi antibiotik. Dari 8 pasien yang ditanyai, tidak ditemukan pasien yang rawat inap mengalami infus slong (cairan infus pada indikator selang infus habis).				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Pertahankan kepatuhan bundle phlebitis.	Mempertahankan kepatuhan petugas dalam menjalankan bundle phlebitis.	Kepatuhan bundle phlebitis tetap baik atau meningkat pada bulan berikutnya.	- Resosialisasi 5 moment cuci tangan. - Monitoring kepatuhan pemakaian APD terutama sarung tangan saat pemasangan infus. - Monitoring teknik aseptik dan penggunaan alat steril pada saat pemasangan infus. - Monitoring penyuntikan yang aman. - Monitoring penggunaan cairan pekat maupun double antibiotic. - Tertibkan pencatatan petugas yang melakukan pemasangan infus pada plester infus pasien beserta tanggal pemasangan untuk mengontrol mutu skill dari perawat. - Mengedukasi perawat unit untuk mengeset tetesan infus secara benar supaya hitungan jam habis infus dapat diperkirakan dan tidak sampai kehabisan.	- Perawat /Bidan - Dokter - Karu - IPCLN/IPCN	Satu bulan

3.1.1.1.7 Kebersihan Tangan

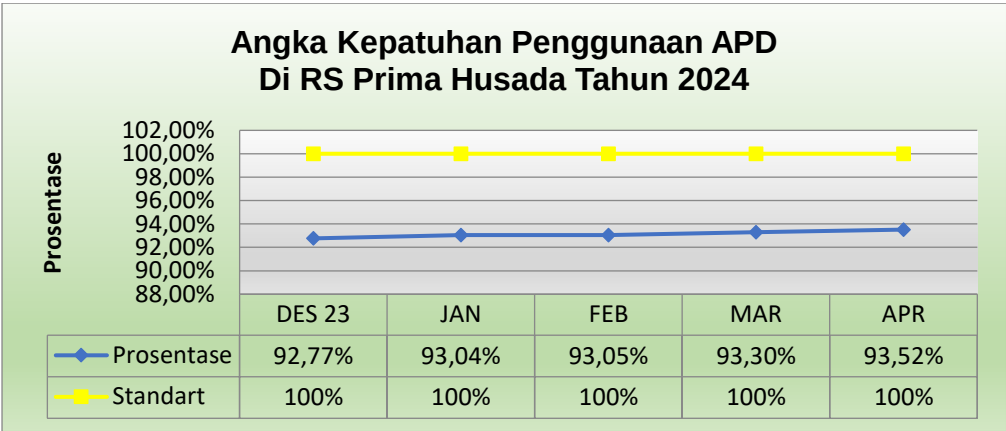
3.1.1.1.7.1 Grafik Angka Kepatuhan kebersihan Tangan (Hand Hygiene)



PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan angka kepatuhan kebersihan tangan semaksimal mungkin (100%) dengan target peningkatan $\pm$ 5% setiap bulannya.				
DO	• Mendata ulang jumlah kebutuhan tatakan dan botol handrub unit. • Mengajak Karu untuk ikut mengecek kebutuhan fasilitas kebersihan tangan unitnya. • Monitoring pelaksanaan audit kepatuhan kebersihan tangan. • Melakukan supervisi terkait fasilitas kebersihan tangan. • Melakukan sosialisasi kebersihan tangan antar staf dibantu oleh IPCLN dan anggota Komite PPI lainnya.				
STUDY	Prosentase kepatuhan kebersihan tangan keseluruhan sudah mencapai standart minimal pada bulan ini yaitu sebesar 85,53. Jika dilihat berdasarkan profesi, masih ditemukan prosentase di bawah standart yaitu pada profesi dokter (80,44%) dan nakes lain (83,30%) dimana berdasarkan 5 moment cuci tangan, kebanyakan dari petugas tidak melakukan moment sebelum kontak dengan pasien (73,48%). Banyak ditemukan temuan petugas tidak melakukan kebersihan tangan sebelum melakukan tindakan karena terbiasa beranggapan tangannya sudah bersih dan perlu diingatkan dulu (pada saat di audit baru patuh). Dari segi petugas, ada yang lebih memilih untuk memakai sarung tangan (handscoon) dibandingkan dengan cuci tangan seperti pada profesi dokter. Namun beberapa perawat sudah mengurangi penggunaan sarung tangan bedah sesuai dengan kebutuhannya saja.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
• Meningkatkan kebersihan tangan.	• Meningkatkan kepatuhan kebersihan tangan.	• Tercapainya kepatuhan kebersihan unit masing-masing diatas 85%.	• Resosialisasi 5 moment dan 6 langkah cuci tangan. • Melakukan audit kepatuhan kebersihan tangan secara rutin. • Memberikan reward-pembelajaran. • Melakukan control monitoring fasilitas kebersihan tangan di unit pelayanan. • Mengingatkan perawat atau nakes lain untuk lebih mengutamakan upaya kebersihan tangan agar aman bagi petugas dan pasien.	• Seluruh petugas yang melakukan pelayanan di RS.	• Satu bulan

3.1.1.1.8 Kepatuhan APD

3.1.1.1.8 .1 Grafik Angka Kepatuhan Penggunaan APD oleh Petugas

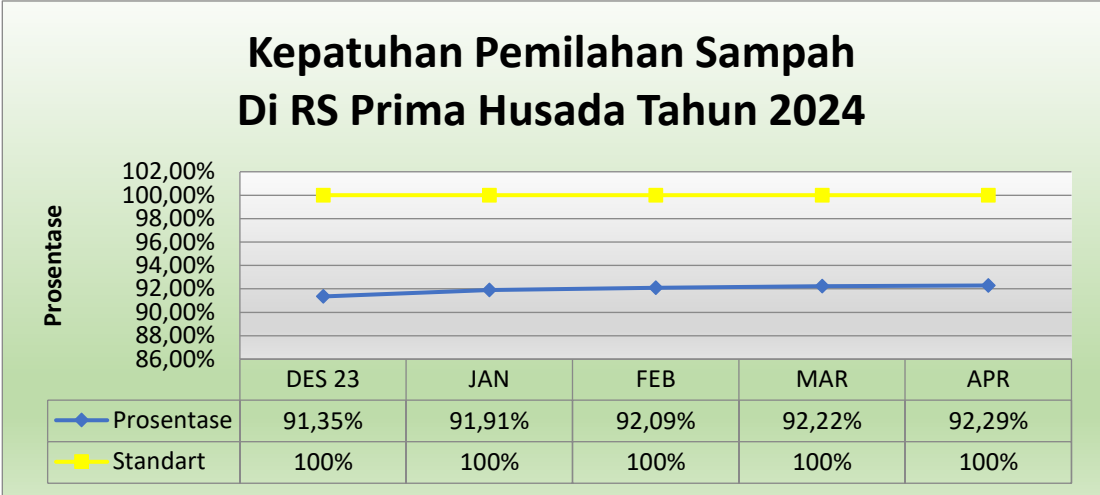


PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan angka kepatuhan penggunaan APD semaksimal mungkin (100%) dengan target peningkatan ± 5% setiap bulannya.				
DO	• Monitoring pelaksanaan audit kepatuhan penggunaan APD yang sesuai. • Melakukan supervise terkait ketersediaan dan kesesuaian penggunaan APD. • Menegur dan melakukan sosialisasi pemakaian APD yang tepat antar staf dibantu oleh IPCLN dan anggota Komite PPI lainnya. • Menegur kepala unit dan IPCLN yang anggotanya ketahuan tidak patuh dalam pemakaian APD. • Sudah dikeluarkan edaran terkait penggunaan jas dokter.				
STUDY	Prosentase kepatuhan penggunaan APD keseluruhan belum mencapai standart, pada bulan ini yaitu sebesar 93,52% meningkat sedikit dari bulan sebelumnya. Dari hasil monitoring dan supervise, penggunaan APD oleh petugas nakes non dokter sudah cukup baik, namun masih ditemukan 1 petugas yang masih berlebihan memakai APD, seperti halnya pada salah satu dokter yang lebih memilih memakai handscoon saat visite karena beranggapan safety untuk dirinya, meskipun sudah seringkali diingatkan. Peningkatan APD juga ada pada unit CS dimana petugas sudah tertib memakai sarung tangan kerja, tidak memakai handscoon saat membersihkan ruangan. Disisi lain juga terdapat peningkatan penggunaan APD pada petugas dapur/penyaji makanan pada saat dilakukan supervise.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
• Meningkatkan kepatuhan pemakaian APD.	• Meningkatkan kepatuhan pemakaian APD di unit.	• Tercapainya kepatuhan APD unit minimal meningkat 2% pada bulan berikutnya.	• Melakukan sosialisasi antar staf tentang penggunaan APD. • Menegur staf yang salah dalam penggunaan APD dan memberikan metode pembelajaran dengan mendata ketidak patuhan teman-teman di unitnya. • Menanamkan kesadaran pada pribadi masing-masing petugas bahwa pemakaian APD yang benar ini penting. • Berkolaborasi dengan perawat untuk tidak memberikan handscoon jika CS meminta handscoon. Selain itu kolaborasi dengan Karu CS untuk menyediakan stok sarung tangan sesuai nama petugas dan 1 stok tiap ruangan untuk menanggulangi sarung tangan yang cepat rusak. • Menjadikan kebiasaan pemakaian APD sesuai dengan	• Seluruh petugas yang melakukan pelayanan di RS.	• Satu bulan

			jenis transmisi penyakit dan tindakan yang akan dilakukan.		
--	--	--	--	--	--

3.1.1.1.9 Pemilahan Sampah Infeksius dan Non Infeksius

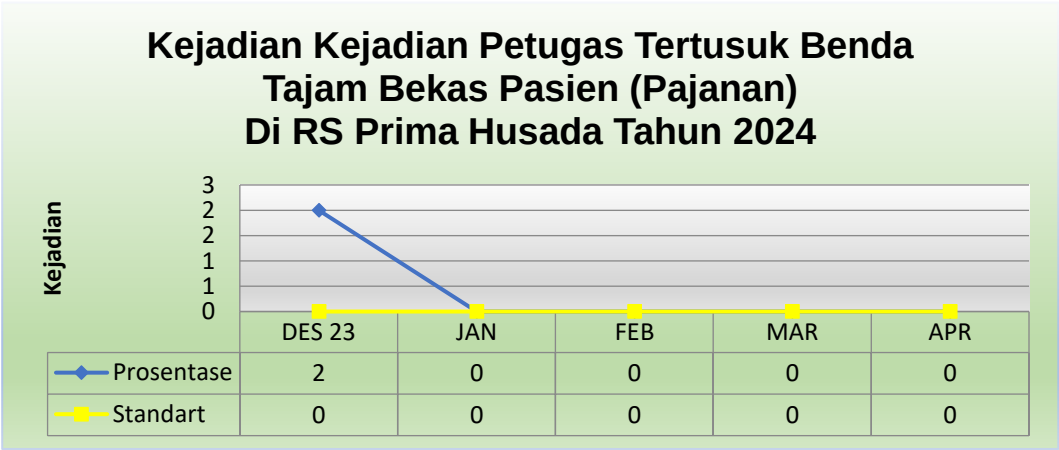
3.1.1.1.9.1 Grafik Kepatuhan Pemilahan Sampah Infeksius dan Non Infeksius di Unit Pelayanan



PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan angka kepatuhan pemilahan sampah infeksius dan non infeksius semaksimal mungkin (100%) dengan target peningkatan ± 5% setiap bulannya.				
DO	- Melakukan supervise terkait pemilahan pembuangan sampah di unit pelayanan pasien. - Melakukan supervise terkait pembuangan sampah di ruang TPS B3. - Melakukan sosialisasi pemilahan sampah yang yang tepat antar staf dibantu oleh IPCLN dan anggota Komite PPI lainnya. - Menegur langsung petugas unit dan Karu/PJ saat itu yang salah melakukan pembuangan sampah dan segera menganjurkan untuk membenarkan bila memungkinkan dan memberitahukan pemilahan sampah yang benar.				
STUDY	Prosentase kepatuhan pemilahan sampah infeksius dan non infeksius keseluruhan belum mencapai standart, pada bulan ini yaitu sebesar 92,29%, sedikit meningkat dari bulan sebelumnya. Dari hasil monitoring dan supervise, petugas sudah mulai melakukan pemilahan sampah sebelum / saat melakukan tindakan sehingga memperkecil risiko salah membuang sampah dan takut ditegur jika ada kesalahan pembuangan sampah karena harus mengambil dan meletakkan ke tempat sampah yang benar. Kesalahan paling sering masih terjadi pada pembuangan plastik spuit dan bungkus alkohol swab, selain itu juga beberapa kali ditemukan ujung tajam selang infus tidak digunting dan tidak dibuang di safety box.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Meningkatkan kepatuhan pemilahan sampah unit.	Meningkatkan kepatuhan pemilahan sampah unit.	Tercapainya kepatuhan pemilahan sampah unit minimal meningkat 3% pada bulan berikutnya.	- Melakukan sosialisasi antar staf tentang pemilahan sampah. - Menegur langsung petugas unit saat itu yang salah melakukan pembuangan sampah dan segera menganjurkan untuk membenarkan bila memungkinkan. - Menyampaikan kesalahan pembuangan unit pada kepala unit dan IPCLN unit dalam forum rapat PPI maupun rapat koordinasi.	Seluruh petugas yang melakukan pelayanan di RS.	Satu bulan

3.1.1.1.10 Kejadian Petugas tertusuk benda Tajam

3.1.1.1.10.1 Grafik Kejadian petugas tertusuk benda tajam bekas pasien (pajanan)



PLAN	Kami berencana untuk menurunkan kejadian petugas tertusuk benda tajam bekas pasien (pajanan) seminimal mungkin (0).				
DO	- Menginputkan laporan pada surveilans SIMRS dan kolaborasi dengan K3RS dan SDM. - Mengevaluasi keadaan luka pasien dan kondisi penyakit sumber pajanan. - Melakukan supervise terkait pengolahan benda tajam dan penyuntikan yang aman. - Melakukan supervise terkait penggunaan APD yang benar sesuai transmisi dan tindakan yang akan dilakukan.				
STUDY	Pada bulan ini tidak ditemukan kejadian petugas tertusuk benda tajam bekas pasien (pajanan).				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Melakukan penyuntikan aman.	Mempertahankan capaian kejadian pajanan 0 kejadian.	Tercapainya standar pajanan 0 kejadian setiap bulannya.	Mempertahankan kegiatan penyuntikan yang aman karena sudah meminimalisir kejadian petugas tertusuk benda tajam bekas pasien.	Seluruh petugas pelayanan di RS.	Satu bulan

3.1.1 Tim PKRS

3.1.1.1 Edukasi Kelompok Unit

NO	UNIT	TARGET	FEB	MAR	APRL	%	MANDOK	KETERANGAN
1	IRNA 2C	8x/Bulan	100%	100%	75%	↓	Ada	
2	ICU HCU	8x/Bulan	0%	50%	0%	↓	Ada	
3	IRNA 3C	8x/Bulan	50%	100%	100%	Tercapai	Ada	
4	MATERNITAS	8x/Bulan	100%	75%	75%	↓	Ada	
5	PERINATOLOGI	8x/Bulan	100%	100%	75%	↓	Ada	
6	IRNA 5C	8x/Bulan	25%	100%	25%	↓	Ada	
7	IRNA 2A,3A,4A	8x/Bulan	100%	100%	50%	↓	Ada	
8	IRNA 6A,7A,8A	8x/Bulan	75%	100%	100%	Tercapai	Ada	
9	IGD	8x/Bulan	100%	100%	100%	Tercapai	Ada	
10	FARMASI	8x/Bulan	100%	100%	25%	↓	Ada	
11	GIZI	8x/Bulan	75%	100%	100%	Tercapai	Ada	
12	IRJA	8x/Bulan	75%	100%	75%	↓	Ada	
13	PPI		100%	100%	100%	Tercapai	Ada	

Analisis : Unit mengalami penurunan dalam produktivitas edukasi kelompok, Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan jumlah pasien setelah hari raya sehingga beberapa perawat tidak dapat

melakukan edukasi kelompok

Rencana Tindak Lanjut : Koordinasi dengan Kepala Ruangan Kepala Bidang Keperawatan Lanjut

3.1.1.2 KIE Individu

NO	UNIT	TARGET	FEB	MAR	APRIL	%	KETERANGAN
1	IRNA 2C	100%	100%	100%	100%	100%	
2	ICU HCU	100%	100%	100%	100%	100%	
3	IRNA 3C	100%	100%	100%	100%	100%	
4	MATERNITAS	100%	100%	100%	100%	100%	
5	PERINATOLOGI	100%	100%	100%	100%	100%	
6	IRNA 5C	100%	100%	100%	100%	100%	
7	IRNA 2A,3A,4A	100%	100%	100%	100%	100%	
8	IRNA 6A,7A,8A	100%	100%	100%	100%	100%	
9	IGD	100%	100%	100%	100%	100%	
10	FARMASI	100%	100%	100%	100%	100%	
11	GIZI	100%	100%	100%	100%	100%	
12	IRJA	100%	100%	100%	100%	100%	

3.1.1.3 Kelengkapan Dokumen Rekam Medis Edukasi (DRM) Edukasi

NO	LEMBAR DRM	JML SAMPLE	KELENGKAPAN		ISI BENAR	VERIFIKASI KE PASIEN	KET
			YA	TIDAK			
1	General Consent	15	15		Isi sesuai	Ya	- Kekurang an TTD pada nama petugas
2	SBAR	15	15		Isi sesuai	Ya	Ketidaklengk apan pada penulisan nama petugas dan nama pasien yg jelas
3	Perencanaan Edukasi / Rencana Asuhan	15	15		Isi sesuai	Ya	Nama Petugas tidak terisi lengkap
4	Pengkajian Kebutuhan KIE	15	15		Isi sesuai	Ya	
5	KIE Informed Consent	15	15		Isi sesuai	Ya	Nama Petugas Tidak terisi lengkap
6	CPPT	15	15		Isi sesuai	Ya	-
7	Ringkasan Pasien Pulang	15	15		Lengka p	Ya	-
8	Discharged Planning	15	15	0			
9	Edukasi kolaborasi	16	16	0	Isi sesuai	Ya	-
11	KIE Menjelang Akhir Kehidupan (Pada Pasien yang mau meninggal)	1	1	0	Isi sesuai		
12	Form AMA	2	2	0	Isi	Ya	

					Sesuai		
13	Semua Form yang ada Pemberian Informasi Ke Pasien	15	15	0	Isi Sesuai	Ya	
14	KIE Pre OP di Lembar Pre OP	1	1	0	Isi Sesuai	Ya	

Analisis

: Seluruh DRM edukasi terisi , terdapat beberapa ketidaklengkapan meliputi kekurangan pada penulisan nama petugas pemberi KIE , Kekurangan pada isi yang kurang lengkap di perencanaan edukasi .

Rencana Tindak Lanjut

: Sosialisasi kepada PPA Pelaksana untuk melengkapi DRM dengan baik dan benar

3.1.1.4 Pembinaan Komunitas Berbasis RSPH

NO	UNIT	TARGET	KEGIATAN	FEB	MAR	APRIL	%	MANDOK	KET
1	Komunitas Geriatri	2X/Bulan	Senam	100%	50%	50%	↓50%	Ada	Ramadhan dan Hari raya
			Hypnoterapi						
			KIE						
2	Komunitas Ibu Hamil	2X/Bulan	Senam	100%	50%	50%	↓50%	Ada	Ramadhan dan Hari raya
			Hypnoterapi						
			KIE						
3	Komunitas Shirothul Jannah Perempuan	2X/Bulan	Pengajian	100%	100%	50%	↓	Ada	Libur Hari raya
			Karya wisata						
4	Komunitas Shirothul Jannah Laki Laki	2X/Bulan	Pengajian	100%	100%	50%	↓	Ada	
5	Bimbingan Doa	8X/Bulan	Mendoakan Pasien	100%	100%	100%	100%	Ada	
6	General Meeting Karyawan	1x/2Bulan		100%			100%	Belum dilakukan	
7	Pembinaan Fatayat	1X/Tahun							Planning dilakukan di Bulan Mei

3.1.1.5 KIE Upaya Preventif Promotif PROGNAS

NO	UNIT	TARGET	FEB	MAR	APRL	%	MANDOK	KETERANGAN
1	PONEK	4X/Bulan	0%	0%	0%	0%		
2	HIV	4X/Bulan	0%	0%	0%	0%		
3	STUNTING dan WASTING	4X/Bulan	0%	0%	0%	0%		
4	KELURAGA BERENCANA RUMAH SAKIT (KABERUSA)	4X/Bulan	0%	0%	0%	0%		
5	TB DOTS	4X/Bulan	0%	0%	0%	0%		

Analisis

: Penanggungjawab PROGNAS Inaktif selama Tahun 2024 tidak melakukan kegiatan edukasi kelompok

Rencana Tindak Lanjut

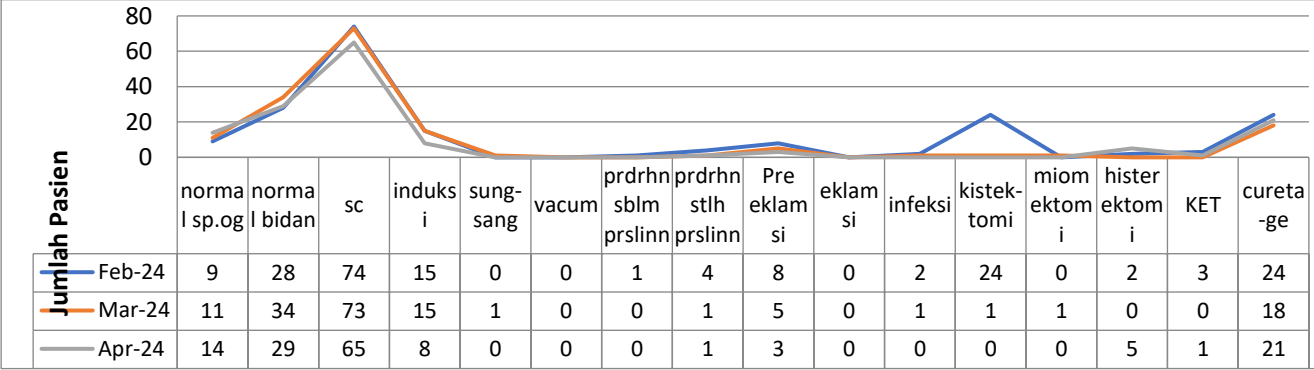
: Koordinasi dengan Kepala Bidang Umum dan Pelayanan untuk dapat menghidupkan kembali kegiatan PROGNAS

3.1.2 Tim Prognas
3.1.2.1 PONEK

3.1.2.1.1 Jumlah Kegiatan Pelayanan Maternal Ponek RSPHM
April 2024

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH PASIEN		
		BULAN FEBRUARI 2024	BULAN MARET 2024	BULAN APRIL 2024
1	Persalinan			
	a. Persalinan Normal Sp. OG	9	11	14
	b. Persalinan Normal Bidan	28	34	29
	c. <i>SectioCaesaria</i>	74	73	65
2				
	a. Induksi / Drip	15	15	8
	b. Sungsang	0	1	0
	c. Vacum	0	0	0
3				
	a. Perdarahan sebelum Persalinan	1	0	0
	b. Perdarahan setelah Persalinan	4	1	1
	c. Pre Eklamsi	8	5	3
	d. Eklamsi	0	0	0
	e. Infeksi	2	1	0
4				
	a. Curretage	24	18	21
	b. Kistektomi	2	1	0
	c. Miomektomi	0	1	0
	d. Histerectomy	2	0	5
	e. KET	3	0	1

3.1.2.1.2 Grafik Jumlah Kegiatan Pelayanan Maternal Di RS Prima Husada Bulan April 2024



Analisis :

1. Pada jenis pelayanan Persalinan secara Sectio Caesaria pada April 2024 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu 65 pasien. Dan untuk persalinan normal ditolong dokter pada bulan pada bulan April 2024 mengalami sedikit peningkatan jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya yaitu 14 pasien. Sedangkan persalinan yang ditolong oleh bidan mengalami penurunan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya yaitu 29 pasien. Untuk persalinan normal, jika memang tidak ada penyulit maka persalinan bisa ditolong bidan terlebih dahulu.
2. Kebanyakan pasien yg dilakukan tindakan SC adalah pasien dari poli kandungan yang memang telah dijadwalkan untuk operasi dikarenakan ada diagnosa khusus sehingga harus dilakukan operasi SC, misalnya bekas sc, floating head, placenta previa, letak sungsang, dan lainnya, atau pasien yang ada di ruang bersalin yang gagal untuk persalinan normal dikarenakan ada penyulit seperti prolong kala 1, kala 2 lama, fetal distress. Dan juga pasien dilakukan operasi sc adalah pasien rujukan dari bidan ataupun puskesmas yang harus dilakukan operasi dikarenakan adanya kegawatan pada ibu atau bayi dan akhirnya harus dilakukan operasi sc cito.
3. Tidak ada Persalinan sungsang pada bulan Februari dan April, sedangkan pada bulan Maret terdapat 1 persalinan sungsang, dan tidak ada persalinan dengan vacum pada bulan Februari sampai dengan April 2024
4. Induksi Persalinan pada bulan April mengalami penurunan jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu sebanyak 8 pasien.
5. Jenis pelayanan persalinan dengan komplikasi ialah pre eklamsi. Pada bulan April 2024 menurun jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya yaitu 3 pasien. Dan tidak ada kejadian eklamsi pada bulan Februari sampai dengan April 2024.
6. Jenis pelayanan curretage di bulan April 2024 mengalami peningkatan jika dibandingkan pada bulan sebelumnya, yaitu 21 pasien. *Curetage* dilakukan untuk indikasi abortus, mola, blighted ovum, sisa plasenta dan pada kasus-kasus gynekology biasanya dengan indikasi menometoragi, hyperplasia endometrium, dan lainnya.

Rencana dan Tindak Lanjut :

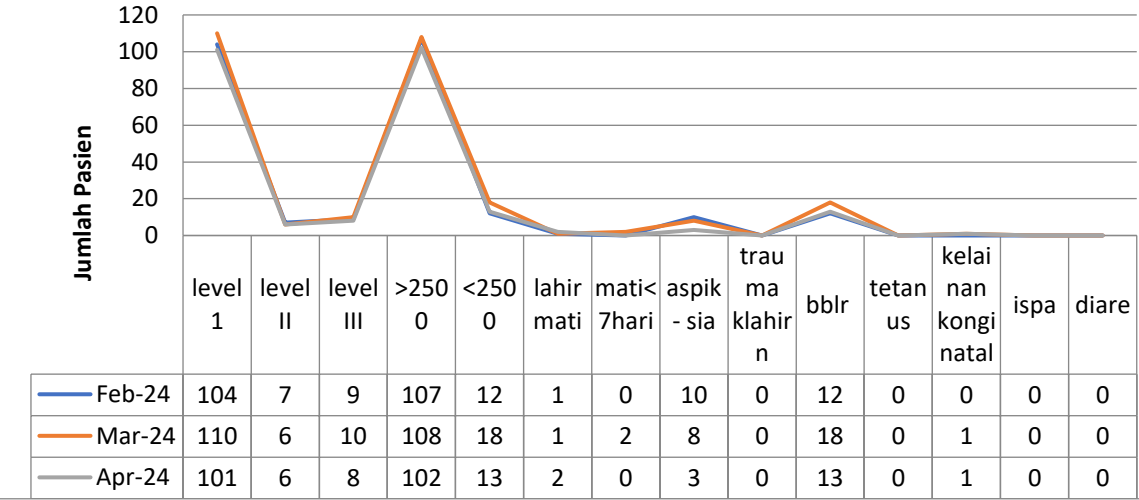
1. Kolaborasi dengan bagian marketing rumah sakit terkait jumlah kunjungan pasien obgyn salah satunya dengan mengadakan pelatihan bidan-bidan perujuk.
2. Melakukan edukasi kepada pasien hamil saat ANC tentang konsumsi makan makan yang mengandung garam terlalu tinggi, terutama pasien dengan riwayat darah tinggi.
3. Melakukan edukasi kepada pasien hamil saat ANC tentang tanda dan bahaya pada kehamilan.
4. Melakukan edukasi kepada pasien ANC trimester 3 tentang tanda-tanda persalinan.

3.1.2.1.2 Jumlah Kegiatan Pelayanan Neonatal

3.1.2.1.2.1 Tabel Jumlah Kegiatan Pelayanan Neonatal Ponек RSPHM April 2024

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH PASIEN		
		BULAN FEBRUARI 2024	BULAN MARET 2024	BULAN APRIL 2024
1				
	a. Level 1	104	110	101
	b. Level II	7	6	0
	c. Level III	9	9	8
2				
	a. ≥ 2500 gram	107	108	102
	b. ≤ 2500 gram	12	18	13
3				
	a. Kelahiran Mati	1	1	2
	b. Mati Neonatal < 7 Hari	0	2	0
4				
	a. Asphyxia	10	8	3
	b. Trauma Kelahiran	0	0	0
	c. BBLR	12	18	13
	d. Tetanus Neonatorum	0	0	0
	e. Kelainan Congenital	0	1	1
	f. ISPA	0	0	0
	g. DIARE	0	0	0
5	Lain-lain	0	0	0

3.1.2.1.2.2 Grafik Jumlah Kegiatan Pelayanan Neonatal Di RS Prima Husada Bulan April 2024



- Analisis :**
- Pada jenis pelayanan pasien neonatal level 1 di bulan April 2024 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu 101 bayi. Sedangkan level 2 pada bulan Maret dan April tetap yaitu 6 bayi. Sedangkan pada level 3 mengalami sedikit penurunan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya yaitu 8 bayi.
 - Pada jenis pelayanan bayi lahir hidup ialah >2500 gram di bulan April 2024 mengalami sedikit penurunan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya yaitu sebanyak 102 bayi.

3. Dan jumlah bayi lahir hidup <2500 gram (BBLR) di bulan April 2024 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 13 bayi. Masih adanya kelahiran < 2500 gram dikarenakan kelahiran belum cukup bulan atau IUGR.
4. Kasus BBLR pada bulan April 2024 menurun jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya yaitu 13 bayi.
5. Kasus kelahiran mati pada bulan April sedikit meningkat yaitu sebanyak 2 kasus
6. Tidak ada kasus kematian neonatus <7 hari pada bulan April, sedangkan pada bulan Maret terdapat 2 kasus kematian.

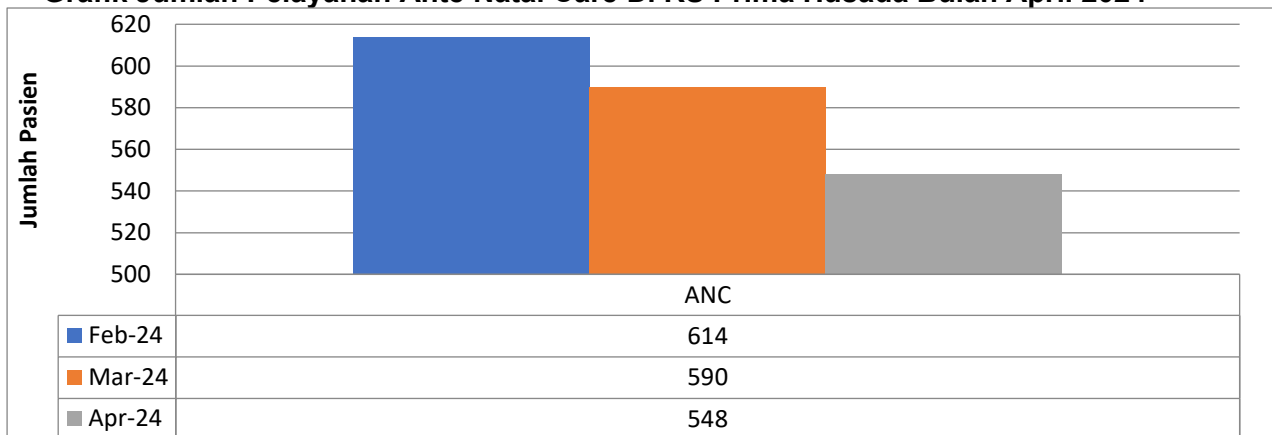
Rencana dan Tindak Lanjut

1. Melakukan edukasi dan sosialisasi kepada ibu hamil saat dilakukan ANC untuk mengurangi kegiatan berat dan istirahat cukup agar tidak terjadi partus prematurus imminens (PPI) yang mengakibatkan kelahiran prematur.
2. Melakukan edukasi dan sosialisasi kepada ibu hamil saat dilakukan ANC terkait asupan gizi saat ibu hamil, guna mencegah bayi lahir dengan IUGR.

3.1.2.1.2.3 Pelayanan Ante Natal Care (ANC)
Tabel Pelayanan Ante Natal Care (ANC) Ponpek RSPHM April 2024

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH		
		BULAN FEBRUARI 2024	BULAN MARET 2024	BULAN APRIL 2024
1	ANC	614	590	548

Grafik Jumlah Pelayanan Ante Natal Care Di RS Prima Husada Bulan April 2024



Analisis :

Pelayanan ANC pada bulan April 2024 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu sebanyak 548 kunjungan.

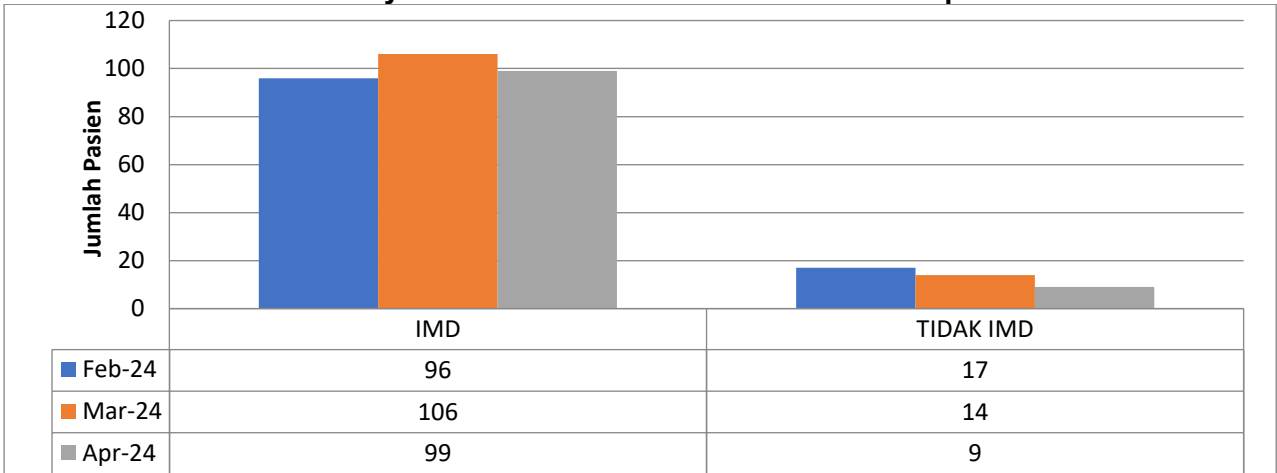
Rencana dan Tindak Lanjut :

Melakukan promosi terkait pemeriksaan ANC seperti USG 4 dimensi serta kegiatan senam hamil yang diharapkan menarik minat para ibu hamil untuk memeriksakan kehamilannya di RS.

3.12.1.2.4 Inisiasi Menyusu Dini (IMD)
Tabel Pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) April 2024

NO	URAIAN	JUMLAH PASIEN		
		BULAN FEBRUARI 2024	BULAN MARET 2024	BULAN APRIL 2024
1	IMD	96	106	99
2	Tidak IMD	17	14	9

Grafik Jumlah Pelayanan IMD di RS Prima Husada Bulan April 2024



Analisis :

1. Bayi yang dilakukan IMD pada bulan April 2024 mengalami sedikit penurunan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 99 bayi. Dan tidak semua bayi baru lahir dilakukan IMD, dikarenakan tidak memenuhi kriteria untuk dilakukannya IMD.
2. Kasus tidak dilakukan IMD pada bulan April 2024 menurun jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu 9 bayi. Hal ini terjadi diiringi dengan masih adanya bayi lahir dengan berat <2500 gr sehingga tidak dilakukan IMD.
3. Pada bayi yang tidak dilakukan IMD memang tidak memenuhi kriteria untuk dilakukan IMD dikarenakan BBLR yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.

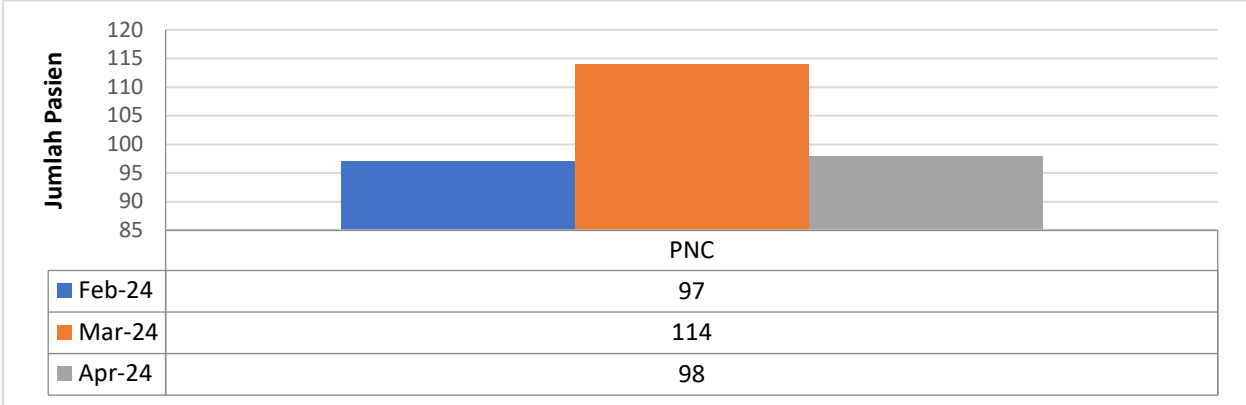
Rencana dan Tindak Lanjut :

Melakukan skrining sebelum dilakukan tindakan inisiasi menyusui dini (IMD) pada bayi baru lahir, apakah sesuai dengan syarat atau tidak.

3.1.2.2.1.5 Pelayanan Post Natal Care (PNC)
Tabel Pelayanan Post Natal (PNC) Ponek RSPHM April 2024

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH		
		BULAN FEBRUARI 2024	BULAN MARET 2024	BULAN APRIL 2024
1	PNC	97	114	98

Grafik Jumlah Pelayanan Post Natal Care di RS Prima Husada Bulan April 2024



Analisis :
Pelayanan PNC pada bulan April 2024 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 98 kunjungan.

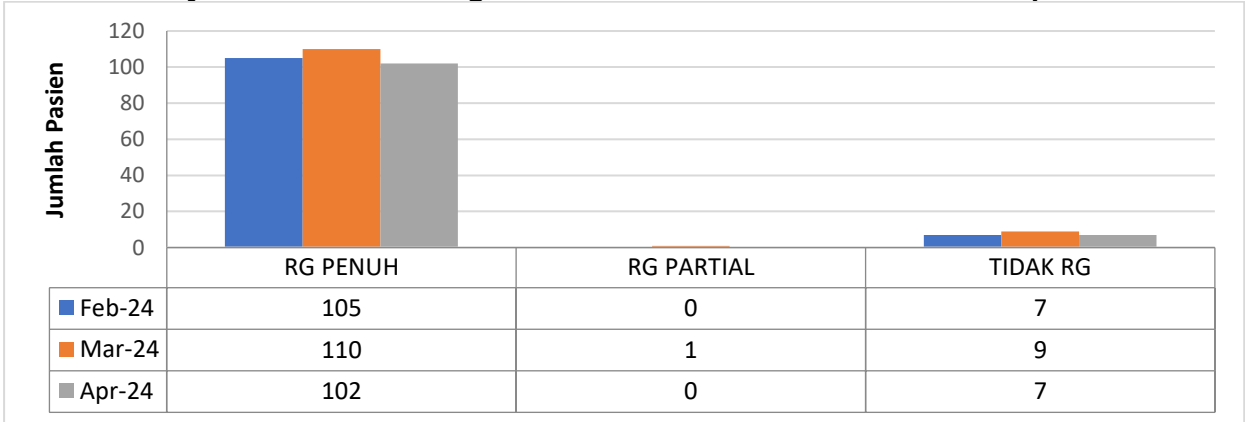
Rencana dan Tindak Lanjut :

Melakukan Edukasi ke pasien pasca bersalin untuk melakukan pemeriksaan PNC di RS Prima Husada

3.1.2.2.1.6 Pelayanan Rawat Gabung
Tabel Pelayanan Rawat Gabung Ponek RSPHM April 2024

NO	URAIAN	JUMLAH PASIEN		
		BULAN FEBRUARI 2024	BULAN MARET 2024	BULAN APRIL 2024
1	Rawat gabung penuh	105	110	102
2	Rawat gabung partial	0	1	0
3	Tidak Rawat gabung	7	9	7

Grafik Pelayanan Rawat Gabung Di Rumah Sakit Prima Husada Bulan April 2024



- Analisis :**
- Jumlah bayi yang dilakukan rawat gabung pada bulan April 2024 sedikit menurun jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu sebanyak 102 bayi. Jumlah bayi yang dilakukan rawat gabung dengan syarat bayi dan ibu dalam kondisi sehat
 - Bayi yang tidak dilakukan rawat gabung pada bulan April 2024 mengalami sedikit penurunan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu sebanyak 7 bayi.
 - Bayi yang tidak dilakukan rawat gabung adalah bayi yang membutuhkan perawatan khusus yaitu diletakkan di cuvis atau incubator karena berat bayi <

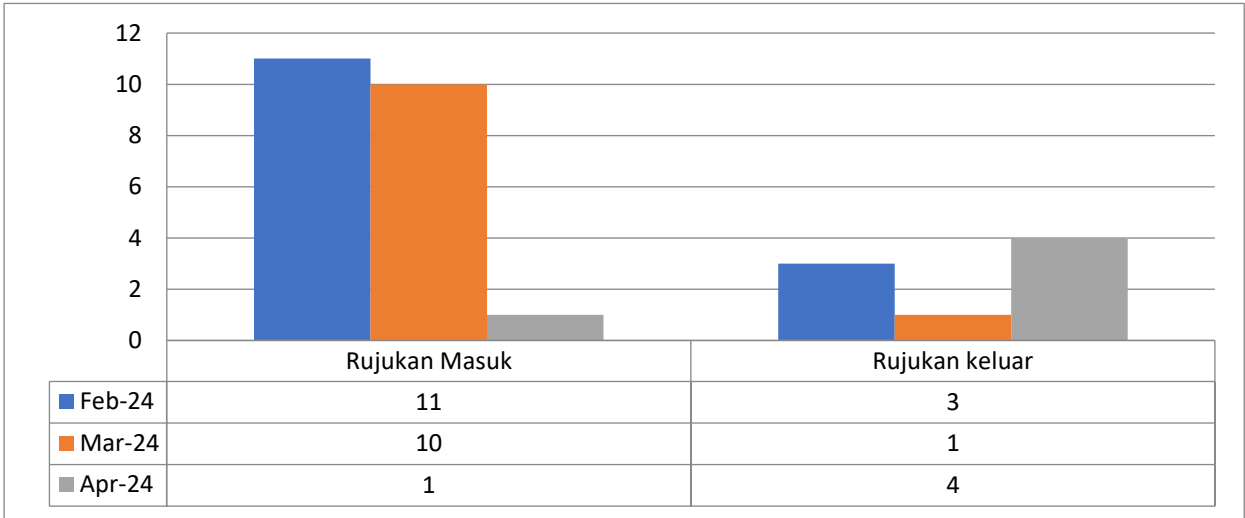
2500 gram dan masih belum memungkinkan dilakukan rawat gabung karena masih menggunakan alat bantu pernafasan.

Rencana dan Tindak Lanjut :
Melakukan skrening awal untuk pasien yang layak dilakukan rawat gabung ibu dan bayi.

3.1.2.2.1.7 Pelayanan Jejaring Rujukan
Tabel Pelayanan Jejaring Rujukan Ponек RSPHM April 2024

NO	RUJUKAN	BULAN FEBRUARI 2024	BULAN MARET 2024	BULAN APRIL 2024
1	Rujukan Masuk	11	10	1
2	rujukan keluar	3	1	4

Grafik Pelayanan Rujukan RS Prima Husada Bulan April 2024

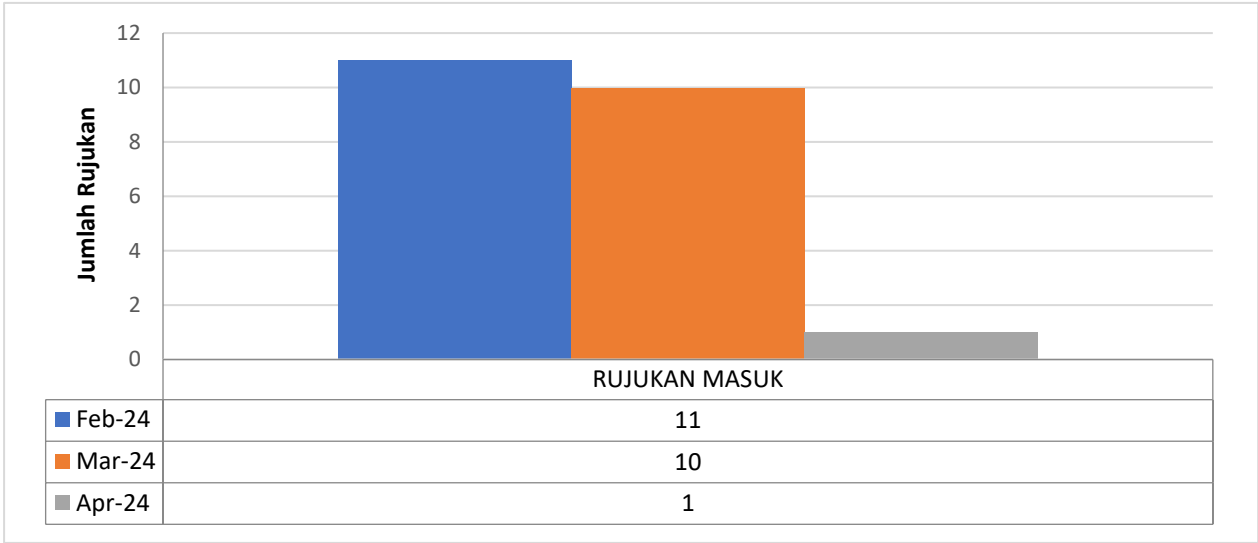


3.1.2.2.1.7.1 Rujukan Masuk
Tabel Rujukan Masuk Ponек RSPHM April 2024

BULAN FEBRUARI 2024		
1	G3 P2002 Ab000 UK 40 mgg dg PEB	BPM Nurul ismawati
2	G3 P2002 Ab000 UK 10 – 12 mgg dg DHF	Klinik Putra Husada
3	G4 P3003 Ab000 11-12 mgg dg Abortus Inkomplit	BPM Suma'iyah
4	G2 P1001 ab000 Uk 39 – 40 mgg dg gemelli + KIFA + PE	BPM Rini Idawati
5	G2 P0000 ab100 uk 39 – 40 mgg dg KIFL	BPM Indi
6	G1 P0000 ab000 uk 40-41 mgg dg kala 2 lama	BPM Tri Widiyawati
7	G1 P0000 Ab000 Uk 39-40 mgg dg susp CPD	BPM Titik
8	G2 P1001 ab000 uk 39-40 mgg dg BSC	BPM Titik
9	G3 P2002 ab000 Uk 39 – 40 mgg dg KIFA	BPM Indi
10	G1 P0000 Ab000 uk 6-8 mgg dg HEG	Klinik Mutiara Sehat
11	NKB + BBLSR + ASFIKSIA	BPM
BULAN MARET 2024		
1	G1 P0000 Ab000 UK 30-32 mgg dengan PPR0M	RS Sumber Sentosa
2	G1 P0000 Ab000 UK : 28-30 mgg dg obs vomiting + anemia	Klinik Mutiara Sehat
3	G3 P2002 Ab000 UK : 39-40 mgg dg Prolong Fase laten + KPD	PKM Singosari
4	G1 P0000 AB000 UK 40-41 MGG DG KIFL	BPM Anis Sulisyorini
5	G2 P1001 Ab000 UK 39-40 mgg dg BSC	PMB Indi
6	G1 P0000 Ab000 UK 36-37 mgg dg prolong fase laten	RS Marsudi Waluyo

7	G2 P1001 Ab000 UK 39-40 mgg dg KIFL + BSC	BPM Sri Utami
8	G1 P0000 Ab000 UK 39-40 mgg dg PE	BPM Titik
9	G2 P1001 Ab000 UK 42 mgg dg KIFA+ PE	BPM Lilik Agustina
10	G3 P2002 Ab000 UK 38-39 mgg dg PE	BPM Subaeda
BULAN APRIL 2024		
1	G1 P0000 ab000 UK 38-39 mgg dg PEB	BPM Sofia

Grafik Pelayanan Rujukan Masuk RS Prima Husada Bulan April 2024



Analisis :

Jumlah rujukan masuk pada bulan April 2024 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu 1 rujukan masuk.

Rencana dan Tindak Lanjut

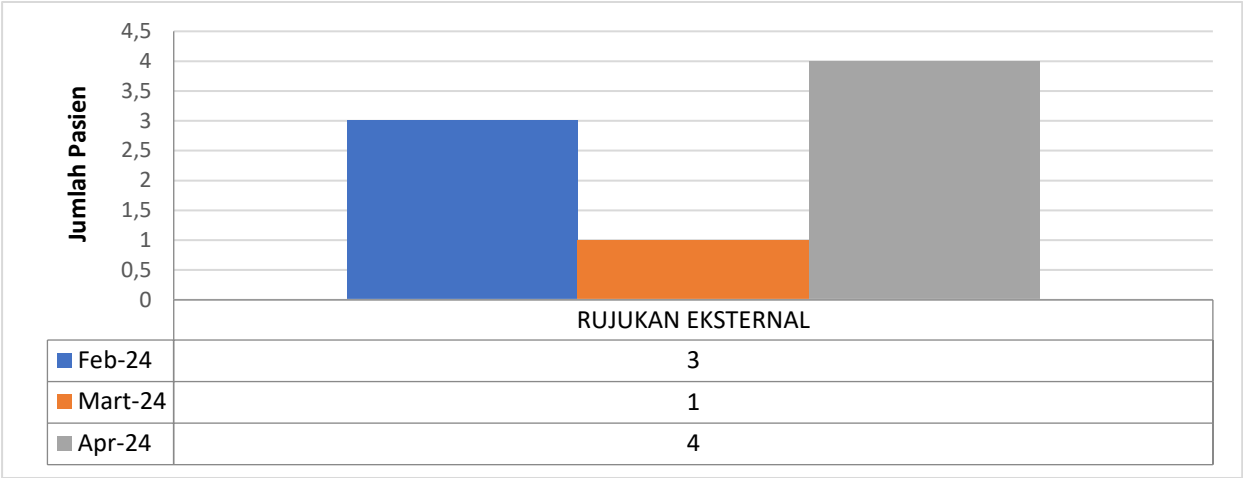
Bekerja sama dengan tim PKRS untuk melakukan promosi kesehatan dan mengajak BPM atau RS setempat untuk bekerja sama.

3.1.2.2.7.2 Rujukan Keluar

Tabel Rujukan Keluar Ponek RSPHM April 2024

BULAN FEBRUARI 2024		
1	NKB+BBLR+ASFIKSIA	RS Soepraoen
2	NKB+BBLSR+ASFIKSIA	RS Soepraoen
3	Pneumonia, Asfiksia. BBLR	RS Lavalette
BULAN MARET 2024		
1	NKB + BBLSR + ASFIKSIA	RS Soepraoen
BULAN APRIL 2024		
1	RDS+HMD dd Neonatal Pneumonia	RS Lavalette
2	RDS dd HMD + BBLSR	RS Lavalette
3	RDS + Prematur + BBLSR	RS Saiful Anwar
4	Akut Abdomen + kista ovarium curiga ganas	RS Saiful Anwar

Grafik Pelayanan Rujukan Eksternal di RS Prima Husada Bulan April 2024



Analisis :

Pada bulan April 2024 pasien yang dirujuk keluar meningkat jika dibandingkan dengan 2 bulan Sebelumnya, yaitu 4 pasien.

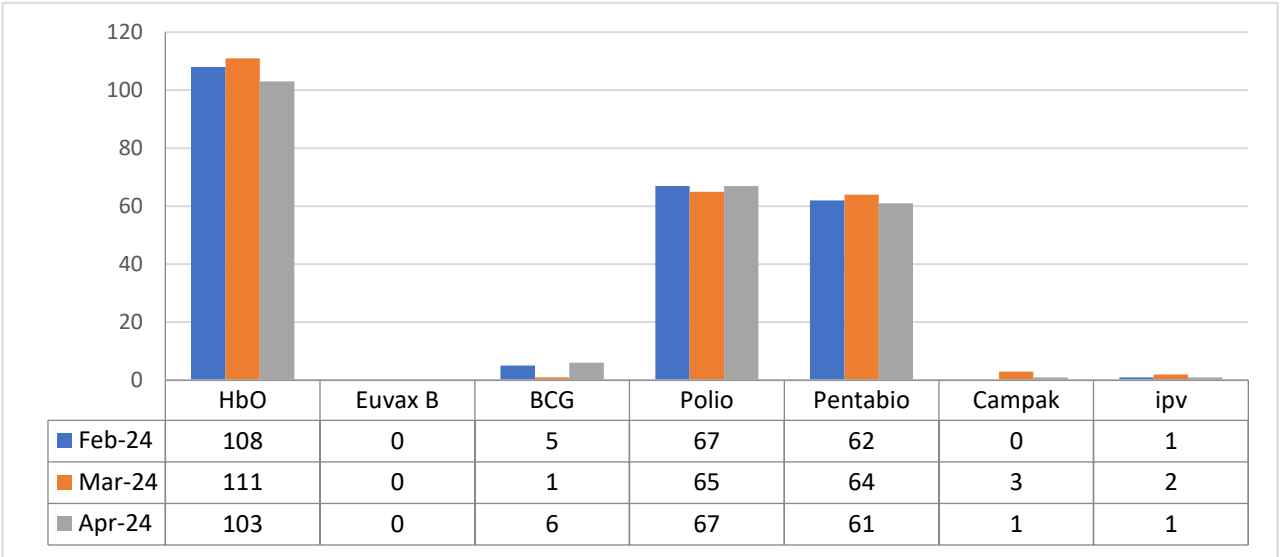
Rencana dan Tindak Lanjut :

Menambah jumlah pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan pasien, sehingga meminimalisasikan untuk dilakukan rujukan keluar.

3.1.2.2.12.8 Pelayanan Imunisasi
Tabel Pelayanan Imunisasi Ponek RSPHM April 2024

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH		
		BULAN FEBRUARI 2024	BULAN MARET 2024	BULAN APRIL 2024
1	HbO	108	111	103
2	Euvax B	0	0	0
3	BCG	5	1	6
3	Polio	67	65	67
4	Pentabio	62	64	61
5	Campak	0	3	1
6	IPV	1	2	1

Grafik Pelayanan Imunisasi Di Rumah Sakit Prima Husada Bulan April 2024



Analisis :

- 1. Tidak ada penggunaan vaksin euvax B pada periode April 2024 maupun 2 bulan sebelumnya, hal ini dikarenakan banyak nya pasien bayi baru lahir dengan status BPJS, sehingga memakai imunisasi HB.O unijek.
- 2. Imunisasi Hbo pada bulan April mengalami penurunan jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu sebanyak 103 bayi. Dan ini seiring dengan jumlah bayi baru lahir yang ada di RS
- 3. Bayi yang melakukan Imunisasi IPV Pada bulan April menurun jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 1 bayi
- 4. Bayi yang melakukan Imunisasi BCG Pada bulan April 2024 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 6 pasien.
- 5. Pada periode April 2024 bayi yang melakukan Imunisasi Campak mengalami penurunan yaitu 3 bayi.
- 6. Bayi yang melakukan Imunisasi Polio Pada bulan April 2024 mengalami sedikit penurunan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 67 bayi
- 7. Jumlah pasien yg imunisasi Pentabio pada bulan April 2024 mengalami sedikit penurunan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 61 pasien

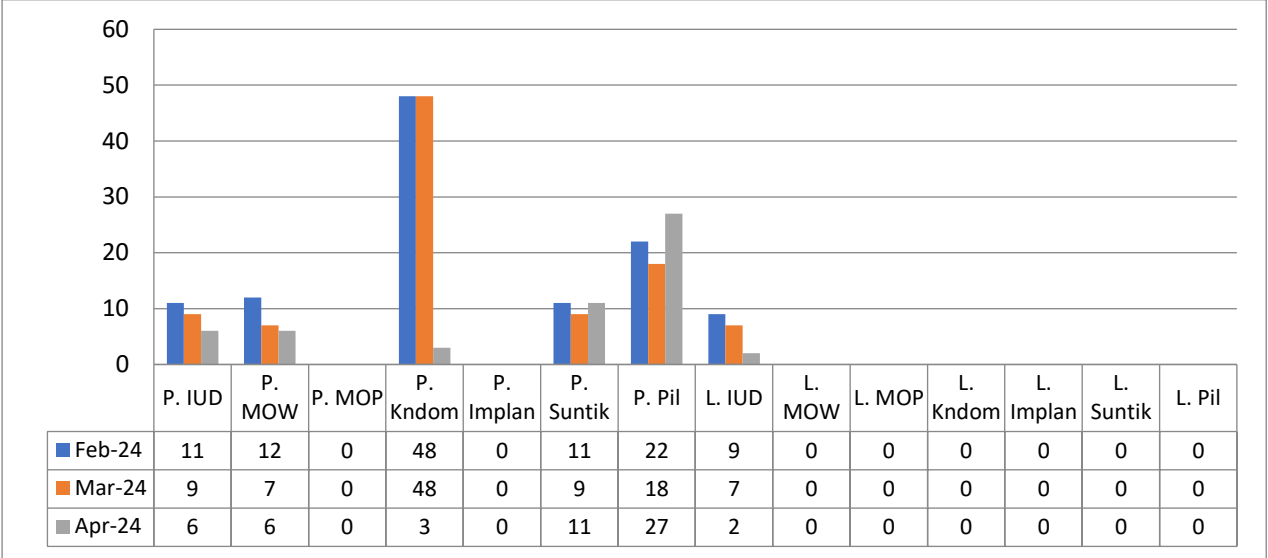
Rencana dan Tindak Lanjut :

- 1.Membuat surat permintaan berupa laporan bulanan kepada puskesmas untuk pemenuhan kebutuhan vaksin di rumah sakit.
- 2.Melakukan promosi terkait pelayanan imunisasi, baik oleh bidan maupun dokter spesialis rumah sakit.

3.2.2.1.2.9 Pelayanan Keluarga Berencana (KB)
Tabel Pelayan Keluarga berencana (KB) Ponok RSPHM April 2024

NO	JENIS	JUMLAH PASANG			JUMLAH LEPAS		
		BULAN FEBRUARI 2024	BULAN MARET 2024	BULAN APRIL 2024	BULAN FEBRUARI 2024	BULAN MARET 2024	BULAN APRIL 2024
1	IUD	11	9	6	9	7	2
2	MOW	12	7	6	0	0	0
3	MOP	0	0	0	0	0	0
4	Kondom	48	48	3	0	0	0
5	Implant	0	0	0	0	0	0
6	Suntikan	11	9	11	0	0	0
7	Pil	22	18	27	0	0	0

Grafik Pelayanan KB Di Rumah Sakit Prima Husada Bulan April 2024



Aanalisis :

- 1. Pemasangan KB IUD pada bulan bulan April 2024 menurun jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu 6 akseptor, dan semua menggunakan IUD Copper T
- 2. Pasien yang menggunakan metode MOW pada bulan April 2024 menurun jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu 6 pasien. Untuk pemasangan KB MOW dilakukan sesuai dengan indikasi pasiennya, seperti pada pasien grande multipara dan primi tua sekunder.
- 3. Pasien yang menggunakan metode kondom pada bulan April 2024 mengalami penurunan yang cukup tinggi yaitu hanya 3 pasien.
- 4. Pasien yang menggunakan metode Pil pada bulan April 2024 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu sebanyak 27 pengguna
- 5. Pasien yang menggunakan metode suntik pada bulan April 2024 mengalami sedikit pwningkatan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 11 pengguna

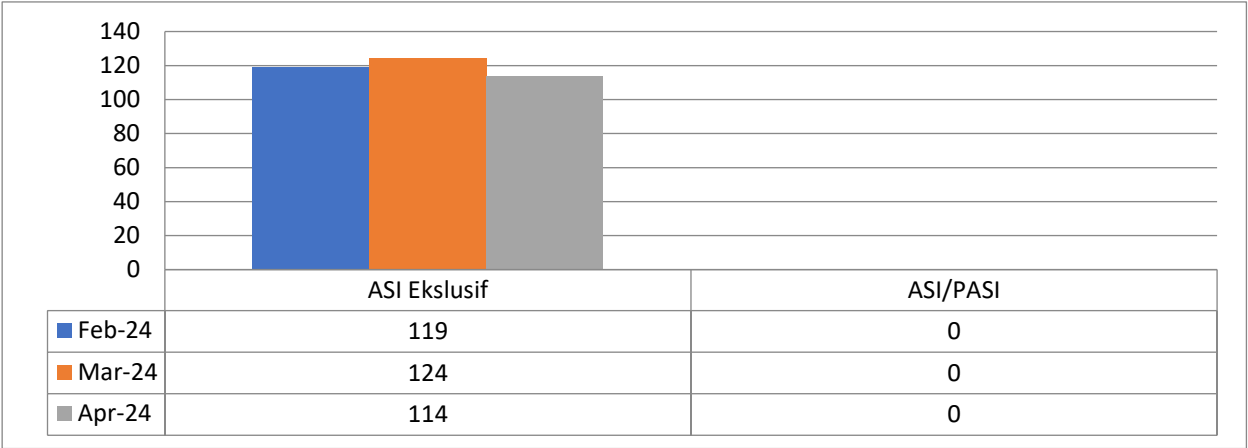
Rencana dan Tindak Lanjut :

Melakukan promosi terkait pelayanan KB baik dilakukan oleh bidan maupun dokter spesialis di rumah sakit.

3.3 Pelayanan Pemberian ASI Eksklusif
Tabel 5.10 Pelayanan Pemberian ASI Eksklusif Ponек RSPHM 2024

NO	PEMBERIAN ASI	JUMLAH PASIEN		
		BULAN FEBRUARI 2024	BULAN MARET 2024	BULAN APRIL 2024
1	Asi eksklusif	119	124	114
2	Asi /PASI	0	0	0

Grafik Pelayanan Pemberian Asi Eksklusif Di RS Prima Husada Bulan April 2024



Analisis :

- 1. Pelayanan pemberian ASI eksklusif pada bulan April mengalami penurunan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 114 bayi. Hal ini dikarenakan meskipun ada bayi dengan BBLR juga tetap diberikan ASI eksklusif
- 2. Diperbolehkan menggunakan sufor pada bayi dengan kondisi tertentu, dan pastinya atas rekomendasi dari dokter spesialis anak.

Rencana dan Tindak Lanjut :

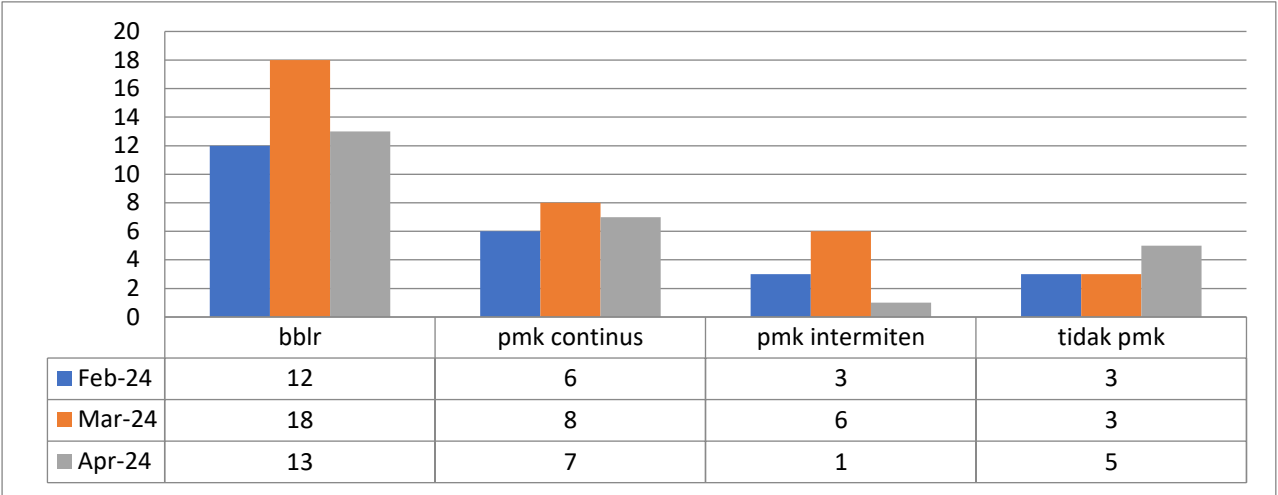
Dilakukannya Edukasi dengan adanya kelas ibu menyusui saat dilakukan perawatan di rumah sakit. Sehingga ada kegiatan tanya jawab, demonstrasi dan bertukar ilmu terkait pemberian ASI eksklusif

3.2.2.1.2.10 Pelayanan Perawatan Metode Kangguru (PMK) Pada BBLR

Tabel Pelayanan Perawatan metode kangguru (PMK) Pada BBLR di Ponok RSPHM April 2024

NO	URAIAN	JUMLAH PASIEN		
		BULAN FEBRUARI 2024	BULAN MARET 2024	BULAN APRIL 2024
1	Bayi BBLR	12	18	13
2	PMK continuos	6	8	7
3	PMK Intermiten	3	6	1
4	Tidak PMK	3	3	5

Garfik Pelayanan Perawatan Metode Kangguru (PMK) Pada BBLR Di RS Prima Husada Bulan April 2024



Analisis :

- 1. Bayi yang dilakukan PMK continus dan PMK intermiten adalah bayi dengan berat badan <2500gram.
- 2. Pelayanan perawatan metode kangguru (PMK) dengan metode intermiten pada BBLR di bulan April 2024 menurun jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, menjadi 1 bayi.
- 3. Sedangkan metode PMK continus pada bulan April 2024 sedikit meningkat jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya yaitu 7 bayi. hal ini seiring dg jumlah BBLR yang ada
- 4. Dan terdapat 5 bayi yang masih tidak dilakukan PMK pada bulan April 2024, dan meningkat jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya. hal ini dikarenakan kondisi bayi yg tidak mendukung untuk dilakukan PMK atau bayi di rujuk ke RS lain.

Rencana dan Tindak Lanjut

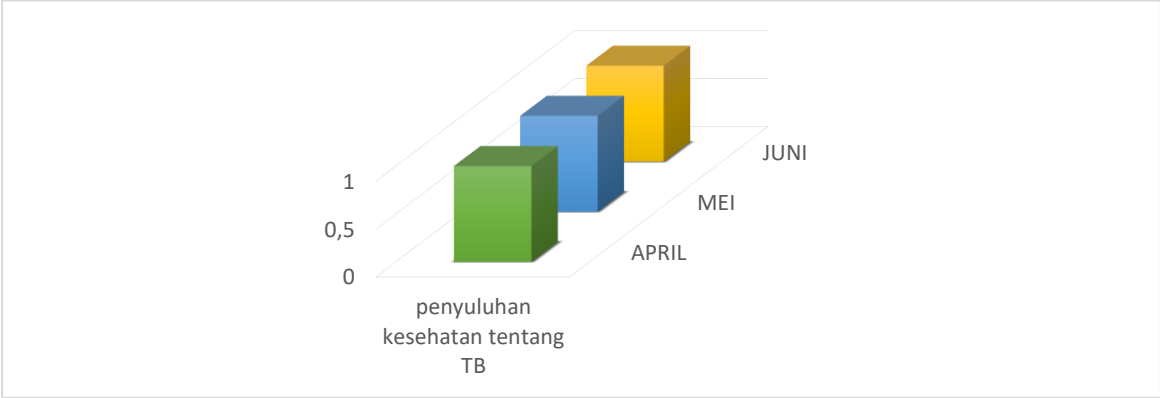
Perawatan Metode Kangguru sesuai dengan SPO yang berlaku

3.1.2.2. TB DOTS

3.1.2.2.1 Jumlah Kegiatan Promosi Kesehatan Tentang Tuberculosis

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH KEGIATAN		
		APRIL	MEI	JUNI
1	Penyuluhan kesehatan tentang tuberculosis	1		

Grafik Jumlah Kegiatan Promosi Kesehatan di RS Prima Husada



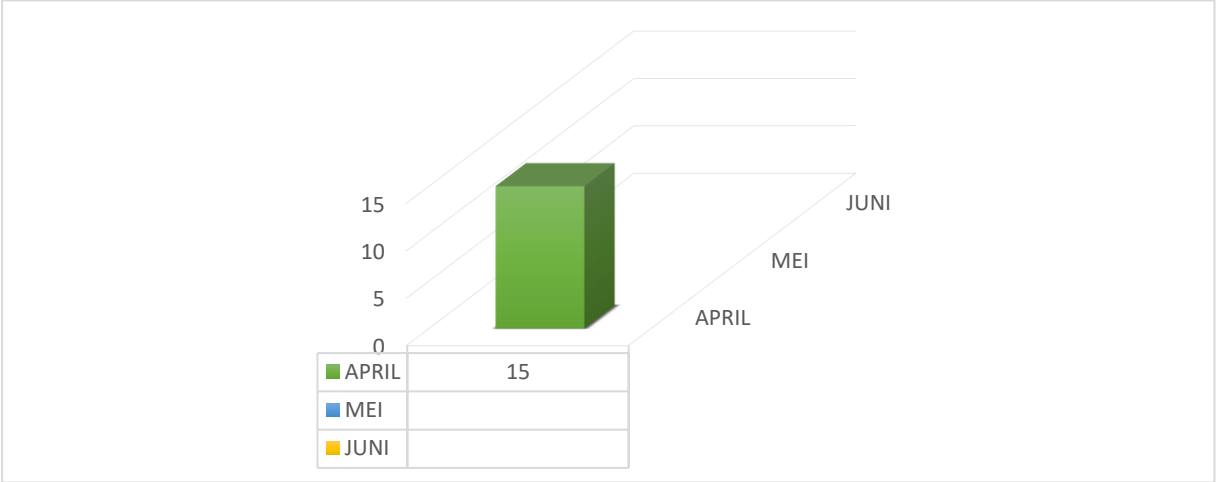
Analisis:
Peserta audiens ditujukan kepada pasien dan keluarga pasien, dengan harapan peserta memahami hasil penyuluhan.

Rencana dan Tindak Lanjut:
Harus diadakan promosi kesehatan secara berkala terkait TBC seperti; pentingnya patuh dalam pengobatan TBC, kapan waktu yang tepat minum obat TBC, apa tanda gejala TBC, dll.

3.1.2.2.2 Skrining Pasien

NO	JENIS SKRINING	JUMLAH PASIEN		
		APRIL	MEI	JUNI
1.	Pemberian Masker	15		

Grafik Jumlah Pasien Dengan Skrining Awal Pemberian Masker Di RS Prima Husada



Analisis :
Pada bulan April 2024 terdapat 15 pasien yang diberikan masker karena masker yang dipakai kotor atau tidak standart

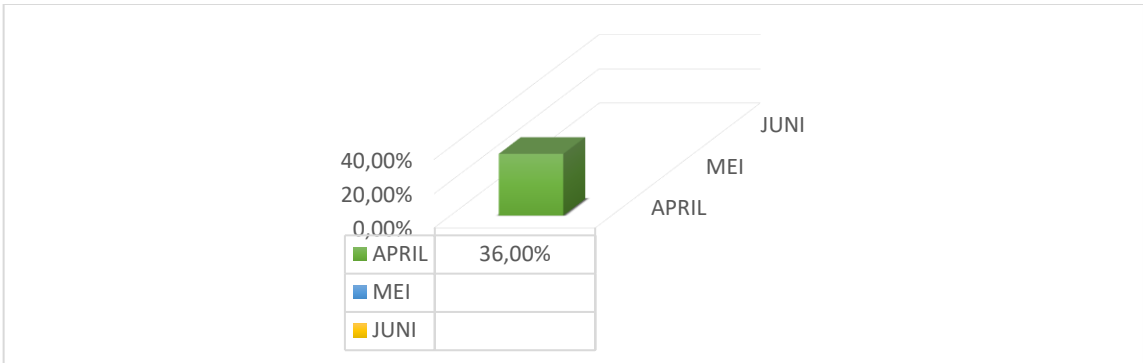
Rencana dan Tindak Lanjut:

- Memfasilitasi ketersediaan masker
- Edukasi pemakaian masker (meliputi fungsi, waktu penggunaan, dan siapa saja yang perlu menggunakan)

3.1.2.2.3 Proporsi Pasien (Terduga dan Baru) Tekonfirmasi Bakteriologis

NO	JENIS SKRINING	JUMLAH PASIEN		
		APRIL	MEI	JUNI
1.	Proporsi pasien (terduga dan baru) tekonfirmasi bakteriologis	36		

Grafik Proporsi Pasien (Terduga dan Baru) Tekonfirmasi Bakteriologis Di RS Prima Husada



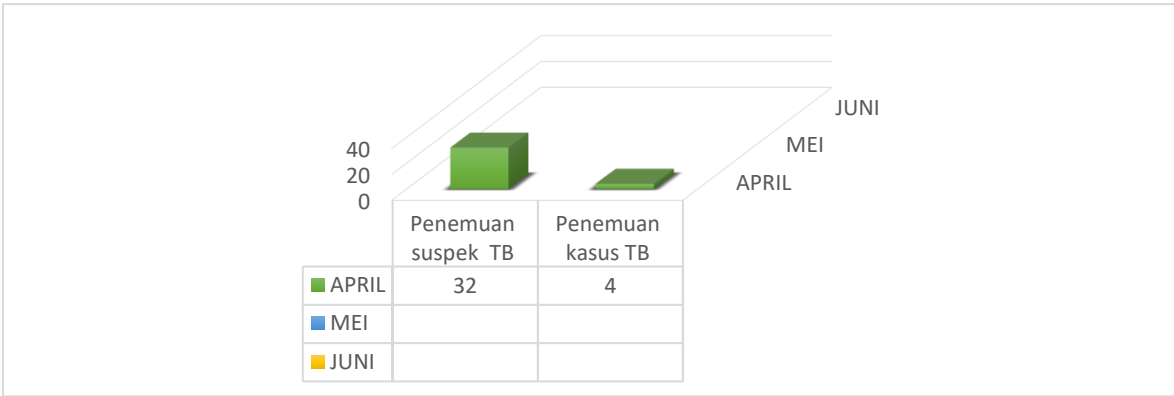
Analisis :
Pada bulan April 2024 jumlah proporsi Pasien terduga TB 36

Rencana dan Tindak Lanjut :
Melakukan edukasi terhadap keluarga pasien dengan kontak TB untuk melakukan skrining TB

3.1.2.2.4 Penemuan Kasus TB

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		APRIL	MEI	JUNI
1.	Penemuan suspek TB	32		
2	Penemuan kasus TB	4		

Grafik Penemuan Kasus TB Baru Di Rumah Sakit Prima Husada



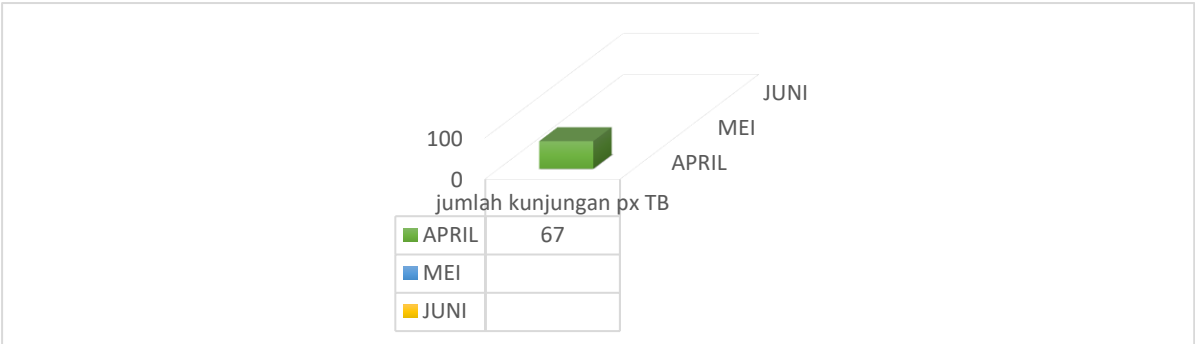
Analisis :
Pada bulan April 2024 terdapat 32 pasien jumlah penemuan suspek TB dan kasus TB positif sebanyak 4 pasien

Rencana Dan Tindak Lanjut:
Menginformasikan kepada pasein dan keluarga pasien untuk melakukan pengobatan dengan teratur dan sesuai jadwal, serta mengedukasi kepada keluarga pasie untuk melakukan skrinning

3.1.2.2.5Jumlah Kunjungan pasien TB

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		APRIL	MEI	JUNI
1.	Pasien TB Kunjungan Keseluruhan	67		

Grafik Jumlah Kunjungan Pasien TB Baru Di Rumah Sakit Prima Husada



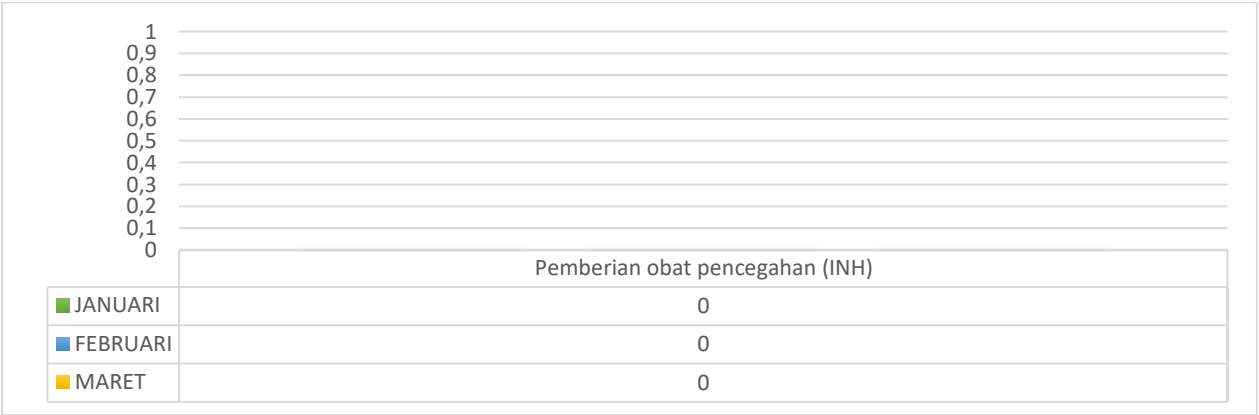
Analisis:
Jumlah keseluruhan kunjungan bulan APRIL 2024 di poli pasien TBC mencapai 67 pasien.

Rencana dan Tindak Lanjut :
Meningkatkan kunjungan pasien

3.1.2.2.6 Pemberian Obat Pencegahan

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		JANUARI	FEBRUARI	MARET
1.	Pemberian obat pencegahan (INH)	0	0	0

Grafik Pemberian Obat Pencegahan Di Rumah Sakit Prima



Analisis :
Tidak ada yang mendapat obat pencegahan (INH), hal ini dikarenakan kurang pengetahuannya pasien dan keluarga pasien mengenai pengobatan pencegahan (INH)

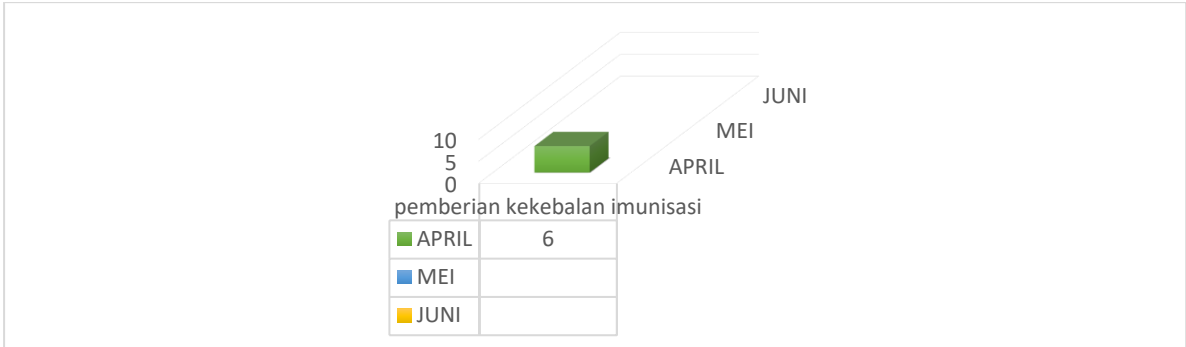
Rencana dan Tindak Lanjut
1. Memberikan edukasi kepada keluarga pasien bahwa jika ada salah satu keluarga yang terdiagnosa TB kemudian memiliki saudara dengan usia dibawah 17 tahun, agar segera memeriksakan dan bersedia di berikan obat pencegahan (INH)

2. Pemberian obat INH ditujukan pada anak usia dibawah 5 tahun yang memiliki kontak erat dengan pasien TB aktif dan orang dengan HIV/AIDS yang tidak terdiagnosa TB

3.1.2.2.7 Pemberian Imunisasi BCG

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		APRIL	MEI	JUNI
1.	Pemberian imunisasi BCG	6		

Grafik Pemberian Kekebalan Imunisasi Di RS Prima Husada



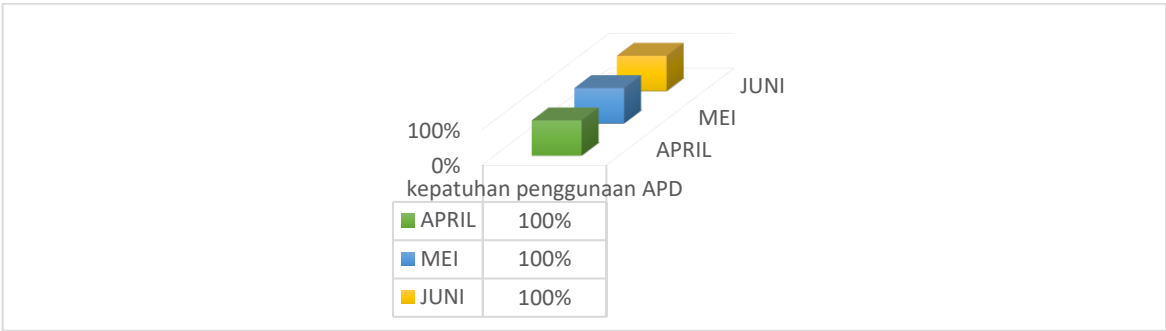
Analisis :
Pemberian kekebalan imunisasi TB diberikan dengan vaksin BCG pada bayi usia 1 bulan Terdapat 6 pasien yang diimunisasi pada bulan APRIL

- Rencana dan Tindak Lanjut :**
- 1. Dilakukan screening pasien dalam memberikan vaksin BCG
 - 2. Setelah dilakukan vaksin BCG dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pemberian vaksin yang akan dilakukan pencatatan dan pelaporan tiap bulany

3.1.2.2.8 Kepatuhan Staf Dan Petugas Terhadap APD

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		APRIL	MEI	JUNI
1.	Kepatuhan staf dan petugas terhadap APD	100%	100%	100%

Grafik Kepatuhan Staf Dan Petugas Terhadap APDRS Prima Husada



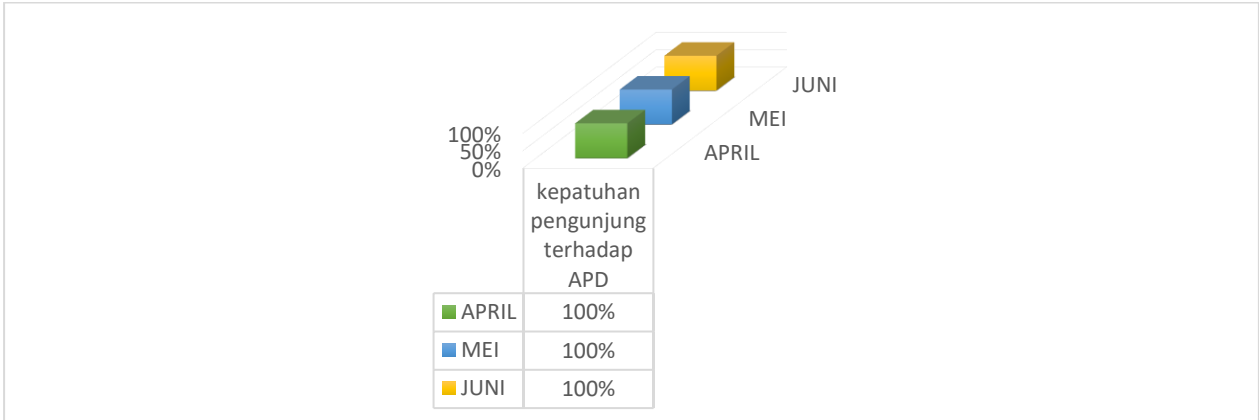
Analisis :
Semua staf sudah patuh dalam penggunaan APD, hal ini menunjukkan kesadaran bahwa sangat penting menjaga diri agar tidak tertular pasien.

Rencana dan Tindak Lanjut :
Mempertahankan kepatuhan dalam penggunaan APD di tiap bulanya

3.1.2.2.9Kepatuhan Pengunjung Pasien Terhadap APD

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		APRIL	MEI	JUNI
1.	Kepatuhan pengunjung pasien terhadap APD	100%	100%	100%

Grafik Kepatuhan Pengunjung Terhadap APD Di RS Prima Husada



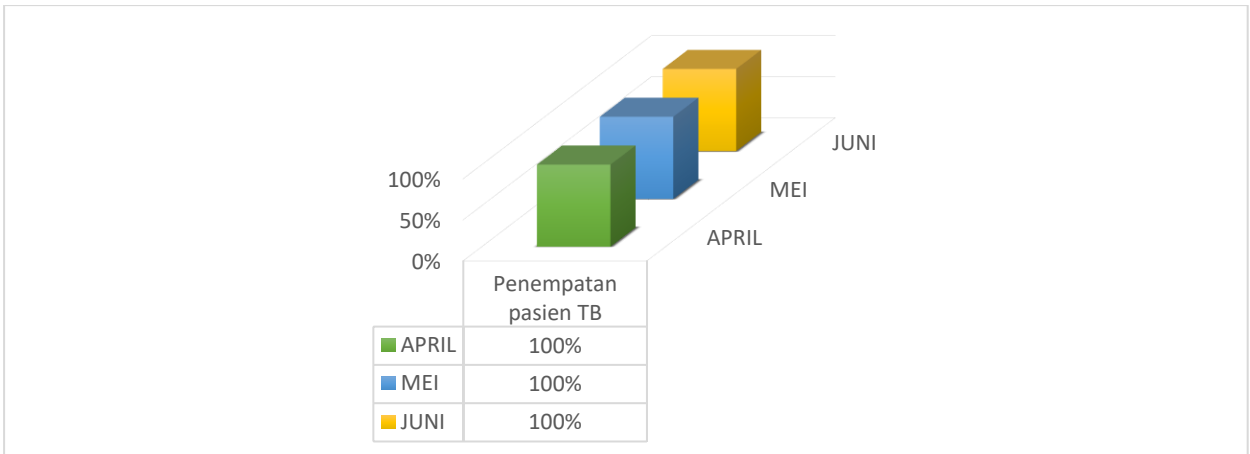
Analisis:
Hasil diatas menunjukan (100%) kepatuhan terhadap APD. Hal ini terjadi karna peningkatan kesadaran pengunjung akan cara penulara.n karena disebabkan covid yang terus menularkan virus

Rencana dan Tindak Lanjut :
Memperkuat kepatuhan pengunjung dengan cara wajib memberikan masker kepada pengunjung saat di nerstation dengan menanyakan keluarga dari pasien isolasi

3.1.2.2.10 Penempatan Pasien TB

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		APRIL	MEI	JUNI
1.	Penempatan pasien TB	100%	100%	100%

Grafik Penempatan Pasien TB Di Rumah Sakit Prima Husada Bulan



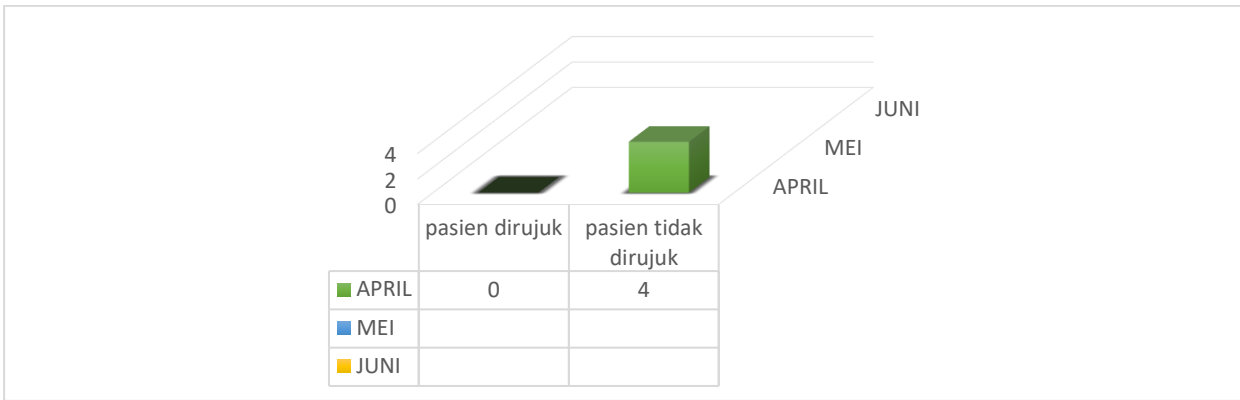
Analisis:
Semua pasien TB sudah ditempatkan di ruang isolasi, hal ini menunjukkan kesadaran staff medis agar antar pasien satu dengan lainnya tidak tertular.

Rencana dan Tindak Lanjut :
Mempertahankan penempatan dengan benar

3.1.2.2.11 Pasien TB yang dirujuk

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		APRIL	MEI	JUNI
1.	Pasien TB yang dirujuk	0		
2.	Pasien TB yang tidak dirujuk	4		

Grafik Pasien TB yang dirujuk Di Rumah Sakit Prima Husada



Analisis :
Pada bulan April 2024 terdapat 0 pasien yang dirujuk ke FKTP I karena pasien memilih lebih dekat dengan rumahnya.

Rencana dan Tindak Lanjut :
Mempertahankan pelayanan yang terbaik untuk pasien sesuai pilihan pasien untuk berobat.

3.1.2.2.12 Stok OAT

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		APRIL	MEI	JUNI
1.	OAT Anak			
2.	OAT Dewasa			
3.	Kombipak			
4.	OAT Harian			
5.	TPT			

Grafik Stok Obat TBC Di Rumah Sakit Prima Husada



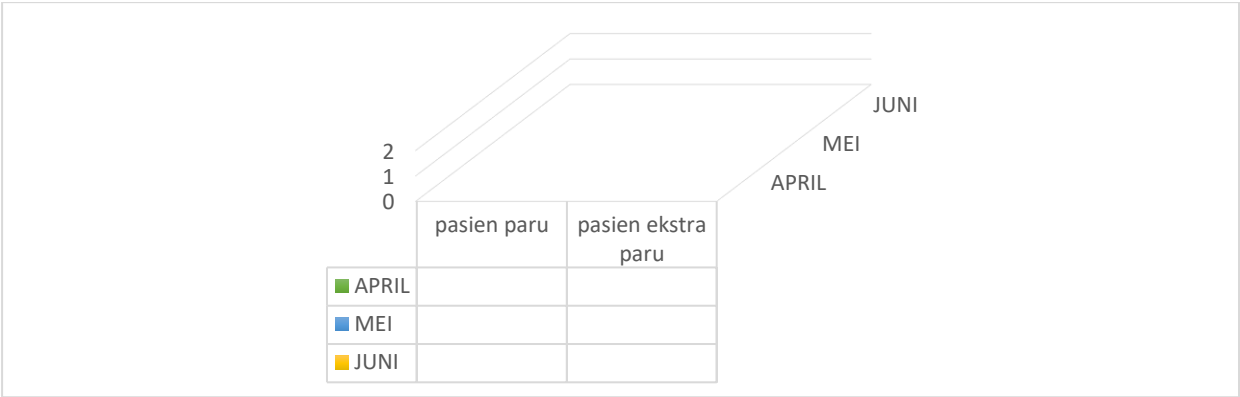
Analisis :
Setiap 1 bulan sekali farmasi akan melakukan pengadaan obat terkait permintaan ke Dinkes

Rencana dan Tindak Lanjut :
Menetapkan pengambilan obat dengan sesuai jadwal.

3.1.2.2.13 Pasien paru dan ekstra paru

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		APRIL	MEI	JUNI
1.	Pasien paru	3		
2.	Pasien Ekstra paru	1		

Grafik Pasien paru dan Ekstra paru Di Rumah Sakit Prima Husada



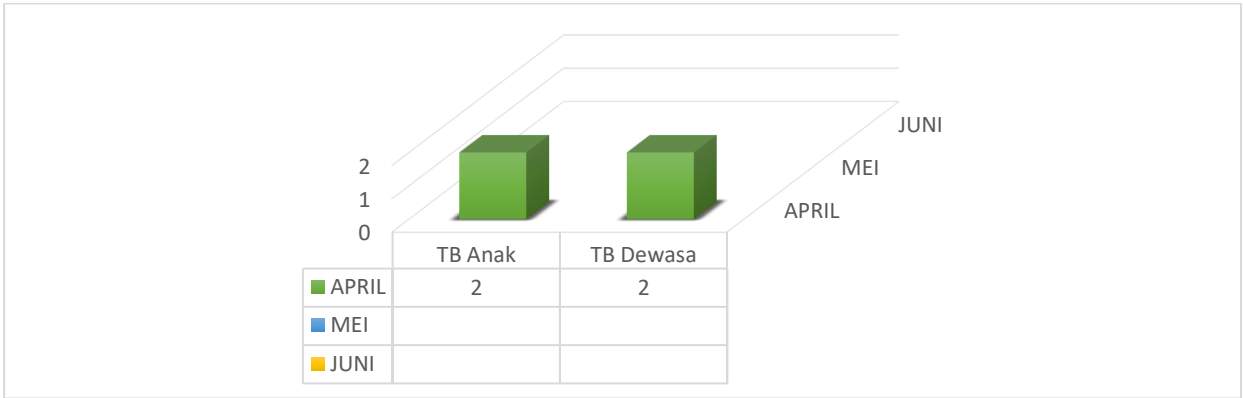
Evaluasi :
Pada bulan April 2024 terdapat 1 pasien ekstra paru

Rencana dan Tindak Lanjut :
Memberikan pengobatan yang sama pada ekstra paru meski pengobatannya akan lebih lama.

3.1.2.2.14 Pasien Anak Dan Pasien Dewasa TB

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		APRIL	MEI	JUNI
1.	Pasien Anak	2		
2.	Pasien Dewasa	2		

Grafik Pasien Anak dan Pasien Dewasa Di Rumah Sakit Prima



Analisis :
Pada bulan April terdapat 2 pasien TB Anak sedangkan pasien TB dewasa mencapai 2 pasien

Rencana dan Tindak Lanjut :
Mempertahankan pencatatan TB sesuai kategori pasien.

3.1.2.2.15 Kepatuhan Dokter Terhadap PPK TB

NO	KEGIATAN	NAMA PASIEN	PATUH	TIDAK PATUH	ALASAN
1.	dr. Andy, Sp. P	Ny. S	V		
		Ny. I	V		
		Ny. S	V		
2.	dr. Catur Elvi p., Sp. P				
		Tn. P	V		
3.	Dr. Yunita, Sp. P				
		Ny. S	V		

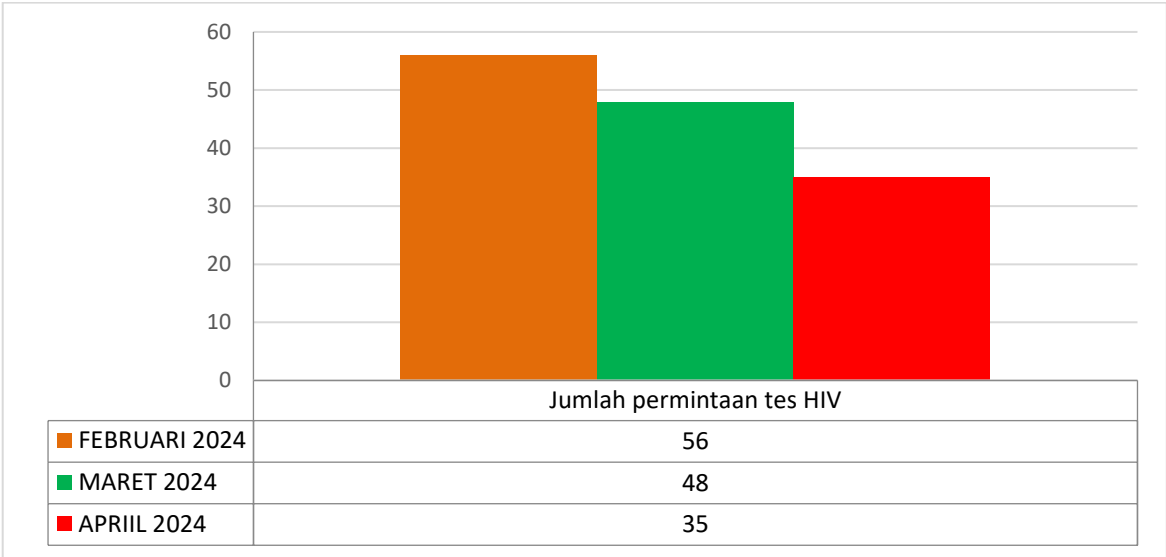
Analisis :
Semua dokter sudah patuh akan PPK (Panduan Praktek Klinis) TB, baik dari anamnesis, kriteria diagnosis, pemeriksaan penunjang, dan Edukasi. Akan tetapi pada *point* edukasi sosial (pencarian kontak serumah) tidak dilakukan

Rencana dan Tindak Lanjut :
Tetap mempertahankan kepatuhan dokter sesuai dengan PPK TB yang berlaku di RS Prima Husada Kabupaten Malang

3.1.2.3 HIV

Jumlah Permintaan Tes HIV				
NO	URAIAN	BULAN		
		FEBRUARI 2024	MARET 2024	APRIL 2024
1	Permintaan Test HIV	56	48	35

Grafik Jumlah Permintaan Tes HIV Di Rumah Sakit Prima Husada
Bulan April 2024



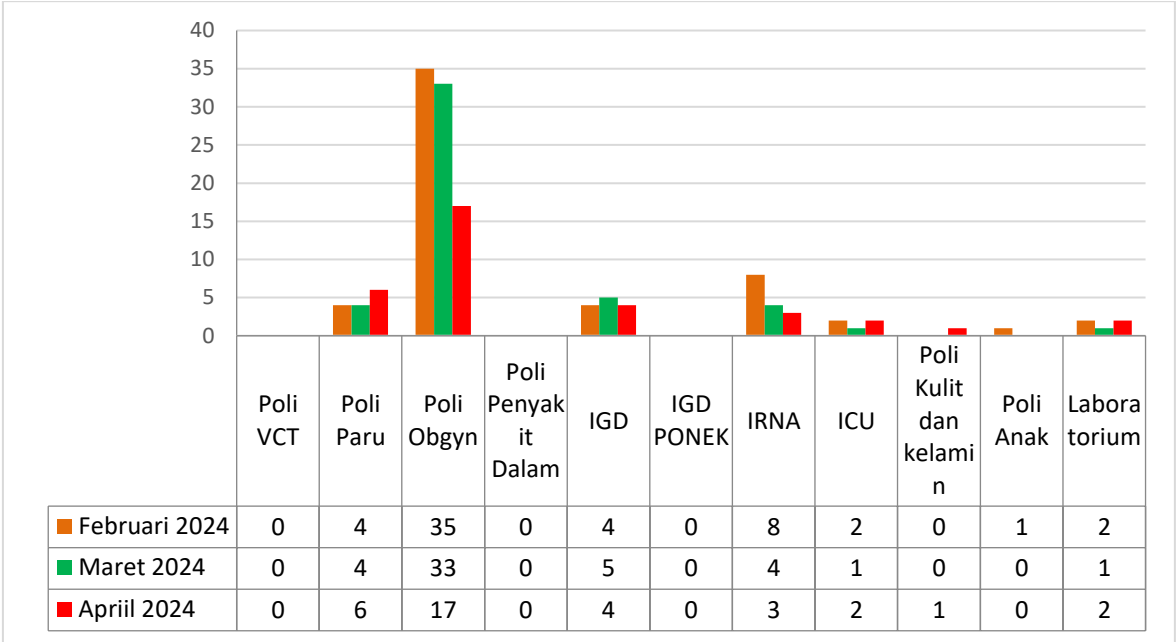
Analisis :
Dari hasil grafik diatas ditemukan data, bahwa jumlah permintaan test HIV pada bulan April 2024 menurun menjadi 35 pemeriksaan dibandingkan pada bulan februari sebanyak 56 pemeriksaan dan pada bulan maret 2024 sebanyak 48 pasien hal ini dikarenakan terdapat pasien hamil yang sudah melakukan dan membawa hasil pemeriksaan PMTCT dari puskesmas domisili, sehingga saat kunjungan di poli kandungan RS Prima Husada Malang sudah tidak perlu lagi diulang pemeriksaanya.

Rencana Tindak Lanjut :
Dilakukan skrining ulang pada pasien-pasien yang terduga HIV, pasien hamil trimester 3 dan juga pasien-pasien mandiri yang ingin dilakukan pemertiksaan HIV sesuai sukarela baik pasien IGD, rawat jalan maupun rawat inap.

3.1.2.3.1. Asal Permintaan Tes HIV

NO	URAIAN	BULAN		
		FEBRUARI 2024	MARET 2024	APRIL 2024
1	Poli VCT	0	0	0
2	Poli Paru	4	4	6
3	Poli Obgyn	35	33	17
4	Poli Penyakit Dalam	0	0	0
5	IGD	4	5	4
6	IGD PONEK	0	0	0
7	IRNA	8	4	3
8	ICU	2	1	2
9	Poli Kulit dan kelamin	0	0	1
10	Poli Anak	1	0	0
11	Laboratorium	2	1	2

Grafik Jumlah Asal Permintaan Tes HIV Di Rumah Sakit Prima Husada
Bulan April 2024



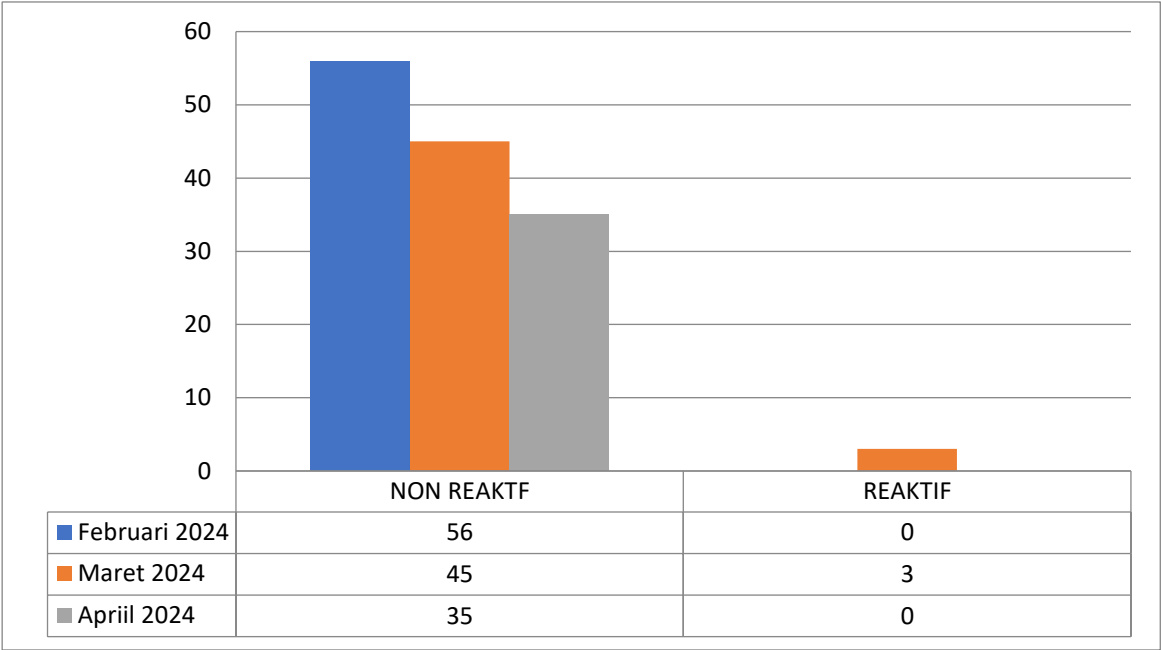
Analisis :
Dari hasil grafik diatas ditemukan data, bahwa jumlah asal permintaan test HIV di Poli kandungan tetap tinggi dibandingkan dari unit lain mulai bulan february 2024 35 pasien, pada bulan maret 2024 sebanyak 33 pasien, sedangkan pada bulan april 2024 sebanyak 15 pasien. Hal ini dikarenakan sudah tersdianya Reagen HIV dari Dinas Kesehatan Kabupaten Malang untuk program ibu hamil sehingga pasien dengan kriteria hamil trimester II sudah bisa dilakukan screening HIV.

Rencana Tindak Lanjut :
Dilakukan sosialisasi terkait Permintaan testing HIV dilakukan baik di IGD, rawat jalan, maupun rawat jalan sesuai dengan kebutuhan pasien. Sehingga capaian permintaan testing HIV bisa berjalan.

3.1.2.3.2 Status HIV

NO	URAIAN	BULAN		
		FEBRUARI 2024	MARET 2024	APRIL 2024
1	Non Reaktif	56	45	35
2	Reaktif	0	3	0

Grafik Status Hiv Di Rumah Sakit Prima Husada
Bulan April 2024



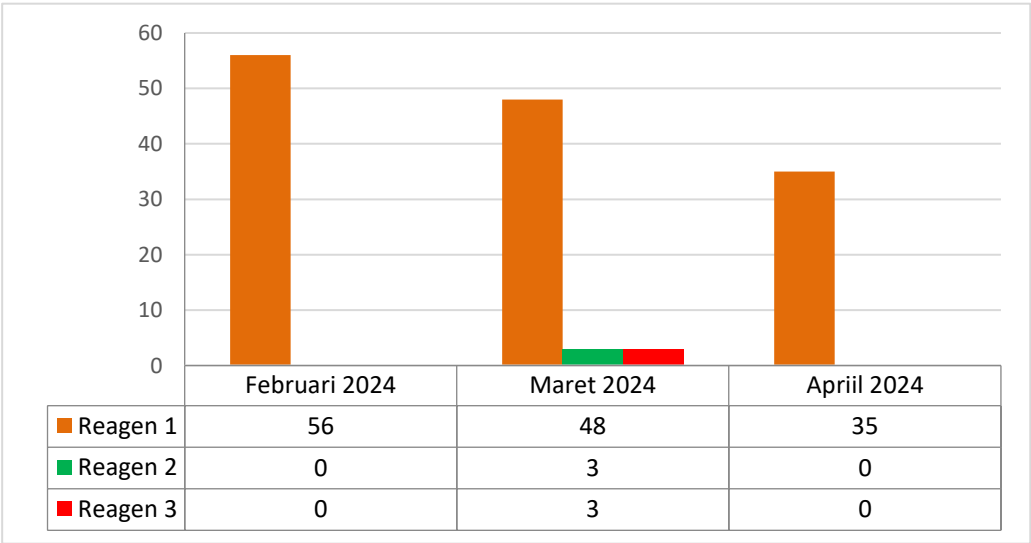
Analisis :
Dari hasil grafik diatas tidak ditemukan data status HIV dengan status reaktif pada pada bulan April 2024. Jumlah status reaktif dibanding pada bulan sebelumnya menurun dari 3 pasien menjadi 0.

Rencana Tindak Lanjut :
Rumah sakt prima husada malang masih belum bisa melakukan pelayanan pasien dengan HIV/AIDS, apabila ditemukan pasien dengan HIV reaktif maka akan kami lakukan rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah MOU dengan RS Prima Husada Malang.

3.1.2.3.3 Jumlah Pemakaian Reagen

No	URAIAN	BULAN		
		FEBRUARI 2024	MARET 2024	APRIL 2024
1	Reagen 1	56	48	35
2	Reagen 2	0	3	0
3	Reagen 3	0	3	0

Grafik Jumlah Pemakaian Reagen Di Rumah Sakit Prima Husada
Bulan April 2024



Analisis :

Dari hasil grafik diatas ditemukan data, bahwa pemakaian reagen Pada bulan februari 2024 pemakaian reage hanya ampai reagen 1 saja. Pada bulan maret ditemukan memakai sampai dengan reagen 3. Sedangkan pada bulan April 2024 pemakaian reagen sampai dengan reagen 1 saja. Hal ini dikarenakan pada bulan April 2024 tidak ditemukan pasien dengan hasil HIV Reaktif.

Rencana Tindak Lanjut :

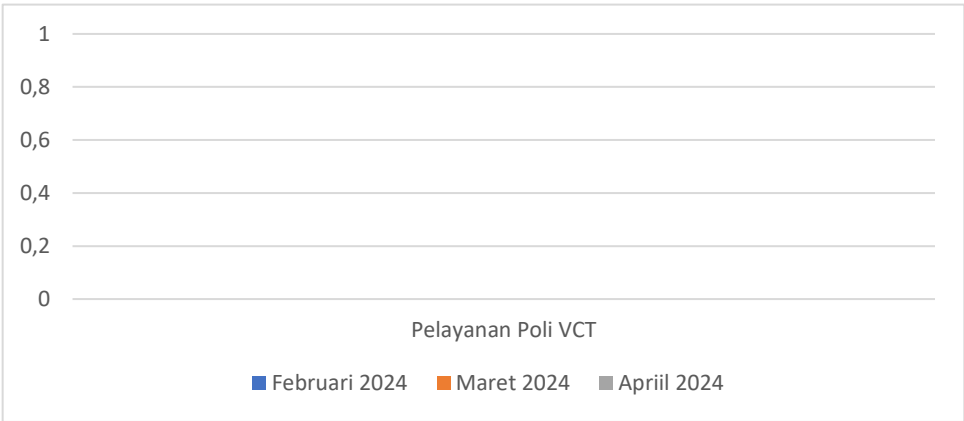
Pemakaian reagen HIV tergantung dari hasil pemeriksaan dengan Reagen 1. Apabila dilakukan pemeriksaan dengan Reagen 1 hasil Non Reatif maka tidak dilanjutkan pemakaian Reagen 2 dan 3.

Tetapi apaila saat pemeriksaan dengan Reagen 1 ditemukan hasil Reaktif maka pemeriksaan dilanjutkan dengan penggunaan Reagen 2 dan Reagen 3

3.1.2.3.4 Pelayanan Poli Vct (Voluntary Conseling And Testing)

No	URAIAN	BULAN		
		FEBRUARI 2024	MARET 2024	APRIL 2024
1	Pelayanan Poli VCT	0	0	0

**Grafik Pelayanan Poli VCT Di Rumah Sakit Prima Husada
Bulan April 2024**



Analisis pelayanan Poli VCT

Dari hasil grafik diatas ditemukan data, bahwa tidak ada kunjungan di poli VCT di RS Prima Husada. Hal ini dikarenakan kurang tahunya masyarakat terkait pentingnya deteksi pemeriksaan HIV/AIDS

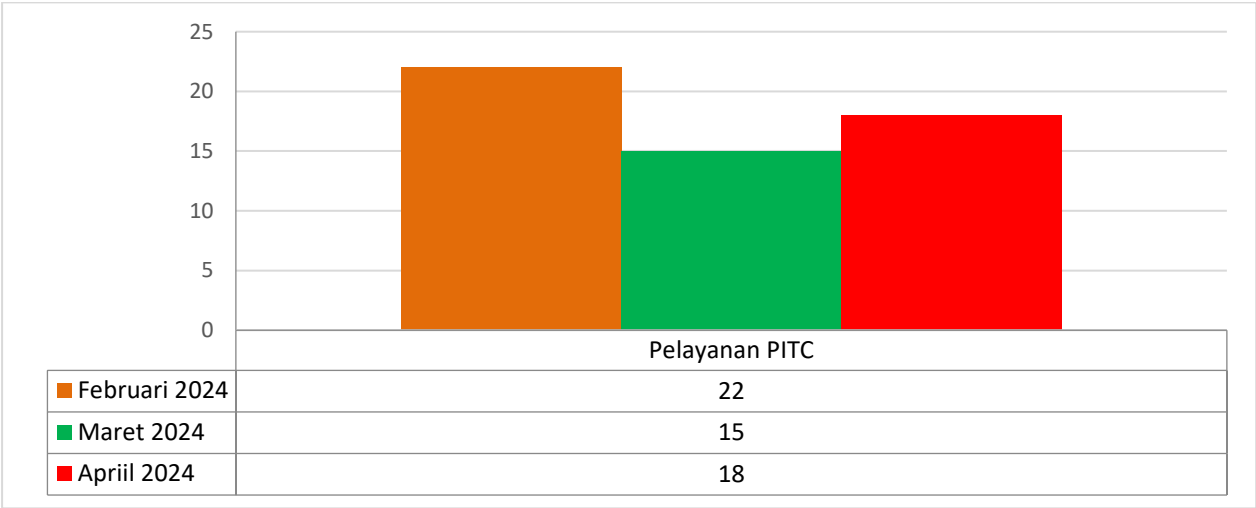
Rencana Tindak Lanjut

Pelayanan Poli VCT di Rumah Sakit Prima Husadabelum berdiri sendiri, melainkan masih bergabung dengan oli penyakit Dalam di Rawat jalan. Hal ini dikarenaka asih belum adanya kunjungan pasien ke poli VCT

3.1.2.3.5 Pelayanan PITC (Provider Initiated Testing and Counseling)

No	URAIAN	BULAN		
		FEBRUARI 2024	MARET 2024	APRIL 2024
1	Pelayanan PITC	22	15	18

Grafik Pelayanan PITC Di Rumah Sakit Prima Husada
Bulan April 2024



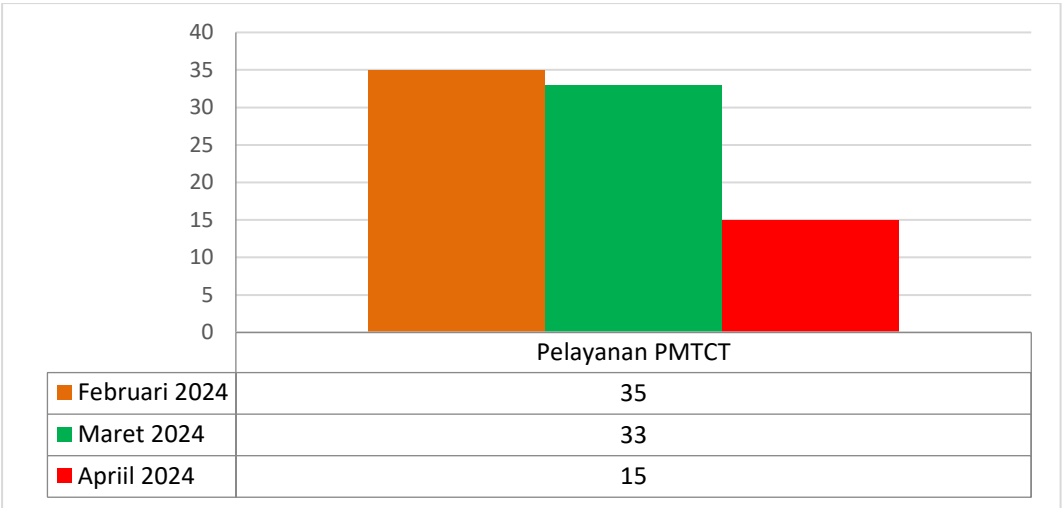
Analisis :
Dari data diatas terdapat keimpulan bahwa telah dilakukan edukasi pemeriksaan HIV oleh petugas kesehatan untuk dilakukan testing HIV pada bulan pada bulan februari 2024 sebanyak 21 pasien, pada bulan maret 2024 sebanyak 15 pasien, sedangkan pada bulan april 2024 sebanyak 18 pasien. Hal ini dikarenakan testing dan konseling dilakukan saat pasien menunjukan gejala HIV dan dilakukanya sreening baik di ruangan maupun IGD

Rencana Tindak Lanjut :
Dilakukan peningkatan terkait penjangrian pasien dengan dialkukanya edukasi pasien tentang testing HIV kepada pengunjung atau masyarakat sehingga pasien paham tenytang pentingya dilakukan pemeriksaan HIV.

3.1.2.3.6 Pelayanan Pmtct (Prevention to Mother Of Child Transmision)

No	URAIAN	BULAN		
		FEBRUARI 2024	MARET 2024	APRIL 2024
1	Pelayanan PMTCT	35	33	15

Grafik Pelayanan PMTCT Di Rumah Sakit Prima Husada
Bulan April 2024



Analisis :

Dari hasil grafik diatas ditemukan data pasien hamil yang dilakukan pemeriksaan HIV sebagai screening dan deteksi pencegahan penularan dari ibu ke Bayi. Pada buan februari 34 pasien, pada bulan maret sebnayak 33 pasien Sedangkan pada bulan april 2024 sebanyak 15 pasien

Hal ini dikarenakan pasien hamil yang sudah melakukan dan membawa hasil pemeriksaan PMTCT dari puskesmas domisili, sehingga saat kunjungan di poli kandungan RS Prima Husada Malang sudah tidak perlu lagi diulang pemeriksaanya.Sehingga pemeriksaan HIV di RS Prima Husada Malang untuk Prevention to Mother Of Child Transmision bias dilakukan.

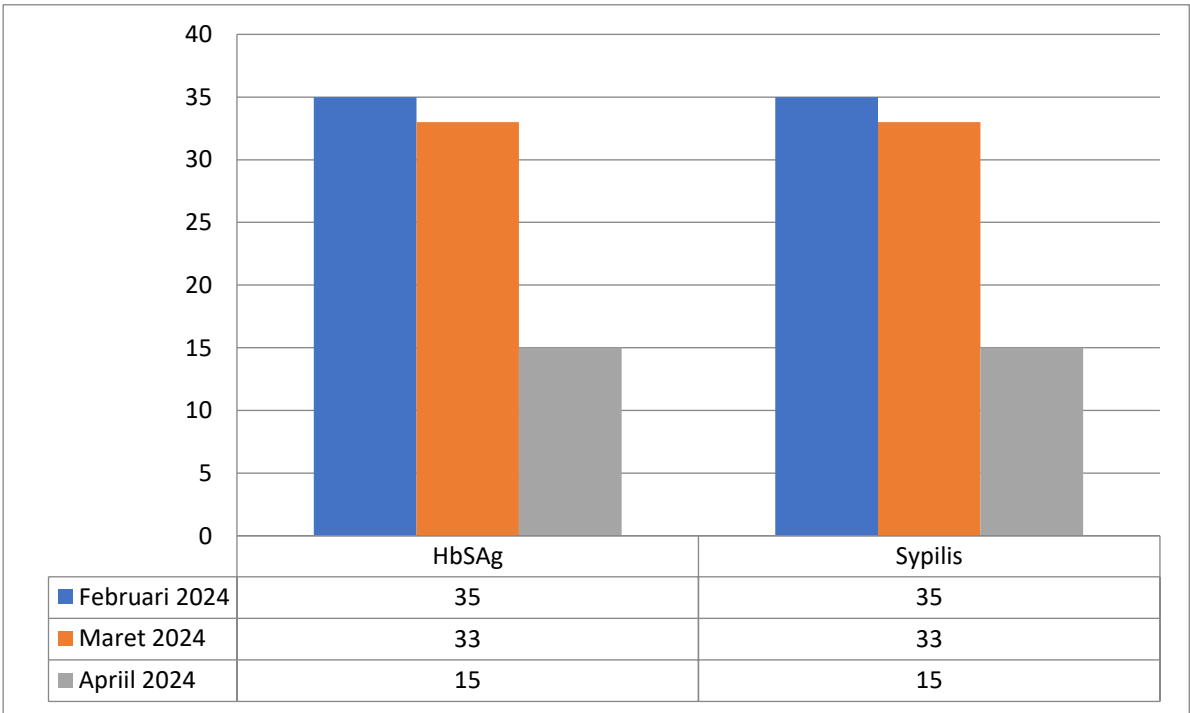
Rencana Tindak Lanjut :

Reagen pemeriksaan HIV yang diperoleh dari dinas kesehatan sudah tersedia di RS Prima Husada Malang sehingga Sehingga pemeriksaan HIV di RS Prima Husada Malang untuk Prevention to Mother Of Child Transmision bias dilakukan.

3.1.2.3.7 Pelayanan Pemeriksaan Triple Eiminasi Pada Ibu Hamil

No	URAIAN	BULAN		
		FEBRUARI 2024	MARET 2024	APRIL 2024
1	HbSAg	35	33	15
2	Sypilis	35	33	15

**Grafik Pelayanan Pemeriksaan Triple Eliminasi Pada Ibu Hamil
Di Rumah Sakit Prima Husada Bulan April 2024**



Analisis :

Dari hasil grafik diatas ditemukan data pasien hamil yang dilakukan pemeriksaan HbSAg dan Sypilis pada bulan februari 2024 sebanyak 34 pasien, pada bulan maret 2024 sebanyak 33 pasien Sedangkan pada bulan april 2024 sebanyak 15 pasien

Hal ini dikarenakan pasien hamil yang sudah melakukan dan membawa hasil pemeriksaan triple eliminasi dari puskesmas domisili, sehingga saat kunjungan di poli kandungan RS Prima Husada Malang sudah tidak perlu lagi diulang pemeriksaanya. Sehingga pemeriksaan Triple eliminasi di RS Prima Husada Malang untuk pemeriksaan HbSAg dan Sypilis bisa dilakukan.

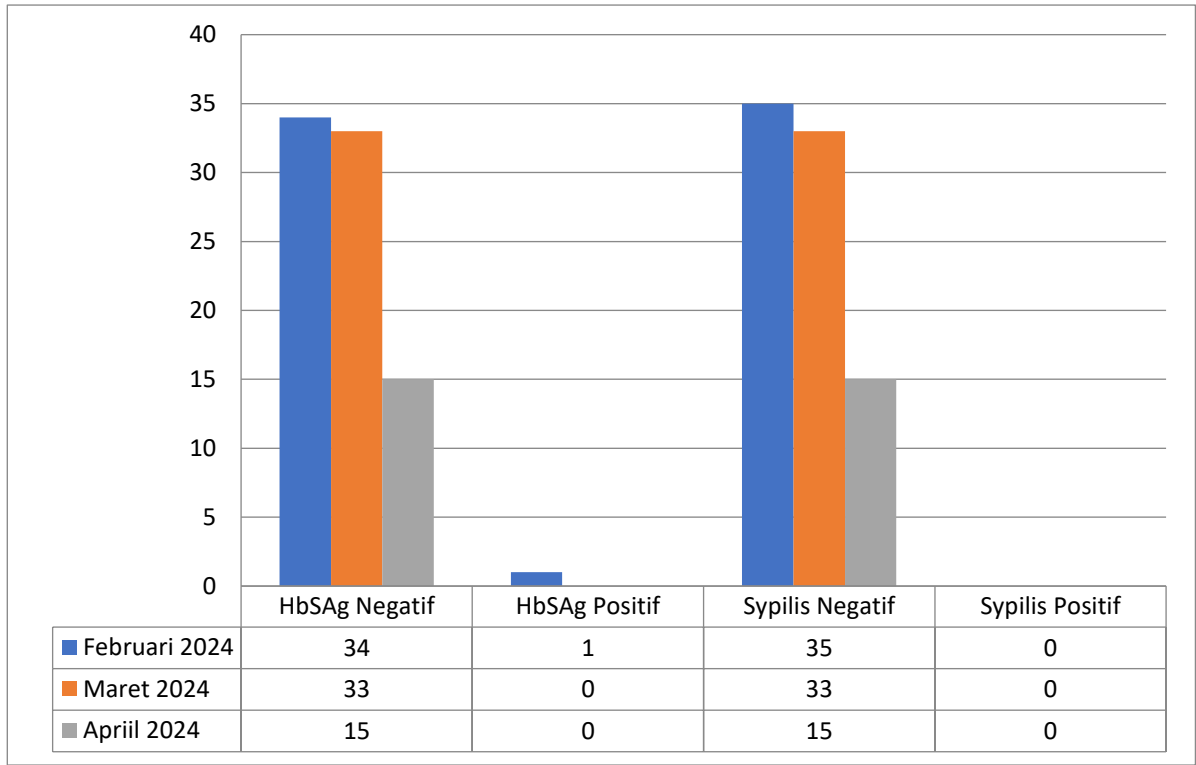
Rencana Tindak lanjut :

Pemeriksaan Triple eliminasi untuk ibu hamil bersifat wajib dan dilakukan 1 kali saat awal kehamilan. Di RS Prima Husada skrining pemeriksaan triple eliminasi sudah berjalan dan dilakukan saat kunjungan pada Trimester 2.

3.1.2.3.8 Status Pelayanan Pemeriksaan Triple Eiminasi Pada Ibu Hamil

No	URAIAN	BULAN		
		FEBRUARI 2024	MARET 2024	APRIL 2024
1	HbSAg			
	Negatif	34	33	15
	Positif	1	0	0
2	Sypilis			
	Negatif	35	33	15
	Positif	0	0	0

**Grafik Status Pelayanan Pemeriksaan Triple Eliminasi Pada Ibu Hamil
Di Rumah Sakit Prima Husada Bulan April 2024**



Analisis :

Dari hasil grafik diatas ditemukan data, bahwa ditemukan 1 kasus pasien dengan HbSAg positif pada buan Februari 2024 sebanyak 1 pasien, pada pemeriksaan syphilis tidak ada kasus pasien positif. Pada bulan Maret 2024 tidak ditemukan pasien dengan HbSAg maupun Sypilis dengan hasil positif, Sedangkan pada bulan April 2024 tidak ditemukan pasien dengan HbSAg maupun Sypilis dengan hasil positif.

Rencana Tindak Lanjut :

1. Pada pasien HbSAg
- Saat kelahiran aka nada pemberian vaksin Hepatitis kepada bayi yaitu Hiper Heb dan juga Hb.O unijec yang diberikan saat bayi baru lahir sampai dengan maksimal 24 jam pemberian. Untuk ibu dengan HbSAg akan dilakukan

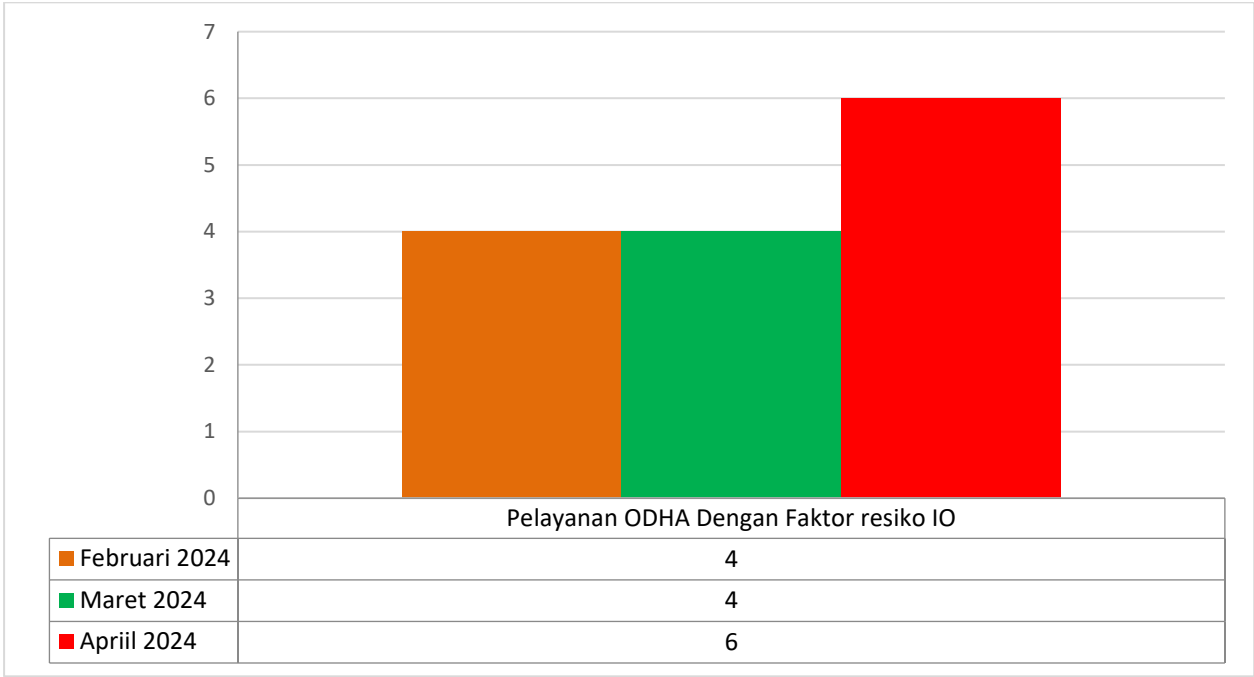
pemberian vaksin hepatitis oleh Puskesmas sesuai domisili pasien. Penanganan pasien dengan HbSAg Rumah Sakit Prima Husada Malang Kolaborasi dengan puskesmas sesuai dengan domisili pasien.

2. Pada pasien Syphilis
Di rumah sakit Prima Husada Malang sudah bisa melakukan pengobatan pasien dengan syphilis positif. Sehingga tidak lagi melakukan rujuk keluar.

3.1.2.3.9 Pelayanan Odha Dengan Factor Resiko Infeksi Oportunistik

No	URAIAN	BULAN		
		FEBRUARI 2024	MARET 2024	APRIL 2024
1	Pelayanan ODHA Dengan Faktor resiko IO	4	4	6

Grafik Pelayanan Odha Dg Faktor Resiko IO Di Rumah Sakit Prima Husada Bulan April 2024



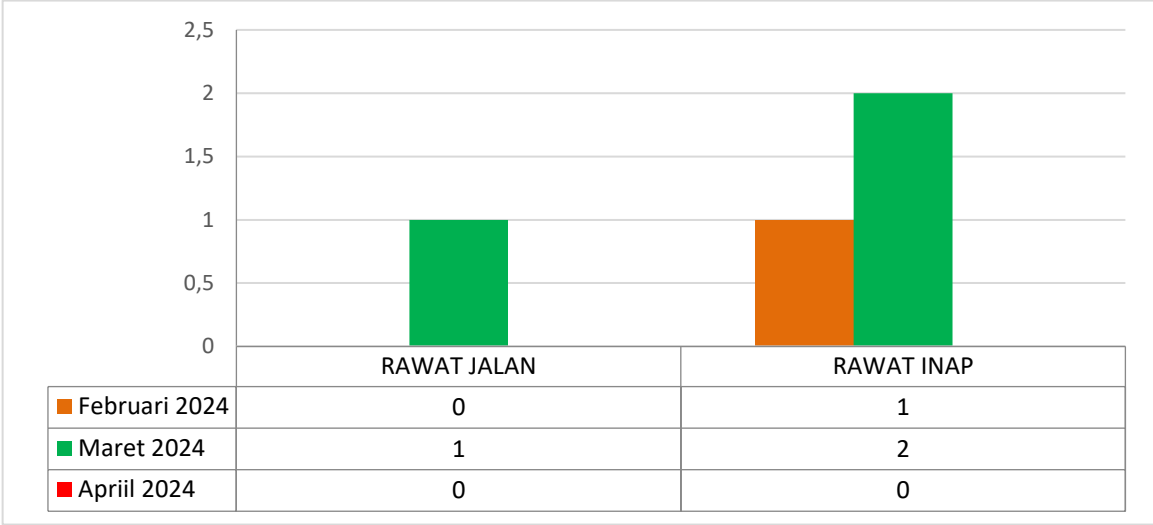
Analisis :
Dari hasil grafik diatas ditemukan data, bahwa terdapat pasien dengan diagnose TB positif yang dilakukan pemeriksaan HIV di RS Prima Husada. Pada bulan februari 2024 dan maret 2024 terjadi penurunan yaitu sebanyak 4 pasien, Sedangkan pada bulan april 2024 sebanyak 6 pasien. Hal ini dikarenakan dilakukanya screening pasien TB di RS Prima Husada Malang.

Rencana Tindak Lanjut :
Pasien-pasien dengan diagnose TB positif di rRumah Sakit Prima Husada Malang sudah patuh dilakukan screening pemeriksaan HIV/AIDS sesuai dengan SPO. Diharapkan bisa saling kerjasama antar tim yaitu TIM TB dan Tim HIV.

3.1.2.3.10 Pelayanan Rujukan Pasien Dengan HIV/AIDS

No	URAIAN	BULAN		
		FEBRUARI 2024	MARET 2024	APRIL 2024
1	Rawat Jalan	0	1	0
2	Rawat Inap	1	2	0

**Grafik Pelayanan Rujukan Pasien Dengan Hiv/Aids Di Rumah Sakit Prima Husada
Bulan April 2024**



Analisis :
Dari hasil grafik diatas ditemukan data, bahwa pada bulan februari 2024 terdapat 1 pasien yang dilakukan rujuk eksternal dari rawat inap. pada bulan maret 2024 terdapat 3 pasien yang dilakukan rujuk eksternal, yaitu 1 dari rawat jalan dan 2 dari rawat inap. Sedangkan pada bulan april 2024 tidak ada pasien yang dilakukan rujuk. Hal ini dikarenakan RS Prima husada malang belum bisa menangani pasien yang ditemukan positif HIV

Rencana Tindak Lanjut :
Pelaksanaan Rujukan dilakukan apabila hasil pemeriksaan HIV Reaktif. Rujukan dilakukan ke fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah bekerjasama dengan Rumah Sakit Prima Husada Malang.

3.1.2.4 Stunting & Wasting
3.1.2.4.1 Pelayanan Tim Penurunan Prevalensi Stunting dan Wasting

Tabel Pelayanan Tim Penurunan Prevalensi Stunting dan Wasting April 2024

NO	KEGIATAN POKOK	RINCIAN KEGIATAN
1	Peningkatan pemahaman dan kesadaran seluruh staf , pasien, dan keluarga tentang masalah stunting dan wasting	Melakukan promosi kesehatan dengan melaksanakan edukasi pasien dan sosialisasi kepada seluruh staff mengenai pentingnya pencegahan dan penanganan stunting dan wasting.
2	Program 1000 HPK	Pemberian Penyuluhan tentang pentingnya pengasuhan pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) kepada pengunjung, pasien, dan keluarga pasien
3	Suplementasi Folat Pada Ibu hamil	Suplementasi Folat Pada ibu hamil dilaksanakan di poli kandungan di RS Prima Husda Malang
4	Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pada ibu hamil	Pemberian PMT pada ibu hamil dilaksanakan pada saat kegiatan senam hamil di RS Prima Husada Malang
5	Promosi dan konseling Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan ASI eksklusif	1. Kegiatan konseling IMD dilaksanakan sesaat setelah ibu melahirkan 2. Konseling IMD dan ASI eksklusif dilaksanakan pada saat ibu telah memasuki rawat inap maternitas

		3. Penyuluhan tentang pentingnya IMD dan pemberian ASI eksklusif juga dilaksanakan di ruang tunggu poli anak dan poli kandungan
6	Pemantauan pertumbuhan (Pelayanan Tumbuh Kembang Bayi dan Balita)	Pemantauan pertumbuhan bayi dan balita dilaksanakan di ruang rawat inap dan melakukan pendampingan di poli anak RS prima husada
8	Pemberian imunisasi	Pemberian imunisasi dilaksanakan di poli anak RS prima husada malang sesuai dengan jadwal praktek dokter spesialis anak dan di rawat inap sesaat setelah bayi baru dilahirkan.
9	Pemberian Makanan Tambahan Balita Gizi Kurang	Pemberian makanan tambahan balita gizi kurang dilaksanakan apabila ditemui balita dengan gizi kurang di rawat inap
10	Penerapan Rumah Sakit sayang Ibu Bayi	1. Menyelenggarakan pelayanan konseling kesehatan maternal dan neonatal. 2. Konseling pemberian ASI eksklusif. 3. Penyediaan Pojok Laktasi untuk mendukung pemberian ASI eksklusif
11	Rumah Sakit sebagai pusat rujukan kasus stunting dan wasting	1. Penyusunan Pedoman Pencegahan dan Tata Laksana Gizi Stunting, Gizi Kurang, Gizi Buruk pada Balita 2. Memastikan kasus, penyebab dan tatalaksana lanjut oleh dokter spesialis anak. 3. Melakukan evaluasi pelayanan, audit kesakitan dan kematian, pencatatan dan pelaporan gizi buruk dan stunting.
12	Rumah Sakit sebagai pendamping klinis dan manajemen serta merupakan jejaring rujukan	Pada Bulan Februari tidak terdapat Kerjasama dengan komunitas eksternal
13	Program Pemantauan dan Evaluasi	Melakukan monitoring dan evaluasi terkait edukasi yang sudah diberikan, serta membuat laporan dan evaluasi kegiatan.

Analisis

1. Melakukan tindakan pelayanan penurunan dan penanggulangan stunting dan wasting di rumah sakit.
2. Melakukan edukasi mengenai pencegahan dan penanggulangan stunting dan wasting kepada pengunjung, pasien, dan keluarga pasien di rumah skait.

3.1.2.4.2 Kinerja Produktivitas

Tabel Peningkatan Efektifitas Intervensi Gizi Spesifik

PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	LOKASI	JAN 2024	FEB 2024	MAR 2024
Program 1000 HPK	Penyuluhan mengenai kehidupan 1000 hari pertama	Pengunjung RS Prima Husada Malang	IRJA anak dan Kandungan	1	1	1
Suplementasi Asam folat pada ibu hamil	1. Penyuluhan tentang pentingnya konsumsi asam folat pada	Ibu Hamil	Senam Hamil , Poli Kandungan, Hall gedung baru lantai 5	1	1	1

	ibu hamil 2. Pembagian tablet tambah darah dan asam folat					
Pemberian PMT Ibu Hamil	Pemberian PMT dengan tinggi kalori terutama pada ibu hamil terindikasi KEK	Ibu Hamil	Hall gedung baru lantai 5	1	1	0
Promosi dan konseling Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan ASI eksklusif	Penyuluhan mengenai pentingnya Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan ASI eksklusif	Ibu hamil	IRJA anak dan kandungan, irna maternitas	1	1	1
Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA)	1. Penyuluhan tentang stunting, makanan sehat pada bayi dan balita 2. Pembagian PMBA	IRNA Anak	-	1	1	1
Pemantauan pertumbuhan (Pelayanan Tumbuh Kembang Bayi dan Balita)	Melakukan Pencatatan dan plotting pada buku KIA setelah pengukuran berat badan dan tinggi badan anak	Pasien Anak	IRJA anak	1	1	1
Pemberian Imunisasi	Memastikan ketersediaan imunisasi agar selalu tersedia di poli anak	Pasien anak dan Bayi baru lahir	IRJA anak	1	1	1
Pemberian vitamin A	Bekerja sama dengan puskesmas terdekat untuk mendukung program pemerintah	Pasien anak	IRJA anak	0	0	0

	mengenai pemberian vitamin A					
Pemberian Makanan Tambahan Balita Gizi Kurang	Memberikan PMT tinggi kalori dengan membantu menyusun menu yang sesuai dengan ketersediaan bahan pangan di lingkungan	Pasien anak	Rawat Inap	2	1	1
Pemberian Taburia pada Baduta	Bekerja sama dengan puskesmas terdekat untuk mendukung program pemerintah mengenai pemberian bubuk taburia	Pasien anak	Rawat Inap dan Rawat Jalan	0	0	1
Pemberian Obat cacing pada ibu hamil	Bekerja sama dengan puskesmas terdekat untuk mendukung program pemerintah mengenai pemberian obat cacing pada ibu hamil	Ibu Hamil	Rawat Inap dan Rawat Jalan	0	0	0

Analisis :
 Sebagian besar intervensi spesifik yang dapat dilaksanakan di rumah sakit telah dilaksanakan. Pemberian bubuk Taburia dan Mineral mix dilakukan pada bulan Maret karena terdapat 1 balita stunting dan wasting yang berasal dari puskesmas Ardimulyo. Sehingga Ahli Gizi Puskesmas Ardimulyo melakukan koordinasi dengan Ahli gizi RSPHM untuk pemberian PKMK, Bubuk Taburia, dan mineral mix terhadap pasien tersebut.

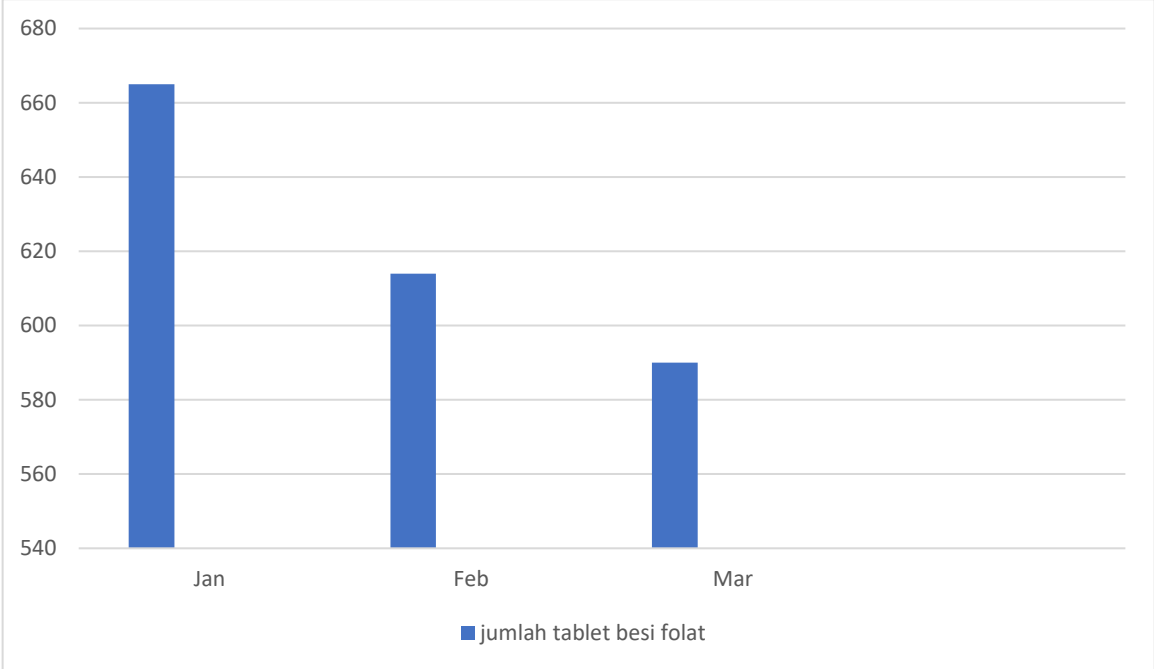
Rencana Tindak Lanjut :
 Bekerjasama dengan puskesmas setempat agar dapat melakukan pendampingan intervensi spesifik di posyandu disekitar wilayah rumah sakit dan melakukan pemantauan kepada balita stunting.

3.1.2.4.3 Pemberian Tablet Besi Folat Bagi Ibu Hamil

Tabel Distribusi Tablet Besi Folat pada Ibu Hamil di RS Prima Husada Malang

BULAN	JAN 2024	FEB 2024	MAR 2024
Jumlah Ibu Hamil yang diberikan tablet besi folat di Poli kandungan	665	614	590

Grafik Jumlah Pemberian Tablet Besi Folat Pada Ibu Hamil Di RS Prima Husada
Bulan Maret 2024



Analisis :
Pemberian asam folat diberikan kepada ibu hamil pada usia kandungan trimester pertama. Sedangkan pemberian tablet zat besi diberikan pada usia kandungan trimester 2 dan 3. Jumlah pemberian tablet besi folat menurun pada bulan Maret yaitu 590 ibu hamil.

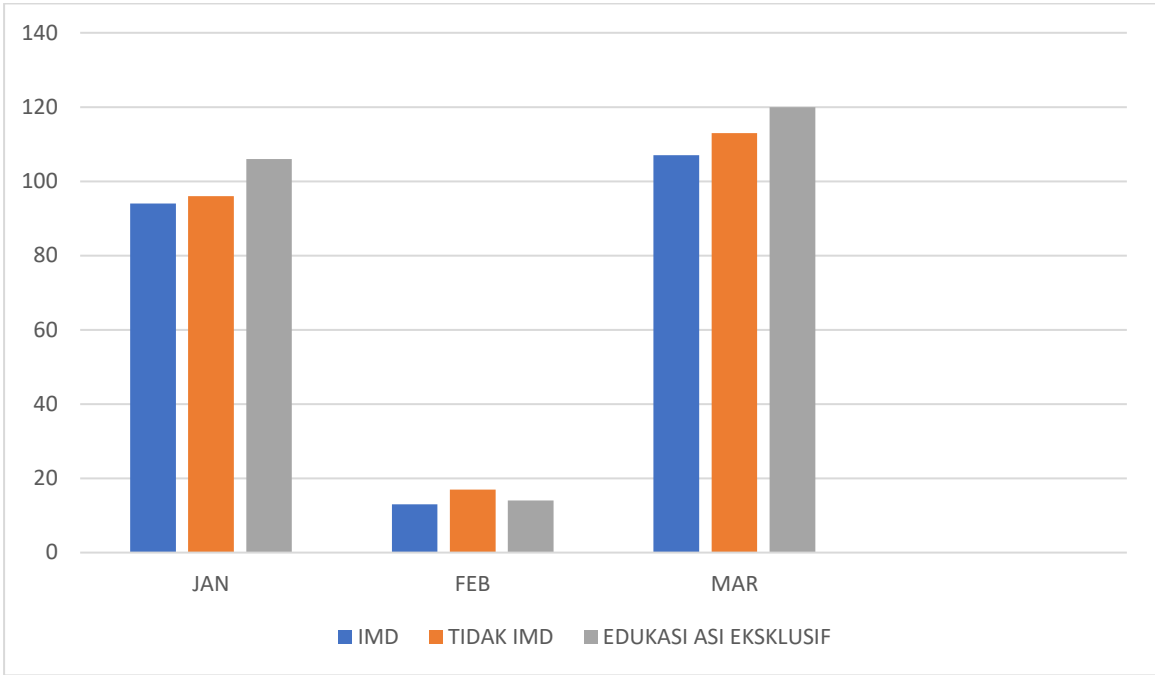
- Rencana Tindak Lanjut:**
- 1. Koordinasi dengan tim farmasi untuk mendukung penyediaan tablet tambah darah, agar program suplementasi tablet tambah darah kepada ibu hamil terus berlanjut
 - 2. Koordinasi dengan tim humas rumah sakit agar ibu hamil yang bergabung semakin banyak agar program suplementasi tablet besi folat semakin baik.

3.1.2.4.4 Jumlah Ibu Melahirkan yang Mendapat Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif

Tabel Jumlah Ibu Melahirkan yang Mendapat Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif

NO	URAIAN	JUMLAH PASIEN		
		BULAN JANUARI 2024	BULAN FEBRUARI 2024	BULAN MARET 2024
1	IMD	94	96	106
2	Tidak IMD	13	17	14
3	Mendapat Konseling ASI Eksklusif	107	113	120

Grafik Pelayanan IMD dan Konseling ASI Eksklusif di RS Prima Husada Bulan Maret 2024



Analisis :

- 1. Bayi yang dilakukan IMD pada bulan Maret 2024 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan sebelumnya, yaitu 106 bayi.
- 2. Kasus tidak dilakukan IMD pada bulan Februari 2024 menurun jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 14 bayi. Hal ini terjadi diiringi dengan masih adanya bayi lahir dengan berat <2500 gr sehingga tidak dilakukan IMD.
- 3. Pada bayi yang tidak dilakukan IMD memang tidak memenuhi kriteria untuk dilakukan IMD dikarenakan BBLR yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.
- 4. 100% ibu melahirkan telah mendapatkan edukasi menyusui. Untuk mendukung pemberian ASI secara eksklusif. Jumlah Ibu mendapat konseling ASI Eksklusif meningkat pada bulan Januari 2024 dikarenakan terdapat dokter spesialis kandungan baru sehingga juga meningkatkan kunjungan jumlah pasien ibu hamil.

Rencana Tindak Lanjut:

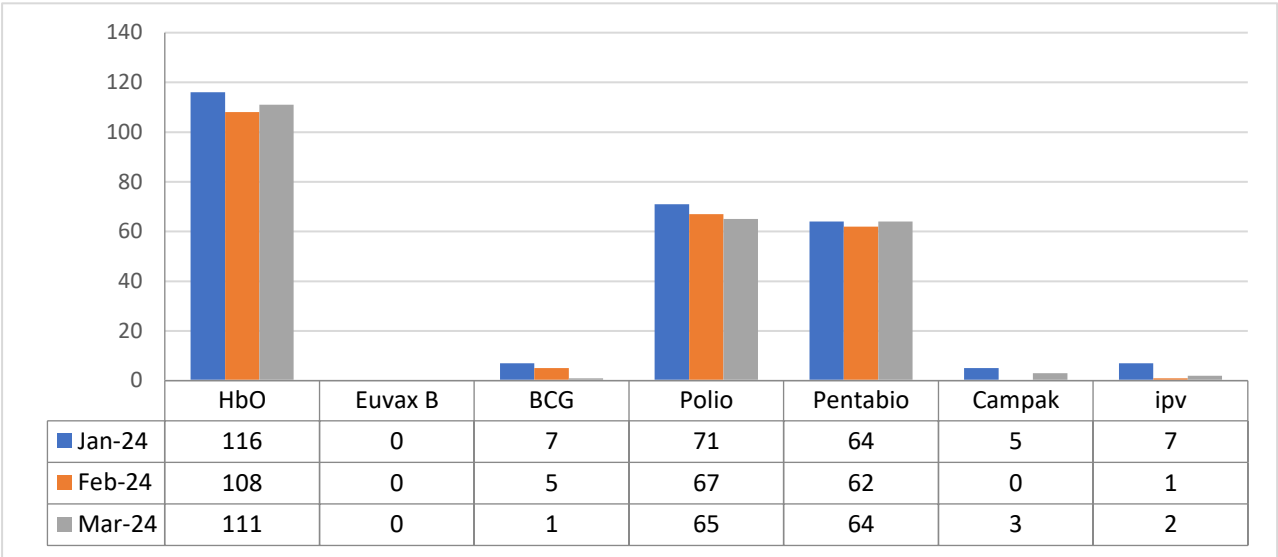
Tingkatkan koordinasi dengan dokter kandungan dan bidan rumah sakit dalam pemberian edukasi tentang pentingnya pemberian ASI eksklusif serta mendokumentasikan bukti telah melakukan edukasi kepada ibu melahirkan pada lembar edukasi.

3.1.2.4.5 Jumlah Balita yang Mendapat Imunisasi

Tabel Jumlah Balita yang Mendapat Imunisasi

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH		
		BULAN JANUARI 2024	BULAN FEBRUARI 2024	BULAN MARET 2024
1	HbO	116	108	111
2	Euvax B	0	0	0
3	BCG	7	5	1
3	Polio	71	67	65
4	Pentabio	64	62	64
5	Campak	5	0	3
6	IPV	7	1	2

Grafik Pelayanan Imunisasi Di Rumah Sakit Prima Husada Bulan Maret 2024



Analisis:

- 1) Tidak ada penggunaan vaksin euvax B pada periode Maret 2024 maupun 2 bulan sebelumnya, hal ini dikarenakan banyak nya pasien bayi baru lahir dengan status BPJS, sehingga memakai imunisasi HB.O unijek.
- 2) Imunisasi Hbo pada bulan Maret mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu sebanyak 111 bayi. Dan ini seiring dengan jumlah bayi baru lahir yang ada di RS
- 3) Bayi yang melakukan Imunisasi IPV Pada bulan Maret sedikit meningkat jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu 2 bayi
- 4) Bayi yang melakukan Imunisasi BCG Pada bulan Maret 2024 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu 2 pasien.
- 5) Pada periode Maret 2024 terdapat 3bayi yang melakukan Imunisasi Campak
- 6) Bayi yang melakukan Imunisasi Polio Pada bulan Maret 2024 mengalami menurunan jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu 65 bayi
- 7) Jumlah pasien yg imunisasi Pentabio pada bulan Februari 2024 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu 64 pasien

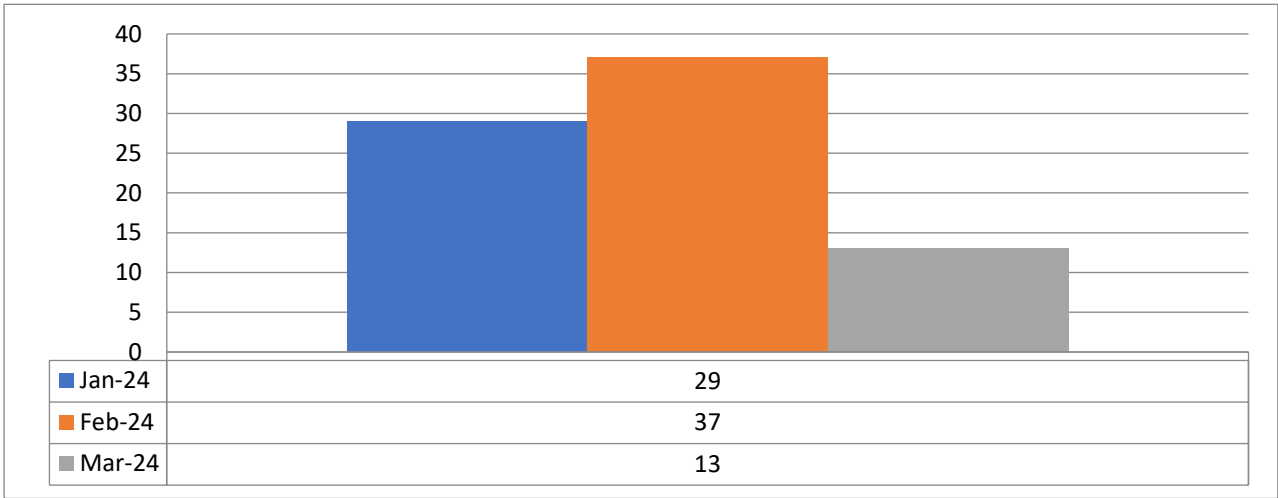
Rencana Tindak Lanjut :

Melakukan promosi terkait pelayanan imunisasi, baik oleh bidan maupun dokter spesialis rumah sakit.

3.1.2.4.6 Penerapan Rumah Sakit sayang Ibu Bayi
Tabel Penerapan Rumah Sakit Sayang Ibu Bayi

KEGIATAN PENERAPAN RUMAH SAKIT SAYANG IBU DAN BAYI	JANUARI 2024	FEBRUARI 2024	MARET 2024
Ruang Pojok Laktasi	1	1	1
Senam Hamil	37	36	13
Pembentukan Grup Laktasi	1	1	1

Grafik Senam Hamil Di Rumah Sakit Prima Husada Bulan Maret 2024



Analisis :

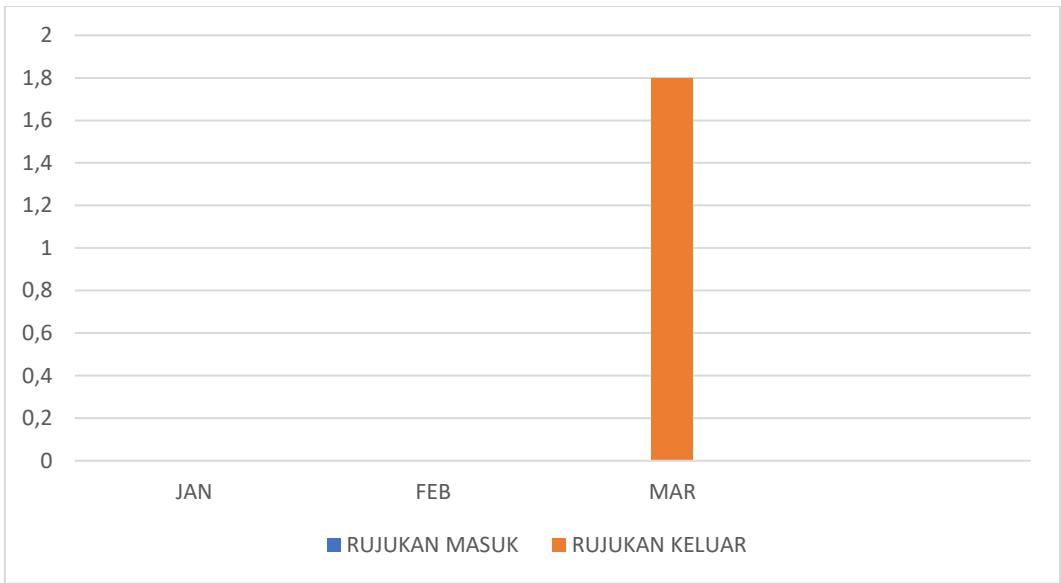
- 1. Pojok laktasi sudah tersedia untuk ibu dan bayi yang akan menyusui di wilayah rumah sakit prima husada malang.
- 2. Grup Laktasi dibentuk untuk memberikan tips menyusui.
- 3. Peserta Senam Hamil pada bulan Maret mengalami penurunan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 13 peserta dikarenakan senam hamil pada bulan maret hanya dilaksanakan satu kali karena bertepatan dengan bulan puasa. Dengan meningkatkan sarana yang nyaman, diharapkan dapat meningkatkan jumlah peserta senam hamil.

Rencana Tindak Lanjut :

- 1. Mengajukan perlengkapan untuk keperluan menyediakan pojok laktasi yang nyaman bagi bayi, balita, dan ibu menyusui seperti pampers dan tissue basah jika terdapat pasien atau pengunjung yang membutuhkan.
- 2. Melakukan edukasi mengenai pentingnya mengikuti senam ibu hamil pada ibu hamil yang tidak memiliki kondisi penyulit saat hamil.

3.1.2.4.7 Pelayanan Jejaring Rujukan Kasus Stunting Dan Wasting
Tabel Penerapan Rumah Sakit Sayang Ibu Bayi

NO	RUJUKAN	BULAN JANUARI 2024	BULAN FEBRUARI 2024	BULAN MARET 2024
1	Rujukan Masuk	0	0	0
2	Rujukan keluar	0	0	1



Analisis :
Terdapat 1 pasien dengan kondisi stunting yang dirujuk keluar yaitu ke RS Saiful Anwar dengan diagnose Stunting + Autism.

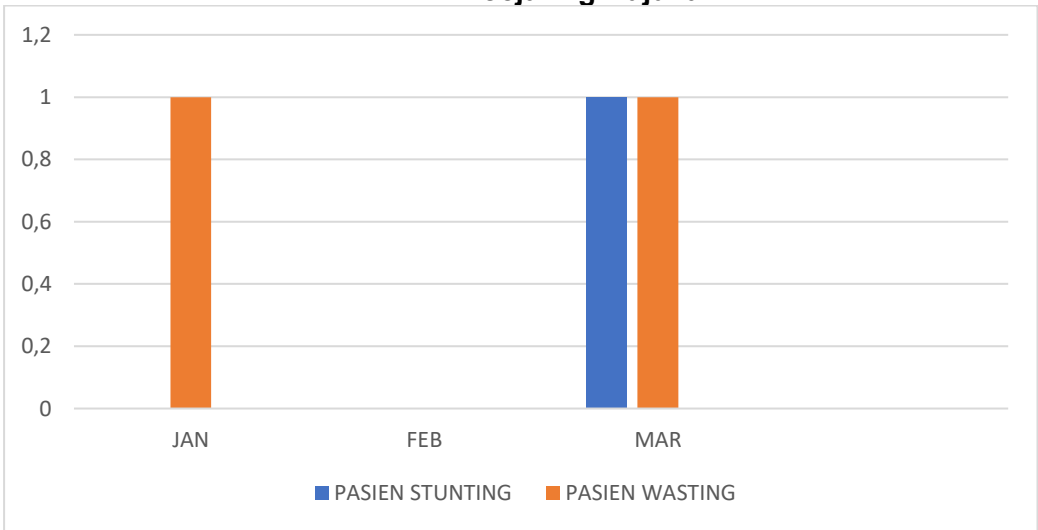
Rencana Tindak Lanjut:
Perlu diadakan kerjasama lagi dengan puskesmas dan klinik faskes pertama untuk bekerjasama dalam menjaring pasien stunting dan wasting.

3.1.2.4.8 Rumah Sakit Sebagai Pendamping Klinis Dan Manajemen Serta Merupakan Jejaring Rujukan

Tabel Rumah Sakit Sebagai Pendamping Klinis Dan Manajemen Serta Merupakan Jejaring Rujukan

BULAN	JANUARI 2024	FEBRUARI 2024	MARET 2024
Jumlah Pasien Stunting	0	0	1
Jumlah Pasien Wasting	1	0	1

Grafik Rumah Sakit Sebagai Pendamping Klinis Dan Manajemen Serta Merupakan Jejaring Rujukan



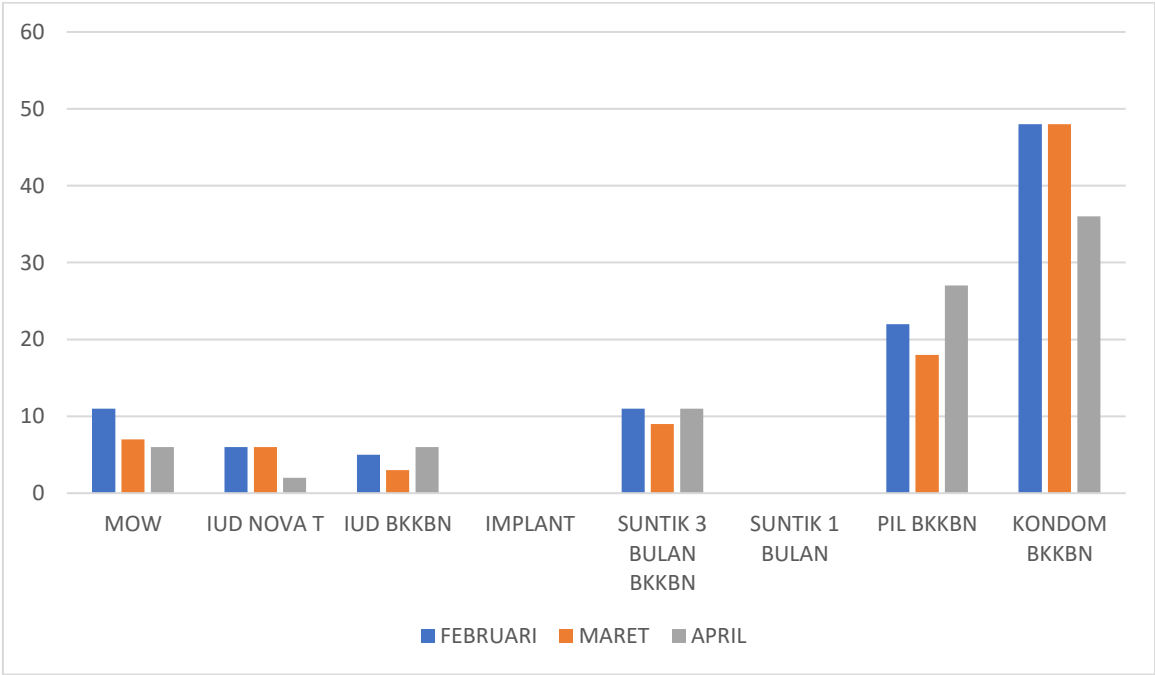
Analisis :
Terdapat 1 pasien wasting pada bulan Januari. Hal tersebut berkaitan dengan pola makan pasien yang terbilang kurang yaitu 2x sehari dan jumlah asupan makan sekali makan terbilang kurang yaitu 2 sdm tiap makan. Pada bulan Maret terdapat 1 pasien stunting yang merupakan psaien yang sudah dalam pantauan puskesmas. Sehingga ahli gizi berkolaborasi dengan dokter spesialis anak dan ahli gizi puskesmas dalam pemberian terapi balita stunting dan wasting.

Rencana Tindak Lanjut :
Tim Stunting dan Wasting RS Prima Husada memberikan terapi dengan bekerja sama dengan dokter spesialis anak untuk memberikan vitamin dan antibiotik yang dibutuhkan untuk mengatasi infeksi yang diderita pasien. Selain itu tim SW juga bekerjasama dengan cara melaporkan pasien stunting kepada petugas Gizi Puskesmas wilayah pasien tinggal untuk melakukan pemantauan lebih lanjut dan pemberian intervensi lanjutan kepada balita stunting dan wasting terseb

3.1.2.5 KBRs
3.1.2.6 Angka capaian pelayanan KB per metode kontrasepsi

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH PASIEN		
		BULAN FEBRUARI 2024	BULAN MARET 2024	BULAN APRIL 2024
1	MOW	11	7	6
2	IUD Nova T	6	6	2
3	IUD BKKBN	5	3	6
4	IMPLANT	0	0	0
5	SUNTIK 3 BULAN BKKBN	11	9	11
6	SUNTIK 1 BULAN	0	0	0
7	PIL BKKBN	22	18	27
8	KONDOM BKKBN	48	48	36

Grafik Angka Capaian Pelayanan KB Per Metode Kontrasepsi



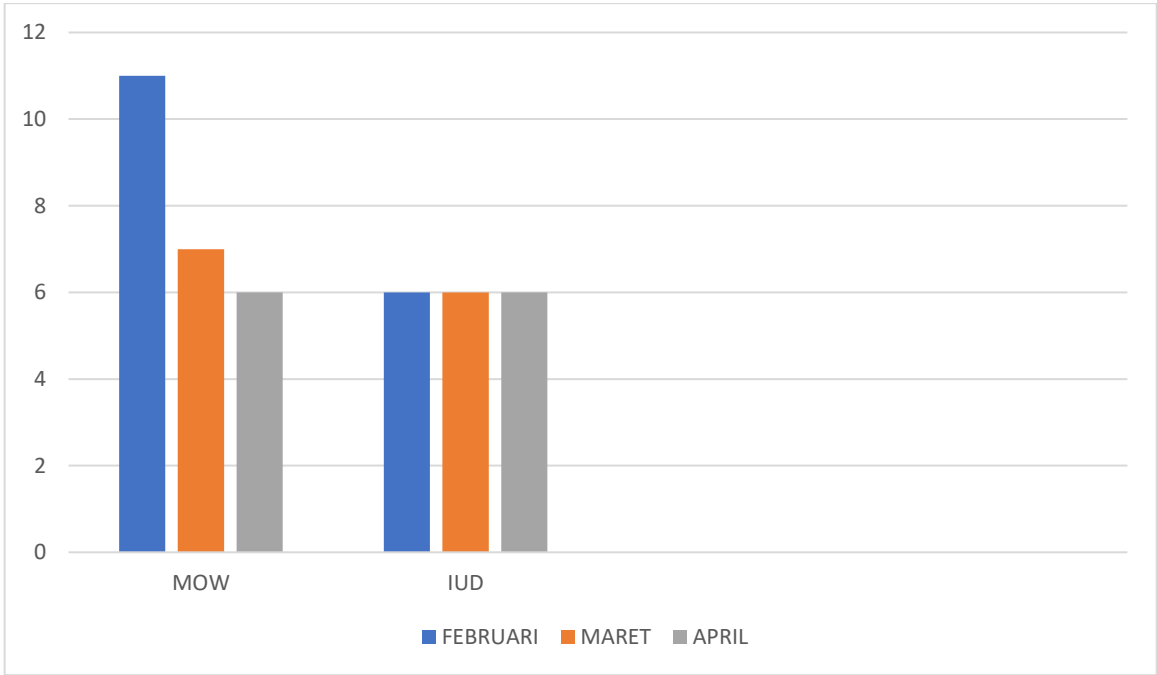
Analisis:

- 1. Peserta MOW pada bulan Februari (11) menurun pada Maret (7) April (6)
- 2. Peserta IUD Nova T pada bulan Februari (6) Maret (6) menurun April (2)Peserta IUD BKKBN, pada bulan februari (5) menurun Maret (3) meningkat April (6)
- 3. Peserta KB suntik 3 bulan, pada bulan Februari (11) menurun maret (9) meningkat April (11)
- 4. Peserta KB pil pada Februari (22) menurun Maret (18)meningkat April (27)
- 5. Peserta KB Kondom pada bulan Februari (48) maret (48) April (36)

3.1.2.6 Angka Capaian Pelayanan KB Pasca Persalinan Dan Pasca Keguguran

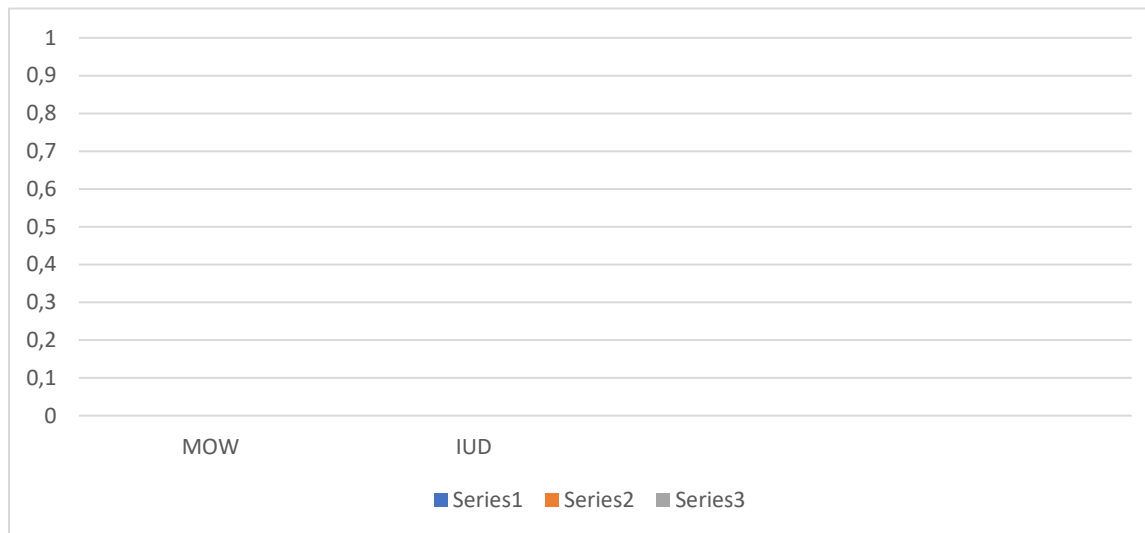
NO	JENIS PELAYANAN PASCA PERSALINAN	JUMLAH PASIEN		
		BULAN FEBRUARI 2024	BULAN MARET 2024	BULAN APRIL 2024
1	MOW	11	7	6
2	IUD	6	7	6

Grafik Angka Capaian Pelayanan KB Pasca Persalinan



NO	JENIS PELAYANAN PASCA KEGUGURAN	JUMLAH PASIEN		
		BULAN FEBRUARI 2024	BULAN MARET 2024	BULAN APRIL 2024
1	MOW	0	0	0
2	IUD	0	0	0

Grafik Angka Capaian Pelayan KB Pasca Keguguran



Analisis :

1. Angka capaian pelayanan KB pasca persalinan pada bulan Februari-maret-April menurun
2. Angka capaian pelayanan KB pasca keguguran pada bulan Februari-maret-April menetap

Rencana dan Tindak Lanjut :

1. Kolaborasi dengan bagian marketing rumah sakit terkait jumlah kunjungan pasien poli obgyn salah satunya dengan mengadakan promosi lewat sosial media.
2. Melakukan edukasi tentang pentingnya KB pada pasangan usia subur dengan rutin melakukan penyuluhan.
3. Melakukan edukasi kepada pasien ANC trimester 3 poli kandungan tentang pentingnya KB lewat penyuluhan.

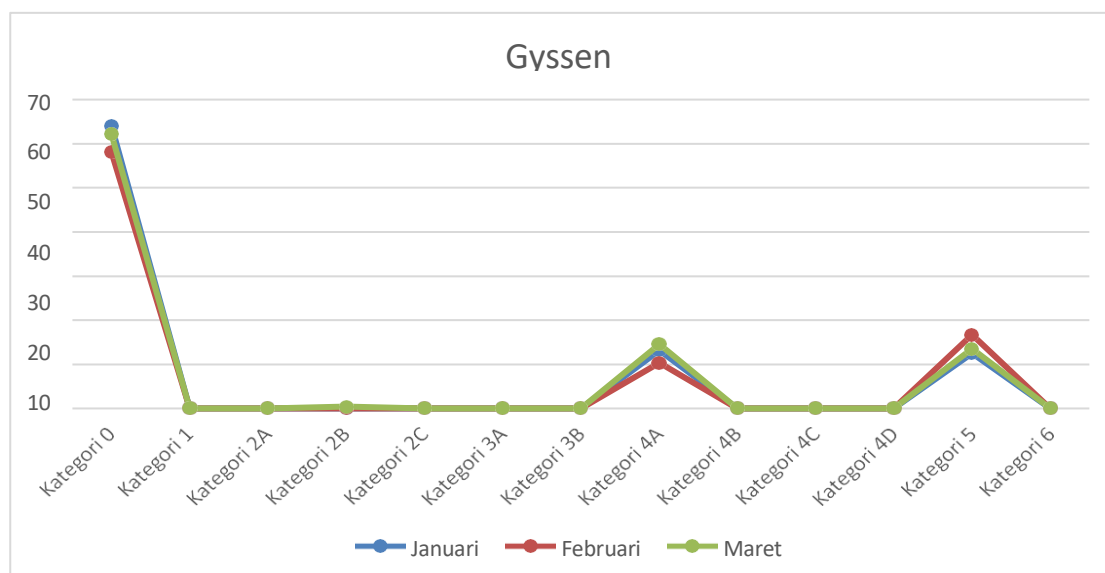
3.2.3 Tim PPRA

3.2.3.1 Audit Penggunaan Antibiotika Secara Kualitatif (Gyssens)

3.2.3.1.2 Tabel Audit Penggunaan Antibiotika Secara Kualitatif (Gyssens)

NO	KRITERIA GYSSENS	STANDAR	BULAN		
			JANUARI (%)	FEBRUARI (%)	MARET (%)
1	Kategori 0	≥ 50	64.03	58.03	62.1
2	Kategori 1	0	0	0	0
3	Kategori 2A	0	0	4.7	0
4	Kategori 2B	0	0	0	0.41
5	Kategori 2C	0	0	0	0
6	Kategori 3A	0	0	0	0
7	Kategori 3B	0	0	0	0
8	Kategori 4A	0	13.2	10.3	14.5
9	Kategori 4B	0	0	0	0
10	Kategori 4C	0	0	0	0
11	Kategori 4D	0	0	0	0
12	Kategori 5	0	12.45	16.7	13.5
13	Kategori 6	0	0	0	0

3.2.3.1.3 Grafik Audit Penggunaan Antibiotika Secara Kualitatif (Gyssens)



Analisis :

1. Pada triwulan I terdapat kategori 0 yaitu penggunaan antibiotik tepat dan rasional. Persentase tertinggi pada bulan Januari yaitu 64.03 %
2. Kategori 2A terdapat pada bulan Februari yaitu sebesar 4.7 % yang menunjukkan pemberian antibiotik tidak tepat dosis
3. Kategori 2B terdapat pada bulan Maret dengan persentase 0.41 % yaitu tidaktepat interval pemberian antibiotik
4. Kategori 4A tertinggi pada bulan Maret sebesar 14.5 % yang menunjukkan pilihan antibiotik yang diberikan tidak tepat karena ada antibiotik lain yang lebih efektif
5. Kategori 5 tertinggi terdapat pada bulan Februari sebesar 16.7 % yang menunjukkan adanya pemberian antibiotik namun tidak ada indikasi

Untuk mempertahankan dan meningkatkan penggunaan antibiotik rasional, maka perlu dilakukan PDSA sebagai berikut :

PLAN	DO	STUDY	ACTION
1. Meningkatkan persepan antibiotic rasional >50%. 2. Meningkatkan kepatuhan DPJP terhadap PPAB dengan cara:	1. Mengamati pelanggaran DPJP terhadap PPAB 2. Menelusuri penyebab terjadinya	DPJP diajak berdiskusi untuk membentuk PPAB yang sesuai dengan PPK yang betul-betul disepakati.	1. Meningkatkan kepatuhan DPJP terhadap PPAB dengan cara: a) Melakukan sosialisasi secara rutin dan terus-menerus

a) Melakukan sosialisasi secara rutin dan terus – menerus b) Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan antibiotik rasional oleh tim PPRA	pelanggaran tersebut dengan pendekatan secara personal.		c) Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan antibiotik rasional oleh tim PPRA
--	---	--	---

3.2.3.1.4 Surveilans Pola Kuman Dan Kepekaan Antibiotika Tahun 2023

Surveilans pola kuman dan kepekaan antibiotika tahun 2023 masih dalam proses pengajuan pembuatan pola kuman

3.2.3.2 Audit Penggunaan Antibiotik secara Kuantitatif Triwulan I Tahun 2024

3.2.3.2.2 Tabel Data Primer Audit Penggunaan Antibiotik Secara Kuantitatif Bulan Januari 2024

No.	Nama	Jenis Kelamin /umur	Dokter	No. RM	Diagnosis KRS	Tgl MRS	Tgl KRS	LOS (Hari)	Antibiotik	Jumlah Antibiotik	Dosis (gram)	Total Dosis (gram)	ATC	DDD
1	Sutik Handayani	P/38	dr. Anton, Sp.B	207573	Gangren Necrotic	4/01/2024	6/01/2024	3	Ceftiaxone	2	1x1	1	2	0,5
									Ceftiaxone		2x1	5	2	2,5
2	Suliyono	L/31	Dr. Ardhi, Sp.Pd	200701	Febris/ fever	5/01/2024	9/01/2024	5	Levofloxacin po	1	1x0,5	2,5	0,5	5
3	Shinta Nafisa	P/22	dr. Heri, Sp.Pd	016887	DHF, Anemia	6/01/2024	8/01/2024	3	Ceftiaxone	2	2x1	6	2	3
									Asam Pipemidat		2x0,4	2	0,8	2,5
4	Yatim	P/65	dr. Heri, Sp.Pd	207671	DM Hiperglikemi	6/01/2024	10/01/2024	5	Ceftriaxone	1	2x1	9	2	4,5
5	Miarsih	P/52	dr. Oka, Sp.OT	092704	Union Fibula (S)	7/01/2024	9/01/2024	3	Cefoperazone	2	1x2	2	4	0,5
									Cefoperazone		2x1	3	4	0,75
5	Suwarni	P/73	dr. Anton, Sp.B	171160	Abdominal Pain, Ileus	6/10/2023	8/10/2023	3	Ceftriaxone	1	2x1	6	2	3
6	Naning Wijaya	P/38	dr. Humairah, Sp.Og	206517	SC	18/01/2024	20/01/2024	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	2	2	1
7	Kasih	P/63	Dr. Heri, Sp.Pd	106412	DM Type 2	18/01/2024	20/01/2024	3	Ceftriaxone	2	2x1	6	2	3
									Asam Pepimidat		2x0,4	1,6	0,8	2
8	Siti Maisaroh	P/21	dr. Humairah, Sp.Og	205457	SC	18/01/2024	21/01/2024	4	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	2	2	1
9	Ngaisah	P/71	dr. Yoga, Sp.JP	128003	AFRVR + CHF +HHD	18/01/2024	23/01/2024	6	Ceftriaxone	1	2x1	12	2	6
10	Samsuri	L/48	dr. Ardhi, Sp.Pd	206413	DM Hiperglikemia	19/01/2024	23/01/2024	5	Ceftriaxone	2	2x1	10	2	5
									Metronidazole po.		3x0,5	3	2	1,5
11	Hairul Saleh	L/52	dr. Zaki, Sp.B	048988	Necroting Facitis	20/01/2024	22/01/2024	3	Cefoperazone	2	1x2	2	4	0,5
									Cefoperazone		2x1	4	4	1
									Ceftriaxone		1x1	1	2	0,5
									Ceftriaxone		2x1	5	2	2,5

12	Esti Rokhana	P/52	dr. Anton, Sp.B	167352	With peripheral circulatory complications	20/01/2024	22/01/2024	3	Metronidazole po	3	3x0,25	1,5	2	0,75
13	Kasmi	P/48	dr. Elvi, Sp.P	200703	COPD	22/01/2024	24/01/2024	3	Ceftriaxone	1	2x1	6	2	3
14	Warsono	L/65	dr. Anton, Sp. B	208359	Gangren Necrotic Diabetic	22/01/2024	24/01/2024	3	Ceftriaxone	3	1x1	1	2	0,5
15	Hasbullah	L/48	dr. Miryanti, SP.JP	208414	Acute subendocardial myocardial infarction	23/01/2024	26/01/2024	4	Ceftriaxone	1	2x1	7	2	3,5
16	Siti Soelichah	P/69	dr. Zora, Sp.Pd	200668	Volume depletion + Jaundice	26/01/2024	30/01/2024	5	Ceftriaxone	1	2x1	9	2	4,5
17	Juwita Rahayu	P/37	dr. Vita Sp.KK	208383	Candiloma	24/01/2024	26/01/2024	3	Doxyciclin	2	2x0,1	0,6	0,1	6
									Metronidazole po		2x0,5	1,2	2	0,6
18	Malia Triyana	P/47	dr. Heri, Sp.B	208480	Volume depletion + ISK	24/01/2024	27/01/2024	4	Ceftriaxone	2	2x1	7	2	3,5
									Asam Pipemidat		2x0,4	2	0,8	2,5
19	Muawanah Citra	P/25	dr. Ardhi, Sp.Pd	143342	DF + Volume Depletion	24/01/2024	29/01/2024	6	Levofloxacin inf	1	1x0,5	2,5	0,5	5
20	Siti Soelichah	P/69	Dr. Zora, Sp.Pd	200668	Volume depletion + Jaundice	26/01/2024	30/01/2024	5	Ceftriaxone	1	2x1	9	2	4,5

3.1.3.2 Tabel Data Primer Audit Penggunaan Antibiotik Secara Kuantitatif Bulan Februari 2024

No.	Nama	Jenis Kelamin/ umur	Dokter	No. RM	Diagnosis KRS	Tgl MRS	Tgl KRS	LOS (Hari)	Antibiotik	Jumlah Antibiotik	Dosis (gram)	Total Dosis (gram)	ATC	DDD
1	Siti Yuliasih	P/67	dr. Zaki, Sp.Ot	123966	Injury of unspecified body region	28/01/2024	01/02/2024	5	Ceftriaxone	2	2x1	8	2	4
									Gentamycin inj		2x0,04	0,24	0,24	1
2	Bambang Irawan	L/39	dr. Ardhi, Sp.Pd	132902	Volume depletion	31/01/2024	02/02/2023	3	Ceftriaxone	2	2x1	6	2	3
									Ciprofloxacin po		2x0,5	3	1	3
3	Iis Naini	P/28	dr. Ardhi, Sp.Pd	094474	Volume depletion	31/01/2024	02/02/2024	3	Ceftriaxone	2	2x1	6	2	2
									Ciprofloxacin po		2x0,5	3	1	3
4	Lintang hairani	P/24	dr. Humairah, Sp.Og	072225	SC	31/01/2024	02/02/2024	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	2	2	1
5	Wiwik Khotimah	P/47	dr. Anton, Sp.B	208768	Diabetic Foot digiti III Pedis (D)	30/01/2024	01/02/2024	3	Ceftriaxone	3	1x1	1	2	0,5
									Ceftriaxone		2x1	5	2	2,5
									Metronidazole po		3x0,25	1,5	2	0,75
6	Mujidah	P/34	dr. Heri, Sp.Pd	041524	Volume depletion, DF, DM	03/02/2024	07/02/2024	5	Ceftriaxone	2	2x1	9	2	4,5
									Asam pipemidat		2x0,4	2	0,8	2,5
7	Izzah Dhiyaul	P/22	dr. Humairah, Sp.Og	206220	Gravida SC	05/02/2024	07/02/2024	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	2	2	1
8	Nadila Dwi N	P/25	dr. Heri, Sp.Pd	094891	Gerd + Pneumoni	07/02/2024	12/02/2024	6	Ceftriaxone	2	2x1	11	2	5,5
									Azitromycin po		1x0,5	1	0,3	3,3
9	Moch Karyadi	L/75	dr. Pradana	130663	Unspecified renal colic	08/02/2024	11/02/2024	4	Gentamycin inf	1	2x0,04	0,24	0,24	1
10	Ramadhan Krisna	P/25	dr. Heri, Sp.Pd	209228	DHF	09/02/2024	12/02/2024	4	Ceftriaxone	1	2x1	6	2	3
11	Intan Gusti Eka	P/19	dr. Andy, Sp.P	209462	Efusi pluera	13/02/2024	17/02/2024	5	Ceftriaxone	1	2x1	8	2	4
12	Djumianah	P/65	dr. Heri, Sp.Pd	116343	DOC, Hipoglikemi	15/02/2024	19/02/2024	5	Ceftriaxone	2	2x1	10	2	5
									Azitromycin po		1x0,5	2	0,3	6,67
									Ceftriaxone		1x1	1	2	0,5

13	Rohim	L/50	dr. Anton, Sp.B	173278	Gangrene	16/02/2024	19/02/2024	4	Ceftriaxone	3	2x1	5	2	2,5
									Metronidazole po		3x0,25	1,5	2	0,75
14	Ngatono	L/69	dr. Heri, Sp. Pd	209539	GERD, Hipokalemi	16/02/2024	20/02/2024	5	Ceftriaxone	2	2x1	6	2	3
									Azitromycin po		1x0,5	1	0,3	3,3
15	Mesenah	P/40	dr. Heri, Sp. Pd	135390	Pneumonia	16/02/2024	20/02/2024	5	Ceftriaxone	2	2x1	8	2	4
									Azitromycin po		1x0,5	1	0,3	3,3
16	Masrap	L/70	dr. Yoga, Sp.JP	169410	Heart failure	16/02/2024	20/02/2024	5	Ceftriaxone	1	2X1	8	2	4
17	Sriati	P/65	dr. Mira, Sp.JP	209551	ADHF, HHD	17/02/2024	20/02/2024	4	Ceftriaxone	1	1x2	6	2	3
18	Mansur Arifin	L/38	dr. Zaki, Sp.B	040901	Gangren Pedis	18/02/2024	20/02/2024	3	Cefoperazone	2	1x2	2	4	0.5
									Ceftriaxone		2x1	5	2	2.5
19	Abd. Rochman	L/63	dr. Anton, Sp.B	209687	Gangren Necrotic	19/02/2024	21/02/2024	3	Ceftriaxone	3	1x1	1	2	0.5
									Ceftriaxone		2x1	6	2	3
									Metronidazole po		3x0,25	1,5	2	0,75
20	Kasiyati	P/57	dr. Ardhi, Sp.Pd	210089	DM Hiperglikemi	26/02/2024	29/02/2024	4	Ceftriaxone	1	2x1	6	2	3

3.1.3.3 Tabel Data Primer Audit Penggunaan Antibiotik Secara Kuantitatif Bulan Maret 2024

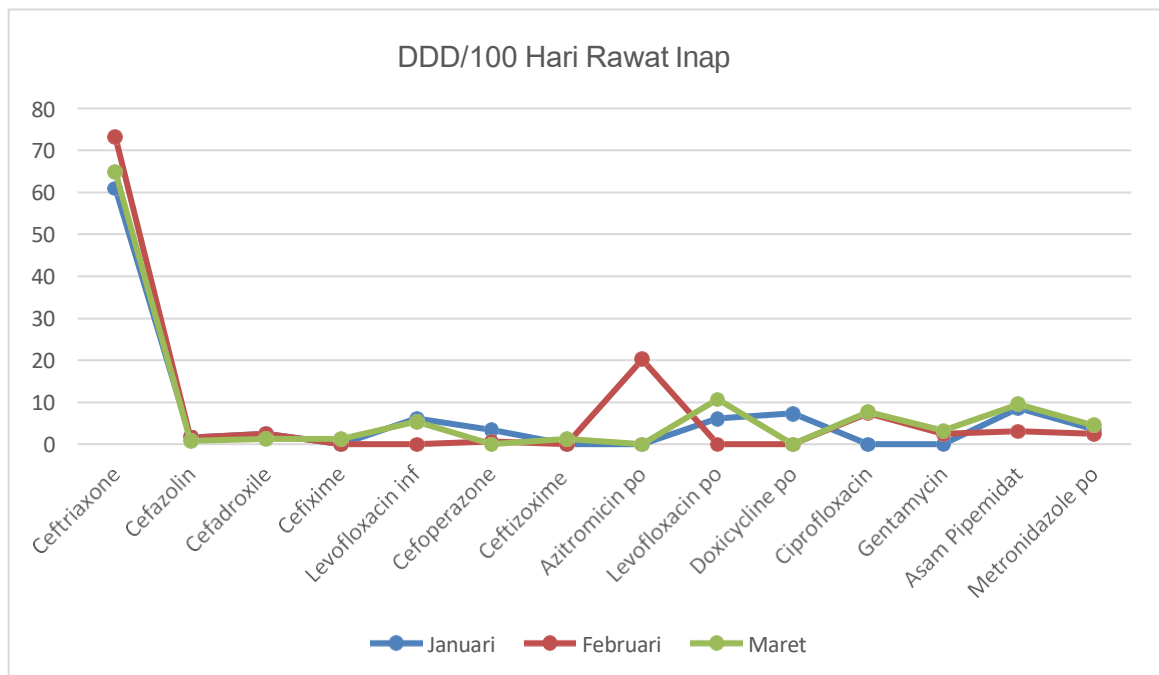
No.	Nama	Jenis Kelamin/ umur	Dokter	No. RM	Diagnosis KRS	Tgl MRS	Tgl KRS	LOS (Hari)	Antibiotik	Jumlah Antibiotik	Dosis (gram)	Total Dosis (gram)	ATC	DDD
1	Tugiyem	P/74	dr. Ardhi, Sp.Pd	204936	GEA + Volume Depletion	02/03/2024	06/03/2024	5	Ceftriaxone	2	2x1	9	2	4,5
									Metronidazole po		3x0,5	6	2	3
2	Bella Chori	L/22	dr. Heri, Sp.Pd	210364	Gastritis	03/03/2024	07/03/2024	5	Ceftriaxone	2	2x1	7	2	4,5
									Asam pipemidat po		2x0,4	2,4	0,8	3
3	Siti Fatimah	P/46	dr. Ardhi, Sp.Pd	122904	GEA + Volume Depletion	04/03/2024	07/03/2024	4	Ceftriaxone	2	2x1	6	2	3
									Ciprofloxacin po		2x0.5	3,5	1	3,5
4	Hery Suprpto	L/62	dr. Ardhi, Sp.Pd	210478	Febris HF	05/03/2024	08/03/2024	4	Levofloxacin po	2	1x0,5	1,5	0,5	3
									Ceftriaxone		2x1	7	2	3,5
5	Sriwati	P/64	dr. Ardhi, Sp.Pd	128694	HT, DM hiperglikemi	05/03/2024	07/03/2024	3	Ciprofloxacin	2	2x0,5	3	1	3
									Ceftriaxone		2x1	6	2	3
6	Riyanto	L/69	dr. Anton, Sp.B	192849	Gangrene necrotic DM	05/03/2024	07/03/2024	3	Ceftriaxone	3	1x1	1	2	0,5
									Ceftriaxone		2x1	4	2	2
									Metronidazole po		3x0,25	1,5	2	0,75
7	Suparmi	P/44	dr. Sigit, Sp.B	210942	CKR 456	13/03/2024	16/03/2024	4	Ceftriaxone	2	1x1	1	1	1
									Ceftriaxone		2x1	4	2	2
8	Suwardi	L/59	dr. Yoga, Sp.JP	113173	ADHF, Pneumoni, HHD	13/03/2024	17/03/2024	5	Levofloxacin po	2	1x0,5	1,5	0,5	3
									Ceftriaxone		2x1	8	2	4
9	Kasiadi	L/54	dr. Yoga, Sp.JP	110047	Chest Pain	14/03/2024	17/03/2024	4	Levofloxacin po	2	1x0,5	1,5	0,5	3
									Ceftriaxone		2x1	7	2	3,5
10	Sunarto	L/54	dr. Farid, Sp. S	210881	Susp CVA infark	14/03/2024	18/03/2024	5	Ceftriaxone	1	2x1	9	2	4,5
11	Misenah	P/66	dr. Ira, Sp. JP	210885	ALO	14/03/2024	18/03/2024	5	Levofloxacin inf	1	1x0,75	2,25	0,5	4,5
12	Sugiarti	P/36	dr. Ardhi, Sp. Pd	074113	Volume depletion	14/03/2024	18/03/2024	5	Ceftriaxone	1	2x1	9	2	4,5

13	M. Fahrul Rossy	L/19	dr. Oka, Sp. OT	210999	Finger tip injury (S)	16/03/2024	17/03/2024	2	Ceftriaxone	2	1x2	2	2	1
									Ceftriaxone		2x1	2	2	1
14	Sucipto Handoyo	L/62	dr. Pradana, Sp. U	097743	Urosepsis	19/03/2024	22/03/2024	4	Ceftizoxime	2	2x1	4	4	1
									Cefixime		2x0,1	0,4	0,4	1
15	Sujarah	P/56	dr. Heri, Sp. Pd	205380	DM Hipoglikemi	19/03/2024	23/03/2024	5	Ceftriaxone	2	2x1	9	2	4,5
									Asam Pipemidat		2x0,4	2	0,8	2,5
16	Suratyaningrum	P/70	dr. Heri, Sp. Pd	078841	Volume Depletion	20/03/2024	23/03/2024	4	Ceftriaxone	2	2x1	7	2	3,5
									Asam Pipemidat		2x0,4	2	0,8	2,5
17	Neni P	P/47	dr. Pradana Sp. U	211272	Other disorders of urinary system	21/03/2024	24/03/2024	4	Gentamycin	1	2x0,08	0,64	0,24	2,67
18	Afni Nur	P/32	dr. Humaira, Sp. OG	128587	SC	22/03/2024	24/03/2024	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	2	2	1
19	Susan Eka	P/45	dr. Heri, Sp. Pd	101806	Vomiting, volume depletion, DM	23/03/2024	27/03/2024	5	Ceftriaxone	1	2x1	8	2	4
20	Dhanis M	P/35	dr. Heri, Sp. Pd	065506	Vomiting	23/03/2024	27/03/2024	5	Ceftriaxone	1	2x1	9	2	4,5

3.1.3.4 Tabel Audit Penggunaan Antibiotik Secara Kuantitatif Triwulan I

NO	NAMA OBAT	BULAN (DDD/100 HARI RAWAT INAP)		
		JANUARI	FEBRUARI	MARET
1	Ceftriaxone	60,97	73,17	64,88
2	Cefazolin	1,63	1,63	0,79
3	Cefadroxile	2,43	2,43	1,19
4	Cefixime		-	1,19
5	Levofloxacin inf	6,09	-	5,35
6	Cefoperazone	3,35	0,61	-
7	Ceftizoxime	-	-	1,19
8	Azitromycin	-	20,20	-
9	Levofloxacin po	6,09	-	10,71
10	Doxyciclin	7,31	-	-
11	Ciprofloxacin	-	7,37	7,73
12	Gentamycin	-	2,43	3,17
13	Asam pipemidat	8,53	3,04	9,52
14	Metronidazole po	3,47	2,74	4,46

3.1.3.5 Grafik Audit Penggunaan Antibiotik Secara Kuantitatif Triwulan I



Analisis :

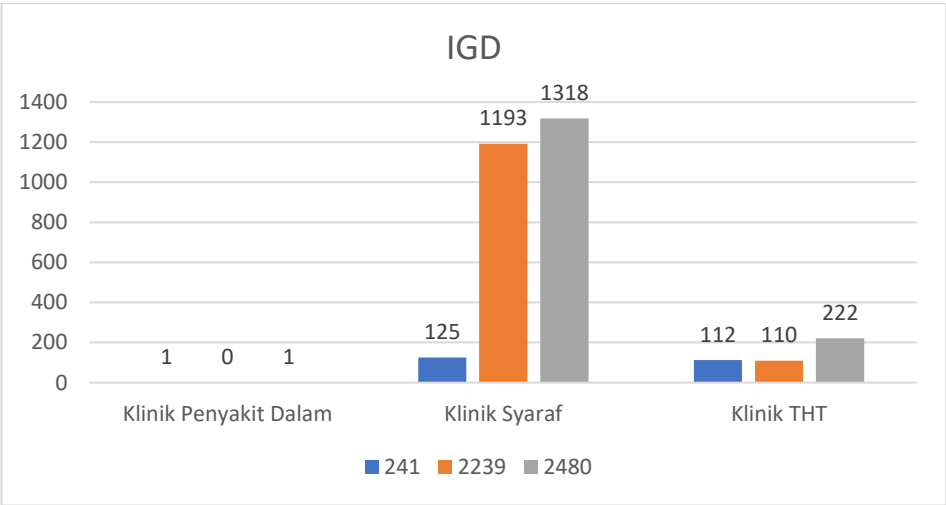
Pada Triwulan I tahun 2024, antibiotik paling banyak digunakan adalah antibiotik ceftriaxone sebesar 60.97; 73.17; 64.88 DDD/100 hari rawat inap. Hasil tersebut dapat dikaitkan dengan pemberian ceftriaxone sebagai terapi empiris pada kebanyakan diagnosis infeksi di RS Prima Husada Malang

3.1.4 Tim Review RM (E-RM)-IT

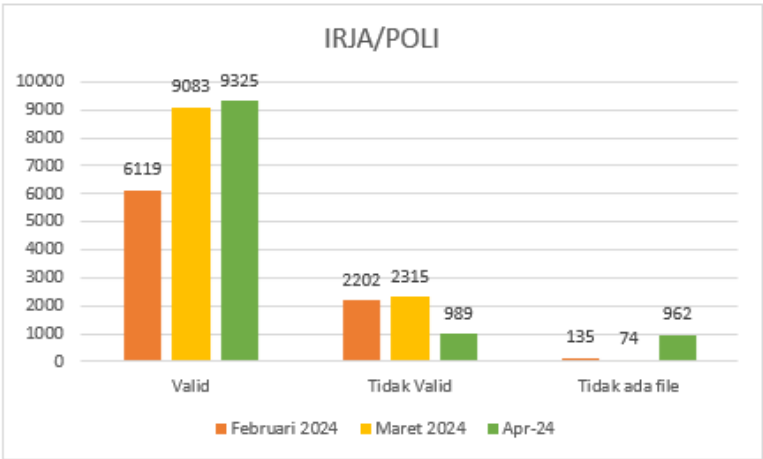
3.1.4.2 Tabel Validasi Data E-RM Bulan Februari-April 2024

NO	UNIT	KUALIFIKASI	BULAN					
			FEBRUARI 2024		MARET 2024		APRIL 2024	
			JUMLAH	(%)	JUMLAH	(%)	JUMLAH	(%)
1	IGD	Valid	0	0	0	0	0	0
		Tidak Valid	468	99,6	772	99,5	833	97
		Tidak ada file	2	0,4	3	0,5	20	3
Total			470		775		853	
2	IRJA/POLI	Valid	6119	72	9083	79	9325	82,5
		Tidak Valid	2202	26	2315	20	989	9
		Tidak ada file	135	2	74	1	962	8,5
Total			8456		11472		11276	

3.1.4.3 Validasi data E-RM di IGD Bulan Februari-April 2024



3.1.4.4 Validasi data E-RM di IRJA/Poli Bulan Februari-April 2024



Analisis :

1. Angka valid di IGD dalam 3 bulan terakhir tidak ada perubahan.
2. Angka valid di IRJA/Poli mengalami peningkatan dan angka tidak valid mengalami penurunan, dimana tarikan data erm sudah sinkron.
3. Masih ditemukan angka tidak ada file dikarenakan pasien yang sudah terdaftar rawat inap meninggal dunia di IGD sebelum 6 jam atau dilakukan rujuk ke RS lain, pada akhirnya terhitung rawat jalan tetapi belum dilakukan ERM.

Rencana Tindak Lanjut :

2. Mendata temuan masalah penggunaan ERM dan disampaikan ke Programmer untuk dilakukan tindaklanjut.

3.2 Permasalahan Rumah Sakit

3.2.3 Permasalah Instalasi Kamar Operasi (IKO)

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
A. Permasalahan Dari Unit			
1		P	Mencegah terjadinya keterlambatan pengurusan SIP Menyesuaikan jadwal untuk tim IKO untuk mengcover staf yang dirumahkan
		D	Melakukan monitoring berkala mengenai SIP setiap anggota di unit agar bisa segera diurus perpanjangannya sebelum SIP mati Meningkatkan system oncall
		S	Angka lembur tinggi
		A	List staf dengan SIP yang mati di tahun ini diminta segera mengurus SIP
B. Permasalahan Dari Kabid/ Komite Terhadap Unit			
1	Permintaan alat baru tidak berjalan sesuai alur	P	Memastikan permintaan alat baru berjalan sesuai alur
		D	Mengingatkan karu dan melakukan konfirmasi pada DPJP
		S	DPJP ada yang tidak paham mengenai alur permintaan alat
		A	Melakukan diskusi dengan DPJP dan membuat permintaan alat sesuai alur

3.2.4 Permasalahan Instalasi Gawat Darurat (IGD)

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
A. Permasalahan Dari Unit			
1	ERM sering trouble karena masih dalam proses perbaikan sehingga sering kali menghambat pelayanan	P	Penyempurnaan ERM agar pelayanan berjalan lancar dan meminimalisir komplain
		D	Membuat group whatsapp dengan programmer agar keluhan mengenai ERM segera diperbaiki
		S	Programmer beberapa kali tidak segera melakukan perbaikan karena memiliki banyak tugas
		A	Meningkatkan komunikasi dengan programmer untuk follow up problem ERM
2	Dokter IGD kewalahan karena jumlah pasien sering kali membludak	P	Melakukan Analisa beban kerja dokter IGD
		D	Melakukan open recruitment dokter umum, saat ini menunggu proses SIP selesai

		S	Dokter IGD akan tetap kewalahan jika hanya bertugas sendiri dalam 1 shift
		A	Membuat shift middle untuk dokter IGD sehingga dokter tersebut dapat membantu dalam jam crowded
B. Permasalahan Dari Kabid/ Komite Terhadap Unit			
1	Dokter IGD beberapa kali melakukan IKP	P	Melakukan telusur alasan dokter IGD terlibat IKP
		D	Kordinasi dengan komite mutu untuk melakukan rapat IKP
		S	Beberapa alasan terjadinya IKP oleh dokter umum adalah karena dokter umum tidak teliti akibat tingginya jumlah pasien, selain itu karena kurangnya refreshing ilmu
		A	Melakukan diklat internal tentang kegawat daruratan untuk dokter IGD

3.2.5 Permasalahan Rawat Inap

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
1	Rekam medis tidak lengkap	P	Meningkatkan kelengkapan rekam medis
		D	Melakukan supervisi
		S	Perawat tidak paham mengenai poin poin yang wajib dilengkapi, DPJP kurang patuh dalam mengisi rekam medis
		A	Membuat pelatihan pengisian dan kelengkapan rekam medis
2	Sistem input tarif di SIMRS sering bermasalah karena ada inputan tarif yang otomatis tetapi tidak sesuai sehingga mempengaruhi kontrol biaya dan membuat DPJP komplain	P	Meningkatkan kendali mutu kendali biaya
		D	Menyampaikan sisa plafon dari kontrol biaya di SIMRS pada DPJP
		S	Terdapat inputan yang tidak sesuai dan muncul secara otomatis sehingga membuat kontrol biaya menjadi rancu
		A	Memperbaiki system penginputan di SIMRS agar tidak ada kekeliruan dengan cara koordinasi dengan programmer

3.2.6 Permasalahan Rawat Jalan

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
1	Ruangan audiometri tidak kedap suara sehingga pemeriksaan audiometri tidak maksimal	P	Merencanakan / pengecekan ruangan audiometri yang kurang kedap
		D	Tim IPSRS segera menindaklanjuti ruangan audiometri
		S	Mengevaluasi ruangan yang ada di poli kekurangannya
		A	Kepala ruangan harus segera koordinasi dengan tim iprs untuk segera memperbaiki ruangan audiometri
2	Pengajuan alat dan pelayanan BPJS spesialis KGA belum selesai	P	Menyegerakan selesainya proses pengajuan pelayanan KGA
		D	Koordinasi dengan unit terkait
		S	Alat belum datang
		A	Follow up berkala, sementara memakan alat dari poli gigi 1

3.2.7 Permasalahan Instalasi Farmasi

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
1	Selisih stok pada FS IKO	P	Memperbaiki system keluar masuknya barang FS di IKO
		D	Koordinasi dengan Programmer terkait sistem IKO untuk meminimalisir terjadinya selisih dan membuat kesepakatan alur dengan petugas IKO
		S	1. Menempatkan TTK yang standby di IKO. 2. Membuat SPO Alur Pelayanan Permintaan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan di IKO. 3. Monitoring, evaluasi dan supervise dari Karu IKO dan Ka IFRS untuk pengadaan obat dan BMHP di IKO
		A	Melakukan pemantauan dan pencatatan keluar masuknya barang di IKO
2	Selisih stok di Depo Farmasi	P	Mencari akar masalah penyebab selisih di Depo Farmasi
		D	Koordinasi dengan Programmer untuk cek mutase barang dan perbaikan system.
		S	1. Melakukan cek riwayat mutase barang dengan selisih terbanyak. barang dengan selisih terbanyak. 2. Menghapus master barang yang inaktif setelah jumlah stok 0.
		A	1. Melakukan monitoring stok setiap harinya. 2. Menjalankan kartu stok. 3. Melaporkan jika ditemukan master barang inaktif yang jumlah stok fisik masih ada untuk disesuaikan dan dibuatkan BA.
3	Penataan rak obat tidak sesuai dengan standar PERMENKES	P	Menerapkan penataan obat di Gudang Farmasi sesuai standar permenkes
		D	Koordinasi dengan Ka IFRS dan Kepala Gudang serta Koordinator CS untuk merapikan sesuai standar
		S	Monitoring, evaluasi dan supervise dari Ka IFRS dan Kabit
		A	1. Melakukan supervise setiap saat. 2. Melakukan penyimpanan obat dengan system FEFO dan FIFO. 3. Melakukan pencatatan di kartu stok yang tertera di masing-masing obat.

3.2.6 Permasalahan Laboratorium

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
1	Terjadi keterlambatan hasil pemeriksaan PA	P	Memperbaiki alur penerimaan hasil PA rujukan
		D	Koordinasi dengan Sp.PA dan analis untuk kesepakatan pengiriman hasil pemeriksaan
		S	Analisis mempunyai tanggungjawab terkait hasil pemeriksaan laboratorium rujukan karena berkaitan dengan klaim
		A	1. Menghubungi dr Berlian, Sp.PA untuk kesepakatan hasil pemeriksaan maksimal 4x24 jam sesuai SPO 2. Analisis melakukan pencatatan dan follow up hasil sebelum batas waktu maksimal
2	Kurangpahaminya petugas melakukan analisa serah terima hasil pemeriksaan laboratorium	P	Memperbaiki SPO serah terima hasil pemeriksaan laboratorium dengan pasien
		D	Koordinasi dengan Karu untuk meminimalisir terjadinya kesalahan/keterlambatan pemberian hasil pemeriksaan dan membuat kesepakatan alur serah terima hasil pemeriksaan laboratorium dengan pasien
		S	1. Memperbaiki alur setelah analisis melakukan

			sampling, surat pengantar diberikan petugas input dan diberi keterangan “pasien rawat jalan, hasil ditunggu”.
		A	1. Petugas input wajib segera menyerahkan hasil kepada pasien setelah selesai input. 2. Mendokumentasikan jika petugas sudah memanggil nama pasien tetapi tidak segera diambil.

3.2.7 Permasalahan Rekam Medis

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
1	Ketidaksesuaian pemahaman pengisian DRM antar perekam medis dengan perawat	P	Melakukan diskusi dengan Kepala MRMIK dan Kabid Keperawatan untuk menyelaraskan pemahaman pengisian DRM antar perekam medis dengan perawat
		D	Koordinasi dengan Karu RM untuk membuat TOR “Diklat analisis kelengkapan pengisian DRM”
		S	Mengumpulkan data ketidaksesuaian pengisian DRM dan disampaikan saat diskusi dengan perawat, dihadiri oleh Kepala MRMIK dan Kabid Keperawatan.
		A	Melakukan “Diklat analisis kelengkapan pengisian DRM”.
2	Ketidaksesuaian antara fitur e-rm poli dengan rekam medis	P	Memperbaiki fitur e-rm poli dan rekam medis.
		D	Koordinasi dengan Programmer untuk meminimalisir data yang tidak valid akibat ketidaksesuaian fitur.
		S	Mencatat temuan permasalahan e-rm dan dilaporkan kepada Programmer.
		A	Melakukan koordinasi dengan Programmer setiap ditemukan masalah e-rm.

3.2.8 Permasalahan Radiologi

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
1.	Alur MCU tidak disetujui oleh DPJP	P	Memperbaiki Alur Pelayanan MCU di Radiologi
		D	Koordinasi dengan DPJP untuk meminimalisir terjadinya tidak dilakukan pemeriksaan yang membutuhkan Spesialis Radiologi.
		S	Berdiskusi dengan Humas Marketing dan Karu Radiologi untuk membuat kesepakatan alur MCU.
		A	Humas Marketing menginformasikan kepada Karu Radiologi H-1 jika akan ada MCU, kesepakatan dengan DPJP : 1. Jika peserta sedikit maka sesuai jadwal DPJP. 2. Jika peserta banyak dan bisa datang dalam 1 waktu maka dijadwalkan diluar jadwal dinas.
2.	Terjadi pembacaan ulang hasil pemeriksaan radiologi oleh DPJP	P	Memperbaiki alur pelayanan pemeriksaan radiologi dan meminimalisir kejadian pembacaan ulang hasil pemeriksaan.
		D	Mencari penyebab dilakukan pembacaan ulang hasil pemeriksaan radiologi. Menentukan alur yang tepat dan disosialisasikan kepada tenaga medis.
		S	Dari kejadian tersebut, hal ini disebabkan karena beberapa hal :

			1. Surat permintaan pemeriksaan yang tidak lengkap 2. Dokter Radiologi kurang teliti dalam membaca hasil.
		A	Dilakukan review hasil pembacaan dengan menyertakan diagnosa secara lengkap.

3.9 Profil SDM

3.9.1 Ketenagaan (Distribusi Tenaga, Kualifikasi, Jabatan dan Kebutuhan)

NO	UNIT	PENDIDIKAN	TOTAL	JUMLAH	TETAP	TIDAK TETAP	RESIGN
1	Direktur	Dokter Umum	1	1	0	1	0
2	Kabid Pelayanan medik	Dokter Umum	1	1	0	1	0
3	Kabid Penunjang Medik	D3 Kebidanan	1	1	1	0	0
4	Kabid Umum & Keuangan	Dokter Gigi	1	1	0	1	0
5	Kabid Keperawatan	Profesi Ners	1	1	0	1	0
6	Dokter IGD	Dokter Umum	7	7	0	7	0
7	Dokter Ruangan	Dokter Umum	0	0	0	0	0
8	Farmasi	SMK	42	5	0	5	0
		D3 Farmasi		20	4	16	0
		S1 Apoteker		12	0	12	0
		S1 Farmasi		3	0	3	0
		S1 Analisis Farmasi dan Makanan		1	0	1	0
		S1 Ekonomi		1	0	1	0
9	Asuransi Center	SMA	11	1	1	0	0
		SMK		1	1	0	0
		D3 Kesehatan		3	0	3	0
		D3 Asuransi Kesehatan		1	0	1	0
		D3 RMIK		5	0	5	0
10	CSSD	SMK	4	2	1	1	0
		D3 Keperawatan		1	0	1	0
		D3 Farmasi		1	0	1	0
11	Fisioterapi	D3 Fisioterapi	4	2	2	0	0
		D3 Kesehatan		1	0	1	0
		S1 Terapi Wicara		1	0	1	0
12	Gizi	SMP	16	2	2	0	0
		SMK		6	0	6	0
		SMA		2	0	2	0
		D3 Gizi		2	2	0	0
		D4 Gizi		2	0	2	0
		S1 Gizi		2	1	1	0
13	Humas & Marketing	S1 Kesehatan Masyarakat	2	1	0	1	0
		Profesi Ners		1	0	0	0
14	ICU dan HCU	D3 Keperawatan	12	5	1	4	0
		Profesi Ners		6	4	2	0
		D3 Kebidanan		1	0	1	0
15	IGD	D3 Kebidanan	28	1	0	1	0
		D4 Kebidanan		5	0	5	0
		D3 Keperawatan		10	0	10	0

		D4 Keperawatan		5	0	5	0
		Profesi Ners		7	1	6	0
16	IKO	D3 Kebidanan	12	1	1	0	0
		D3 Keperawatan		3	1	2	0
		Profesi Ners		8	3	5	0
17	IPCN	Profesi Ners	1	1	1	0	0
18	IPSRS	D3 TEM	7	1	0	1	0
		SKM		1	0	1	0
		D3 Teknik		1	0	1	0
		S1 Teknik		1	0	1	0
		SMA		3	1	2	0
19	IRJA	D3 Kebidanan	27	5	3	2	0
		D3 Keperawatan		13	6	7	0
		D4 Keperawatan Gigi		1	0	1	0
		Profesi Ners		8	4	4	0
20	IRNA 2C	D3 Keperawatan	7	2	0	2	0
		Profesi Ners		5	1	4	0
21	IRNA 6A & 7A & 8A	D3 Keperawatan	24	12	0	12	0
		D4 Keperawatan		4	0	4	0
		Profesi Ners		8	0	8	0
22	IRNA 3C Anak	D3 Keperawatan	14	8	0	8	0
		D4 Keperawatan		1	0	1	0
		Profesi Ners		5	0	5	0
23	IRNA 3A & 4A	D3 Keperawatan	19	14	0	14	0
		Profesi Ners		5	0	5	0
24	IRNA 5C	D3 Keperawatan	10	5	0	5	0
		Profesi Ners		5	0	5	0
25	Maternitas	D3 Kebidanan	12	8	7	1	0
		D4 Kebidanan		2	1	1	0
		Profesi Bidan		2	0	2	0
26	Neonatologi	D3 Keperawatan	9	5	0	5	0
		Profesi Ners		4	3	1	0
27	Keuangan dan Akuntansi	SMA	10	4	1	3	0
		S1		5	3	2	0
		D3 Keuangan		1	0	1	
28	Laboratorium	D3 Kesehatan	10	4	0	4	0
		D3 Analisis Kesehatan		4	1	3	0
		D4 Analisis Kesehatan		2	0	2	0
29	Laundry	SMA	5	5	3	2	0
30	Rekam Medis	D3 RMIK	10	9	3	6	0
		D4 RMIK		1	0	1	0
32	Pendaftaran	SMA	15	6	1	5	0
		D3 RMIK		4	2	2	0
		D3 Kesehatan		2	0	2	0
		S1 Sosial		1	0	1	0
		D4 Manajemen		2	0	2	0
33	PIPP	Ners	5	1	1	0	0
		D3 Keperawatan		1	0	1	0
		D3 Kebidanan		1	1	0	0
		D4 Kebidanan		2	1	1	0
34	PMKP	Profesi Ners	1	1	0	1	0
35	Radiologi	D3 Radiodiagnostik & Radioterapi	7	7	0	7	0

36	SDM	S1 Psikologi	2	2	0	2	0
37	Sekretaris	S1 Administrasi Publik	1	1	0	1	0
38	SIMRS & IT	S1 Komunikasi	3	3	0	3	0
39	Umum Rumah Tangga	S1 Ekonomi	1	1	1	0	0
40	Cleaning Service	SMP	44	3	1	2	0
		SMA		41	5	36	0
41	Security	SMA	12	12	6	6	0
42	Driver	SMA	5	5	1	4	0
43	Gudang Umum	SMA	1	1	1	0	0
44	Dokter Spesialis Syaraf		4	4	0	4	0
45	Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah		3	3	0	3	0
46	Dokter Spesialis Paru		4	4	0	4	0
47	Dokter Spesialis Penyakit Dalam		3	3	0	3	1
48	Dokter Spesialis Anestesi		2	2	0	2	0
49	Dokter Spesialis Bedah		4	4	0	4	0
50	Dokter Spesialis Bedah Plastik		1	1	0	1	0
51	Dokter Spesialis Orthopedi		3	3		3	0
52	Dokter Spesialis Patologi Anatomi		1	1	0	1	0
53	Dokter Spesialis Patologi Klinis		1	1	0	1	0
54	Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi		1	1	0	1	0
55	Dokter Spesialis Mata		3	3	0	3	0
56	Dokter Spesialis Urologi		2	2	0	2	0
57	Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa		2	2	0	2	0
58	Dokter Spesialis Obstetry Ginekology		4	4	0	4	0
59	Dokter Gigi Spesialis Orthodontist		1	1	0	1	0
60	Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin		2	2	0	2	0
61	Dokter Spesialis THT		1	1	0	1	0
62	Dokter Spesialis Gigi Periodonti		1	1	0	1	0
63	Dokter Spesialis Radiologi		3	3	0	3	0
TOTAL			451				

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

RS Prima Husada Malang yang selalu berbenah untuk meningkatkan pelayanan baik dari sisi Sumber Daya Manusia ataupun dari sisi sarana dan prasarannya. Dimana masih terdapat beberapa Sumber Daya manusia yang masih belum tertib baik dari kelompok tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang masih belum tertib secara administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dimulai dengan penataan SDM yang disesuaikan dengan alur dan tata letak Gedung yang baru, maka dilakukan juga penambahan tenaga khususnya perawat untuk memenuhi kebutuhan setelah dilakukan evaluasi dan Analisa beban kerja. Proporsi antara karyawan kontrak/tidak tetap dengan karyawan tetap, dimana masih banyak karyawan kontrak/tidak tetap di RS Prima Husada Malang diperkirakan bisa mempengaruhi kualitas pelayanan di Rumah sakit

Kepatuhan DPJP dalam memvisite pasien dan melengkapi dokumen Rekam medis yang masih jauh dari standar juga mempengaruhi kualitas pelayanan di RS Prima Husada Malang dan menghambat proses klaim. Kinerja RS dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal Rumah Sakit. Jumlah kunjungan di RS Prima Husada Malang masih didominasi oleh kunjungan pasien lama dari BPJS Kesehatan. Pelayanan di beberapa unit yang belum optimal dikarenakan salah satu dampak kekurangan tenaga kerja membawa akibat pada pelayanan.

B. SARAN

1. Meningkatkan ketertiban administrasi di Unit SDM terutama ketertiban absensi dengan memanfaatkan SIM SDM yang baru
2. Membentuk dan mengoptimalkan kinerja dari komite – komite yang ada di RS Prima Husada Malang
3. Meningkatkan kepatuhan visite DPJP dengan mencatat dan melaporkan waktu visite DPJP serta mentertribkan DPJP dalam pengisian Dokumen Rekam Medis
4. Memperbaiki proses rekrutmen staf sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan
5. Meningkatkan skill dan pengetahuan SDM dengan giat mengaktifkan diklat dan pelatihan internal serta mengikuti pelatihan secara eksternal
6. Meningkatkan marketing dan promosi untuk meningkatkan kunjungan ke RS Prima Husada Malang
7. Menjalin lebih banyak kerjasama dengan stakeholder dari luar RS Prima Husada Malang

BAB V
PENUTUP

Demikian laporan bulan April 2024 ini kami buat sebagai bahan pertanggungjawaban atas kinerja Rumah Sakit Prima Husada Malang pada bulan April 2024, masih ada beberapa target yang belum tercapai sesuai standard namun upaya selalu kami lakukan secara terus menerus. Perbaikan dan pengembangan pelayanan akan terus kami lakukan seoptimal mungkin.

Malang, 07 Mei 2024
PLT Direktur Rumah Sakit Prima Husada Malang



dr. Nur Mazidah

LAMPIRAN

NO	INSTANSI	NAMA PKS	JENIS INSTANSI	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	TANGGAL EXPIRED	KETERANGAN	NOMOR PKS RUMAH SAKIT	NOMOR PKS INSTANSI
1	PT. Asuransi Allianz Life Indonesia	Perjanjian Pelayanan Kesehatan	Asuransi	Selamanya	12 Desember 2017	Perpanjang Otomatis	Berlaku	-	729/AZLI-LGL/AG/XII/2017
2	PT. Global Asistensi Manajemen Indonesia (GAMI)	Perjanjian Layanan Kesehatan Rawat Jalan	Asuransi	Selamanya	26 Agustus 2019	Perpanjang Otomatis	Berlaku	-	640/IP-OP/PKS/GAH/VIII/2019
3	PT. Fullerton Health Indonesia	Perjanjian kerjasama Pelayanan Kesehatan	Asuransi	Selamanya	26 Agustus 2019	Perpanjang Otomatis	Berlaku		640/IP-OP/PKS/FHI/VIII/2019
4	PT Prudential Life Insurance	Surat Kesepakatan Kerjasama Pelayanan Kesehatan	Asuransi	Selamanya	13 April 2020	Perpanjang Otomatis	Berlaku		3143/PMN-PA/IV/2020
5	PT AIA Financial	Perjanjian Kerja sama Pelayanan Kesehatan	Asuransi	Selamanya	4 November 2020	Perpanjang Otomatis	Berlaku	069/DPM/E-PKS/DIR/X/2020	639/AIA-DPM/XI/2020
6	PT. Medlinx Asia Teknologi (Medlinx)	Perjanjian Pelayanan Kesehatan	Asuransi	Selamanya	28 November 2016	Perpanjang Otomatis	Berlaku	150/ PKS-RSPRIMAHUSADA-MAT/DIR/XI/2016	
7	PT. Asuransi AA Internasional	Pelayanan Kesehatan	Asuransi	Selamanya	19 September 2019	Perpanjang Otomatis	Berlaku	-	AAII/RS/E-384/PKS/Feb/2015
8	PT. Suprima Mitra Adihusada	Perjanjian Kerja sama Pelayanan Kesehatan	Asuransi	Selamanya	26 agustus 2019	Perpanjang Otomatis	Berlaku		640/IP-OP/PKS/TIRTA/VIII/2019
9	PT. Equity Life IND-Corporate	Perjanjian Pelayanan Kesehatan	Asuransi	Selamanya	14 Oktober 2019	Perpanjang Otomatis	Berlaku		091/ELI/LGL/X/19
10	PT. Axa Services Indonesia	Perjanjian Kerjasama Layanan	Asuransi	Selamanya	15 Agustus 2013	Perpanjang Otomatis	Berlaku	-	067/AGR-Leg/ASI/VII/2013

		Kesehatan							
11	PT. Asuransi Jiwa Sinarmas Msig	Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan	Asuransi	Selamanya	9 Oktober 2012	Perpanjangan Otomatis	Berlaku	-	063/PKS - AJSMSIG-Rs / IX/ 2012
12	PT. Asuransi Jiwa Sinarmas	Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan Rawat Inap	Asuransi	Selamanya	9 April 2019	Perpanjangan Otomatis	Berlaku	010/DPM/E- PKS/DIR/IX/2019	364/PKS-RS/PH.RI.ASM/IX/2019
13	PT. Hanwha Life Insurance Indonesia	Perjanjian Kerjasama Layanan Kesehatan	Asuransi	Selamanya	16 Maret 2015	Perpanjangan Otomatis	Berlaku	-	0088/HLI-GH/ PKS-RS/03-2015
14	PT. Equity Life IND-Cassles	Perjanjian Pelayanan Kesehatan	Asuransi	Selamanya	14 Oktober 2019	Perpanjangan Otomatis	Berlaku		090/ELI/LGL/X/19
15	PT. Asuransi Adira Dinamika	Perjanjian Pelayanan Kesehatan	Asuransi	Selamanya	24 Oktober 2013	Perpanjangan Otomatis	Berlaku	PH/E-IKS/171/X/2013	499B/AAD-LEG-AGR/X/2013
16	PT. Prima Sarana Jasa	Pelayanan Kesehatan	Asuransi	Selamanya	17 September 2018	Perpanjangan Otomatis	Berlaku	735/E-PKS/DIR/IX/2018	296/GAN/PT-6/HOSP/SEP/2018
17	PT. BNI Life Insurance	Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan	Asuransi	Selamanya	24 Juli 2019	Perpanjangan Otomatis	Berlaku	082/RSPH/E-IKS/DIR/II/2016	274.PKS.BL.DIR.0716
18	Administrasi Medika (Admedika)	Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	Asuransi	Selamanya	28 April 2018	Perpanjangan Otomatis	Berlaku	025/RSPH/E- PKS/DIR/IV/2015	141/PKS/ADMEDIKA/IV/2015
19	Asuransi Jiwa Generali	Perjanjian Pelayanan Kesehatan	Asuransi	Selamanya	10 Oktober 2019	Perpanjangan Otomatis	Berlaku	070/DPM/E- PKS/DIR/IX/2019	109/GI/OPS/Prov-SK/IX/2019
20	PT. Aplikanusa Lintasarta (Owlexa Healthcare)	Nota Kesepakatan Layanan Pemeriksaan Kesehatan	Asuransi	Selamanya	25 Februari 2015	Perpanjangan Otomatis	Berlaku	PH/IKS/100/II/2015	095/LA/MoU/00300/2015
21	PT. Asuransi Takaful Keluarga	Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan	Asuransi	Selamanya	02 Januari 2017	Perpanjangan Otomatis	Berlaku	508/RSPH/E- IKS/DIR/XI/2016	0642/PKS-RS-01/II/2017

22	PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia	Perjanjian Pelayanan Kesehatan Peserta Individu	Asuransi	Selamanya	2 Maret 2020	Perpanjangan Otomatis	Berlaku	017/DPM/E- PKS/DIR/XI/2019	045-02/EB-CONT/2020
23	PT. AJ Central Asia Raya (CAR)	Perjanjian Pelayanan Kesehatan	Asuransi	Selamanya	29 November 2019	Perpanjangan Otomatis	Berlaku	795/E-ADD/DIR/XI/2019	DIR/PKS-ADD/RS/154/XI/2019
24	PT. Java Smartindo	Jasa Pengelolaan Administrasi Kesehatan	Asuransi	2 Tahun	21 Agustus 2020	Perpanjangan Otomatis	Berlaku	364/DPM/I- PKS/DIR/VIII/2020	PKS.TPA-JSMART.290/VIII/20/RS.SW.C
25	PT PLN Insurance	Asuransi Pelayanan Kesehatan	Asuransi	Selamanya	30 Oktober 2019	Perpanjangan Otomatis	Berlaku	612/RSPHS/E- PKS/DIR/XI/2019	300/PKS/TKI/X/2019
26	PT. Asuransi Jasa Indonesia	Perjanjian Kerja sama Pelayanan Kesehatan	Asuransi	Selamanya	28 Agustus 2020	27 Agustus 2023	Berlaku	PKS.031/GHASKES/157- 1/2020	053/DPM/E-PKS/DIR/VIII/2020
27	PT. Asuransi Reliance Indonesia	Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan	Asuransi	Selamanya	7 September 2020	7 September 2025	Berlaku	490/RSPH/I- IKS/DIR/XI/2016	930.01/UM/ARI-RS/XI2016
28	PT. Pan Pacific Insurance	Pelayanan Perawatan dan Pengobatan	Asuransi	Selamanya	31 Agustus 2020	Perpanjangan Otomatis	Berlaku	017/DPM/E- PKS/DIR/VII/2020	0593-01/PKS/PRV-PANFIC/RS- PHMS/VIII/2020
29	PT. Jasindo Health Care	Pelayanan Perawatan dan Pengobatan	Asuransi	Selamanya	4 Januari 2014	Perpanjangan Otomatis	Berlaku	-	-
30	PT. International Services Pacific Cross	Asuransi Pelayanan Kesehatan	Asuransi	Selamanya	10 maret 2022	Perpanjangan Otomatis	Berlaku	150/DPM/E-PKS/DIR/X/2022	953/ISPC/PKS/X/2022
31	PT. Asuransi Jiwa BCA	Asuransi Pemberian Pelayanan Kesehatan	Asuransi	Selamanya	10 Oktober 2023	10 Oktober 2028	Berlaku	149/DPM/E- PKS/DIR/VIII/2023	286/PKS/BCAL-PHMS/2023
32	Klinik Husada Asih YPAC	Kerja sama Penunjang	Klinik	Selamanya	11 September 2012	Perpanjangan Otomatis	Berlaku		
33	PT HM Sampoerna Tbk	Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan	Perusahaan	Selamanya	1 Juni 2014	Perpanjangan Otomatis	Berlaku	-	55/Perj/HMS/IX/2014

34	PT Adonai Manajemen Kesehatan	Perjanjian Kerja Sama Pemeriksaan Mediacak Chek Up	Perusahaan	Selamanya	26 Agustus 2019	Perpanjangan Otomatis	Berlaku		055/PKS-PF/AMK/VIII/2019
35	PT. Nestle Indonesia Kejayan Factory	Pelayanan Kesehatan	Perusahaan	Selamanya	1 April 2013	Perpanjangan Otomatis	Berlaku		
36	PT. Ajinomoto Sales Indonesia	Pelayanan Pengobatan dan Perawatan Kesehatan	Perusahaan	Selamanya	5 Januari 2012	Perpanjangan Otomatis	Berlaku	008/PERS/RSPH-I/2012	LEG/ASI/120510-85
37	PT. Coca Cola Distribution Indonesia	PELAYANAN KESEHATAN	Perusahaan		9 Januari 2019	Perpanjangan Otomatis	Berlaku	573/I-PKS/PMS/IV/2019	004/Perjanjian/HRSEJ/IX/2019
38	PT. Indolakto Pandaan	Jasa Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja (PPK)	Perusahaan	Selamanya	1 Oktober 2014	Perpanjangan Otomatis	Berlaku		
39	PT. Nestle Indonesia Kejayan Factory	Perjanjian Pelayanan Kesehatan	Perusahaan	2 Tahun	20 Maret 2015	Perpanjangan Otomatis	Berlaku		
40	Harris Hotel & Conventions Malang	Rujukan Pelayanan Kesehatan	Perusahaan	2 Tahun	14 Oktober 2019	Perpanjangan Otomatis	Berlaku	308/E-PKS/PMS/V/2018	001/IKS/HR/V/2018
41	PT. Duha Mulya Abadi	Penyediaan paket BHP Operasi Katarac	Perusahaan	Selamanya	11 Januari 2019	Perpanjangan Otomatis	Berlaku		
42	RS Sahabat Pasuruan	Rujukan Asuhan Pasien & Penunjang	Rumah Sakit	Selamanya	2 Desember 2016	Perpanjangan Otomatis	Berlaku	1097.1/E-PKS/DIR/VIII/2021	
43	PT. Asuransi Dayin Mitra TBK			Selamanya	1 Mei 2015	Perpanjangan Otomatis	Berlaku	003/MKT/HLT/PKS/I/2015	PH/IKS/269/XII/2014
44	PT. Jasa Raharja (Perseroan Perwakilan Malang)	Penanganan dan Penyelesaian Santunan Korban Kecelakaan Penumpang Angkutan Umum dan Lalu Lintas	Asuransi	5 Tahun	4 Juli 2022	4 Juli 2027	Berlaku	912.1/E-PKS/DIR/VII/2022	P/13/SP/2022

		Jalan							
45	PT. Jasa Raharja (Perseroan Perwakilan Malang) (ADENDUM)	Penanganan dan Penyelesaian Santunan Korban Kecelakaan Penumpang Angkutan Umum dan Lalu Lintas Jalan	Asuransi	4 Tahun	7 Februari 2023	4 Juli 2027	Berlaku		
46	Klinik Pratama Rawat Jalan Mawar Waskitha Husada	Pelayanan Asuhan Pasien & Penunjang	Klinik	3 Tahun	23 Januari 2024	20 Januari 2027	Berlaku	001.34/DPM/E- PKS/DIR/I/2024	
47	Klinik Losari Medika	Pelayanan Asuhan Pasien & Penunjang	Klinik	3 Tahun	6 Februari 2024	6 Februari 2027	Berlaku	021/DPM/E-PKS/DIR/II/2024	
48	PT. Samator	Operasional Pasokan Produk	Perusahaan	5 Tahun	1 September 2022	1 September 2027	Berlaku		DISTRIBUTIONAGREEMENT_LGL_1850
49	RS Persada	Pelayanan Kesehatan, Rujukan, Laboratorium dan Radiolog	Rumah Sakit	5 Tahun	10 Oktober 2022	10 Oktober 2027	Berlaku	152.42/DPM/E- PKS/DIR/XI/2022	1083.b.Hs/MOU/X/PH.2022
50	PT. Kartika Bina Medikatama (Medika Plaza)	Perjanjian Pelayanan Kesehatan	Asuransi	3 Tahun	26 Juni 2023	26 Juni 2026	Berlaku	103.1/DPM/E- PKS/DIR/IV/2023	358/KBM-DPM/PKS/VI/2023
51	ASABRI	Pelayanan Pengobatan Dan Perawatan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Peserta Asabri Aktif	Asuransi	3 Tahun	13 Desember 2023	13 Desember 2026	Berlaku	1902/E-PKS/DIR/XII/2023	PERJ-182/HK.02.01/HBL.H/XII/2023
52	Klinik Rawat Inap Muslimat Singosari	Rujukan Asuhan Pasien	Klinik	3 Tahun	15 April 2023	15 April 2026	Berlaku	107.1/DPM/E- PKS/DIR/IV/2023	031.A/A.1/M/RSMS/02/IV/2023

53	Klinik Tirta Husada	Rujukan Asuhan Pasien & Penunjang	Klinik	3 Tahun	18 September 2023	18 September 2026	Berlaku	176.3/DPM/E- PKS/DIR/IX/2023	015.004/KTH/IX/2023
54	Klinik BLKI Singosari	Rujukan Asuhan Pasien	Klinik	3 Tahun	24 April 2023	27 April 2026	Berlaku	108.1/DPM/E- PKS/DIR/IV/2023	150/0187B00/IV/23
55	Klinik Brawijaya Lawang	Rujukan Asuhan Pasien	Klinik	3 Tahun	3 Juli 2023	3 Juli 2026	Berlaku	144.1/DPM/E- PKS/DIR/VII/2023	PKS/115/VII/2023
56	Klinik Jantung Hasna Medika Malang	Pelayanan Asuhan Pasien & Penunjang	Klinik	3 Tahun	1 Desember 2023	31 November 2026	Berlaku	241.2/DPM/E- PKS/DIR/XII/2023	023/PKS/DIR/HMMALANG/XII/2023
57	Klinik Rawat Inap Wijaya Husada	Rujukan Asuhan Pasien	Klinik	3 Tahun	15 April 2023	15 April 2026	Berlaku	001/PKS/15/4/2023	113.2/DPM/E-PKS/DIR/V/2023
58	Klinik Endisa Husada	Rujukan Asuhan Pasien & Penunjang	Klinik	3 Tahun	21 Juli 2023	21 Juli 2026	Berlaku	148.3/DPM/E- PKS/DIR/VII/2023	PK/01/VII/2023-KEH
59	Klinik Siaga Medika	Rujukan Pelayanan Kesehatan	Klinik	3 Tahun	3 Aoktober 2023	3 Oktober 2026	Berlaku	188/DPM/E-PKS/DIR/X/2023	14.30/KSM/VII/2023
60	Klinik Garuda	Pelayanan Kesehatan	Klinik	3 Tahun	31 Mei 2023	31 Mei 2025	Berlaku	131.2/DPM/E- PKS/DIR/V/2023	B/25/VI/2023
61	Laboratorium Panglima Sudirman	Pelayanan Rujukan Laboratorium	Laboratorium	3 Tahun	5 Juni 2023	5 Juni 2026	Berlaku	135.2/DPM/E- PKS/DIR/VI/2023	Q.0150/LKPS.VI/25.2023
62	PT. Sumber Alfaria	Pelayanan Kesehatan	Perusahaan	3 Tahun	22 Juni 2023	22 Juni 2026	Berlaku	142.1/DPM/E- PKS/DIR/VI/2023	0002/SDM-MLG/VI/2023
63	Solaris Hotel	Rujukan Pelayanan Kesehatan	Perusahaan	3 Tahun	1 November 2023	1 November 2026	Berlaku	222/DPM/E- PKS/DIR/XI/2023	108/HRD/SHM/X/2023
64	PT. Arthawena Sakti Gemilang	Pelayanan Rujukan kesehatan	Perusahaan	3 Tahun	15 Juni 2023	15 Juni 2026	Berlaku	138.3/DPM/E- PKS/DIR/VI/2023	-
65	Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS)	Kerjasama dalam proses akreditasi rumah sakit	Perusahaan	4 Tahun	22 April 2022	24 April 2026	Berlaku		
66	CV. Aumireta Anggun	Rujukan Pelayanan Kesehatan	Perusahaan	3 Tahun	28 Agustus 2023	28 Agustus 2026	Berlaku	164.1/DPM/E- PKS/DIR/VIII/2023	-
67	RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang	Rujukan Pelayanan Kesehatan	Rumah Sakit	3 Tahun	30 Oktober 2023	30 Oktober 2026	Berlaku	220.1/DPM/E- PKS/DIR/X/2023	HK.03.01/D.XXXVII/12226A/2023

68	RS Islam Unisma Malang	Rujukan Pelayanan Kesehatan dan Pemulasaraan Jenazah	Rumah Sakit	3 Tahun	1 Januari 2024	31 Desember 2026	Berlaku	222.11/DPM/E- PKS/DIR/XI/2023	MENUNGGU SEKRETARIAT
69	RS Puri Bunda	Rujukan Pelayanan Kesehatan dan Penunjang	Rumah Sakit	2 Tahun	6 Februari 2024	6 Februari 2026	BERLAKU	020/DPM/E-PKS/DIR/II/2024	001/PKS/PB/II/2024
70	RSUD Lawang	Rujukan Pelayanan Kesehatan dan Penunjang	Rumah Sakit	2 Tahun	1 Maret 2024	1 Maret 2026	Berlaku	245.1/E-PKS/DIR/II/2024	074.3/35.07.302.102/2024
71	Avrist Assurance	Perjanjian Pelayanan Kesehatan	Asuransi	2 Tahun	24 Agustus 2023	24 Agustus 2025	Berlaku	951/PKS/PROV/IPOP/AVR-1494/VII/2023	
72	PT. Asuransi Mandiri Inhealth Manage Care Indonesia	Pelayanan Kesehatan & pelayanan obat	Asuransi	2 Tahun	30 Januari 2023	31 Januari 2025	Berlaku	028.2/DPM/E- PKS/DIR/II/2023	0.32/AJII/KOP-SBY/PKS/0123
73	BPM Inung Indah sari	Rujukan Asuhan Pasien	Bidan Praktek Mandiri	3 Tahun	10 Januari 2022	10 Januari 2025	Berlaku	004.1/DPM/E- PKS/DIR/I/2022	-
74	Klinik Dokter 24 Jam	Rujukan Asuhan Pasien & Penunjang	Klinik	3 Tahun	2 Agustus 2022	2 Agustus 2025	Berlaku		
75	Klinik Mutiara Sehat	Rujukan Asuhan Pasien & Penunjang	Klinik	3 Tahun	5 Januari 2022	5 Januari 2025	Berlaku	200.11/DPM/I- PKS/DIR/I/2022	
76	Klinik 24 Jam	Rujukan Asuhan Pasien & Penunjang	Klinik	3 Tahun	2 Agustus 2022	2 Agustus 2025	Berlaku	112.1/DPM/E- PKS/DIR/VIII/2022	138/MOU/VIII/CSH.2022
77	PT. Jaya Obayashi	Rujukan Pelayanan Kesehatan	Perusahaan	5 Tahun	1 Juli 2020	1 Juli 2025	Berlaku	360/DPM/I-PKS/VIII/2020	
78	PT. Malang Intermedia Pers	Pelayanan Kesehatan	Perusahaan	5 Tahun	1 Juli 2020	1 Juli 2025	Berlaku	025/DPM/E- PKS/DIR/VII/2020	103.1/PKS/DIR/JPRM/VIII/2020
79	PT. Pancamas Elite	Rujukan Pelayanan Kesehatan	Perusahaan	5 Tahun	1 Juli 2020	1 Juli 2025	Berlaku	032/DPM/E- PKS/DIR/VII/2020	
80	PT. Yamaha Musical Product Indonesia	Pelayanan Kesehatan Rawat Inap Bagi	Perusahaan	3 Tahun	1 Juni 2022	1 Juni 2025	Berlaku	004/DPM/E-PKS/III/2020	452/YMPI/II/PKS/III/2020

		Karyawan Dan Keluarga							
81	PT. Tirta Investama	Pelayanan Kesehatan Karyawan & Keluarga	Perusahaan	5 Tahun	31 Agustus 2020	31 Agustus 2025	Berlaku		
82	PT. TASPEN	Perawatan Peserta Program Jaminan Kecelakaan Kerja	Perusahaan	2 Tahun	1 Januari 2023	31 Desember 2025	Berlaku	008/E-PKS/DIR/2023	JAN-01/DIR/2023
83	PT. Kemas Super Indonesia (KSI)	Pelayanan Kesehatan	Perusahaan				Berlaku		
84	PT. Nayaka Era Husada	Pelayanan Kesehatan	Perusahaan	2 Tahun	30 Mei 2023	30 Mei 2025	Berlaku	143.1/DPM/E- PKS/DIR/VII/2023	PKS/106/072023
85	PMI Kabupaten Malang	Pelayanan Darah Transfusi Bagi Pasien Peserta BPJS & Asuransi lainnya	PMI	1 Tahun	1 Juni 2023	1 Juni 2025	Berlaku	768/E-PKS/DIR/V/2023	#REF!
86	PMI Kota Malang	Pelayanan Darah Transfusi Bagi Pasien Peserta BPJS & Asuransi lainnya	PMI	1 Tahun	20 November 2023	31 Desember 2025	Berlaku	1790/E-PKS/DIR/XI/2023	2214/02.06.27/UTD/XI/2023
87	RS Lavalette	Rujukan Asuhan Pasien & Penunjang	Rumah Sakit	2 Tahun	10 Agustus 2023	10 Agustus 2025	Berlaku	155.2/DPM/E- PKS/DIR/VIII/2023	RSL-KONTR-PKS/VII/23.124
88	RS Prima Husada Sukorejo	Rujukan Asuhan Pasien	Rumah Sakit	3 Tahun	21 Februari 2022	21 Februari 2025	Berlaku	213/E-PKS/DIR/III/2019	126/RSPHS/E- PKS/III 2019
89	RS Panti Nirmala	Kerjasama Pelayanan Rujukan	Rumah Sakit	3 Tahun	7 Oktober 2022	6 Oktober 2025	Berlaku	152.44/DPM/E- PKS/DIR/XI/2022	3740/069/RSPN/X/2022
90	PT Kimberly Clark	Pasokan produk	Perusahaan	1 Tahun	1 Januari 2024	1 Januari 2025	BERLAKU		106/KCS-PNS/MOU/II/2023
91	PT. Lippo General Insurance	Perjanjian Pelayanan Kesehatan	Asuransi	5 Tahun	18 September 2019	18 September 2024	Berlaku	267/RSPHS/E- PKS/DOR/VI/2019	1502/LI-HOSPT/VI/2019
92	PT. Asuransi Multi Artha Guna Tbk	Fasilitas Rawat Inap dan Rawat	Asuransi	4 Tahun	28 Januari 2020	27 Januari 2024	Berlaku	015/DPM/E- PKS/DIR/XI/2019	PKS-0097/XI/2019/MAG-R2

	(Asuransi MAG)	Jalan							
93	BPJS KESEHATAN	Pelayanan Penjamin Rujukan Tingkat Lanjutan Bagi Peserta Program JKN	Asuransi	1 Tahun	1 Januari 2024	31 Desember 2024	Berlaku	1879/E-PKS/DIR/XII/2023	602/KTR/VII-05/1223
94	BPJS KETENAGAKERJAAN	Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan	Asuransi	1 Tahun	1 Januari 2023	31 Desember 2024	Berlaku	1571/E-PKS/DIR/XII/2022	PER/60/102022
95	BPM Silvian Wulandari	Rujukan Asuhan Pasien & Penunjang	Bidan Praktek Mandiri	3 Tahun	10 Maret 2021	10 Maret 2024	Berlaku	031/DPM/E-PKS/DIR/III/2022	
96	Klinik Idamamuk	Rujukan Asuhan Pasien & Penunjang	Klinik	3 Tahun	16 Juni 2021	16 Juni 2024	Berlaku	347/DPM/I-PKS/DIR/VII/2021	005/VI/2021
97	PT. Etercon Pharma	Sponsorship Maternity Kit Free untuk pasien Maternitas	Perusahaan	1 Tahun	1 Juni 2023	1 Juni 2024	Berlaku	132.1/DPM/E-PKS/DIR/VI/2023	039/ETC-CBX/PKS/VII/2023
98	PT. Kasoem Hearing	Pelayanan Pemasangan Alat Bantu Mendengar (ABM)	Perusahaan	2 Tahun	1 Maret 2022	1 Maret 2024	Berlaku	339.6/E-PKS/DIR/III/2022	002/KHC/KSO-SMAD/III/2022
99	PT. Kencana Tiara Gemilang (KTG)	Pelayanan Kesehatan	Perusahaan	3 Tahun	12 Desember 2021	12 Desember 2024	Berlaku	174.1/DPM/E-PKS/DIR/XII/2021	017/KTG/HRGA.06/XII/2021
100	PT. Rentokil	Pengendalian Hama dengan Program General Pest (GP)- Non	Perusahaan	1 Tahun	11 September 2023	11 September 2024	Berlaku	173.1/DPM/E-PKS/DIR/IX/2023	003/PT.RI/MLG-37/52400326/IX/2023

		Station							
101	PT. DELAPAN BERUANG MADU (BEETU)	Layanan Antar Obat Pasien	Perusahaan	1 Tahun	15 Juni 2023	15 Juni 2024	Berlaku	138.2/DPM/E- PKS/DIR/VI/2023	003/PKS/V/PT.DISAPRIMAMEDIKA/MLG/23-24
102	PT. TSSA (Teman Sejati Sejahtera Abadi)	Pengelolaan Limbah B3	Perusahaan	1 Tahun	6 Februari 2023	2 Juni 2024	Berlaku	0175/LGL-PK/DPM-TSSA-AMP/II/2023	
103	PT. Pillar Utama Cortindo	Vendor Pelayanan Pemeliharaan Peralatan Elevator	Perusahaan	1 Tahun	1 Juni 2023	30 Juni 2024	Berlaku	-	KS/PUCCSBY-1216/VII/2023
104	PT. Global Trans Jaya Mulia	Pengangkutan dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Perusahaan	1 Tahun	1 April 2023	31 Maret 2024	Berlaku	060.2/DPM/E- PKS/DIR/II/2023	037/SPH-T/DPM-GTJM/BSJ/IV/2023
105	PT. Uniplastindo Interbuana	Rujukan Pelayanan Kesehatan dan Penunjang	Perusahaan	3 Tahun	8 Juni 2023	8 Juni 2024	Berlaku	302/DPM/I-PKS/DIR/VI/2021	001/PKS-IU-HRD/VI/2021
106	RSUD Dr. Saiful Anwar Malang	Rujukan Asuhan Pasien	Rumah Sakit	2 Tahun	1 November 2022	1 November 2024	Berlaku	1562.1/e-pks/dir/xi/2022	116/302/2019
107	RS. TK.II dr. SOEPRAOEN (RST)	Rujukan Pelayanan Kesehatan dan Penunjang	Rumah Sakit	2 Tahun	16 September 2022	15 September 2024	Berlaku	152.40/DPM/E- PKS/DIR/X/2022	PKS/173/IX/2022
108	RS Siti Miriam Lawang	Rujukan Pelayanan Kesehatan dan Pemulasaraan Jenazah	Rumah Sakit	2 Tahun	4 Oktober 2022	3 Oktober 2024	Berlaku	151.1/DPM/E- PKS/DIR/X/2022	810/HMS/RSSM/X/2022
109	RS Dr. SYAIFUL ANWAR (RSSA)	Rujukan Pekayanan Penunjang	Rumah Sakit	2 Tahun	1 November 2022	1 November 2024	Berlaku	1562.2/E-PKS/DIR/XI/2022	116//102.7/2022
110	RSU Muhammadiyah (RSUMM)	Pelayanan Rujukan Kesehatan, Laboratorium	Rumah Sakit	1 Tahun	21 Agustus 2023	21 Agustus 2024	Berlaku	159.1/DPM/E- PKS/DIR/VII/2023	100/SK_PKS/RSU-UMM/VII/2023

		dan Radiologi							
111	DINKES Kabupaten Malang	Pelaksanaan Kegiatan Skrining Tuberkulosis Pada Penyandang Diabetes Melitus Dengan Metode Radiologis	Dinas Pemerintah			31 Desember 2023	PROSES PERMOHONAN	1183/E-PKS/DIR/VII/2023	415.4/61/35.07.103/2023
112	PT. TSSA dan PT. Tenang Sejahtera	Pengangkutan dan Pemusnahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Perusahaan	1 Tahun	23 Februari 2024	23 Februari 2025	Proses TTD Pihak Kedua		
113	PT. Kartika Bina Medikatama (Medika Plaza)	Perjanjian Pelayanan Kesehatan	Asuransi				PROSES TTD DILUAR		
114	Asuransi Jiwa Generali	PKS Asuransi Kesehatan	Asuransi				PROSES DISPOSISI SIM		
115	PT Teknologi Pamadya Analitika (Meditap)	Asuransi Pelayanan Kesehatan	Asuransi				PROSES PERPANJANGAN/PEMBAHARUAN PKS		
116	BKKBN	pelayanan keluarga berencana iud dan implant	Dinas Pemerintah	1 Tahun	17 Januari 2024	17 Januari 2025	Proses pengajuan TTD ke BKKBN	294/E-PKS/DIR/I/2024	
117	CV. Galaxy Mulia Cahaya	PKS Alat Proteza Ortesa	Pengadaan Alat				PROSES DISPOSISI SIM		
118	PT Pesta Pora Abadi	Rujukan Pelayanan Kesehatan	Perusahaan	3 Tahun			Progres Review di Pihak Kedua		
119	Batas Media 99	Rujukan Pelayanan Kesehatan	Media Online	2 Tahun			Progres Review di Pihak Kedua		
120	PT Yamaha Electronic Manufacturing Indonesia	Rujukan Pelayanan Kesehatan	Perusahaan				Progres Review di Pihak Kedua		

121	PT Tentrem Sejahtera	Rujukan Pelayanan Kesehatan	Perusahaan				Progres Review di Pihak Kedua		
122	Klinik Utana Rawat Jalan Akasia	Rujukan Pelayanan Kesehatan	Klinik				Progres pengajuan di PT by SIMRS		